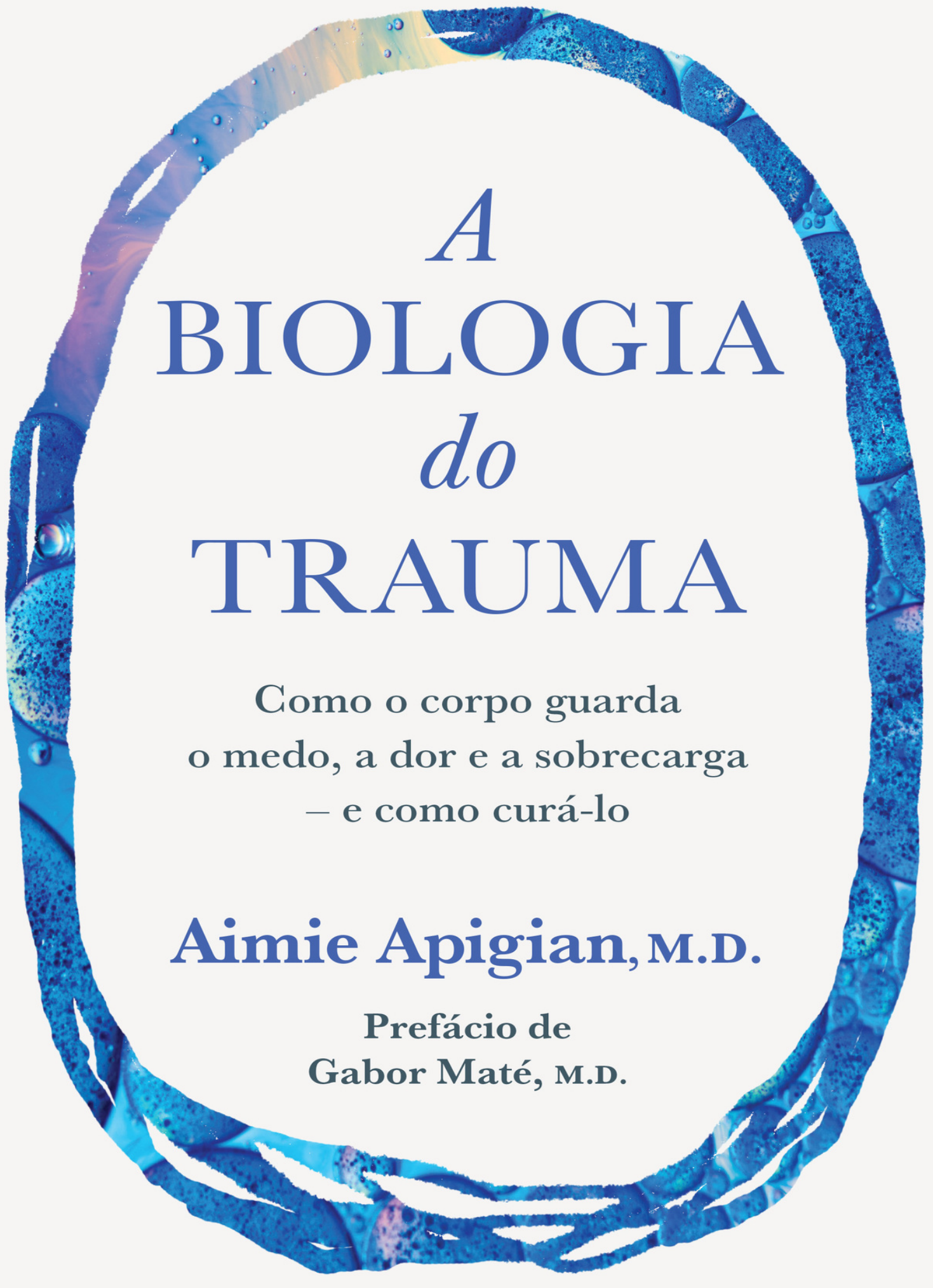


A circular border made of a microscopic image of cells, likely from a tissue sample, framing the central text. The cells are stained in shades of blue and purple, with some showing distinct nuclei and cytoplasm.

A BIOLOGIA *do* TRAUMA

Como o corpo guarda
o medo, a dor e a sobrecarga
– e como curá-lo

Aimie Apigian, M.D.

Prefácio de
Gabor Maté, M.D.



SEXTANTE

A Editora Sextante agradece a sua escolha.
Agora, você tem em mãos um dos nossos livros
e pode ficar por dentro dos nossos lançamentos,
ofertas, dicas de leitura e muito mais!

Clique aqui para assinar
nossa newsletter e receber
as novidades diretamente
em seu e-mail.

A
BIOLOGIA
do
TRAUMA

A
BIOLOGIA
do
TRAUMA

Aimie Apigian, M.D.

Prefácio de
Gabor Maté, M.D.

Traduzido por
Fabiano Morais da Costa



SEXTANTE

Este livro tem finalidade exclusivamente informativa e não substitui o aconselhamento médico profissional. A autora e a editora se isentam expressamente de toda e qualquer responsabilidade decorrente, direta ou indiretamente, do uso das informações contidas nesta obra. Um profissional habilitado da área da saúde deve ser consultado a respeito de sua situação específica de saúde. Qualquer menção contida neste livro a produtos não implica endosso por parte da autora ou da editora. Os nomes e algumas informações de determinadas pessoas neste livro foram alterados e, em alguns casos, histórias foram combinadas a fim de proteger o anonimato dos pacientes.

Título original: *The Biology of Trauma*

Copyright © 2025 por Aimie Apigian

Copyright da tradução © 2026 por GMT Editores Ltda.

Publicado originalmente nos Estados Unidos pela BenBella Books, Inc. Tradução publicada mediante acordo com BenBella Books, Inc., e Agência Literária Riff, Ltda.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser utilizada ou reproduzida sob quaisquer meios existentes sem autorização por escrito dos editores.

coordenação editorial: Sibelle Pedral

produção editorial: Guilherme Bernardo

preparo de originais: Melissa Lopes Leite

revisão: Hermínia Totti e Luana Luz de Freitas

diagramação: Valéria Teixeira

ilustrações de miolo: Sienna Roman

capa: Brigid Pearson

imagens de capa: Daco / Adobe Stock

adaptação de capa: Ana Paula Daudt Brandão

foto da autora: ©Jesse Nesser

e-book: Pedro Wainstok

CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

A652b

Apigian, Aimie

A biologia do trauma [recurso eletrônico] / Aimie Apigian ; tradução Fabiano Morais da Costa ; prefácio Gabor Maté. - 1. ed. - Rio de Janeiro : Sextante, 2026.
recurso digital

Tradução de: The biology of trauma

Formato: epub

Modo de acesso: World Wide Web

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-431-1262-6 (recurso eletrônico)

1. Trauma psíquico. 2. Psiquiatria biológica. 3. Corpo e mente (Terapia). 4. Livros eletrônicos. I. Costa, Fabiano Morais Da. II. Maté, Gabor. III. Título.

26-104676.0

CDD: 616.8521

CDU: 616.891.6



Carla Rosa Martins Gonçalves - Bibliotecária - CRB-7/4782

Todos os direitos reservados, no Brasil, por

GMT Editores Ltda.

Rua Voluntários da Pátria, 45 – 14º andar – Botafogo

22270-000 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 2538-4100

E-mail: atendimento@sextante.com.br

www.sextante.com.br

Este livro é dedicado a todos que foram um santuário para o meu coração ferido durante minha jornada de cura. Dick e Judy Hart, e Aida, vocês me deram a segurança e o amor de que eu precisava para encontrar o meu caminho. Obrigada.

E a Miguel, que inspirou minha busca incansável por compreender o trauma e encontrar soluções práticas para ele. Você abriu uma porta que mudou a minha vida. E viverá para sempre no meu coração.

SUMÁRIO

PREFÁCIO

INTRODUÇÃO

PARTE 1 COMO O CORPO VIVENCIA O TRAUMA

CAPÍTULO 1 As etapas universais da resposta instintiva do corpo ao trauma

CAPÍTULO 2 A diferença entre estresse e trauma

CAPÍTULO 3 Entendendo nosso limite crítico: neurocepção, capacidade e os estados de funcionamento

CAPÍTULO 4 A sobrecarga no nível celular

CAPÍTULO 5 A experiência de sobrecarga que afeta o corpo inteiro

CAPÍTULO 6 Os três mecanismos de sobrevivência: como nosso corpo resiste à impotência

PARTE 2 COMO E POR QUE O CORPO RETÉM O TRAUMA

CAPÍTULO 7 Por que o corpo retém o trauma

CAPÍTULO 8 Presos em um loop: a formação de uma biologia do trauma

CAPÍTULO 9 Padrões de sofrimento: reconhecendo o trauma armazenado no corpo

CAPÍTULO 10 Quando o trauma se torna doença: o quinto padrão do trauma armazenado

CAPÍTULO 11 Vulnerabilidade ao trauma: infância e filtros preexistentes

PARTE 3 COMO O CORPO SE CURA

CAPÍTULO 12 O mapa e o modelo para a jornada

CAPÍTULO 13 Como começar com segurança

CAPÍTULO 14 Suporte: alcançando a regulação por meio do reparo

CAPÍTULO 15 A química interna da desregulação

CAPÍTULO 16 Reparando a programação de medo da primeira
infância

CAPÍTULO 17 Reparando a programação para a disfunção e a doença

CAPÍTULO 18 Da cura para a vida plena: próximos passos

EPÍLOGO

AGRADECIMENTOS

BIBLIOGRAFIA

PREFÁCIO

O trauma, como demonstra a Dra. Aimie Apigian nesta obra valiosa, é muito mais que uma ferida psicológica dolorosa. É uma experiência física que se manifesta nos órgãos, nos tecidos e nas células da nossa constituição fisiológica. Com um detalhismo impressionante, este livro explica como tudo isso acontece.

A Dra. Apigian baseia sua obra na ciência da unidade mente-corpo, amplamente fundamentada por várias décadas de pesquisa na área da psiconeuroimunologia – a disciplina que tornou obsoleta a separação entre mente e corpo, tão defendida pela medicina tradicional. E faz isso em uma linguagem fácil de entender e adequada para o público leigo.

Chega a ser irônico que as informações apresentadas aqui sejam novidade para a maioria dos médicos hoje atuantes. Em grande parte, a formação em medicina teima em ignorar novos conhecimentos que desafiem seus pressupostos fundamentais, apesar de milhares de estudos já terem comprovado, para além de qualquer dúvida razoável, a existência da unidade mente-corpo. Eis por que este livro é tão oportuno.

Em um artigo publicado em 1977, o clínico geral e psiquiatra americano George Engel argumentou que a grande falha da medicina moderna “é não levar em consideração o paciente e suas características pessoais. Ainda assim, na prática diária do médico, o principal objeto de estudo é uma pessoa”. Como escrevi em *O mito do normal*, devemos tratar a pessoa como um todo, em sua plena “natureza psicológica e social”, para citar o Dr. Engel, aplicando uma abordagem *biopsicossocial*. Isso significa reconhecer a unidade entre emoções e fisiologia, entendendo ambas como processos dinâmicos que se desenrolam no contexto dos relacionamentos, do nível pessoal ao cultural.

O fato de os insights pioneiros do Dr. Engel não terem servido de guia

para a prática médica dominante é lamentável. Como a Dra. Apigian e muitos colegas, inclusive eu mesmo, descobrimos, as informações que nossa profissão tende a ignorar podem ser de suma importância na cura de diversos males que afetam a mente e o corpo como um todo. Isso também se manifesta em muitas disfunções da vida “normal” que talvez não possam ser chamadas de patologias, mas que ainda assim podem prejudicar a energia, o humor, os padrões de relacionamento e a atitude das pessoas em relação à própria vida, sem falar na visão que elas têm de si mesmas.

É aí que entra o trauma, e por isso este livro é uma contribuição extraordinária. Ao apresentar as marcas emocionais e psicológicas do trauma na mente e na alma, a autora descreve seus impactos no nível celular e até mesmo subcelular. Delineia, assim, um quadro claro de como as adaptações psicofisiológicas ao trauma são fundamentais para a sobrevivência e, ao mesmo tempo, podem prejudicar a manutenção da saúde.

Um exemplo disso é o modelo muito útil da Dra. Apigian para entender as cinco etapas em potencial da resposta ao trauma: sobressalto (hipervigilância); estresse (alta energia); o “muro” (sensação de impotência); congelamento (paralisia) e apagão (uma sensação profunda de abatimento). Todas essas etapas podem ser adaptativas a curto prazo, mas debilitantes a longo prazo. Uma vez desencadeadas por acontecimentos adversos da vida e enraizadas no organismo, elas comprometem o funcionamento fisiológico, as habilidades cognitivas e emocionais e a própria saúde física, podendo se manifestar como uma série de desafios e crises ou doenças – mesmo muitos anos depois.

Aimie Apigian sabe do que está falando, pois vivenciou o trauma em primeira mão e teve que aprender a respeito das dinâmicas sobre as quais escreve. Até mesmo sua formação médica altamente especializada, com diplomas suficientes para mais de uma vida, representa a motivação de alguém que busca escapar de traumas que havia normalizado. Foi o bloqueio do próprio corpo, somado aos desafios que enfrentou como mãe, que a impeliu a estudar tudo aquilo que não havia aprendido na faculdade de medicina. Devemos ser gratos a ela. Esse aprendizado, aliado à sua própria jornada de cura, a levou a criar um caminho terapêutico que outras pessoas também poderão trilhar.

Poucas obras conseguem combinar relato pessoal, formação médica

rigorosa, profundidade psicológica, investigação científica e experiência clínica no acompanhamento de tantas pessoas em seu processo de cura. Isso porque *A biologia do trauma* não se limita a informações científicas e insights psicológicos. Ele apresenta também um caminho de cura forjado com esmero por Aimie Apigian, do qual muitos de seus alunos já se beneficiaram. Este livro é bem-sucedido em dois aspectos: como material educativo fascinante e como manual de cura. Ele cumpre a promessa de nos ajudar a navegar por nosso corpo e pelo mundo interno maravilhoso que todos nós temos, e que é capaz de experimentar a cura depois da dor, da sobrecarga, do medo e do trauma.

GABOR MATÉ,
médico e autor de *O mito do normal:*
Trauma, saúde e cura em um mundo doente

INTRODUÇÃO

“Mamãe, eu vou te matar amanhã.”

As palavras pairaram no ar quente como uma ameaça, quebrando a paz do nosso ritual diário enquanto eu embalava meu filho adotivo de 5 anos, Miguel. Como muitas mulheres que sonharam com a maternidade, eu tinha imaginado esses momentos tranquilos de outra forma: risadas, abraços carinhosos, mãe e filho construindo um vínculo afetivo. Em vez disso, meu garotinho tinha acabado de me dizer que queria me matar, no mesmo tom casual que usaria para pedir um lanche, acrescentando que começaria arrancando meus olhos com um pedaço de pau.

Meu coração não apenas se partiu: ele se despedaçou em um milhão de pedacinhos. Qualquer um que tenha amado outra pessoa aberta e profundamente e foi rejeitado conhece a dor de que estou falando. Mas esse caso era diferente. Aquele era o meu filho, a criança que eu havia escolhido e que eu deveria curar com o meu amor. Apesar de as probabilidades estarem contra mim – uma mãe solo cursando medicina, com mestrado em bioquímica e sem experiência em adoção –, eu era otimista e acreditava no poder do amor. (Soa familiar?) Eu tinha todo o conhecimento teórico sobre desenvolvimento infantil e criação com apego, bem como a preparação necessária para me tornar mãe adotiva. Havia organizado uma rotina estável, comprado a cadeira de balanço perfeita para nosso momento de fortalecimento do vínculo e estava fazendo tudo “certo”. Mesmo assim, lá estava eu, segurando uma criança pequena determinada a rejeitar aquilo de que ela mais precisava: o meu amor. Sozinha, me sentindo perdida e incompreendida por outros pais, amigos e familiares bem-intencionados, eu estava me sentindo péssima.

No entanto, naquele dia, sentada na cadeira de balanço, decidi que iria

encontrar as respostas para o Miguel. Seria o começo de uma jornada repleta de desafios, reviravoltas e desdobramentos que eu jamais poderia ter previsto. Foi ao mesmo tempo a coisa mais difícil que fiz na vida e a mais transformadora. Mudou não só minha abordagem em relação à criação com apego e minha carreira, como também meu crescimento como pessoa e minha cura individual. Ao mesmo tempo que eu enfrentava as expressões do trauma de Miguel em casa, passei a perceber padrões semelhantes de inseguranças relacionadas à confiança e ao apego nos meus pacientes. Esses padrões acabariam por se manifestar na minha própria vida, nos meus relacionamentos e na minha saúde de maneiras que eu ainda não vislumbrava.

Na residência em cirurgia geral, fundei uma organização sem fins lucrativos que promovia acampamentos de fim de semana para famílias com crianças que enfrentavam dificuldades relacionadas a apego e confiança. À medida que os padrões de trauma ficavam mais evidentes nas centenas de crianças adotadas com as quais eu trabalhava, tornou-se impossível ignorar as semelhanças que eu via nas reações emocionais dos meus pacientes. Isso me intrigou, inspirando um desejo ainda maior de entender a fundo como o trauma é assimilado pelo corpo. Minha jornada me levou a um mestrado em saúde pública, certificações em medicina preventiva e medicina da dependência, além de especializações em medicina psicossomática, medicina funcional e nutrição voltada à saúde mental. Busquei ainda treinamento em abordagens terapêuticas para o trauma, entre elas a Experiência Somática, o Toque Neuroafetivo e uma modalidade de terapia de base narrativa e artística integrada ao modelo dos Sistemas Familiares Internos. Devorei todas as informações que encontrei.

Durante todo esse tempo, enquanto tratava de milhares de pacientes com condições clínicas e cirúrgicas – de doenças autoimunes até fadiga crônica, passando por dor, problemas digestivos, câncer e vício –, algo se tornava cada vez mais evidente para mim: a prevalência do trauma “armazenado”, porém não reconhecido. Por meio dos padrões que identifiquei, percebi que a origem comum dos problemas de saúde crônicos reside em corpos presos à biologia da sobrevivência, impedidos de acessar seus próprios processos naturais de cura. E, de modo surpreendente, os sintomas do trauma armazenado não surgiam apenas naqueles com diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, mas também em

indivíduos inteligentes, capazes e altamente funcionais, inclusive naqueles que acreditavam nunca ter passado por uma experiência traumática. Fiquei chocada ao me dar conta da epidemia silenciosa do trauma não reconhecido, responsável por sintomas crônicos, tanto mentais quanto físicos, em pessoas no mundo todo.

Até que, em 2014, aconteceu comigo. Eu me tornei a paciente. Começou como um cansaço debilitante que me forçou a enfrentar a ansiedade, a depressão, o ganho de peso e os problemas digestivos subjacentes que eu vinha ignorando e “empurrando com a barriga”. Quando meus exames laboratoriais revelaram uma doença autoimune, fiquei espantada ao perceber que sofria de problemas de saúde crônicos semelhantes aos daquelas pessoas que haviam passado por traumas na infância, algo com que eu nunca tinha me identificado. Quando minhas questões de saúde chegaram a um ponto crítico e me obrigaram a fazer uma pausa, precisei embarcar em outro tipo de jornada, agora profundamente pessoal: a de recuperar minha vida e minha saúde.

Para ser sincera, tive muito medo de que fosse tarde demais para mim. Meu corpo estava visivelmente carregando um grande fardo traumático. Comecei a fazer terapia, como havia recomendado a tantos dos meus pacientes, e logo me vi sobrecarregada, estagnada e, às vezes, traumatizada de novo ao desenterrar meu passado e as dinâmicas familiares da minha infância. Somava-se a isso a vergonha: ainda que estivesse mais consciente, continuava incapaz de alterar minhas reações, o que me fez concluir que eu não tinha força de vontade suficiente. Gastei anos e todo o meu dinheiro experimentando terapias diferentes que se mostraram, na melhor das hipóteses, paliativas e temporárias. Racionalmente, eu entendia o impacto do trauma na mente e no corpo, tendo adquirido competências para trabalhar de maneira efetiva com crianças com trauma de apego, mas agora eu precisava delinear uma trajetória de cura para adultos com décadas de respostas de sobrevivência aprendidas, incluindo problemas de saúde crônicos.

Compartilharei com você neste livro tudo que essas experiências me ensinaram: a ciência da biologia do trauma. Ela não só revela a sabedoria do corpo humano como também explica por que pode ser tão difícil mudar certos padrões. Evidencia do que nosso corpo precisa para se curar e restaurar o bem-estar emocional e físico; então, assim como acontece

quando pegamos um resfriado, não teremos dúvidas de que vamos melhorar. Quero que todos se sintam fortalecidos por esse conhecimento, pois as ferramentas contidas neste livro poderão ajudar as pessoas a compreender seu próprio corpo, que é capaz de se curar após dores profundas, sobrecarga emocional, medo e trauma.

Antes de começarmos, quero deixar claro para quem este livro *não* serve. Ele não é indicado às pessoas que buscam soluções rápidas ou superficiais. Tampouco se destina a quem prefere ignorar os fundamentos biológicos da cura ou recorrer apenas a abordagens baseadas em medicação. Se não for de seu interesse questionar algumas das crenças mais comuns sobre o trauma e o estresse, ou se aprofundar na forma como eles impactam nossa biologia, este livro talvez não seja para você.

Ele foi escrito para quem deseja um roteiro para lidar melhor com a vida, seus estressores e seus traumas. É voltado para pessoas que buscam uma vida mais autêntica e fascinante, que valha a pena ser vivida. Tanto faz se você acha que passou ou não por um trauma. Se o seu interesse é compreender em profundidade e se conectar com a experiência interna do seu corpo e com suas estratégias inatas de cura, este livro será o seu guia.

Se tem sintomas crônicos de saúde, dificuldades para desenvolver confiança ou mecanismos de enfrentamento nocivos, ou se atua profissionalmente ajudando outras pessoas a superar esses desafios, você descobrirá por que às vezes reagimos com raiva e, em outras, sofremos um apagão, e como aprender a trabalhar *com* o seu corpo, e não *contra* ele. Se já se sentiu incapaz de mudar sua vida, seus relacionamentos ou padrões de saúde mesmo fazendo terapia, ou se já ouviu dizer que basta “mudar seus pensamentos”, você encontrará outro caminho nestas páginas: um caminho que respeita a sabedoria natural e a capacidade de cura do seu corpo.

Este livro apresenta uma abordagem prática para entender como nosso mundo interno funciona, o que determina se nos sentimos seguros ou em perigo e o que acontece no corpo quando nos sentimos impotentes. Sem mergulhar fundo em histórias terríveis de traumas, ele ajudará você a compreender o funcionamento do seu corpo por meio de diferentes situações do dia a dia. Não pretendo minimizar as experiências traumáticas que muitos tiveram, mas permitir que você leia, aprenda e encontre esperança sem o sofrimento e os gatilhos provocados por detalhes dolorosos.

Com base nas minhas experiências e na de milhares de pacientes, profissionais e pessoas de diferentes partes do mundo que orientei, ensinei e treinei em meu programa de Biologia do Trauma, sei que, com o conhecimento e as ferramentas que trago aqui, você também poderá alcançar níveis de cura e qualidade de vida que nunca imaginou serem possíveis. Seu corpo sabe exatamente como retornar ao seu estado natural de saúde, integridade e autenticidade. Com o entendimento e os recursos certos, isso é possível – e você é capaz de chegar lá.

PARTE 1

Como o corpo vivencia o trauma

Tanto o estresse quanto o trauma deixam marcas em nosso corpo. Os próximos capítulos desenharão um mapa do seu mundo interno, mostrando a diferença fundamental entre um estresse que pode nos ajudar a crescer e um trauma que pode nos arrasar. Nesta parte vamos empreender uma jornada rumo ao nosso mundo interior, transitando do visível ao invisível, da mente às emoções, dos sistemas fisiológicos às células.

Você vai aprender os cinco passos que o corpo percorre para garantir sua proteção em momentos de alto risco e sobrecarga emocional. Também descobrirá seu “limite crítico de sobrecarga” e entenderá como o sistema nervoso calcula constantemente se estamos em segurança ou em perigo. Vamos explorar o que acontece em nível celular durante o trauma, explicando por que a dor emocional pode desencadear as mesmas reações fisiológicas que o perigo físico. Veremos como o corpo organiza sua resposta ao trauma, afetando tudo – do metabolismo até a imunidade. Por fim, aprenderemos os três mecanismos fundamentais que nosso corpo aciona para sobreviver ao que lhe parece insuportável. Você verá por que o trauma não se limita ao evento em si, mas abarca o que acontece dentro do seu corpo como resultado da sensação de impotência.

Para ilustrar o mapa do nosso mundo interno, você conhecerá

pessoas com vivências interiores similares às nossas. Como Elena, no momento em que um carro vinha em sua direção; Claire, que desenvolveu fadiga crônica; Alex, ao lidar com uma notícia inesperada em uma sala de conferências; e Sarah, à beira do leito da mãe enquanto esta sofria uma parada cardíaca. Também conhecerá Laura, com sua reação exagerada de sobressalto e a dificuldade de expressar afeto.

O mais importante: esta parte mostrará a sabedoria do corpo humano e suas respostas e adaptações precisas para nos servir da melhor forma, o tempo todo. Por mais que tenhamos experimentado reações que julgamos serem prova de nossa falibilidade, fraqueza ou loucura, aprenderemos quão extraordinária é a proteção oferecida pelo instinto de sobrevivência do nosso corpo e como esse instinto é mais forte que a lógica e o pensamento consciente. Vamos começar analisando a resposta programada universal e instintiva ao trauma que gera uma experiência interior compartilhada por todos nós.

CAPÍTULO 1

As etapas universais da resposta instintiva do corpo ao trauma

O trauma não é aquilo que nos aconteceu, mas o que aconteceu dentro de nós como consequência.

– Gabor Maté, *O mito do normal*

O som de pneus derrapando rasga o silêncio da manhã. Nos 30 segundos seguintes, o corpo de Elena executaria a sequência biológica precisa e instintiva que assume o controle para nos ajudar a sobreviver a qualquer ameaça.

Elena estava dirigindo de volta para casa após fazer compras em uma manhã de domingo, sentindo-se grata por aquele momento semanal distante das filhas adolescentes. Tinha chovido na noite anterior, o que deixava o trajeto especialmente bonito. *Acho que vou pôr um audiolivro*, ela pensou, baixando os olhos para o celular.

Foi então que ouviu os pneus derrapando. Ela ergueu a cabeça depressa e olhou ao redor. Um motorista havia perdido o controle do carro na estrada molhada e o veículo vinha deslizando bem na sua direção. Todo o corpo de Elena entrou em alerta. Com o coração disparado e a postura rígida, ela agarrou o volante e começou a girá-lo enquanto pisava no freio para evitar a colisão. Apesar do esforço para fazer tudo certo, ela não conseguiu desviar a tempo. Ficou paralisada, olhando o carro se aproximar.

Elena guardaria apenas uma lembrança fragmentada do que aconteceu em seguida. O tempo pareceu desacelerar, e o impacto se apagou da sua mente. O resto foi como um sonho. Ela se recorda de estar deitada no chão, sentindo-se estranhamente desconectada do corpo, que lhe parecia pesado e

frio. As vozes e os movimentos das pessoas ao redor eram distantes, irreais. Quando os paramédicos chegaram, as instruções claras e tranquilas deles foram como uma âncora: algo que ela pôde seguir sem precisar pensar. A névoa mental só começou a dissipar na ambulância, a caminho do hospital. Aos poucos, o mundo tornou a entrar em foco: ela voltou a distinguir vozes, e seus pensamentos clarearam o suficiente para que respondesse perguntas. Com esse retorno à realidade, vieram as primeiras ondas de dor física, da cabeça aos pés.

Nos meses que se seguiram, Elena se recuperou das lesões físicas, mas não das feridas psicológicas e emocionais. Já não conseguia sair de carro pela manhã sem ficar bastante ansiosa; em geral, estava mais sensível, sentindo vontade de chorar e explodindo com as filhas quando elas brigavam entre si. Elena nunca tinha sido assim. Um ano depois, após várias idas ao pronto-socorro por causa de fadiga e inchaços, ela teve o diagnóstico de lúpus, uma doença autoimune. Aquilo a pegou de surpresa.

Ela estava no processo de procurar respostas que fossem além da medicação convencional que lhe haviam prescrito quando me ouviu falar em um podcast sobre a conexão entre o trauma e as doenças autoimunes. Elena nunca havia feito aquela conexão e se sentiu motivada a trabalhar o seu trauma, caso isso pudesse ajudar. Porém, antes de ingressar no meu programa, ela quis saber se *realmente* seria útil, já que seu tipo de trauma era um acidente de carro. Ela fez uma das perguntas que mais ouço: “O seu programa funciona com meu *tipo específico de trauma*?”

Como acontece com muitas pessoas, você talvez se surpreenda com a resposta: o corpo não distingue um tipo de evento do outro. Diante do trauma, nosso sistema nervoso aciona uma resposta universal.

A RESPOSTA INSTINTIVA UNIVERSAL DO CORPO AO TRAUMA

O corpo humano aperfeiçoou uma resposta instintiva para nos ajudar a sobreviver a qualquer cenário, até mesmo a perigos que pareçam inescapáveis. Meu primeiro contato com essa resposta instintiva ao trauma foi na prática clínica do psiquiatra Louis Tinnin e de sua esposa, arteterapeuta Linda Gantt, enquanto eu buscava terapias para ajudar

Miguel. O que me intrigou foi reconhecer a mesma progressão, embora descrita em termos fisiológicos, no meu estudo da teoria polivagal proposta pelo Dr. Stephen Porges. Para minha surpresa, era a mesma sequência descrita durante minha formação em terapia somática ao abordar a resposta do corpo quando seus movimentos de autodefesa são bloqueados. Somático significa “do corpo” e, no contexto da terapia do trauma, refere-se a modalidades baseadas no corpo, ou abordagens de processamento ascendente (*bottom-up*).

O Dr. Peter A. Levine, ph.D. e criador do método terapêutico Experiência Somática, explica da seguinte forma essa resposta instintiva em seu livro *O despertar do tigre*: “Em resposta a ameaças e lesões, os animais, incluindo os seres humanos, executam padrões de ação inconscientes, de base biológica, que os preparam para enfrentar o perigo e se defender. A própria estrutura do trauma, que inclui mobilização, dissociação e congelamento, baseia-se na evolução de comportamentos de sobrevivência.”

Munida desse conhecimento, eu agora era capaz de enxergar melhor como essas etapas se desenrolavam. Tudo fez sentido, desde a reação de desligamento do meu próprio corpo durante a terapia até os ataques de fúria de Miguel que antes me pareciam imprevisíveis. No meu trabalho voluntário com centenas de crianças adotadas de todo o mundo, comecei a perceber que essa sequência progressiva era ativada quando as feridas de apego delas (danos emocionais específicos resultantes de necessidades não atendidas na primeira infância) eram reabertas. Quer fosse um paciente meu passando pelo trauma físico de uma cirurgia ou lidando com sobrecarga emocional ao receber seu diagnóstico, quer fosse um familiar dominado pelo luto ao lado de um ente querido em seu leito de morte, a mesma progressão se revelava.

A resposta instintiva do nosso corpo ao trauma é uma programação de sobrevivência composta por cinco etapas simples, porém significativas, que podem ocorrer ao longo de horas, minutos ou segundos, como no caso de Elena – às vezes tão rápido que mal identificamos cada etapa separadamente. Pelo fato de essa programação ocorrer fora do nosso controle consciente, as reações nem sempre seguem uma lógica e, às vezes, nos levam a questionar nossa sanidade. No entanto, assim como não decidimos conscientemente retirar a mão de uma superfície quente, nosso corpo aciona essa programação de sobrevivência de modo automático, com a mesma naturalidade com que mantém nossos batimentos cardíacos e

nossa respiração estáveis.

Independentemente de um carro vir em nossa direção, como no caso de Elena, de termos nos sentido impotentes quando criança ou de enfrentarmos a dor insuportável de um divórcio ou de uma morte, nosso corpo passa pela mesma sequência. Os gatilhos podem diferir, sendo alguns emocionais e outros físicos, mas a experiência interna permanece a mesma.

AS CINCO ETAPAS DA RESPOSTA DO CORPO AO TRAUMA

1. O sobressalto

Um estado interno de hipervigilância

2. O estresse

Um estado interno de alta energia

3. O muro

Um estado interno de impotência

4. O congelamento

Um estado interno de paralisia

5. O apagão

Um estado interno de peso e opressão

É por isso que essas cinco etapas nos fornecem um mapa do nosso mundo interno, revelando não apenas como nosso corpo entra em modo de resposta ao trauma, mas também o caminho de volta ao equilíbrio, muitas vezes negligenciado. Mesmo que nosso corpo esteja guardando um trauma não resolvido há décadas, essas etapas serão o mapa para encontrar o caminho de volta à saúde, à plenitude e à autenticidade.

Este mapa, que nos ajuda a entender o propósito e a fisiologia de cada etapa, é tão poderoso que foi a última peça de que Miguel precisava para conseguir se abrir, construir um vínculo afetivo comigo e se sentir livre para dar e receber amor pela primeira vez, quando tinha 9 anos. No final deste capítulo, vou compartilhar com você o exercício de narrativa artística que

usamos com Miguel e que reflete essas mesmas etapas da resposta instintiva do corpo ao trauma.

Vamos analisar as cinco etapas e ver como cada uma delas é programada para cumprir uma função crucial para nossa sobrevivência.

Etapas 1: O sobressalto

Aquilo que se torna uma resposta ao trauma sempre começa com um sobressalto. Trata-se do momento em que percebemos pela primeira vez que algo está errado e da reação instintiva do corpo diante de uma ameaça *potencial*. Sua função é avaliar rapidamente se a provável ameaça é real, bem como sua magnitude, e gerar uma descarga de energia que funciona como um impulso inicial para o caso de precisarmos reagir.

Nossa fisiologia se adapta de várias maneiras para cumprir essa função.

Nossos sentidos se tornam hiperaguçados e recolhem rapidamente *todas* as informações sobre essa ameaça potencial: primeiramente o que vemos, ouvimos e sentimos, embora cheiros e sabores também façam parte dessa avaliação imediata. Nossa atenção se concentra unicamente em coletar dados para determinar se o perigo é real e, se for, qual é a dimensão dele.

Esse estado de alerta instantâneo é despertado pela noradrenalina, um hormônio relacionado à adrenalina que é armazenado previamente em nossos tecidos, onde fica à espera de um sinal para ser liberado. Quando liberada, a noradrenalina promove o sobressalto característico e nos põe em estado de alerta máximo, oferecendo uma breve janela de energia e lucidez aumentadas para avaliarmos a situação e tomarmos decisões.

Quando Elena ouviu os pneus derrapando, seu corpo entrou no modo resposta de sobressalto antes mesmo de ela processar conscientemente o som. Os olhos e ouvidos dela captaram tudo depressa, de modo que a resposta de sobressalto cumpriu seu papel. Logo se confirmou que a ameaça potencial (o som) era um perigo real: um carro vinha em sua direção. A resposta de sobressalto evoluiu para a etapa seguinte: a resposta ativa de estresse. Graças à resposta de sobressalto, seu corpo recebeu um impulso inicial, e ela agiu de imediato para evitar a batida com o outro carro.

Quando bloqueamos nossa avaliação instintiva de ameaças, o corpo interpreta isso como um sinal de perigo real e avança para a etapa seguinte,

por exemplo, evitando intencionalmente olhar para algo que nos causa sobressalto ou medo por temermos o que poderíamos ver. Stephanie Gorka, pesquisadora da Universidade Estadual de Ohio, estudou o papel da incerteza como fator que nos leva a avançar para a etapa de estresse, inclusive criando a chamada “ansiedade antecipatória”. Também é possível que nosso sistema nervoso tenha sido programado para perceber *tudo como uma ameaça real* ou para ser incapaz de travar nossa resposta de sobrevivência depois que o processo já foi iniciado com a etapa do sobressalto. Essa programação ocorre no primeiro ano de vida, algo que exploraremos mais a fundo no Capítulo 11.

Embora toda resposta ao trauma comece com essa avaliação inicial rápida de algo que parece errado, ter uma reação de sobressalto não é, por si só, ruim. Ficamos sobressaltados com qualquer coisa repentina, muito ruidosa ou inesperada, até mesmo quando uma criança salta de onde estava escondida para nos assustar. O sobressalto é apenas uma reação reflexa. Depois disso, é função do sistema nervoso avaliar rapidamente a situação e determinar se há um perigo real ou se podemos relaxar e voltar à sensação de segurança.

Pense nas vezes em que teve um sobressalto, talvez em resposta a um barulho alto, ao sentir o cheiro de comida queimada ou ao ouvir sua campainha tocar inesperadamente. É a resposta reflexa do seu corpo alertando-o para um possível perigo e dando um impulso inicial para a próxima etapa, o estresse, caso o perigo se confirme.

Etapa 2: O estresse

A função desta etapa é agir para vencer o perigo, o que requer um aumento imediato da energia. Enquanto o sobressalto serve como alerta inicial para avaliar se é preciso agir, a resposta de estresse é nossa única chance de superação. Embora essa resposta seja muitas vezes simplificada por meio da expressão “luta ou fuga”, a atividade invisível no nosso corpo é impressionante. Ele passa a gerar mais energia, canalizando-a *inteiramente* para agir no sentido de superar o risco. O sistema nervoso libera adrenalina, que alimenta esse estado de alta energia, como quando pisamos fundo no acelerador de um carro. O corpo inteiro coordena seus esforços com um

único objetivo: vencer o perigo.

Foi exatamente isso que aconteceu no corpo de Elena. No instante em que a resposta de sobressalto confirmou o perigo, o organismo dela foi inundado por uma onda de energia impulsionada pela adrenalina. O coração bateu mais rápido para fornecer mais oxigênio e nutrientes às principais células e gerar um pico de energia. As mãos agarraram o volante com uma força que ela não sabia ter. Ela agiu depressa, pisando no freio e girando o volante. O corpo inteiro se mobilizou de imediato para ajudá-la a vencer a ameaça. Tudo aconteceu muito rápido, antes que ela conseguisse analisar logicamente a situação e refletir sobre o que iria fazer.

Um equívoco comum sobre a resposta de estresse é a ideia de que ela pode se tornar prolongada ou crônica. Não: é como um sprint, ou tiros de corrida; ela é uma injeção de energia de alta intensidade e, portanto, de curto prazo. É possível trotar por bastante tempo, mas não podemos manter um sprint indefinidamente. Conhecer o mecanismo da nossa resposta de estresse é importante, pois ele determina o que acontece em seguida: nosso corpo precisa superar a ameaça ou mudar a estratégia de sobrevivência.

Todos já experimentamos um pico de energia como esse não só em momentos dramáticos como também no dia a dia – ao segurar uma criança antes que ela caísse, correr para cumprir um prazo urgente ou sair da frente de um carro que se aproxima. Em cada um desses casos, nosso corpo nos dá exatamente aquilo de que precisamos: energia imediata para agir. Quando tudo dá certo, nos sentimos aliviados e podemos relaxar, como um bombeiro depois de apagar um incêndio ou um velocista após cruzar a linha de chegada.

No entanto, algumas vezes, como no caso de Elena, nossos esforços não são suficientes. Assim como a resposta de sobressalto avança para a próxima etapa quando o perigo é confirmado, a resposta de estresse evolui quando o pico de energia não é páreo para a dimensão do perigo e os esforços em curso são inúteis.

Etapas 3: O muro

Ao contrário das outras etapas, o “muro” não é uma estratégia de sobrevivência: é o momento determinante que aciona a mudança no nosso

corpo para outro tipo de proteção. Saímos do estado de alta energia do estresse e nos deparamos com um muro que nos deixa impotentes. Para Elena, esse foi o momento em que, embora sua resposta ao estresse tivesse funcionado perfeitamente, ela percebeu que não conseguiria desviar do carro que vinha em sua direção. A colisão era inevitável.

Imagine que você encontra um cachorro enorme em um beco escuro à noite. Ele rosna, late e então avança em sua direção. A resposta de estresse é ativada perfeitamente: a adrenalina inunda o seu organismo e você corre mais rápido do que se achava capaz. Talvez até consiga escapar. Mas, quando vira à esquerda, se vê diante de um muro impossível de escalar. Você se sente encurralado. Não há mais nada a fazer.

O que cria o trauma, no entanto, não é o perigo em si nem o muro. A causa é a experiência interna de estar acuado e impotente diante de uma ameaça inescapável à própria vida. De acordo com Dr. Bessel van der Kolk, especialista em trauma: “O que constitui o trauma é a sensação de imobilidade diante de um acontecimento terrível.” Muitos especialistas chamam isso de “obstrução de movimento”, que ocorre quando os movimentos de autodefesa se tornam ineficazes. Nada do que fizermos mudará o cenário.

Os muros com que nos deparamos nem sempre são visíveis. Na maioria das vezes, são barreiras invisíveis que nos encurralam e, ao mesmo tempo, nos deixam impotentes. Crenças negativas a nosso respeito que tomamos como verdade podem ser tão intransponíveis quanto barreiras físicas; são tão reais quanto estas e provocam a mesma sensação de impotência, de estarmos acuados. Alguns dos muros invisíveis mais comuns são:

- Sermos condicionados durante a infância a acreditar que a raiva não é segura, o que nos impede de nos manifestar e nos defender.
- Uma crença arraigada de que não somos bons o suficiente, de modo que nem vale a pena tentar.
- O desamparo de ver uma pessoa amada sofrer sem que possamos ajudá-la.

Você se lembra de momentos da vida em que se sentiu impotente? Quando, mesmo se esforçando ao máximo, não foi suficiente? É útil reconhecer momentos como esses, em que nos deparamos com um muro,

pois eles mudam tudo. É o que faz o corpo trocar de estratégia de sobrevivência ao cruzar um limite de sobrecarga do qual, naquele momento, não há volta. Se as etapas anteriores tinham dois resultados possíveis – resolução ou intensificação –, o muro nos dá apenas uma possibilidade: avançar para o congelamento, a primeira etapa da resposta ao trauma propriamente dita.

Etapas 4: O congelamento

Com o muro assinalando nossa impotência, o corpo aciona sua estratégia de sobrevivência mais poderosa: o congelamento. Enquanto as etapas anteriores envolvem energia, movimento e ação, o congelamento marca nossa entrada na resposta ao trauma: uma forma fundamentalmente distinta de sobreviver quando a ação se torna impossível. Muitos confundem essa imobilidade com fraqueza passiva, mas o congelamento é, na verdade, o mecanismo de sobrevivência mais forte do corpo, sobrepujando tanto o pico de energia causado pela adrenalina quanto o pensamento lógico.

A sabedoria do congelamento como estratégia de sobrevivência está no seu propósito de interromper movimentos e ações que, naquele momento, nos colocam mais em perigo do que nos ajudam. Como um disjuntor que corta a energia para evitar danos ao sistema, o congelamento é a forma de o corpo mudar a estratégia de sobrevivência da ação heroica para a paralisia estratégica.

O que acontece no corpo durante esse congelamento é extraordinário. O Dr. Peter Levine, fundador da abordagem terapêutica Experiência Somática, descreve como os músculos se retesam, prendendo toda a energia da resposta de estresse anterior dentro do corpo. Ficamos literalmente “petrificados de medo”, com o corpo congelado em estado de choque diante do inimaginável.

O corpo de Elena entrou em resposta de congelamento. Por uma fração de segundo, ao perceber que o impacto era inescapável, ela congelou, observando o carro avançar em sua direção. O tempo pareceu desacelerar; seu corpo travou, parando de tentar escapar ao inevitável. Ela inspirou fundo, prendendo a respiração, enquanto o choque da impotência daquele momento assumia o controle.

Ela congelou não por escolha própria, por fraqueza ou por alguma espécie de falha, mas porque seu corpo decidiu que a inação e o apagão eram sua melhor chance de sobreviver. O congelamento é a etapa de transição entre o muro e o estado de apagão.

É possível que você reconheça momentos da sua vida em que se sentiu congelado por dentro. Talvez quando criança, ao ver uma briga entre seus pais sem poder fazer nada para impedi-la. Talvez hoje você tenha uma sensação de paralisia diante de um conflito no trabalho ou em casa. Talvez tenha tido experiências sexuais difíceis no passado e agora congele nos momentos de intimidade com um parceiro carinhoso. Ou talvez congele por dentro quando se vê no centro das atenções, como se mal conseguisse respirar. Embora as experiências variem enormemente, há um padrão interno comum: o choque sentido pelo corpo quando percebemos que estamos encurralados, impotentes e sozinhos.

O corpo, porém, não pode permanecer nesse estado de choque extremo para sempre. A pressão interna intensa do congelamento, ou seja, toda aquela energia e choque contidos, leva o nosso corpo a avançar para a etapa protetora final: o apagão.

Etapa 5: O apagão

A estratégia de sobrevivência do apagão é clara: “Não morra; mantenha-se minimamente vivo.” O apagão é a resposta do corpo ao que o Dr. Bessel van der Kolk define como trauma: uma experiência que parece “*esmagadora, inacreditável e insuportável*”. É natural que o corpo sofra um apagão diante de algo assim. Do mesmo modo que outros mamíferos congelam e apagam quando se sentem encurralados e impotentes, nosso corpo age segundo uma sabedoria ancestral: *talvez, se eu me fingir de morto, a ameaça vá embora*.

O apagão nos ajuda a sobreviver a experiências devastadoras ativando três mecanismos de sobrevivência ao trauma: dissociação, imobilização e conservação de energia. Isso cria um distanciamento mental e emocional de sensações que parecem insuportáveis, ajudando-nos a preservar energia em vez de consumi-la. Esses mecanismos de sobrevivência, que exploraremos mais a fundo no Capítulo 6, explicam por que Elena se sentiu desconectada do próprio corpo e das pessoas à sua volta após a batida; por que se sentiu

pesada e com frio; e por que até mesmo tarefas básicas, como falar, lhe pareceram difíceis.

Embora a estratégia de sobrevivência em si seja simples, manejar nossa fisiologia para não morrer e continuar minimamente vivo é uma tarefa complexa. Após a inspiração profunda do congelamento, soltamos a respiração, que se torna lenta e superficial, às vezes até irregular, suficiente apenas para nos fornecer a quantidade de oxigênio necessária para sobreviver. As pessoas à nossa volta talvez nos digam que devemos respirar. Podemos sentir vontade de nos encolher em posição fetal. Tudo que custe energia, até mesmo falar, parece difícil. Podemos nos sentir desorientados, como se tivéssemos perdido completamente a sensação de segurança, sem saber se vamos ficar bem. No íntimo, nos sentimos sozinhos e desamparados.

Talvez você identifique momentos em que seu corpo sofreu um apagão como resposta ao trauma. Provavelmente já descreveu essa sensação como “desconectar”, “ficar anestesiado” ou “entrar no piloto automático”. Compreender que essa é uma estratégia sofisticada de sobrevivência pode ajudar a mudar a forma como você enxerga essas experiências.

O apagão é a etapa final da sequência universal e instintiva do trauma no corpo. Ele mostra que nosso organismo possui uma incrível resiliência inata para sobreviver, mesmo quando para isso precisa “se desligar”. Seu corpo sabe exatamente o que está fazendo, ainda que sua mente tenha dificuldade em compreender a experiência e a resposta do próprio corpo. É por isso que quero voltar à pergunta de Elena e propor um exercício que pode ser muito útil para ajudar mente e corpo a encontrar uma resposta a um trauma do passado.

ISSO FUNCIONA COM MEU TIPO ESPECÍFICO DE TRAUMA?

Vamos retomar a pergunta inicial de Elena: “O seu programa funciona com meu tipo específico de trauma?” Agora que temos o mapa da resposta universal e instintiva do corpo ao trauma, fica mais fácil responder a esse questionamento.

As etapas que analisamos revelam que o trauma não é o que acontece

conosco, mas sim o que ocorre dentro de nós quando nos sentimos encurralados e impotentes. Identificar essas etapas lança uma nova luz em momentos da nossa vida que talvez tenhamos subestimado como “apenas estresse”, nos permitindo entender a influência que tiveram sobre nosso corpo quando nos vimos diante de um acontecimento inescapável ou de algo que não podíamos mudar. Proponho um exercício poderoso para reprogramar essa crença e registrar um trauma como um evento que pertence ao passado, tanto para o cérebro quanto para o corpo. Assim como no caso de Miguel, esse exercício pode desfazer o impacto que o trauma ainda exerce sobre nós.

UMA JORNADA CÉREBRO-CORPO: CONCLUINDO SUA HISTÓRIA DE RESPOSTA AO TRAUMA

Uma das formas mais eficazes de ajudar o seu corpo a reconhecer que uma experiência passada terminou e que agora você está em segurança é escrever a história dessa vivência e dar a ela um desfecho em que o perigo já tenha passado. No intuito de que a narrativa faça sentido para o cérebro e soe verdadeira para o corpo, invocamos cada uma das etapas, identificando a experiência interna do corpo ao longo dos estados de sobressalto, estresse, muro, congelamento e apagão. Incorporamos todos os elementos sensoriais do que vimos, ouvimos, cheiramos e sentimos. Invocamos também as sensações internas em cada uma dessas etapas. E, o que é mais importante, narramos a história em terceira pessoa, identificando cada personagem (especialmente a nós mesmos) com seus nomes reais. Isso nos permite permanecer no momento presente como “eu” e não estar dentro da história.

Em seguida, devemos invocar um momento posterior a essa experiência, mesmo que seja anos depois (ou agora, no presente), em que nos sintamos em segurança. Esse exercício de narrativa artística ativa os hemisférios direito e esquerdo do cérebro à medida que somos guiados pelo que teria sido a experiência interna do corpo. É uma forma de trabalhar tanto com as memórias lineares quanto com as memórias sensoriais fragmentadas. Isso ajuda a “ligar os pontos” do que o cérebro ainda entende como uma história inacabada. Usar as cinco etapas em uma narrativa estruturada para encerrar uma história específica do passado é algo muito poderoso para o cérebro.

Foi dessa peça final que Miguel precisou para sair do modo sobrevivência e finalmente conseguir se abrir e se conectar comigo.

Hoje, oriento outras pessoas a realizar esse processo nos meus workshops, além de ensiná-lo a profissionais da área da saúde no meu programa de Biologia do Trauma. Mesmo que tenha apenas o conhecimento sobre a resposta instintiva do corpo ao trauma e cada uma de suas etapas, você conseguirá aplicá-lo de um jeito muito prático e útil. As instruções detalhadas, passo a passo, estão disponíveis no endereço BiologyofTrauma.com/book [em inglês], além de um vídeo que explica todo o processo. Essas diretrizes ajudarão você a explorar um momento do seu passado em que o corpo passou por essas cinco etapas de um modo que protegeu o seu sistema nervoso.

No entanto, ainda que eu incentive você a explorar esse processo, quero fazer uma observação importante sobre como devemos conduzir qualquer trabalho interno daqui por diante. É muito fácil nos traumatizarmos novamente durante o processo de desenvolvimento pessoal ou da terapia do trauma. Não quero que o exercício de narrativa lhe cause sobrecarga emocional. Sempre que passamos por uma sobrecarga, nosso corpo reforça as estratégias de sobrevivência de congelamento e apagão. Esse trabalho interno será estressante, portanto, não devemos ir além daquilo que conseguimos suportar. Evitar a sobrecarga é fundamental à medida que começamos a usar o mapa que acabamos de adquirir para navegar de modo diferente pelo nosso mundo interior.

Digo isso porque, quando Elena começou a reconhecer os traumas armazenados no próprio corpo, ela teve vontade de mergulhar na terapia e “resolver tudo de uma vez”. Mas ela ainda precisava aprender a diferença entre estresse e sobrecarga de modo a permanecer em sua zona de crescimento durante a terapia e não se traumatizar novamente, por mais que tivesse boas intenções. Nosso corpo faz uma distinção clara entre estresse e trauma por meio de um “limite crítico de sobrecarga”, que exploraremos no próximo capítulo, junto com as duas razões que nos levam a ultrapassar esse limite.

RESUMO

O gatilho específico – seja um acidente de carro, a perda de um ente querido ou dinâmicas familiares caóticas na infância – importa menos do que a experiência interna comum a todos: as cinco etapas sequenciais que nosso corpo percorre, cada uma com sua função específica, do sobressalto ao apagão. Essas etapas nos fornecem o mapa da nossa programação instintiva de sobrevivência, que é mais forte que nossa lógica e nosso controle consciente. Ele nos permite compreender que as respostas do corpo têm o propósito de nos proteger, mesmo quando a mente não as percebe dessa forma.

Outro benefício de compreender esse mapa é perceber que somos mais parecidos uns com os outros do que diferentes. Curiosamente, quando nosso corpo entra em modo de resposta ao trauma, nós nos sentimos completamente sozinhos; no entanto, essa resposta instintiva universal é o que nos torna vivos, humanos e iguais a todas as outras pessoas.

Conhecer as cinco etapas é essencial, mas, para mudarmos nossas respostas e reações, isso não basta. Também precisamos compreender os dois motivos que levam o corpo a se sentir impotente e a linha crítica de sobrecarga que ele acaba ultrapassando.

CAPÍTULO 2

A diferença entre estresse e trauma

Eu não sou preguiçosa. Só estou exausta de ter que lutar todos os dias.

– Mimi Love

“**E**u faço tudo certo, mas meu corpo não colabora.” A voz de Claire embargou ao contar por que acabara de se inscrever em mais um programa de exercícios on-line. Ex-maratonista que os amigos chamavam de “coelhinho da Duracell”, ela sempre havia encarado a vida com uma disposição incansável. Até que, um dia, simplesmente não conseguiu mais.

Nove anos após sua segunda gravidez, Claire começou a perceber um cansaço crescente. Mas, fiel à sua maneira de lidar com os desafios, tentou passar por cima disso: aumentou o consumo de cafeína e procurou maneiras de se manter alerta, acreditando que em algum momento sua energia natural voltaria. Quando o cansaço constante finalmente a impediu de manter suas atividades, ela decidiu procurar um médico. Seus exames, no entanto, não revelaram nenhuma causa para a fadiga. Havia algumas pequenas alterações, mas nada fora dos parâmetros a ponto de ser considerado relevante. Ela foi diagnosticada com síndrome da fadiga crônica e orientada a administrar melhor o estresse, algo que já vinha tentando fazer, sem resultado.

Claire passou a investir a pouca energia que lhe restava em cursos e certificações no campo do desenvolvimento pessoal. Por conta de seus níveis de energia imprevisíveis e das oscilações de humor causadas pelas crises de

fadiga, ela achava difícil manter um emprego em tempo integral. Então, com a ajuda do marido, Mark, passou a ministrar cursos de mindset, meditação e respiração, áreas nas quais se tornara uma especialista. Ainda assim, nada disso parecia suficiente, e sua busca desesperada por respostas continuou levando-a a mais e mais cursos, tratamentos e terapias.

Quando conheceu meu programa da Biologia do Trauma, Claire não estava buscando uma cura para o trauma. Na verdade, nem sequer acreditava ter passado por uma experiência traumática. Estava em busca de respostas para sua fadiga. No íntimo, Claire às vezes achava que era um caso perdido. Como alguém que entendia tanto sobre bem-estar podia se sentir tão mal? Tudo o que ela queria era que o cansaço desaparecesse.

O que ela não percebia era a mensagem que seu corpo tentava comunicar: uma mensagem de sobrecarga que explicava não apenas sua fadiga, mas também a ansiedade pós-parto, as oscilações de humor e os problemas digestivos que tolerava, mas não conseguia resolver. Quando começou sua Jornada Estruturante, um programa de seis semanas conduzido por mim para acessar com segurança traumas antigos, Claire finalmente conseguiu ouvir a mensagem do próprio corpo. A fadiga era uma manifestação do estado de apagão. Seu corpo não estava apenas sob estresse, mas sim em uma resposta ao trauma por ter cruzado o limite crítico da sobrecarga.

O LIMITE CRÍTICO DA SOBRECARGA

Todo corpo tem um limite: um ponto exato em que o crescimento se transforma em sobrecarga, em que o desafio se torna excessivo e o estresse se converte em trauma. Como cirurgiã, meu primeiro contato com esse limite foi em uma sala de cirurgia. Todo tecido tem seu ponto de ruptura.

Kenneth foi o primeiro paciente em que precisei realizar uma cirurgia de bíceps no hospital de veteranos durante minha residência. Aquela manhã na academia havia começado como qualquer outra para ele. Ao iniciar sua rotina habitual de musculação, Kenneth decidiu pegar um pouco mais pesado. *Hora de aumentar o nível*, pensou ele.

As primeiras repetições foram boas: desafiadoras, mas nada que ele não aguentasse. Até que ouviu um estalo alto, e o peso despencou do seu braço

direito. Ao olhar para baixo, Kenneth viu o bíceps amontoado no meio do braço, totalmente solto do ombro ao qual deveria estar conectado. Ele havia forçado seus músculos de tal forma que, em vez de fazê-los crescer, acabou por rompê-los.

Assim como o bíceps de Kenneth tinha um ponto exato de ruptura, nosso corpo também possui uma linha precisa entre o que nos faz crescer e o que nos quebra. Um limite crítico de sobrecarga marca a diferença entre o estresse e o trauma. **O estresse nos energiza, ao passo que o trauma nos esgota.** Quando permanecemos do lado do estresse, os desafios nos fortalecem. Mas, quando cruzamos para o lado da sobrecarga, já não é possível crescer.

Essa linha conversa com as cinco etapas da resposta do corpo ao trauma, apresentadas no capítulo anterior. As respostas universais de sobressalto e de estresse ocorrem do lado do crescimento, quando ainda temos capacidade de reagir de forma efetiva. Mas, quando batemos no muro e nos sentimos impotentes, cruzamos o limite crítico da sobrecarga, entrando nas etapas de congelamento e apagão.

Durante meus anos de prática clínica, eu percebia a diferença entre o lado do crescimento e o lado da sobrecarga nas palavras que meus pacientes usavam. Alguns chegavam perguntando: “Como podemos resolver isso?” Eles ainda estavam do lado do crescimento, em que a resposta de estresse lhes dava energia para agir. Outros começavam dizendo: “Não aguento mais.” Esses já haviam cruzado para o lado da sobrecarga, e sua energia tinha sido drenada pelo trauma. Como médica e pesquisadora, o que me fascinava era notar a constância com que essa distinção previa o grau dos sintomas e a resposta ao tratamento. Quanto maior a sobrecarga, piores os sintomas e menos eficaz era o tratamento.

Compreender essa linha em nós mesmos é fundamental se quisermos mudanças positivas em nossa vida, nos relacionamentos e na saúde. Quando percebeu que a fadiga crônica era um sinal de que seu corpo estava cruzando o limite crítico da sobrecarga, Claire entendeu por que as técnicas de gerenciamento do estresse que aprendera não funcionavam. Ela precisava saber por que seu corpo estava atravessando essa linha, pois só então poderia usar ferramentas mais acertadas.

Por que cruzamos o limite crítico

Nosso corpo cruza o limite crítico da sobrecarga por duas razões: ou porque algo *foi muita coisa em pouco tempo*, ou porque foi *pouca coisa por muito tempo*.

Imagine-se segurando uma pedra pesada acima da cabeça. Seus músculos tensionam, ativando a resposta de estresse para enfrentar o desafio. Enquanto você consegue mantê-la no lugar, seu corpo permanece no estágio de pico de energia, superando o estresse do peso. Mas, no momento em que já não consegue mais segurá-la, sua fisiologia interna muda. Não é mais possível manter a pedra sobre sua cabeça com segurança, e ela desaba sobre você.

Essa pedra pode esmagá-lo por duas razões, da mesma forma que qualquer coisa na vida pode tanto nos fortalecer quanto nos destruir. A primeira é que foi muita coisa em pouco tempo. Como desde o início a pedra era pesada demais para você, o esforço foi mais rápido e mais intenso do que deveria. Sem tempo suficiente para se preparar, você não teve forças para segurá-la por mais tempo, o que levou seu corpo a cruzar o limite crítico da sobrecarga.



A segunda razão é ter sido pouca coisa por muito tempo. Nesse cenário, a pedra não é pesada demais no início, mas você não tem permissão para descansar nem por um segundo. Sem alívio, o peso acabará se tornando insuportável, o que também levará seu corpo a cruzar o limite crítico da sobrecarga.

Não importa se cruzamos esse limite porque foi muita coisa em pouco tempo ou pouca coisa por muito tempo: ambos resultam na experiência interna de impotência, que é a Etapa 3 da resposta instintiva ao trauma, e nosso corpo avança para as fases de congelamento e apagão. É importante compreender bem essas duas razões que geram uma sensação de impotência e nos fazem cruzar o limite crítico da sobrecarga. Vamos analisá-las mais de perto.

Muita coisa em pouco tempo

Quando se vê diante de desafios, nosso corpo precisa de tempo para processar e responder a eles. Quanto mais tempo temos, mais somos capazes de nos adaptar e superá-los. Se acontece muita coisa em pouco tempo, deixamos de ter esse intervalo ideal para reagir. O resultado é que até problemas do dia a dia podem nos fazer cruzar o limite crítico da sobrecarga.

Considere o caso de Elena: com mais tempo, ela talvez tivesse conseguido desviar do carro que vinha na sua direção e o episódio teria sido apenas um estresse do qual poderia se recuperar. Porém, como não teve tempo suficiente, o que aconteceu foi uma resposta ao trauma que desencadeou uma doença autoimune. Foi algo grande demais, rápido demais.

E não são apenas experiências que duram alguns segundos que são consideradas muita coisa em pouco tempo. Esse fenômeno pode se estender por períodos mais longos. Diversas pessoas chegam ao meu programa descrevendo experiências desse tipo que ocorreram ao longo de meses. Algumas perderam vários entes queridos no mesmo ano. Outras tiveram sua casa destruída por um desastre natural logo depois de ficarem desempregadas. Conseguimos lidar com um revés de cada vez em nossa vida, mas, quando eles vêm um atrás do outro, quase sem respiro, pode ser

muita coisa em pouco tempo.

O tempo é um recurso que raramente temos. Na correria da vida moderna, nossos problemas podem parecer ainda maiores. Precisamos de espaço para pensar e respirar. Precisamos de momentos ociosos, para nos recuperarmos entre um desafio e outro. A falta desse tempo pode fazer com que o estresse cruze o limite crítico e se torne sobrecarga.

No entanto, não só eventos externos têm a capacidade de nos fazer cruzar esse limite. Podemos ser tomados por emoções que parecem grandes demais para suportar. Como aconteceu com Claire, quando acessamos muito depressa emoções armazenadas, seja por meio da terapia, da respiração consciente ou de outras práticas de cura, nosso organismo tende a ficar sobrecarregado; é simplesmente muita coisa em pouco tempo para processarmos. Muitos chegam ao meu programa achando que podem fazer mais atividades e ir mais depressa para terminar logo, mas acabam descobrindo que, quando emoções e memórias submersas vêm à tona, aquilo pode se tornar muita coisa em pouco tempo. Nossa cura emocional tem seu próprio ritmo, e ele precisa ser respeitado para não cruzarmos o limite crítico da sobrecarga.

Pouca coisa por muito tempo

A segunda forma de cruzarmos o limite crítico da sobrecarga é mais sutil e muitas vezes passa despercebida até já estarmos no estado de apagão. Como contou Katie, uma participante do meu programa: “Descobri que muitas vezes o apagão acontece por eu ignorar os sinais que meu corpo dá, alguns sutis, outros nem tanto, até o ponto em que simplesmente não aguento mais. Parece que é de repente, mas não é bem assim.” O que ela descreve é exatamente a dinâmica de pouca coisa por muito tempo: uma progressão gradual rumo à sobrecarga que parece súbita apenas porque ignoramos os sinais de alerta que se acumularam ao longo do tempo.

A trajetória de Claire ilustra bem como a razão para sua sobrecarga foi pouca coisa por muito tempo. No início da segunda gestação ela já estava esgotada, com deficiências nutricionais que ignorava, um excesso de cobre que causava neurotoxicidade e danos não resolvidos em seu sistema de desintoxicação por conta de uma exposição anterior a mofo. Seu corpo deu

tudo o que tinha para gerar e manter uma nova vida durante nove meses, mas, sem a reposição adequada e sem apoio, ela acabou por cruzar o limite crítico da sobrecarga.

A experiência de pouca coisa por muito tempo também se manifesta no campo emocional. Vemos isso claramente nos casos de negligência emocional infantil, quando uma criança não recebe de maneira constante o afeto e o cuidado necessários. Enquanto o abuso representa muita coisa em pouco tempo, a negligência exemplifica a dinâmica gradual de pouca coisa por muito tempo. Conhecidos como “filhos da negligência”, esses indivíduos sofrem adaptações físicas por causa da recorrência das respostas traumáticas causadas pela sobrecarga. O sistema de assistência à infância dos Estados Unidos relata que 75% dos casos de maus-tratos infantis estão relacionados à negligência, e não propriamente ao abuso, o que evidencia como esse padrão de esgotamento é comum.

A psicoterapeuta e educadora Ruth Cohn há anos estuda crianças vítimas de negligência. Segundo ela: “Muitas vezes, o trauma do desenvolvimento causado pela negligência na infância, que é um dos mais devastadores, parece não ser ‘nada’. Ele não deixa cicatrizes visíveis no corpo e geralmente ocorre muito antes de o cérebro desenvolver a capacidade de registrar os acontecimentos de forma autobiográfica. Por isso, fica ‘gravado’ como memória sensorial, emocional e somática.”

Se não for reparada, essa memória, codificada como uma ou várias feridas de apego, conforme veremos no Capítulo 11, acompanhará a pessoa nos relacionamentos da fase adulta. Muitos casamentos acabam se tornando exemplos de pouca coisa por muito tempo na conexão emocional, com o afeto e a intimidade sendo lentamente corroídos. Os índices de divórcio e os milhões de visualizações de palestras TEDx sobre casamento sem sexo são reflexos dessa negligência emocional que nos sobrecarrega pela ausência de algo essencial.

O que nos leva a um ponto importante sobre o que pode ser pouca coisa por muito tempo. Não é um único acontecimento que nos faz cruzar o limite, como pode ocorrer no cenário de muita coisa em pouco tempo; é o fato de nossas necessidades não serem atendidas continuamente que se torna mais do que podemos suportar. Não se trata de um desentendimento pontual com um filho ou parceiro, mas sim de algo que vira um padrão persistente e crônico.

No caso de Claire, o corpo dela vinha enviando sinais (ansiedade, oscilações de humor e problemas digestivos) muito antes de a fadiga crônica se manifestar. Ela havia passado tempo demais carregando sua pedra metafórica, sem se permitir o descanso, a recuperação e a reposição necessários para sustentar o peso. O problema não era que os desafios da vida tinham se tornado excessivos, mas o fato de que sua capacidade de enfrentá-los havia se esgotado aos poucos, corroída pelo desgaste acumulado. Mesmo um peso que inicialmente parecia administrável torna-se uma sobrecarga quando ignoramos de maneira crônica as necessidades físicas e emocionais do corpo.

A combinação

Quando chegam ao meu programa, as pessoas muitas vezes percebem que os dois padrões estão presentes na vida delas: o de muita coisa em pouco tempo sobreposto ao de pouca coisa por muito tempo. A experiência de Claire ilustra perfeitamente essa combinação. Embora sua fadiga crônica tenha se desenvolvido com o desgaste gradual de pouca coisa por muito tempo, seu corpo agora reagia a qualquer aumento repentino na demanda como sendo muita coisa em pouco tempo.

Até mesmo a atividade física podia facilmente se tornar muita coisa em pouco tempo. Outro exemplo: quando ela marcava clientes demais no mesmo dia e um deles ficava irritado e exigia um reembolso ou quando tinha uma sessão intensa de terapia sobre questões familiares da infância, seu corpo, que já estava desgastado, considerava isso uma sobrecarga.

A história de Elena revela essa combinação sob outra perspectiva. Embora o acidente de carro seja um exemplo evidente de muita coisa em pouco tempo, na época seu corpo já carregava os efeitos de pouca coisa por muito tempo. A doença autoimune que surgiu um ano depois da batida refletia não só o trauma agudo daquele momento, mas o impacto combinado dos dois padrões. Seu sistema imunológico, já comprometido pelo desgaste crônico, não conseguiu manter o equilíbrio diante daquele estresse agudo e esmagador.

Assim como Claire e Elena, quando chegamos à vida adulta, nossas respostas ao trauma raramente surgem de um único padrão. Há exceções,

mas a razão mais comum para elas é quando anos de desgaste sutil criam uma base de pouca coisa por muito tempo de modo que até pequenos estressores passam a parecer muita coisa em pouco tempo.

O ESTRESSE PODE SER UMA COISA BOA?

O estresse não é o vilão que costumamos imaginar; na verdade, ele é um dos maiores trunfos do corpo humano. O mito de que o estresse faz mal se perpetuou sem qualquer base científica sólida. As evidências indicam justamente o contrário. No livro *Auge do desempenho*, Brad Stulberg e Steve Magness resumem as descobertas científicas da seguinte forma: estresse + descanso = crescimento. Seja nos esportes, nos estudos ou nos desafios da vida, o estresse seguido de recuperação nos fortalece.

A fisiologia do estresse nos dá a energia necessária para lutar pelo que importa, proteger o que amamos, sobreviver a perigos reais e realizar feitos extraordinários. Um grande exemplo disso é uma das heroínas da minha infância, Harriet Tubman. Harriet, que nasceu escravizada, era uma mulher miúda e analfabeta, que ainda por cima sofria desmaios frequentes por causa de uma lesão na cabeça. Apesar de tudo, ela usou sua resposta de estresse para alcançar o que parecia impossível. Conduziu dezenas de pessoas escravizadas à liberdade por meio da Underground Railroad (rede secreta de rotas de fuga e esconderijos) e, mais tarde, tornou-se a primeira mulher a liderar tropas em batalha durante a Guerra de Secessão. Sua resposta de estresse, em vez de ser controlada ou reduzida por meio do autocuidado, foi justamente a força que lhe permitiu mudar a história.

O verdadeiro dano está em não nos recuperarmos após o estresse e em confundirmos trauma com estresse; ou seja, errar o “diagnóstico” e, consequentemente, aplicar o tratamento inadequado. Assim como os atletas precisam distinguir entre o estresse que promove crescimento e o excesso de treino que causa lesões, também precisamos reconhecer quando nosso corpo cruza o limite crítico da sobrecarga.

Quando confundimos trauma com estresse

Como médica, sempre confiei na minha capacidade de diagnosticar corretamente o problema para prescrever o tratamento adequado. Quando Kenneth chegou à emergência com a lesão no bíceps, o diagnóstico preciso nos permitiu oferecer o tratamento mais eficaz. Se ele tivesse apenas distendido o músculo, sem rompê-lo completamente, a cirurgia não só teria sido desnecessária como também prejudicial. Mas, com o diagnóstico preciso de um tendão rompido, era fundamental que ele fosse operado.

Da mesma forma, se eu prescrevesse apenas antitérmico a um paciente com febre, ignorando um abscesso interno grave, isso não seria apenas ineficaz, mas perigoso. O abscesso oculto continuaria crescendo e se agravando. Esse mesmo princípio se aplica quando confundimos trauma com estresse. Além de usarmos ferramentas ineficazes, permitimos que a condição subjacente piore.

Termos como “estresse crônico” e “burnout” descrevem a etapa de apagão da resposta ao trauma. Quando classificamos a experiência de uma pessoa como estresse, mesmo depois de ela ter cruzado o limite crítico da sobrecarga, é como se subestimássemos a gravidade do seu estado interno. Assim como prescrever antitérmico para um abscesso, aplicar técnicas de gerenciamento do estresse em estados de trauma pode deixar a condição subjacente sem tratamento. Quando fazemos isso, permitimos que o trauma interno cresça por mais tempo, tornando o processo de cura ainda mais difícil.

Esse equívoco não ocorre apenas nos consultórios médicos, mas também em nossa própria mente. Como Claire, muitas vezes minimizamos nossas experiências chamando-as de “apenas estresse”, dizendo a nós mesmos para “aguentar firme”, mesmo quando nosso corpo está prestes a cruzar (ou já cruzou) o limite crítico da sobrecarga. Esse tipo de negação deixa o corpo sem a compreensão e o suporte de que precisa, intensificando a experiência de pouca coisa por muito tempo.

As consequências desse erro de diagnóstico podem ser profundas. Como Claire, muitos pacientes passam anos sem respostas precisas para seus problemas de saúde, recebendo apenas recomendações para reduzir o estresse. Ela tentava “gerenciar” o estresse com meditação e respiração, quando, na verdade, seu corpo precisava de ajuda para sair da resposta ao

trauma. O corpo de Elena contava uma história parecida: sua doença autoimune surgiu um ano após o acidente de carro porque nem ela nem seus médicos perceberam que ela estava sob um estado constante de sobrecarga. Essas histórias mostram a frequência com que tendemos a minimizar o trauma chamando-o de estresse e privando nosso corpo dos recursos corretos para a cura.

Quando o corpo ultrapassa o limite crítico da sobrecarga e entra em estado de apagão, não basta apenas administrar o estresse. Tentar lidar com o trauma usando técnicas de gerenciamento do estresse é como tratar o tendão rompido de Kenneth somente com gelo e repouso. Isso pode até aliviar a dor temporariamente, mas a lesão em si não será regenerada. Um corpo traumatizado requer ferramentas e abordagens específicas para tratar a origem do problema e permitir a cura. É por isso que tanto Claire quanto Elena precisavam de algo além de técnicas de gerenciamento do estresse. Elas precisavam de recursos desenvolvidos especialmente para lidar de maneira segura com o trauma.

TORNANDO-SE ESPECIALISTA NO PRÓPRIO CORPO

Talvez você já tenha buscado a ajuda de profissionais da área médica ou da saúde mental que não reconheceram seu estado interno e acabaram prescrevendo o tratamento errado. Talvez tenham lhe oferecido técnicas de gerenciamento do estresse quando, na verdade, você precisava de ferramentas para lidar com o trauma subjacente. Isso é muito comum, já que essa ciência não faz parte da nossa formação médica. Até compreender as etapas e o limite crítico da sobrecarga por meio das minhas próprias experiências e de capacitação complementar, eu mesma prescrevi técnicas de redução de estresse para o que hoje reconheço serem respostas de trauma.

Embora a maioria dos profissionais da área da saúde ainda não entenda a ciência do estresse e a biologia do trauma, minha intenção não é desanimar você, mas oferecer uma nova perspectiva que transforma qualquer pessoa em uma especialista no próprio corpo. Pense por um momento na sua própria vida: nos períodos em que se sentiu sob pressão, mas capaz de

resistir, e naqueles em que se sentiu esmagado e sem forças. Essas são experiências internas, não eventos externos, e ninguém pode discernir melhor que você o seu estado interior. Em vez de depender de outra pessoa para avaliar o que se passa dentro de você, é possível tornar-se especialista no seu próprio corpo e identificar quando você está em um estado de estresse ou de trauma.

Pensando nisso, criei um “diário do sistema nervoso”, que uso com todos os participantes do meu programa de coaching em saúde sobre a Biologia do Trauma. Por meio dele, você poderá acompanhar seus estados internos ao longo do dia, aprendendo a distinguir as respostas de estresse das respostas de trauma no seu corpo. Você pode fazer o download desse material e assistir a um vídeo explicativo em BiologyofTrauma.com/book [em inglês].

Sobrecarga ou trauma?

Durante o treinamento sobre a Biologia do Trauma, Claire aprendeu sobre o limite crítico da sobrecarga. Foi então que ela se deu conta de quantas vezes tinha vivido situações de trauma, confundindo-as com estresse. Ela havia trabalhado por mais de dez anos como policial em uma das cidades mais perigosas dos Estados Unidos. Testemunhou colegas morrerem em serviço, sobreviveu a um grave acidente de carro e viveu com a família em meio a gangues violentas. Sempre resistira a usar a palavra “trauma” para si mesma, achando que se aplicava apenas a vítimas de crimes brutais ou a soldados na linha de frente. Apesar da natureza do seu trabalho, nunca sentira que isso se aplicava a ela. *Isso é só a vida como ela é, pensava Claire. Não é trauma.*

Muitas vezes, nós também subestimamos nossas experiências e deixamos de perceber os sinais de que nosso corpo já cruzou o limite da sobrecarga. Também é comum sentirmos resistência à palavra “trauma”. Se esse for o seu caso, você não está só. Se preferir, use o termo “sobrecarga”. O que importa não é a terminologia, mas reconhecer quando o seu corpo cruzou o limite crítico da sobrecarga e precisa de ferramentas diferentes das técnicas de gerenciamento do estresse.

Mas o que determina onde esse limite crítico se situa em cada um de nós? No próximo capítulo, vamos explorar como nosso sistema nervoso

avalia constantemente segurança e perigo por meio de um processo chamado neurocepção, que define exatamente onde está o nosso limite crítico da sobrecarga a cada momento.

RESUMO

Neste capítulo, vimos que o que separa o estresse do trauma não é o evento em si, mas uma linha interna do nosso corpo, o limite crítico da sobrecarga. É essa linha que determina se uma experiência nos fortalece ou nos quebra – ou seja, se ela se torna uma fonte de crescimento ou de sobrecarga.

Vimos também que essa linha pode ser cruzada de duas formas: com muita coisa em pouco tempo – como no acidente de carro de Elena ou na ruptura repentina do bíceps de Kenneth – ou com pouca coisa por muito tempo, como no esgotamento gradual de Claire que levou à fadiga crônica. Muitas vezes, quando chegamos à vida adulta, já estamos vivenciando as duas coisas ao mesmo tempo: episódios de muita coisa em pouco tempo sobre uma base construída com pouca coisa por muito tempo.

Compreender esse limite muda tudo na forma como enxergamos e lidamos com o estresse e o trauma no corpo. Quer você prefira usar a palavra “sobrecarga” ou “trauma”, o que importa é a experiência interna de cruzar esse limite crítico, entrando na zona que nos quebra em vez de nos fortalecer. Convido você a baixar o diário do sistema nervoso, que o ajudará a acompanhar seus estados internos ao longo do dia e perceber quanto tempo você passa em cada um deles. O material está disponível, junto com um vídeo explicativo, em BiologyofTrauma.com/book [em inglês].

A resposta ao trauma não é algo “ruim”; ela faz parte do nosso programa instintivo universal de sobrevivência quando cruzamos o limite crítico da sobrecarga. Parte do processo de cura é mudar a forma como falamos com nós mesmos, deixando de rotular nossas experiências ou estados internos como “bons” ou “ruins”. O segredo está em nos tornarmos especialistas no nosso próprio mundo interno e reconhecermos em que estado estamos, de modo que possamos reagir com as ferramentas certas.

Identificar o estado em que nos encontramos não é algo que devemos fazer só de vez em quando. Como veremos no próximo capítulo, nosso limite crítico da sobrecarga muda de uma hora para outra. Algo que em um

momento geraria apenas uma resposta de estresse pode, em outro, nos empurrar para uma resposta de trauma. Essa percepção ajudará você não só a entender onde esse limite está, mas também a reconhecer os sinais internos que indicam quando você se encontra à beira da sobrecarga. E, o mais importante, ela mostra onde estão as alavancas que, com o tempo, poderão ser usadas para *deslocar* seu limite de sobrecarga, ajudando você a viver de outra forma: com mais alegria, saúde e leveza, mesmo nos momentos difíceis.

CAPÍTULO 3

Entendendo nosso limite crítico: neurocepção, capacidade e os estados de funcionamento

*É perfeitamente suportável carregar somente o fardo de cada dia.
Mas o fardo se tornará pesado demais se carregarmos, no dia de hoje,
também o fardo de ontem e acrescentarmos ainda o fardo de amanhã
antes do tempo.*

— John Newton, *pastor anglicano abolicionista*

Alex entrou na sala de reuniões conversando e rindo com os outros gerentes, sem imaginar o que seria anunciado ou o impacto que isso teria nele.

“Vamos fazer uma reestruturação na empresa”, disse o CEO em tom solene. As palavras pairaram no ar. Visivelmente desconfortável, o CEO fez uma pausa e então acrescentou: “Estou aberto a perguntas.” Enquanto os outros gerentes entraram imediatamente em ação, questionando e propondo soluções, Alex congelou. Por dentro, estava em pânico, mas não conseguia se mover. Era como se seu corpo tivesse travado. Alex não ouviu mais nada do que foi dito e só percebeu que a reunião tinha terminado quando viu todos se levantando para sair da sala. Então voltou para a mesa de trabalho sem notar as pessoas ao seu redor, não mais descontraído como quando entrara na sala de reuniões. Sua mente estava confusa e lenta, com as palavras que ouvira ecoando em seus pensamentos: “Vamos fazer uma reestruturação.” Passou o resto do dia olhando fixamente para a tela do computador, incapaz de trabalhar.

Ele se sentia frustrado e confuso com a própria reação. Normalmente, era um gerente eficiente, conhecido por manter a presença de espírito quando surgiam problemas. Aquela reação parecia ilógica e atípica. *Por que essa notícia me impactou de um jeito tão diferente dos meus colegas?*, Alex se perguntou. Ele refletiu sobre a própria trajetória. Aos 48 anos, tinha uma vida boa: era casado e pai de duas filhas que o amavam. Orgulhava-se, acima de tudo, de ter construído a segurança que nunca tivera na infância.

Quando Alex tinha 8 anos, o pai perdeu o emprego, e a família foi despejada do apartamento em que morava. Durante seis meses, eles moraram no carro, dependendo da generosidade de desconhecidos e de abrigos locais para conseguir comida. Além das dificuldades concretas da falta de moradia, Alex enfrentou a vergonha de ir à escola com roupas sujas, bem como a dor de ver seu melhor amigo trocá-lo por colegas mais “normais”. Para poupar seus pais, que já tinham problemas suficientes, ele suportou tudo isso em silêncio. Sentia-se impotente perante a dor que enfrentava todos os dias na escola.

Quando ouviu as palavras “vamos fazer uma reestruturação”, seu sistema nervoso fez um cálculo rápido e concluiu que o perigo e a impotência estavam de volta. Ainda que racionalmente ele pudesse discordar dessa conclusão, seu corpo mesmo assim ativou a sequência instintiva de sobrevivência (congelamento, seguido de apagão), enquanto seus colegas permaneceram na etapa do estresse, fazendo perguntas e buscando soluções.

Todos ouviram o mesmo anúncio, na mesma sala, ao mesmo tempo. A diferença não estava na experiência externa, mas na experiência interna de cada um. O limite crítico da sobrecarga de Alex estava em um ponto diferente do limite dos colegas, e o dele tinha sido ultrapassado. A resposta de cada pessoa naquela sala dependia de seus limites individuais. Alex entrou para o meu programa quando descobriu que, embora tivesse construído um futuro para si mesmo, ainda era assombrado pelo passado. Suas experiências da infância influenciavam seu senso de segurança e perigo por meio de um mecanismo do sistema nervoso chamado neurocepção.

Neste capítulo, vamos explorar o que é a neurocepção, como ela faz um cálculo contínuo da capacidade em relação à demanda para determinar onde está nosso limite crítico e como esse cálculo direciona nossa fisiologia para um de três estados de funcionamento da mente, do corpo e da biologia. Somente quando entendermos o que determina essa linha interna entre

crescimento e sobrecarga é que poderemos aprender a alterá-la, construindo assim segurança interna e resiliência.

NEUROCEPÇÃO: O CONDUTOR DA NOSSA FISIOLOGIA

Um conceito essencial para entender seu mundo interno e a biologia do trauma é a neurocepção, termo cunhado pelo Dr. Stephen Porges em seu trabalho com a teoria polivagal. A neurocepção é a avaliação contínua e em segundo plano que nosso sistema nervoso faz da segurança e do perigo. Na verdade, não se trata apenas de avaliar: ela cria a percepção corporal de quão seguros ou em risco nos sentimos em determinado momento. Essa percepção determina, em parte, onde estamos em relação ao nosso limite crítico da sobrecarga.

Pense na neurocepção como o sistema de direção autônoma mais sofisticado de todos. Assim como veículos modernos monitoram diversos parâmetros por meio de seus sistemas eletrônicos, a neurocepção faz um escaneamento constante do nosso mundo interno e externo. No painel de um carro, vemos indicadores de temperatura do motor, nível do óleo e freios ABS, todos mostrando se estamos em zonas de segurança ou de risco. O corpo humano tem sua própria versão desse sistema de monitoramento, porém ela é muito mais sofisticada.

Nossa neurocepção opera um painel de controle equivalente para manter o corpo em funcionamento, monitorando vários grupos de dados que o Dr. Porges chama de sinais de segurança e de perigo. Esses sinais vêm de todos os lados: do ambiente externo, da nossa biologia interna, de pensamentos e crenças e, especialmente, da energia e das deixas sutis de outras pessoas. Ela processa informações de todos os nossos sentidos, ou seja: o que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e percebemos pelo tato. Registra sinais sutis das nossas relações e interações sociais. Monitora a biologia interna, detectando inflamações, níveis hormonais e reservas de energia. E, de modo singular, leva em consideração nossas experiências passadas, criando um filtro personalizado para definir o que constitui segurança ou perigo para cada um de nós.

Isso explica por que a neurocepção de Alex interpretou a notícia da

reestruturação como uma ameaça à sobrevivência, enquanto a dos colegas percebeu aquilo como um desafio administrável. Cada neurocepção trabalha com seus próprios grupos de dados. A experiência de ficar sem casa na infância e o que isso significou para o senso de pertencimento e conexão de Alex na escola levaram seu sistema a interpretar a notícia como um perigo.

Por isso, o corpo de Alex entrou imediatamente na sequência de sobrevivência, mostrando como a neurocepção vai muito além de monitorar sinais. Como o carro autônomo mais avançado, ela não só coleta informações, mas toma decisões em uma fração de segundo sobre como reagir. Quando um carro autônomo detecta gelo na pista, tráfego pesado ou um obstáculo à frente, ele não apenas alerta o motorista como ajusta ativamente a operação do veículo. Pode desacelerar, mudar de faixa ou acionar a frenagem de emergência, dependendo da gravidade da ameaça.

Nossa neurocepção faz o mesmo, só que com uma sofisticação ainda maior. Ela processa todos os dados recebidos para realizar um cálculo crucial: nossa capacidade atual dá conta da demanda que estamos enfrentando? Com base nesse cálculo, a neurocepção direciona nossa fisiologia para seu estado operacional mais protetor. Quando todos os sistemas indicam que estamos em segurança, seguimos tranquilos em nosso estado calmo-ativo. Quando as demandas aumentam mas continuam administráveis, passamos para o estado de estresse, que nos fornece mais energia. E, quando o perigo excede nossa capacidade, os sistemas de emergência entram em ação e ativam a resposta ao trauma.

Antes de analisarmos o complexo papel da neurocepção de “conduzir” nosso corpo, vamos detalhar os dois elementos centrais do cálculo constante que ela faz: nossa capacidade em relação ao perigo que enfrentamos.

Capacidade

Nossa capacidade pode ser comparada a uma conta bancária que recebe depósitos e saques. O saldo disponível nessa conta representa quão preparados estamos para lidar com as alegrias, demandas e os perigos da vida. Se a conta no banco mostra o saldo em dinheiro, nossa conta de capacidade mostra o saldo em energia, recursos e resiliência. Se virmos o

que aumenta nossa capacidade como depósitos na conta, entenderemos melhor por que cruzamos o limite crítico da sobrecarga.

Vários tipos de depósitos aumentam nossa capacidade. A saúde biológica faz contribuições significativas: sono de qualidade, nutrição adequada, uma microbiota saudável, boa circulação sanguínea e linfática, e níveis de glicose estáveis. Um sistema nervoso equilibrado, capaz de descansar e processar, também é um dos grandes depositantes dessa conta.

Os depósitos emocionais e psicológicos são igualmente essenciais. Conexões genuínas com pessoas que nos compreendem, situações em que nos sentimos realmente vistos e aceitos, e momentos de alegria e diversão: tudo isso aumenta o saldo da nossa conta de capacidade. Mesmo pequenas interações positivas, como um sorriso sincero trocado com um desconhecido, risadas com um amigo ou um toque acolhedor exatamente quando precisamos contam como depósitos. Conhecimento, competências e conquistas também reforçam esse saldo. Cada novo aprendizado ou desafio vencido representa um novo depósito. Essas experiências se tornam recursos que ficam disponíveis para enfrentarmos desafios futuros.

Cada depósito é como um sinal de segurança enviado ao painel de controle da nossa neurocepção, que então desloca nosso limite crítico da sobrecarga um pouco adiante. Nossa capacidade, portanto, muda efetivamente a posição da linha que separa a resposta de estresse da resposta de trauma. Quanto mais capacidade temos, mais energia conseguimos mobilizar em nossa resposta de estresse antes de chegar ao ponto em que nos sentimos impotentes.

Demandas: o outro lado da equação

Toda demanda da nossa vida, seja correr uma maratona ou fugir de um perigo, exige um saque da nossa conta de capacidade. O que determina se uma demanda nos fortalece ou nos empurra para a sobrecarga não é a natureza da demanda em si, mas o fato de termos ou não saldo suficiente na conta.

Assim que consegui meu primeiro emprego, abri uma conta bancária e aprendi a usar meu dinheiro e a economizar. Eu tinha 12 anos e, embora comprasse algumas coisinhas para mim com o salário, como CDs, poupava

a maior parte do que ganhava. Quando comprei meu primeiro carro, precisei usar parte desse dinheiro para custear o seguro, a gasolina e a manutenção. Não me esqueço da ansiedade que sentia ao olhar o saldo e calcular se teria o suficiente para cobrir as despesas. Mas continuei trabalhando e poupando, e em dois anos eu tinha o suficiente para pagar uma viagem de férias à Alemanha, mantendo ainda uma reserva para emergências.

Sabemos que não devemos gastar todo o nosso dinheiro com itens supérfluos; precisamos guardar para objetivos maiores, como a entrada para financiar uma casa. Também sabemos que é importante ter reservas para despesas inesperadas, como consertar o telhado. Enquanto temos dinheiro em caixa, seja para algo que desejamos, seja para algo com que preferiríamos não gastar, está tudo bem. As coisas começam a sair dos trilhos quando não conseguimos pagar por algo essencial.

Gerenciar nossa capacidade é como administrar nossas finanças. Precisamos ter o suficiente para cobrir todas as funções básicas, como digestão, resposta imunológica e produção hormonal, mas também para tarefas cotidianas, como trabalhar, dirigir e preparar refeições. No entanto, há dias em que queremos mais que apenas o básico; nesses casos, podemos fazer depósitos e aumentar nossa conta de capacidade para iniciar um novo projeto, viajar para ver a família, adquirir uma nova competência, escalar uma montanha ou ter um filho. Tudo isso requer um saque maior da nossa conta de capacidade. Até mesmo eventos alegres, como comemorações ou viagens, exigem capacidade.

O importante é manter reservas nessa conta, pois haverá dias em que teremos que lidar com demandas grandes e *inesperadas*. O acidente de carro de Elena é um bom exemplo: o perigo repentino exigiu, de imediato, uma quantidade enorme de capacidade. A notícia da reestruturação foi uma demanda igualmente repentina para Alex. Se não tivermos acumulado capacidade suficiente na conta com antecedência, o resultado inevitável será a sobrecarga.

Os saques diários e as demandas desnecessárias podem nos deixar vulneráveis, esvaziando a conta sem percebermos. O estresse da preocupação ou da autocrítica vão sugando nossas energias de modo constante. Muitas vezes, acrescentamos uma camada adicional por meio de expectativas autoimpostas. Quando estabelecemos padrões perfeccionistas,

nos sentimos pressionados a agradar os outros ou ignoramos as necessidades do próprio corpo, aumentamos o fardo que carregamos. Essas demandas autoimpostas drenam nossa conta, até que, um dia, percebemos que estamos praticamente sem reservas.

Isso nos leva ao ponto central do que a neurocepção faz por nós: ela executa continuamente um cálculo para determinar se nossa capacidade é suficiente para atender à demanda que enfrentamos. Essa é a única maneira que ela tem de nos proteger.

Capacidade *versus* demanda: o cálculo da neurocepção

Nossa neurocepção realiza esse cálculo vital entre capacidade e demanda muito mais rápido do que conseguimos processar conscientemente. Assim como o sistema de bordo de um carro desliga o motor antes que ele entre em pane por superaquecimento, a neurocepção age para nos proteger quando as demandas excedem nossa capacidade. Vejamos como esse cálculo funciona em situações reais.

Capacidade X Demanda: a resposta do corpo ao perigo



Pense no cenário do Capítulo 1 em que nos deparamos com o muro: estávamos diante de um cachorro bravo em um beco. Nesse momento, a neurocepção calcula rapidamente: temos capacidade suficiente para correr mais rápido que o cachorro? Existem pessoas por perto que podem nos ajudar? Temos força ou habilidade para nos defender? Enquanto a neurocepção detectar que temos capacidade suficiente para lidar com essa demanda, ela nos manterá do lado do estresse, antes do limite crítico da sobrecarga, utilizando o aumento de energia para superar o desafio.

Porém, no instante em que o perigo é percebido como algo que exige mais que a capacidade disponível, a neurocepção determina que a resposta de trauma é a mais adequada para a sobrevivência. O congelamento impede qualquer ação que esgotaria ainda mais nossa capacidade limitada, ao passo que o apagão reduz o consumo de energia ao mínimo necessário para sobreviver.

Esse cálculo ocorre diante de qualquer demanda, não apenas dos perigos óbvios. A notícia da reestruturação não era a princípio um perigo evidente,

mas, para a neurocepção de Alex, sim. Isso também pode acontecer quando nos excedemos durante um exercício físico, assumimos responsabilidades demais ao mesmo tempo ou até quando mergulhamos fundo em questões emocionais antes de estarmos preparados.

Por mais contraintuitivo que pareça em termos lógicos, nossa neurocepção trata perigos emocionais com a mesma seriedade que trata ameaças físicas. A dor emocional que parece insuportável é processada como uma ameaça mortal. Rejeição social e vergonha podem esgotar nossa capacidade tão rapidamente quanto o perigo físico de um carro avançando em nossa direção. Até mesmo a negligência emocional crônica é capaz de gerar a mesma sobrecarga que a privação física. Podemos racionalizar e dizer que “são só sentimentos”, mas a neurocepção processa a dor emocional extrema como uma ameaça à sobrevivência.

Por isso, não importa se uma demanda é “boa” ou “ruim”, simples ou complexa, física ou emocional, porque tudo entra no cálculo. Pense naquela vez em que você tinha planejado fazer uma faxina mas depois decidiu que estava sem condições e acabou vendo um filme. Isso foi sua neurocepção calculando que a demanda da faxina era maior que sua capacidade naquele momento. Esse cálculo pode ter levado em conta vários fatores. Vamos supor que o treino na academia na véspera foi mais pesado e seus músculos estavam doloridos. Depois, você não comeu direito antes de sair correndo para o trabalho, onde precisou tomar várias decisões psicologicamente estafantes. Para completar, quando estava voltando para casa, teve o desgaste emocional de uma discussão com seu parceiro ou parceira, pois não conseguiam decidir se jantavam fora ou pediam comida. Sua neurocepção consultou o saldo da sua conta de capacidade e concluiu: “Não temos a menor condição de limpar a casa hoje.”

Ainda assim, muitas vezes contrariamos essas mensagens do corpo aplicando a lógica. Talvez movidos pelo perfeccionismo, acabamos forçando a barra: dizemos a nós mesmos que seremos preguiçosos se não limparmos a casa naquele dia, então tomamos mais um café e ignoramos o aviso do corpo. Foi assim que Claire acabou vivendo uma experiência de pouca coisa por muito tempo, forçando-se continuamente sem realizar novos depósitos na sua conta da capacidade. E é quase sempre por ignorar os sinais de esgotamento que somos levados a cruzar o limite crítico da sobrecarga e, depois, nos perguntamos por que entramos em estado de apagão.

O cálculo constante da neurocepção leva em conta todos os tipos de demanda, visíveis e invisíveis, externas e internas, reais e antecipadas. É por meio dessa medição precisa que ela determina qual dos três estados de funcionamento vai nos atender melhor em cada momento. Exploraremos esses três estados, que criam fisiologias, energias, pensamentos e humores específicos.

TRÊS ESTADOS DE FUNCIONAMENTO ORIENTADOS PELA NEUROCEPÇÃO

Assim como um carro tem modos operacionais diferentes, nosso corpo também possui três estados de funcionamento distintos que nos ajudam a transitar pelas várias situações da vida. Cada estado serve a um propósito específico: o estado calmo-ativo nos permite tratar da vida cotidiana com tranquilidade; o estado de mobilização nos confere a energia necessária para os desafios; e o estado de trauma funciona como nosso freio de emergência quando as demandas excedem nossa capacidade.

Diferentes estados do sistema nervoso



Esses estados são orientados pela neurocepção por meio do nosso sistema nervoso autônomo, a parte do sistema nervoso que controla as funções do corpo sem a nossa intervenção consciente. Embora esse sistema automático nos mantenha vivos ao regular funções básicas como respiração e batimentos cardíacos, o estado específico em que estamos determina como essas funções operam. Assim como um carro se comporta de modo

diferente no modo cruzeiro ou esportivo, cada estado comanda nossos órgãos, tecidos e células de maneiras específicas.

Como um veículo sofisticado que responde tanto às condições da estrada quanto ao seu sistema interno, nossa fisiologia alterna entre esses três estados operacionais com base no cálculo contínuo que a neurocepção realiza da capacidade e da demanda. Vamos explorar como cada estado funciona e o que leva a neurocepção a escolhê-los.

O estado calmo-ativo

Imagine que você está dirigindo por estradas tranquilas em um dia de céu claro. O carro está estável, funcionando perfeitamente, sem nenhuma luz de alerta no painel. Isso corresponde ao que chamo de estado calmo-ativo, conhecido cientificamente como estado vagal ventral ou estado parassimpático. Quando vários sinais indicam à neurocepção que estamos em segurança e as demandas são administráveis, ela direciona nossa fisiologia para esse modo operacional ideal em que nos sentimos protegidos, seguros, criativos e cheios de esperança no futuro.

Nesse estado, os sistemas do corpo trabalham em harmonia, apresentando boa digestão, batimentos cardíacos regulares, clareza de pensamento e capacidade de se conectar com outras pessoas. Como um carro em seu modo mais eficiente, é nesse estado de energia moderada que somos mais eficazes. Temos acesso total à nossa conta de capacidade, realizando menos saques e mais depósitos por meio do descanso, da alegria e da nutrição. No estado calmo-ativo, nossa saúde está ótima e somos a melhor versão de nós mesmos.

O estado de mobilização

De repente, você percebe que vai se atrasar para uma reunião importante. Como as consequências de chegar tarde são significativas, você imediatamente muda de marcha. Concentra-se ao máximo, ativa o modo esportivo e dirige em alta velocidade, com precisão e habilidade. O carro passa a consumir mais combustível, e o ritmo não é sustentável, mas você espera conseguir chegar a tempo se mantiver esse nível elevado de

desempenho. Os indicadores do painel alertam que você está levando o carro ao limite.

No nosso corpo, esse modo equivale ao que chamo de estado de mobilização, que inclui os dois primeiros passos da resposta instintiva ao trauma: o sobressalto e o estresse. Mas, assim como um carro no modo esportivo, e como o sprint da resposta de estresse, esse estado não pode ser sustentado indefinidamente, pois exige demais da nossa capacidade.

O estado de trauma

Agora imagine que o carro foi forçado a ir além da capacidade, considerando as condições da estrada, e começa a perder o controle. Como é um veículo autônomo, ele aciona o freio de emergência sozinho, mais rápido do que um motorista conseguiria reagir conscientemente diante do perigo. Com o nosso corpo acontece a mesma coisa. Quando batemos no muro, por causa de muita coisa em pouco tempo ou de pouca coisa por muito tempo, e vamos além da nossa capacidade, o corpo ativa seu terceiro estado fisiológico, que chamo de estado de trauma. O termo científico da teoria polivagal é “resposta vagal dorsal”, uma reação que envolve o corpo inteiro e que exploraremos no Capítulo 5.

Esse estado operacional contém as duas últimas etapas da sequência de sobrevivência: o congelamento e o apagão. Sua função fisiológica principal é conservar energia. No congelamento, é como se pisássemos no acelerador com o freio de mão acionado; ficamos presos no estado de choque da impotência, incapazes de avançar ou recuar. O apagão vem em seguida, quando o corpo se compromete totalmente com a economia de energia, como se tirássemos o pé do acelerador e acionássemos tanto o pedal do freio quanto o freio de mão.

Podemos vivenciar esse estado como fadiga, desconexão ou uma sensação de peso no corpo. Quando já não conseguimos interagir com os desafios da vida como antes e apenas assistimos de longe enquanto as outras pessoas lidam com o que para nós parece impossível, provavelmente estamos nesse estado de proteção. Isso talvez aconteça de maneira súbita e drástica, como no caso de Alex na sala de reuniões, ou de maneira lenta e gradual, como ocorreu com Claire, cuja exaustão acabou evoluindo para

episódios de fadiga crônica após a segunda gravidez.

Podemos tentar lutar contra nossas reações, analisá-las ou até sentir vergonha delas, como Alex fez ao comparar sua resposta com a dos colegas. Mas a verdade é simples: dentro de cada um de nós existe um cálculo constante entre capacidade e demanda. Enquanto os colegas permaneciam no estado de mobilização, a neurocepção de Alex já havia acionado o freio de mão. A realidade e a lógica não tiveram papel algum nesse cálculo. A neurocepção determinou que o apagão era necessário para a sobrevivência, que é sempre a prioridade do nosso corpo em detrimento do desempenho, mesmo quando nossa mente racional discorda.

Isso nos leva a uma característica importante da neurocepção, do cálculo que ela faz e desses três estados de funcionamento: eles são dinâmicos, ou seja, estão sempre mudando. Em qualquer outro dia, Alex talvez tivesse conseguido permanecer no estado de mobilização, e ele pode aprender a fazer isso. Vamos entender como essa mudança entre estados acontece, de que modo ela nos ajuda e por que o mesmo desafio pode nos energizar em um dia e nos sobrecarregar no outro.

A NATUREZA DINÂMICA DOS NOSSOS ESTADOS E DO LIMITE CRÍTICO

Imagine que você está dirigindo por aquela mesma estrada, mas, desta vez, ao dobrar uma curva, percebe que uma inundaç o recente a deixou enlameada. Ou talvez note que o motor est  come ando a superaquecer. Ambas as situa  es exigem que voc  altere o modo de condu  o. Assim como dirigir, viver   um processo din mico: uma sequ ncia cont nua de ajustes, influenciados tanto por condi  es externas quanto internas. Regido pela neurocep  o, nosso sistema nervoso aut nomo opera de acordo com o n vel de agilidade necess rio, mudando de estado r pida ou lentamente conforme as condi  es exigem. Cada vez que enfrentamos uma demanda, o sistema nervoso realiza uma nova avalia  o: quanta capacidade eu tenho agora? Com quais outras demandas preciso lidar? At  que ponto me sinto amparado neste momento?

A natureza inconsciente desse c lculo e da mudan a constante entre estados tomar  o controle at  a levarmos para o n vel consciente. Um estudo

divulgado em 2011 na publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos analisou mais de mil decisões de pedidos de liberdade condicional tomadas por oito juízes. Os pesquisadores descobriram que, após uma pausa, 65% dos casos recebiam decisões favoráveis aos solicitantes. O índice de concessão era mais alto no início do dia, caía gradualmente até quase 0% e subia novamente para cerca de 65% após o intervalo para o almoço; então, despencava outra vez para quase 0% quanto maior fosse o tempo desde a última pausa.

Estejamos conscientes disso ou não, nossa capacidade oscila sempre, até mesmo em função da fadiga mental. Quando ocorre de maneira inconsciente, nosso corpo reage de formas que parecem confusas, frustrantes e podem até impactar outras pessoas. Já reparou como, em alguns dias, encaramos os desafios da vida com facilidade, enquanto em outros ficamos sobrecarregados com situações parecidas? Podemos lidar bem com o estresse no trabalho quando estamos descansados e o ambiente está organizado. No entanto, esse mesmo estresse nos faz cruzar o limite crítico da sobrecarga quando estamos resfriados ou chegamos irritados depois de levar uma fechada no trânsito. Talvez, se fizéssemos pausas regulares, nos alimentássemos bem, nos movimentássemos um pouco ou até tirássemos um cochilo no início da tarde para revigorar nossa capacidade, não acabaríamos gritando com nosso parceiro ou parceira por causa daquelas pequenas manias que um dia até achamos cativantes.

A capacidade de ontem não nos ajuda hoje. Foi aqui que Claire se sentiu empacada em sua jornada. Ela *costumava* ser um “coelhinho da Duracell”. Mas a grande capacidade que tivera antes das gestações já não servia para o momento atual. Em alguns dias, ela conseguia lidar bem com tarefas básicas; em outros, atividades semelhantes faziam com que fosse dominada pela fadiga. Ela precisava aprender a reconhecer a natureza dinâmica da própria capacidade e a identificar quando estava se aproximando do limite crítico da sobrecarga. Somente assim saberia quando recuar, em vez de se forçar a ir além do que devia. Para tanto, ela tinha que descobrir como se conectar com o próprio corpo, e foi esse o trabalho que realizou comigo na Jornada Estruturante. Como ela mesma disse: “Passei a vida toda vivendo na minha cabeça. Está na hora de realmente viver no meu corpo.”

À primeira vista, Claire e Alex eram muito diferentes, mas ambos perceberam que os padrões determinados por suas experiências da infância

ainda os afetavam. Claire não tinha consciência de que suas vivências quando criança foram traumáticas para o seu corpo, e Alex estava certo de que deixara para trás tudo aquilo que lhe acontecera. Os dois ainda tinham trabalho a fazer em sua programação de apego e na biologia que essa programação havia moldado para, assim, deterem o perfeccionismo e a insegurança subjacentes.

Cada pequeno depósito na nossa conta de capacidade, seja por meio de descanso, uma refeição saudável, hidratação, conexão humana, vitaminas ou exercícios leves, desloca nosso limite crítico da sobrecarga. Embora nem sempre sejamos capazes de controlar as demandas da vida, podemos trabalhar em parceria com a calculadora interna do nosso corpo e manter reservas na conta de capacidade, criando as condições necessárias para a resiliência e o crescimento.

Como exatamente esses depósitos e saques afetam nosso corpo nos níveis mais profundos? E se considerássemos que, da mesma forma que nosso organismo tem um limite crítico da sobrecarga, cada célula do nosso corpo também tivesse sua própria linha divisória entre crescimento e proteção? No Capítulo 4, vamos entrar no mundo microscópico das células e descobrir que o trauma não é apenas uma experiência emocional; é uma realidade biológica que chega até nossas mitocôndrias e nosso DNA. Entender como as células do corpo humano respondem ao estresse e ao trauma revelará por que uma terapia eficaz precisa incluir a reparação biológica para restaurar nossa capacidade interna de segurança, conexão e autenticidade.

RESUMO

Neste capítulo, vimos como a neurocepção – nossa calculadora interna de capacidade e demanda – determina quando e por que cruzamos o limite crítico da sobrecarga. Por meio do monitoramento constante de múltiplos grupos de sinais, externos e internos, ela identifica qual dos nossos estados de funcionamento é mais útil a cada momento.

Quando nossa capacidade está confortavelmente acima das demandas, seguimos no estado calmo-ativo. Pensamos com clareza, nos conectamos com facilidade com outras pessoas e lidamos com os desafios da vida com

relativa tranquilidade. À medida que as demandas aumentam e começam a pressionar nossa capacidade, o sistema passa para o estado de mobilização, que é uma resposta natural e saudável, como alterar o carro para o modo esportivo quando precisamos de mais potência. Porém, quando as demandas excedem nossa capacidade – seja por muita coisa em pouco tempo, seja por saques que criaram uma experiência de pouca coisa por muito tempo –, a neurocepção aciona o freio de emergência e nos leva ao estado de trauma. Ao cruzar o limite crítico da sobrecarga, o corpo entra em um estado fisiológico de apagão.

Embora as experiências de estresse e trauma sejam percebidas por meio de nossas emoções, pensamentos e níveis de energia, essas respostas também ocorrem no nível celular, conforme iremos analisar no próximo capítulo.

CAPÍTULO 4

A sobrecarga no nível celular

Sua mente está em cada célula do seu corpo.

– Candace Pert, *psicofarmacologista*

Como em tantas outras manhãs, Sarah se espremeu para sair do seu SUV estacionado rente a outro carro, entrou no hospital, percorreu os corredores e atravessou as portas de vidro largas que davam acesso à UTI. Mas aquela manhã não era como as outras. Fazia vinte anos que trabalhava na UTI como enfermeira intensivista, mas ela não estava ali para trabalhar, e sim para visitar a mãe, internada no dia anterior em estado crítico. Seu prognóstico não era animador. A pressão arterial, os eletrólitos e a saturação estavam todos em níveis alarmantes.

Ao longo da carreira, Sarah tinha visto esse tipo de situação milhares de vezes. Ela conhecia todos os protocolos de cor. Na verdade, era uma das melhores enfermeiras da unidade, com uma habilidade natural para manter a calma, agir com rapidez e liderar com eficácia em emergências. Paradas cardíacas inesperadas faziam parte da rotina, e ela se destacava naquele ambiente em que o trabalho intenso, o café e os donuts lhe proporcionavam a adrenalina necessária para manter o foco sob pressão.

No entanto, toda a sua experiência e competência não seriam suficientes naquela manhã. De pé ao lado do leito da mãe, ela ouviu o monitor cardíaco emitir um alarme estridente, indicando que o coração estava parando. A resposta inicial de sobressalto durou menos de uma fração de segundo antes que Sarah entrasse em ação. Ela correu para a porta e chamou ajuda. Foi até o carrinho de emergência, empurrou-o até o leito e se posicionou para iniciar a massagem cardíaca. Quando a equipe médica chegou e assumiu o controle, Sarah os observou seguir o protocolo: massagem cardíaca,

desfibrilador, adrenalina intravenosa. O coração de Sarah batia acelerado, ela própria experimentando um pico de adrenalina. Com as mãos suadas e a respiração acelerada, concentrou sua atenção em cada etapa para verificar se estavam fazendo tudo corretamente. E estavam. Mas não funcionou. Eles continuaram por 3 minutos, conforme o protocolo, até que ficou evidente: sua mãe havia partido.

Quando a equipe interrompeu as tentativas de reanimação, eles lhes deram os pêsames na forma de uma breve troca de olhares e se retiraram para deixá-la sozinha. Atordoada, com um nó na garganta, Sarah sentiu o quarto girar ao seu redor. De repente, teve dificuldade para continuar de pé e se apoiou em uma cadeira. Uma sensação de peso tomou conta de todo o seu corpo; até manter a cabeça erguida parecia difícil, e ela a deixou cair sobre o leito da mãe. Seu próprio coração parecia em choque. Sentiu frio, mas não teve forças para pegar um cobertor. Justo ela, que tantas vezes havia oferecido um cobertor aos familiares sentados ao lado dos pacientes. Ficou prostrada na cadeira pelo que podem ter sido minutos ou horas. Sentia-se anestesiada, exausta, como se o próprio coração estivesse continuamente recebendo descargas elétricas. Tudo o que queria era se encolher em posição fetal e chorar, mas as lágrimas não vinham. Só havia o torpor. Dois dias antes, estava fazendo planos com a mãe. Agora, ela estava morta. Sarah não estava pronta para dizer adeus.

Uma colega de trabalho aproximou-se e perguntou:

– Sarah, você está bem?

– Estou... só preciso de um minuto – respondeu ela, surpresa com o esforço que precisou fazer para falar.

Ela se perguntou onde tinha ido parar sua firmeza habitual, aquela força interna que a sustentara ao longo de vinte anos cuidando dos pacientes mais graves. Ao me contar essa história tempos depois, descreveu aquele momento como “estresse”, mas havia muito mais em jogo. Pelo que ela relatou, estava evidente que seu corpo havia cruzado o limite crítico da sobrecarga e entrado em estado de trauma. Os sinais externos estavam ali, porém havia mais coisas acontecendo no nível celular. Sempre há.

Tendemos a pensar na resposta ao trauma como uma experiência sobretudo emocional ou psicológica, mas os processos celulares também fazem dela uma experiência fisiológica. Além de nossas células nos ajudarem a responder às demandas que nos são impostas, elas vivenciam os

estados de estresse e de trauma junto conosco.

NOSSA COMUNIDADE DE CÉLULAS

As células do corpo humano são as trabalhadoras da linha de frente em um processo chamado homeostase. A homeostase é o equilíbrio delicado de eletrólitos, fluidos, níveis de açúcar e inúmeros outros parâmetros fisiológicos que nos mantêm vivos e operantes. No capítulo anterior, vimos como a neurocepção coleta sinais constantemente para fazer um cálculo de nossa capacidade em relação à demanda e, assim, decidir qual dos três estados de funcionamento nos atenderá melhor.

Cada estado aciona um modo diferente de operação, e é aqui que o sistema nervoso autônomo assume o controle, demonstrando uma sofisticação maior que a de qualquer carro autônomo. O sistema nervoso autônomo não se limita a coletar dados: ele corrige múltiplos parâmetros ao mesmo tempo, fazendo inclusive microajustes a fim de manter todos os sistemas equilibrados dentro de uma faixa segura que sustenta a vida. Vemos isso, por exemplo, quando saímos de casa em um dia quente: nossas glândulas sudoríparas recebem um comando do sistema nervoso autônomo para se abrirem e manterem nossa temperatura interna dentro de uma faixa saudável. Microajustes acontecem sem que tenhamos consciência deles, como a liberação de hormônios quando o nível de glicose começa a cair. Antes que a glicose chegue a um nível perigosamente baixo, o corpo inteiro já está fazendo uma série de microcorreções por meio desse processo chamado homeostase.

Quando todos os sistemas indicam que estamos seguros e a neurocepção nos mantém no estado calmo-ativo, manter a homeostase é relativamente fácil. Mas o que acontece quando surge uma demanda e a neurocepção nos conduz ao estado de mobilização? Nesse estado, fica mais difícil equilibrar todos aqueles parâmetros, e mais ainda quando cruzamos o limite crítico da sobrecarga.

Em cada célula existe uma cidade sofisticada, onde departamentos especializados trabalham sem parar para manter o equilíbrio, responder a desafios e até se desligar quando estão sobrecarregados. Compreender esse mundo celular revelará por que toxinas e dor emocional podem causar

sobrecarga celular da mesma forma que um perigo físico, e por que uma jornada de cura do trauma requer mais do que apenas uma mudança nos pensamentos.

A METRÓPOLE CELULAR

O corpo humano é uma comunidade com cerca de 50 trilhões de células. Cada célula é uma metrópole vibrante, com sistemas complexos que funcionam 24 horas por dia para nos manter vivos e operantes. Como em qualquer cidade bem administrada, cada departamento tem uma função especializada, mas todos precisam trabalhar em conjunto, especialmente quando surge um perigo. Vamos dar um passeio por essa cidade interna para entender como sistemas celulares respondem quando enfrentamos desafios, demandas ou ameaças.

Mitocôndrias: as usinas de energia

No coração da homeostase e da nossa capacidade estão as mitocôndrias, pequenas organelas que convertem os alimentos que comemos e o oxigênio que respiramos em adenosina trifosfato, ou ATP, a fonte de energia do corpo. As mitocôndrias são as usinas de energia do organismo, e cada célula abriga milhares delas. Essa produção de energia é chamada de “respiração celular”, porque, no final das contas, a função de cada respiração nossa é abastecer as mitocôndrias. Inspiramos oxigênio para que elas possam produzir energia e expiramos o subproduto desse processo, o dióxido de carbono.

Quando estamos no estado calmo-ativo, essas usinas trabalham com uma flexibilidade impressionante. Elas conseguem alternar facilmente entre diferentes fontes de combustível, sejam açúcares, gorduras ou proteínas, ajustando sua produção de energia para se adequar às necessidades do corpo de acordo com nossa alimentação.

Membrana celular: a fronteira inteligente

A membrana celular é muito mais do que uma barreira: é um sistema de fronteira inteligente que controla o transporte e a comunicação. Chamado de “o cérebro da célula” pelo especialista em epigenética Bruce Lipton, esse sistema é formado por duas camadas de gordura (uma bicamada lipídica) que lhe dão flexibilidade. Essa flexibilidade é essencial para impedir a entrada de substâncias nocivas, como toxinas, enquanto permite a passagem de nutrientes e sinais.

Núcleo: a central de comando

No centro da nossa metrópole celular está o núcleo, a central de comando que protege nosso bem mais precioso: o DNA. Como uma fortaleza que guarda informações vitais, o núcleo dispõe de várias camadas de proteção. Atrás de suas paredes protetoras, proteínas especializadas defendem o DNA contra ameaças como o estresse oxidativo, da mesma forma que sistemas de segurança protegem documentos essenciais.

Dentro do núcleo, o DNA encontra-se cuidadosamente organizado, enrolado em torno de proteínas chamadas histonas. Essas histonas atuam como bibliotecários competentes, controlando quais informações genéticas podem ser acessadas e quando. Alguns genes permanecem armazenados com segurança, ao passo que outros são disponibilizados conforme as necessidades da célula, seja para manter o funcionamento diário, seja para responder ao estresse e ao perigo.

RE e complexo de Golgi: produção e transporte de proteínas

Toda cidade precisa de uma zona industrial e, na nossa cidade celular, essa função é desempenhada por dois compartimentos especializados: o retículo endoplasmático (RE) e o complexo de Golgi. Trabalhando juntos como um sistema de fabricação e envio sofisticado, eles produzem e distribuem as proteínas de que a célula precisa para funcionar.

Podemos pensar nas proteínas como os veículos por meio dos quais o corpo realiza suas tarefas. O DNA fornece o projeto, mas as proteínas

precisam ser montadas e enviadas de maneira precisa para exercerem suas funções. O RE funciona como a fábrica, dobrando cuidadosamente cada proteína em sua forma tridimensional correta; um único erro pode inutilizá-la. O complexo de Golgi, então, atua como o centro de distribuição, etiquetando cada proteína com o endereço para onde ela deve ir. Sem esse sistema minucioso de fabricação e envio, nossa cidade celular mergulharia rapidamente no caos.

Matriz extracelular: o suporte da comunidade

Ao redor das células e conectando todas elas está a matriz extracelular (MEC), a infraestrutura que mantém nossa comunidade celular unida. Produzida pelas células vizinhas a partir de proteínas e açúcares, a MEC oferece suporte estrutural e canais de comunicação.

Assim como ruas, linhas elétricas e redes de comunicação permitem que uma cidade funcione, a MEC possibilita que as células permaneçam conectadas e se apoiem mutuamente. Em momentos de estresse ou perigo, essa infraestrutura se torna fundamental, pois fornece pontos de ancoragem para que as células não entrem em colapso e mantém os canais de comunicação abertos, mesmo quando células individuais estão atendendo a alguma demanda.

Da mesma forma que achamos fácil nos equilibrarmos com os dois pés no chão, nosso sistema nervoso autônomo e nossas células não têm dificuldade em manter a homeostase quando estamos no estado calmo-ativo. Porém, quando uma demanda surge e nossa capacidade é colocada à prova, é preciso mais foco e atenção para manter o equilíbrio. Vamos ver agora como as células vivenciam o estresse e tentam preservar esse equilíbrio.

O COMANDO DO ESTRESSE: QUANDO AS CÉLULAS AUMENTAM A POTÊNCIA

Assim como uma cidade tranquila se transforma quando as sirenes de emergência começam a soar, nossa metrópole celular passa por mudanças

drásticas quando enfrenta estresse ou perigo. Cada departamento entra em estado de alerta máximo, redirecionando recursos e ajustando operações para lidar com a crise.

Foi isso que aconteceu nas células de Sarah quando ela ouviu o alarme do monitor cardíaco. Cada departamento celular adaptou sua função rapidamente para fornecer o pico de energia de que ela necessitava para reagir. As usinas tiveram que aumentar a produção, os sistemas de comunicação foram acelerados e a manutenção de rotina precisou ser adiada. Nossas células realizam essas mudanças profundas em milésimos de segundo.

Sarah sentiu essa mudança imediatamente. O coração disparado, as mãos suadas e a respiração ofegante foram manifestações de trilhões de células, cada uma fazendo sua parte para gerar um pico de energia ao seu modo. As células cardíacas aceleraram, as glândulas sudoríparas dos braços e das mãos se abriram. As mitocôndrias intensificaram a produção de energia, enquanto a respiração de Sarah se apressou para levar mais oxigênio a elas e eliminar o resíduo na forma de dióxido de carbono. Foi assim que ela teve pique para correr até a porta, gritar por ajuda e deixar o carrinho de emergência a postos.

Agora, vamos nos concentrar no que acontece dentro das mitocôndrias – afinal, são elas que dão às células a capacidade extraordinária de aumentar a potência quando precisamos de força, velocidade e foco quase sobre-humanos durante o estado de mobilização.

As mitocôndrias ativam seu modo mais eficiente de produção de ATP, chamado fosforilação oxidativa. Elas se dobram sobre si mesmas, formando “cristas” e ampliando o espaço disponível para produzir mais energia. Também enviam sinais ao núcleo para a fabricação de proteínas específicas para o estresse. A membrana celular se adapta para atender ao aumento de demanda energética do estado simpático: torna-se mais fluida e ativa, permitindo que o oxigênio e os nutrientes entrem mais depressa na célula. Até a matriz extracelular ao redor da célula muda, fornecendo mais suporte para que ela tolere o aumento do estresse sem se danificar. A estrutura ao redor da célula é remodelada rapidamente para otimizar sua fixação às proteínas circundantes. Isso ajuda a impedir que a célula entre em colapso, aumentando a eficiência da entrega de nutrientes e da remoção de resíduos pelos canais de transporte.

Uma proteína fundamental nesse processo, e que vem recebendo mais atenção ultimamente, é a galectina-3. Ela é liberada na MEC durante momentos de estresse para reforçar o suporte estrutural ao redor da célula e pode ser medida por um exame de sangue. O resultado é usado para avaliar o grau da biologia do trauma no organismo.

Capacidade celular

Assim como nós temos uma capacidade, cada célula também possui seus próprios limites e pontos de ruptura. O grau em que o sistema nervoso autônomo consegue manter o equilíbrio (homeostase) mesmo sob estresse é o que os cientistas chamam de capacidade homeostática. Cada célula tem sua própria capacidade, ou seja, quanto de descarga energética ela é capaz de gerar. Passado esse ponto, ela cruza seu próprio limite crítico da sobrecarga.

Isso nos lembra que a etapa de estresse da resposta instintiva de sobrevivência não dura para sempre – ela se assemelha mais a um sprint. Dois fatores determinam nosso sucesso em superar esse momento *sem* avançar para uma resposta ao trauma: a velocidade e a duração desse sprint. Ambos dependem diretamente da capacidade homeostática e da capacidade de aumento da produção de energia quando necessário.

A experiência de Sarah sugere que suas células tinham capacidade suficiente para sustentar a resposta ao estresse durante a emergência, pois ela teve energia para agir até o final. Não foi a capacidade física das células que desencadeou sua resposta ao trauma, mas o choque emocional que excedeu a capacidade do seu corpo. Já no caso de Claire, cada episódio de fadiga parecia exceder sua capacidade celular, seja quando marcava clientes demais para um só dia, seja quando exagerava nos exercícios físicos. O mesmo valia para Elena, com suas crises de inchaço e exaustão ao desenvolver uma doença autoimune após o acidente de carro.

Quando uma célula não consegue funcionar rápido o suficiente ou por tempo suficiente para dar conta das demandas, ela chega ao seu limite. Mesmo que continue a receber um sinal dizendo “Precisamos de mais velocidade agora!”, a célula não tem mais o que entregar. Seja porque a demanda foi muita coisa em pouco tempo, seja porque deixamos de dar às células o que elas precisam (pouca coisa por muito tempo), o resultado é o

mesmo. Quando a demanda supera o que uma célula consegue sustentar e a capacidade homeostática é ameaçada, ela aciona o seu próprio apagão. Como acontece conosco, a melhor forma de sobreviver é se render, em vez de continuar tentando quando o seu máximo já não é suficiente. Esse processo é chamado de resposta celular ao perigo: a versão da célula da resposta ao trauma.

A RESPOSTA CELULAR AO PERIGO: QUANDO AS CÉLULAS SE DESLIGAM PARA SOBREVIVER

Assim como puxamos o freio de mão quando começamos a perder o controle do carro, as células também possuem um sistema de emergência. Quando ultrapassam sua capacidade, elas abandonam o estado de alta energia e se desligam para se proteger. Esse processo foi identificado pelo biólogo celular Robert Naviaux, que o chamou de resposta celular ao perigo.

Esse freio transforma completamente o funcionamento celular. Da mesma forma que a resposta ao trauma do corpo se sobrepõe a qualquer controle consciente, a resposta celular ao perigo se sobrepõe ao funcionamento normal da célula. Cada departamento da metrópole celular reduz suas operações ao mínimo, concentrando-se exclusivamente na sobrevivência.

As mitocôndrias sofrem a mudança mais drástica. Elas mudam de formato, deixando de ser longas e flexíveis para se tornarem arredondadas e rígidas. Em vez de produzir energia de forma eficiente por meio da via normal (a fosforilação oxidativa), elas recorrem a um sistema reserva que exige menos oxigênio porém produz muito menos energia. Esse processo alternativo gera mais estresse oxidativo, que acaba se acumulando e danificando membranas, o DNA e as próprias mitocôndrias.

A membrana celular, antes um portal flexível e ativo, passa a ser uma barreira rígida que reduz o fluxo de nutrientes e sinais. A comunicação entre células diminui à medida que essas barreiras ficam menos maleáveis. Até a manutenção do equilíbrio adequado de minerais essenciais (eletrólitos) se torna difícil conforme as funções regulatórias da membrana são reduzidas.

No núcleo, a sobrevivência vira prioridade máxima. As proteínas responsáveis por proteger e reparar o DNA interrompem o trabalho de

manutenção. Somado ao estresse celular crescente, resultado de uma produção de energia menos eficiente, isso deixa o DNA mais vulnerável a danos.

Talvez o mais fascinante seja a forma como a MEC, a rede de suporte entre as células, se transforma durante esse bloqueio. A mesma proteína (galectina-3) que ajuda a reforçar essa estrutura de apoio durante o estresse agora atua como um sinal de perigo, disparando processos inflamatórios e alertando células vizinhas. A MEC deixa de ser uma infraestrutura de suporte e passa a funcionar como um sistema de alerta de emergência, espalhando o comando de apagão para as células ao redor.

A SABEDORIA DO APAGÃO CELULAR

Nossas células são projetadas com a resposta celular ao perigo como um programa instintivo de proteção, fundamentado na mesma lógica de que, ao batermos de frente com o muro da impotência, o apagão passa a ser nossa melhor chance de sobreviver. Esse freio celular explica por que nos sentimos tão pesados e exaustos quando o corpo sofre o apagão. As células literalmente alteram a forma como produzem energia. A sensação de peso é o reflexo direto das nossas mitocôndrias e células reduzindo sua atividade no estado de trauma.

Quando Sarah vivenciou a névoa mental, a exaustão e as emoções anesthesiadas ao lado do leito da mãe, isso refletiu as respostas celulares que aconteceram em seu cérebro, músculos e sistema nervoso. Suas células também vivenciaram uma resposta ao trauma e ativaram seu programa instintivo de proteção diante de uma dor inevitável.

Quando as células chegam ao ponto de ruptura e reduzem seu funcionamento para sobreviver, não é possível simplesmente “forçar a barra” ou “encontrar uma saída racional”. É exatamente assim que muitas pessoas, como Claire, acabam desenvolvendo fadiga crônica ou outros problemas de saúde após anos de grandes “saques” sem fazer depósitos na sua conta de capacidade. Mudar a mentalidade não é eficaz quando seu corpo sofreu um apagão no nível celular. As células precisam de tempo, energia e segurança para se recompor e se abrir novamente para a vida.

No entanto, a resposta ao trauma não acontece apenas no nível celular. O

trauma afeta o corpo inteiro, até no nível dos sistemas. No próximo capítulo, vamos explorar como o corpo vivencia o trauma de maneira coordenada entre todos os seus sistemas: digestivo, imunológico, endócrino, etc. Você vai entender não só o impacto do trauma em todo o organismo, mas também quais sistemas biológicos precisam ser tratados para que tenhamos uma jornada de cura eficaz.

RESUMO

Neste capítulo, recorreremos ao microscópio para observar como nossas células vivenciam o estresse e o trauma. Vimos que cada célula funciona como uma metrópole, com sistemas sofisticados que trabalham em conjunto para manter o equilíbrio. Quando enfrentam o estresse, nossas células geram mais energia por meio de adaptações precisas organizadas pelo estado simpático. Mas, quando são levadas para além da sua capacidade, seja por muita coisa em pouco tempo ou pouca coisa por muito tempo, elas acionam seu próprio freio de emergência por meio da resposta celular ao perigo.

Compreender essas alterações celulares transforma a maneira como enxergamos nossas respostas a experiências de sobrecarga. O que antes poderíamos ter julgado como fraqueza ou reação exagerada são, na verdade, mecanismos de sobrevivência sofisticados que ocorrem no nível celular. Isso explica por que a dor emocional chega a ser tão esmagadora quanto um perigo físico: nossas células respondem a ambos como ameaças à sobrevivência.

Levar a sobrecarga a sério é reconhecer alterações biológicas reais que exigem um suporte específico para que haja cura. No próximo capítulo, veremos como somos impactados pelo trauma não só no nível celular mas no corpo como um todo e o que fazer para apoiar sistemas inteiros.

CAPÍTULO 5

A experiência de sobrecarga que afeta o corpo inteiro

Todo jovem, quando chega a uma percepção clara da verdadeira relação entre corpo e mente e mente e corpo, deve considerar sua saúde tão sagrada quanto seu caráter. E pensar no corpo como uma construção rara e maravilhosa, para que possa estudá-la e enxergar as relações vitais entre a maneira como cuida dela e todo o seu sucesso na vida.

– Frederick M. Rossiter, médico, *The Story of a Living Temple*, 1902

Laura estava prestes a tomar seu café da manhã, ansiosa pelo primeiro gole que a ajudava a despertar todos os dias. Como estava de costas, não viu Nick, seu filho de 3 anos, que veio sonolento em sua direção querendo um abraço. Quando o menino abraçou as pernas dela, Laura pulou de susto e soltou um grito, derramando o café quente. Nick berrou de dor e recuou quando o líquido respingou em suas mãos. O marido, Sean, correu para a cozinha e entendeu de imediato a cena. Em geral era ele quem acionava aquela reação de sobressalto em Laura: bastava entrar de supetão onde ela estivesse ou falar quando ela não estava esperando.

Laura sempre se assustara com facilidade, embora não soubesse o motivo, e tinha vergonha disso. Supondo ser reflexo de algum estresse ou trauma, ela decidiu trabalhar o problema comigo. “Conviver com um marido e duas crianças significa que eu vivo me assustando, geralmente várias vezes por dia”, disse ela com uma risada nervosa, tentando amenizar até que ponto aquilo a incomodava.

Esses sustos frequentes faziam seu corpo inteiro reagir de imediato. A

tensão era palpável, das pernas até o pescoço. O coração acelerava, gerando uma onda de ansiedade, e ela sempre se perguntava se tomar café logo depois de ter um sobressalto era mesmo uma boa ideia. A resposta de corpo inteiro era algo difícil de acalmar.

No entanto, as reações de Laura não se limitavam ao sobressalto. Quando entrava em estado de estresse, seu organismo inteiro mudava: a irritabilidade vinha à tona, o que a fazia comer sem pensar, mesmo sem fome. Sua temperatura subia, o que a obrigava a tirar as blusas de manga comprida que gostava de usar. Sua mente ficava acelerada, assim como os pulmões e o coração.

Nas horas em que se sentia sobrecarregada, a resposta vinha da mesma forma. Nunca era apenas uma questão de alteração de humor ou pensamentos negativos: todo o seu corpo entrava em sobrecarga. Um peso nos músculos a obrigava a passar horas sentada, em momentos nos quais ela normalmente estaria ativa; tinha uma sensação de inchaço e peso na barriga; e sua respiração ficava lenta e superficial. A sobrecarga não se limitava à mente, portanto um simples pensamento não era capaz de afastá-la. Era uma experiência que afetava até mesmo sistemas dos quais ela não estava consciente.

Ela se sentia à mercê do próprio corpo, como se não tivesse qualquer controle sobre ele.

Laura ainda não entendia até que ponto cada uma dessas respostas (sobressalto, estresse e apagão) estava desencadeando mudanças fisiológicas em todo o corpo por meio dos rápidos sistemas de comunicação neural. Quando o estresse a fazia suar, sentir vontade de comer doce e perder a paciência com a família, ele também afetava seus tecidos e órgãos, que entravam no mesmo modo. A sobrecarga não era apenas uma sensação, mas um estado fisiológico integral.

O corpo coordena todos os seus sistemas simultaneamente com base na decisão da neurocepção sobre qual estado de funcionamento nos atenderá melhor. Da produção de energia à defesa imunológica, da digestão ao controle de temperatura, tudo opera em perfeita coordenação. Talvez você tenha percebido como seus estados internos e suas respostas envolvem o corpo inteiro. Já notou que, quando está sob pressão, você sofre alterações no apetite e na saúde da pele, sente palpitações cardíacas ou não consegue pensar com clareza? Ou que a sobrecarga parece tomar toda a sua mente e o

seu corpo, afetando até sua capacidade de se conectar com outras pessoas?

No capítulo anterior, vimos como as células vivenciam individualmente o estresse e a resposta ao trauma, seja energizando seus sistemas, seja reduzindo ao máximo o funcionamento de suas organelas. Agora, vamos explorar como o organismo vivencia integralmente o estresse e o trauma. Isso nos ajudará a entender melhor o impacto total do trauma na mente e no corpo e por que apenas processar experiências ou tentar mudar nossos pensamentos não basta. Cuidar da nossa biologia é essencial na jornada de cura.

O PROPÓSITO UNIFICADO DO CORPO

Nosso corpo coordena todos os seus sistemas simultaneamente, seguindo a orientação da neurocepção sobre qual o melhor estado de funcionamento a cada situação. Cada estado tem um propósito específico que exige a participação total e coordenada de nossos órgãos, tecidos e sistemas. No estado calmo-ativo, por exemplo, todos os sistemas se unem para propiciar descanso, digestão, conexão e criatividade. Já o estado de mobilização prioriza velocidade e ação – a própria anatomia da cadeia simpática garante que nenhum sistema deixe de contribuir para esse estado de alta energia. Por fim, quando entramos no estado de trauma, toda a biologia se reorganiza para dar suporte ao apagão e à sobrevivência.

Essa união em torno do mesmo propósito que envolve todo o corpo é essencial. Se a digestão permanecesse ativa durante o enfrentamento de um perigo, ou se o sistema imunológico ficasse em modo de defesa durante o descanso, não conseguiríamos cumprir a função de nenhum desses estados de forma eficaz. Nossa anatomia possibilita essa coordenação por meio de redes de comunicação altamente sofisticadas.

A anatomia da comunicação coordenada

O corpo humano, assim como um carro, possui um acelerador e dois freios: o do pedal e o de mão. Assim como frear ou acelerar um carro produz respostas imediatas, esses sistemas no corpo geram respostas instantâneas

em todo o organismo. Mas acelerar, ou entrar em estado de mobilização, sem um sistema de freios seria perigoso. Portanto, assim como o carro tem o freio do pedal e o de mão, o corpo também possui duas formas distintas de frear.

A diferença é que, no corpo, ambas as estratégias de frenagem são transmitidas pelo mesmo nervo: o nervo vago.

O primeiro mecanismo de frenagem, cujo termo científico é vago ventral, serve para equilibrar a ativação por meio de uma oposição suave, como desacelerar pisando no freio. Quando nos sentimos seguros, esse freio reduz a ativação e nos permite seguir na velocidade de cruzeiro, em um estado de conexão. O freio de mão, conhecido como vago dorsal na teoria polivagal, entra em ação quando ultrapassamos o limite crítico da sobrecarga. Embora ambos usem o mesmo nervo para transmitir seus sinais, eles se originam em regiões diferentes do cérebro e servem a propósitos distintos de sobrevivência.

Esses sistemas de comunicação diferentes nos permitem trocar de estado rapidamente. Alex, por exemplo, entrou na sala de reuniões em estado calmo-ativo e, um minuto depois, estava em estado de trauma após as notícias sobre a reestruturação. No caso de Laura, a mudança foi ainda mais rápida do estado calmo-ativo enquanto preparava café para a mobilização após o abraço repentino de Nick. Nos bastidores, o sistema de comando do corpo estava fazendo exatamente o que foi programado para fazer: coordenar todos os sistemas para funcionarem juntos em um estado específico.

A anatomia da mobilização

O estado de mobilização proporciona o pico de energia e o impulso necessários quando precisamos reagir a um desafio ou perigo. Seu funcionamento e sua comunicação acontecem por meio de uma rede de nervos chamada de cadeia simpática. Como os trilhos de um trem de alta velocidade, esses nervos percorrem toda a extensão da coluna vertebral, formando as vias de comunicação mais velozes que temos. São eles os responsáveis por promover a coordenação rápida de todo o corpo e de seus sistemas individuais em um estado altamente energizado de mobilização.

A resposta de Sarah quando viu a mãe entrar em parada cardíaca na UTI é um exemplo perfeito desse sistema. Naquele momento crítico, seu corpo inteiro entrou em mobilização antes mesmo que ela tivesse tempo de pensar. Ela chamou ajuda, correu para pegar o carrinho de emergência e se posicionou para iniciar a massagem cardíaca; tudo com velocidade e precisão sobre-humanas. Não foi apenas adrenalina; sua cadeia simpática coordenou uma mobilização completa e sistêmica.

Três características fundamentais desse sistema de comunicação nos permitem reagir rapidamente em emergências. Primeiro, ele usa uma linha direta, como se tivéssemos um trilho de trem-bala ao longo da coluna vertebral, permitindo que os sinais cheguem a todas as partes do corpo em milissegundos. Segundo, ele conta com um revestimento isolante, espesso e gorduroso chamado mielina, que acelera a condução dos sinais. Terceiro, ele mantém estações locais chamadas gânglios, pontos de apoio que garantem que a mensagem de mobilização mantenha a velocidade e a potência até chegar aos tecidos. Essa arquitetura sofisticada permite que os sinais viajem do cérebro aos músculos e órgãos em frações de segundo.

O sistema de mobilização cria mudanças imediatas e sustentadas por todo o corpo. Primeiramente, ocorre um pico de noradrenalina, que coloca o corpo em ação e dispara a produção de energia. Em poucos segundos, o organismo é inundado pela adrenalina, o que gera aquela sensação familiar de força, agilidade e hiperfoco. Foi por isso que Sarah conseguiu pensar com clareza suficiente para preparar tudo de que a equipe médica iria precisar, mesmo em um momento de tamanha carga emocional.

O sistema de comunicação simpático é tão eficiente que consegue manter o estado elevado de estresse em todos os sistemas corporais. O coração de Sarah bateu mais rápido para fornecer mais oxigênio, enquanto a respiração acelerou para sustentar a produção energética. O fluxo sanguíneo foi direcionado para os músculos, enquanto a digestão desacelerou para priorizar a sobrevivência. Seu cérebro permaneceu hiperfocado, o que lhe permitiu deixar tudo preparado para a chegada da equipe da UTI.

A anatomia do sistema de frenagem

Se a anatomia da cadeia simpática é projetada para ativação rápida, o nervo

vago é projetado para cumprir a função oposta: frear. O que torna o nervo vago diferente de qualquer outra via de comunicação no corpo é sua capacidade de exercer duas formas distintas de frenagem: uma suave, para segurança, e outra de emergência, para desligar o sistema. O nervo vago começa no tronco encefálico e se divide em dois ramos, direito e esquerdo, que descem por ambos os lados do pescoço, atravessam o tórax e alcançam o abdômen, com raízes que chegam até a pelve. Da cabeça à pelve, sua anatomia ramificada explica por que o corpo inteiro consegue entrar em modo de segurança ou apagão como uma só unidade.

Certos ramos controlam os músculos do rosto, da garganta e da laringe; por isso nossas expressões faciais e nossa voz mudam de maneira tão drástica dependendo do estado em que estamos. Outros alcançam o coração e os pulmões, o que explica por que nossos padrões de respiração e batimentos cardíacos se alteram quando transitamos entre os estados. E ainda há ramos que se estendem abaixo do diafragma para se comunicar com o sistema digestivo, criando uma conexão íntima entre estado emocional e funcionamento intestinal.

Quando Laura está tomando seu café da manhã com Sean, o vago ventral aplica um freio suave para balancear a mobilização, permitindo que ela se sinta calma e conectada. Esse freio se manifesta por meio de expressões faciais relaxadas, respiração estável e digestão tranquila. No entanto, em momentos de sobrecarga, o vago dorsal aciona seu freio de emergência, produzindo um apagão sistemático. Os músculos faciais perdem tonicidade, tornando nossa expressão menos receptiva. Temos a sensação de nó na garganta, que fica contraída, como aconteceu com Sarah ao tentar responder à colega, e com Elena quando teve dificuldade para falar sobre a vergonha que carregava desde a infância. A digestão se torna mais lenta, e podemos nos sentir empanturrados, inchados ou ter refluxo gástrico. Todas essas reações não são eventos isolados, mas manifestações de uma anatomia que se comunica de forma coordenada para realizar um apagão sistêmico e garantir nossa proteção.

RESPOSTAS COORDENADAS DOS SISTEMAS DO CORPO

Quando entendemos a anatomia dessa comunicação, fica mais fácil ver por que uma resposta emocional está diretamente ligada às nossas sensações físicas e à nossa saúde. Nossas emoções são vivenciadas no contexto do estado do nosso sistema nervoso. Assim, quando estamos relaxados e conectados, como Laura enquanto preparava seu café, ou Alex ao entrar na sala de reunião naquele dia, o estado calmo-ativo toma conta do corpo inteiro. Da mesma forma, os estados de mobilização e de trauma também envolvem todo o corpo.

Pesquisas mostram que é a nossa biologia que *cria* as experiências emocionais. Quando nos sentimos sobrecarregados, muitas vezes é porque o corpo já entrou na fisiologia do trauma, que altera as funções biológicas de cada um de nossos sistemas. Vamos observar alguns deles e o papel que cada um desempenha nessa sinfonia da sobrevivência.

Metabolismo: do pico de energia ao modo de economia

O metabolismo é um dos primeiros sistemas a responder ao sinal de perigo da neurocepção, já que é responsável por gerar o pico de energia. Embora as mitocôndrias em cada célula produzam essa energia, o metabolismo é o sistema biológico mais amplo que organiza a resposta do corpo como um todo. Quando a cadeia simpática aciona a mobilização, os processos metabólicos em todo o organismo se coordenam para gerar o aumento energético.

Essa mudança metabólica pode ser sentida no dia a dia. Quando Laura se assustou com o abraço inesperado de Nick, seu corpo inteiro se energizou de imediato: o coração acelerou, a respiração ficou mais rápida, a temperatura corporal subiu. Foi um choque metabólico instantâneo. Durante respostas de estresse mais prolongadas, percebemos sinais de que nosso metabolismo está acelerado: suamos mais, sentimos calor e queremos comer doce, pois o corpo busca energia rápida.

No entanto, quando cruzamos o limite crítico da sobrecarga e entramos no estado de trauma, o metabolismo coordena uma resposta muito

diferente. Evidências científicas mostram que, em vez de aumentar a produção de energia, nossas células entram em um modo de economia. Sentimos isso na exaustão pesada que se instala nos músculos, na queda perceptível da temperatura corporal e na fadiga profunda que não passa por mais que descansemos. Quando entrou em sobrecarga, Laura percebeu nitidamente essa mudança: sua energia habitual desapareceu, substituída por um peso que a obrigava a passar horas sentada, mesmo em momentos nos quais normalmente estaria ativa.

Essa coordenação metabólica demonstra a precisão com que o corpo ajusta todos os sistemas para cumprir a função de cada estado. No estado de mobilização, o metabolismo sustenta a necessidade de energia rápida e ação. No de trauma, ele facilita o apagão dos sistemas, apoiando a sobrevivência.

Funcionamento cerebral: do foco total à névoa protetora

O contraste entre as respostas de estresse e de trauma fica especialmente evidente no funcionamento do cérebro. A combinação de adrenalina e dopamina cria um estado de hiperfoco durante o estresse, ao passo que a inflamação provoca fadiga mental e uma névoa cognitiva protetora na resposta de trauma.

Como enfermeira de UTI, Sarah dependia da resposta de estresse para que o cérebro funcionasse da maneira ideal. Quando comandava um protocolo de parada cardíaca, esse estado lhe permitia recordar e executar cada passo com precisão, levando-a a salvar vidas. Sob o efeito da adrenalina e da dopamina, ela tinha mais clareza mental que nunca.

Essas diferenças marcantes entre as respostas de estresse e de trauma no cérebro podem ajudar a avaliar o estado do nosso sistema nervoso. Quando o corpo de Sarah entrou no estado de trauma, seu cérebro passou do foco total para a névoa mental e a fadiga. Ela se sentiu deprimida, com pensamentos sombrios e pessimistas. Isso ocorreu porque a inflamação cerebral altera a química do cérebro, diminuindo os níveis de serotonina, dopamina e GABA (ácido gama-aminobutírico, um neurotransmissor), que normalmente nos proporcionam a sensação de bem-estar.

Sistema imunológico: do foco na defesa à resposta caótica

As funções do sistema imunológico mostram outro forte contraste entre o estado de estresse e o estado de trauma. Assim como nossa força física aumenta no estado de mobilização, as funções imunológicas também se intensificam. A adrenalina mobiliza células imunológicas do baço e dos linfonodos como parte do pico de energia para enfrentar e superar o perigo.

O cortisol também contribui para melhorar o desempenho do sistema imunológico durante o estresse. Ele inibe a inflamação, por isso é usado em emergências, como crises de asma ou sintomas autoimunes, para manter as respostas inflamatórias sob controle.

Embora geralmente só notemos a ação do sistema imunológico quando ficamos doentes, seus padrões são uma pista do papel que ele desempenha nas respostas de estresse e de trauma. É comum atravessarmos um período intenso de estresse, como um prazo apertado ou provas finais, e adoecermos logo depois. Isso acontece porque a combinação de adrenalina e cortisol fortalece temporariamente o sistema imunológico e inibe a inflamação. No entanto, quando o estresse acaba e a ação inibitória do cortisol desaparece, o sistema imunológico passa por um período de vulnerabilidade e exaustão.

Quando o corpo cruza o limite crítico e entra no estado de trauma, também liberamos o que o cortisol estava inibindo. Fora do estado de mobilização, o cortisol perde boa parte da sua eficácia com o sistema imunológico em estado de trauma, e a inflamação deixa de ser controlada. Ficamos mais suscetíveis a infecções e mais sensíveis. Se essa desregulação imunológica se mantiver por muito tempo, haverá confusão sobre o que deve ser combatido. Nossos tecidos poderão se tornar alvos, o que levará a vários tipos de doença autoimune.

Não é que um único evento – como um acidente de carro, uma situação de abuso sexual ou a impotência que Elena vivenciou na infância – cause diretamente uma doença autoimune. É a fisiologia do trauma, com sua resposta imune caótica e prolongada, que cria o terreno propício para a autoimunidade, como permeabilidade intestinal, sobrecarga de toxinas e comprometimento mitocondrial.

Sistema digestivo: da pausa estratégica à disfunção

Como nosso intestino é considerado um segundo cérebro, com uma vasta rede de nervos (a maior fora do cérebro), o impacto das mudanças de estado no sistema digestivo é profundo. Tanto nas respostas de estresse quanto nas de trauma a digestão desacelera, mas de maneiras diferentes.

Durante a resposta de estresse, o sistema digestivo entra em uma pausa estratégica, como se estivesse dando um tempo. Primeiro com a noradrenalina e depois com a adrenalina, a cadeia simpática redireciona rapidamente o fluxo de sangue do intestino para os músculos e o cérebro. Durante esse pico de energia, o corpo entende que aquele não é momento de comer, mas de agir e resolver o problema. Assim, a digestão fica temporariamente em segundo plano para dar lugar à necessidade mais urgente de sobreviver. O sistema digestivo continua funcional, mas em suspenso até que o perigo passe.

Naquela manhã na UTI, enquanto a mãe entrava em parada cardíaca, a última coisa que passava pela mente de Sarah era se estava com fome. Na verdade, o estado de mobilização pode causar náusea, mas, como estamos hiperfocados no perigo, muitas vezes nem percebemos.

No entanto, quando cruzamos o limite crítico da sobrecarga, o sistema digestivo sofre algo bem mais radical. O nervo vago coordena uma mudança drástica na função digestiva: o fluxo sanguíneo deixa de ser apenas reduzido e fica estagnado. Os músculos que normalmente realizam contrações ondulantes para mover o alimento relaxam. Até a barreira protetora do intestino se altera, tornando-se porosa, ou desenvolvendo a chamada síndrome do intestino permeável, que leva à inflamação.

Nos dias seguintes àquela manhã na UTI, Sarah sentia a barriga cheia e inchada. Nada que comia lhe caía bem, como se a refeição demorasse horas para ser digerida. Sua digestão não estava apenas em pausa, pois, no estado de trauma, o intestino se torna disfuncional. A conexão íntima entre intestino e cérebro, mediada pelo nervo vago, explica por que sentimos nas entranhas experiências emocionais e por que um trauma afeta tão intensamente nossa digestão.

Essa conexão também explica por que os sintomas digestivos tendem a melhorar conforme ajudamos o sistema nervoso a voltar ao estado de segurança. O intestino não está somente reagindo às emoções: ele atua de

forma crucial na criação delas em cada estado de funcionamento do nosso sistema nervoso.

CONGELAMENTO: A TENSÃO INTERNA

Agora que você entende como o corpo coordena diferentes estados de funcionamento, vamos examinar um momento singular: o congelamento. Essa etapa da resposta ao trauma é a única em que múltiplos estados operam ao mesmo tempo. Quando exploramos os três estados de funcionamento no Capítulo 3, vimos que o congelamento é o momento em que ainda estamos pisando fundo no acelerador, em pleno estado de mobilização, mas, ao mesmo tempo, já puxamos o freio de mão do estado de trauma.

A experiência interna e a fisiologia do congelamento são muitas vezes mal interpretadas e rotuladas erroneamente como uma reação de luta ou fuga. Mas o congelamento é algo distinto. A reação de luta ou fuga ainda faz parte do pico de energia do estresse; já o congelamento combina esse pico com o acionamento do freio de mão. A simultaneidade da aceleração e da frenagem cria uma experiência interna muito específica: pânico e paralisia ao mesmo tempo. Podemos nos ver incapazes de falar ou nos mover, sem ação diante de acontecimentos inconcebíveis ou inevitáveis.

No entanto, uma vez que esses estados fisiológicos opostos atuam simultaneamente, nem sempre congelamos por fora. Podemos continuar agindo ou nos movendo enquanto, por dentro, estamos paralisados e em choque. Penso na experiência do meu avô durante o genocídio armênio de 1915. Um dia, ele contou sua história aos fiéis da igreja na qual era pastor. Quando menino, foi forçado a atravessar o deserto em uma marcha da morte. Seus avós foram assassinados na sua frente por estarem atrasando o grupo. Horrorizado, em choque e internamente paralisado, ele ainda assim foi obrigado, sob o fio da espada, a continuar caminhando.

A experiência dele revela a sabedoria e a capacidade incríveis do corpo para saber o que fazer. De maneira rápida e inconsciente, todo o seu organismo se organizou para o estado de funcionamento que oferecia a melhor chance de sobrevivência às exigências físicas e emocionais de uma marcha da morte, fosse ele um estado calmo-ativo, um estado de

mobilização ou um estado de trauma.

Sabendo como o corpo humano é sábio, fica uma pergunta: como o apagão nos ajuda a sobreviver? Por que o corpo coordenaria um desligamento fisiológico completo, nos níveis celular e sistêmico, justamente quando estamos impotentes? Se o objetivo é sobreviver, que vantagem poderia haver em congelar ou reduzir seu funcionamento ao mínimo?

A resposta está em três mecanismos de sobrevivência incríveis que exigem esse tipo de resposta precisa do nosso corpo. No próximo capítulo, vamos descobrir quais são esses mecanismos e como eles nos permitem sobreviver ao entrar em apagão.

RESUMO

Nosso corpo garante a sobrevivência por meio de uma união em torno do mesmo propósito. Cada estado de funcionamento – seja dar suporte ao descanso e à conexão, possibilitar ação rápida ou nos proteger por meio do apagão – exige que todos os sistemas biológicos atuem em perfeita sintonia. Guiado pela neurocepção, que faz cálculos em segundo plano o tempo todo, o corpo transita entre esses estados, com cada sistema desempenhando o devido papel para agir em conjunto.

Compreender essa finalidade unificada explica por que o trauma afeta toda a nossa biologia – não apenas no nível das células e das mitocôndrias, mas no nível sistêmico. Quando ficamos sobrecarregados, não se trata apenas de uma reação emocional, mas de uma mudança completa no modo de funcionamento de todos os sistemas. O metabolismo desacelera, o cérebro cria uma névoa protetora, o sistema imunológico perde a coordenação e a digestão é suspensa. Embora isso se manifeste em sintomas distintos, não são reações separadas, mas sim partes de uma única e sofisticada resposta de sobrevivência.

No próximo capítulo, veremos como essa participação unificada de todos os sistemas biológicos nos proporciona a melhor chance de sobreviver quando nos vemos impotentes diante de uma ameaça.

CAPÍTULO 6

Os três mecanismos de sobrevivência: como nosso corpo resiste à impotência

Vulnerabilidade é a suscetibilidade a sermos feridos. Essa fragilidade é parte inevitável da nossa natureza. O máximo que o cérebro pode fazer é desligar a consciência quando a dor se torna tão intensa ou insuportável que ameaça superar nossa capacidade de funcionar.

– Gabor Maté, *O reino dos fantasmas famintos*

“**E**u sempre odiei o que fiz, que foi ter aguentado tudo calada, sem nunca contar a ninguém.”

Elena estava sentada, olhando para baixo, a voz tentando vencer um nó na garganta. Finalmente compreendia a origem de uma vergonha que havia carregado a vida inteira. Enquanto ela arrancava pequenos fiapos da calça de ioga sem pensar no que estava fazendo, eu esperei, sem querer pressioná-la nem colocar palavras em sua boca. Aquele era um momento crucial em sua reconexão com o corpo.

“Ainda consigo me ver como aquela menina, escondendo-se com minhas bonecas, quieta, imóvel e completamente apavorada.” Ela fechou os olhos, como se visse aquela garotinha diante de si. Lágrimas quentes começaram a escorrer. “Como ele teve coragem de me assustar e me machucar daquele jeito? Eu queria ter feito alguma coisa, queria ter revidado.” Todo o seu corpo estremeceu, e ela apertou uma almofada contra a barriga. Graças às práticas somáticas da Jornada Estruturante, ela estava aprendendo a ajudar o próprio corpo a lidar com emoções intensas. “Mas agora eu sei que meu

corpo só estava tentando me manter viva.” Ao dizer isso em voz alta, um alívio visível se espalhou pelo seu semblante e seus ombros relaxaram. Ela abriu e ergueu os olhos e, em um gesto involuntário, deu um suspiro profundo.

Embora Elena tivesse iniciado sua jornada para “lidar com” o trauma que havia contribuído para seu diagnóstico de doença autoimune, ela estava descobrindo anos de equívocos sobre si mesma. Estava claro que a história de sobrecarga do seu corpo começara muito antes daquele dia em que o carro derrapou na pista. Criada por uma mãe solo que tinha jornadas longas de trabalho, Elena passava muito tempo sozinha com o namorado da mãe, sem ter como escapar dos seus acessos de fúria e de episódios ocasionais de agressão física. Ela sabia que não tinha como lutar contra um homem adulto e não queria preocupar a mãe, que já precisava lidar com tantos problemas. A jovem Elena se sentia encurralada, incapaz de impedir o que lhe acontecia.

Naqueles momentos de impotência, seu corpo sabia exatamente o que fazer. Ele acionava os três mecanismos de sobrevivência que estão por trás de toda resposta ao trauma, ajudando-a a sobreviver fisicamente à infância. É verdade que esses mesmos mecanismos cobrariam um preço por isso. Ela desenvolveria cicatrizes emocionais profundas, que se manifestariam na forma de uma doença autoimune por volta dos 40 anos, no divórcio, nas dificuldades de cultivar intimidade e em um perfeccionismo implacável.

Conforme foi se reconectando com seu corpo, Elena conseguiu reconhecer esses mecanismos que lhe permitiram sobreviver a uma infância dolorosa. Por meio das práticas da Jornada Estruturante, ela aprendeu a ajudar o próprio corpo a lidar com emoções intensas. Permitiu-se sentir e se libertar da vergonha de ter permanecido em silêncio, de nunca ter revidado, de ter passado horas em mundos imaginários para escapar. Finalmente entender a sabedoria por trás dessas respostas primitivas lhe devolveu a capacidade de amar a si mesma.

Quando nossa neurocepção entra em cena para nos ajudar a sobreviver à impotência, seja na infância ou na vida adulta, a resposta ao trauma não acontece ao acaso. Ela é concebida para proteger nossa integridade física por meio de três mecanismos unificados. Assim como cada uma das cinco etapas da resposta ao trauma cumpre um papel específico, cada mecanismo também tem sua função para nos manter vivos, independentemente dos

custos emocionais, mentais e físicos que virão depois caso não haja reparação.

Compreender esses três mecanismos – dissociação, imobilização e conservação de energia – revela a camada mais profunda da sabedoria de sobrevivência do nosso organismo. Eles explicam como suportamos o intolerável, e seus padrões nos ajudam a reconhecer quando nosso corpo está em uma resposta ao trauma, mostrando como podemos apoiá-lo de modo eficaz ao longo da jornada de cura.

OS TRÊS MECANISMOS DE SOBREVIVÊNCIA DIANTE DA IMPOTÊNCIA

Como sobrevivemos ao que parece insuportável? Quando nos deparamos com uma ameaça inescapável e percebemos que não há mais nada que possamos fazer, o corpo sabe a resposta: nós nos rendemos para sobreviver.

Essa rendição acontece quando batemos de frente com o muro: o ponto da resposta instintiva ao trauma em que tudo muda. É o instante em que percebemos nossa impotência, o que desencadeia um de nossos medos mais profundos, que é estar totalmente à mercê de forças que não podemos controlar. O muro serve de gatilho para a experiência interna de sobrecarga, e ela é tão convincente e intolerável que dispara a resposta ao trauma. A neurocepção faz o cálculo rapidamente: nossa capacidade foi excedida. Lutar ou fugir, além de não poderem nos salvar, agora também são opções perigosas. O congelamento e o apagão se tornam nossa rendição.

Elena havia vivenciado essa rendição instintiva muitas vezes ao longo da vida. Na verdade, ela descobriria que essa história se iniciara antes mesmo do acidente de carro e das experiências traumáticas da infância. Em cada um desses momentos, seu corpo sabia instintivamente que a situação estava fora do seu controle. Quando a própria sobrevivência parecia duvidosa, ele acionava seus três mecanismos por meio da resposta ao trauma para lhe dar a melhor chance possível. É paradoxal, mas a melhor chance de sobreviver é, muitas vezes, render-se.

Vamos analisar os três mecanismos de sobrevivência presentes em toda resposta ao trauma: dissociação, imobilização e conservação de energia. Cada um cumpre um propósito distinto, mas todos convergem na mesma

intenção de garantir a sobrevivência física, por maior que seja o custo posterior para o corpo.

Dissociação: a sabedoria do afastamento

Quando somos fisicamente incapazes de fugir, o corpo oferece outra saída: a fuga mental. A dissociação é a maneira engenhosa do corpo de se distanciar daquilo que seria insuportável sentir. Trata-se de um mecanismo de sobrevivência sofisticado que nos permite parar de nos preocupar com o que não podemos controlar.

Pense na dissociação como o disjuntor emocional do corpo. Assim como um disjuntor corta a energia para evitar possíveis danos causados por uma sobrecarga elétrica, a dissociação corta nossa presença para nos proteger da sobrecarga emocional. Esse distanciamento pode ser tão profundo que algumas pessoas têm a sensação de estar assistindo ao que acontece com elas como se estivessem fora do próprio corpo.

A dissociação se manifesta de várias formas. Podemos ter a sensação de que o tempo ficou mais lento, como aconteceu com Alex na sala de reuniões; ou de estarmos em um sonho, como o que Sarah vivenciou junto ao leito da mãe. Podemos nos sentir desconectados do mundo ao nosso redor, como Elena após o acidente de carro. Podemos ficar emocionalmente anestesiados ou distantes, para nos protegermos de sentimentos esmagadores. Em alguns casos, podemos até deixar de sentir o que está acontecendo – um nível profundo de proteção quando não há como escapar fisicamente.

Sem conseguir evitar o impacto iminente do carro, a mente de Elena se distanciou de uma realidade insuportável. As vozes ao redor pareciam vir de muito longe, o tempo ficou distorcido e mais tarde ela não conseguia se lembrar dos detalhes. Era o seu corpo ativando a dissociação para protegê-la, mantendo-a longe o bastante para ajudá-la a sobreviver a algo inevitável.

Quando dissociamos nesses momentos de sobrecarga, nossas lembranças muitas vezes se fragmentam e fica difícil uni-las em uma narrativa coesa. Por isso Elena tinha dificuldade para se lembrar tanto do acidente quanto de partes da infância. Essas lacunas não eram falhas de memória, mas a maneira que seu corpo encontrou de se proteger de sentimentos que seriam intoleráveis.

Somente anos depois, em um workshop de arteterapia, Elena finalmente compreendeu a sabedoria profunda dessa resposta corporal. Ao revisitar essas memórias, seu corpo tremeu, as lágrimas voltaram a fluir e ela percebeu uma verdade poderosa: “Eu fui forte, não fraca. Fiz o que precisava para sobreviver.”

Quer a dissociação apareça na forma de “sair do ar” em reuniões difíceis, sentir-se desconectado durante um conflito ou ter problemas para recordar os detalhes de uma experiência de sobrecarga, ela é a maneira que o nosso corpo encontra de criar uma distância vital quando a fuga física não é possível.

Imobilização: a sabedoria da quietude

A imobilização é outro mecanismo de sobrevivência da resposta instintiva do corpo ao trauma. Ela começa no congelamento e se prolonga até a etapa seguinte, o apagão. É mais uma resposta que envolve o corpo inteiro, incluindo a desaceleração da respiração e a diminuição da motilidade digestiva. É muito mais que simplesmente ficar parado: trata-se de uma experiência interna de imobilidade.

O que torna esse estado particularmente desafiador é que ele contraria o instinto que temos de lutar ou fugir diante do medo. O medo costuma nos impelir à ação, mas a imobilização nos impede de tomar medidas coordenadas nesse sentido. Isso acontece porque a resposta de trauma, como vimos nos capítulos anteriores, é mais potente que a resposta de estresse. O freio de mão se sobrepõe ao acelerador à medida que a neurocepção, o condutor dos três estados do nosso sistema nervoso, decide que ficar parado em vez de agir é nossa melhor chance de sobrevivência.

Na natureza, o benefício da imobilização para a sobrevivência é nítido. Quando um animal pequeno não consegue correr mais do que seu predador, ficar imóvel pode impedir que ele seja notado. Nosso corpo carrega essa mesma programação instintiva. Ao ficarmos quietos e até diminuirmos a respiração, podemos não chamar a atenção para nós mesmos quando estamos em perigo. Se formos notados em uma situação de impotência, isso pode comprometer nossa sobrevivência.

A imobilização, porém, não se restringe a uma paralisia física. Emoções

como medo ou vergonha podem ficar cristalizadas tanto no corpo quanto na mente. Certos aspectos da nossa experiência podem permanecer imobilizados, formando aquilo que sentimos como fragmentos de nós mesmos e de nossas narrativas. É como se parte de nós se mantivesse estagnada ou congelada no tempo. Foi isso que Elena descobriu ao se aprofundar em sua jornada de cura: uma parte de si ainda estava congelada como uma garotinha impotente que não sabia que havia sobrevivido.

Claire também teve a ajuda desse mecanismo de sobrevivência, tanto na infância quanto na vida adulta ao lutar contra a fadiga crônica. A princípio, ela não se identificava com a palavra “trauma”, mas, em nosso trabalho juntas, se conectou com uma versão mais jovem de si mesma que ainda esperava ser vista e amada pela mãe. Essa parte sua continuava presa à infância, congelada na experiência do desamparo de não ser vista ou amada. A fadiga de Claire, quando vista sob esta ótica, remontava a essa memória somática, a memória da impotência dos seus músculos incapazes de agir. Ela precisava voltar no tempo e “resgatar” aquela parte sua que ainda era uma garotinha.

Compreender a imobilização como um mecanismo de sobrevivência, não como fraqueza, transforma a maneira como enxergamos as reações do nosso corpo. Quer a imobilização se manifeste como uma paralisia física durante determinada experiência ou surja diante de um conflito ou ao recebermos críticas, ela é um dos mecanismos de sobrevivência mais poderosos do nosso corpo para nos proteger quando estamos desamparados.

Conservação de energia: a sabedoria de desligar

O terceiro mecanismo de sobrevivência que o nosso corpo aciona diante da impotência é talvez o mais incompreendido: a conservação de energia. Não faz sentido para o nosso cérebro lógico que comecemos a “não nos importar” ou a não fazer nada em resposta ao perigo, mas, no momento em que estamos diante de um muro e lutar se torna inútil, o corpo muda de estratégia de sobrevivência. Em vez de lutar para sobreviver, o corpo se rende para sobreviver. A estratégia agora é preservar energia em vez de utilizá-la. É sábio “puxar o fio da tomada” para preservar uma energia

preciosa que pode ser necessária mais tarde.

Esse mecanismo de sobrevivência é o que fica mais evidente em todos os níveis que discutimos. O corpo como um todo deixa de produzir e utilizar energia para conservá-la. Durante a resposta ao trauma, o sinal vagal dorsal praticamente desliga os sistemas, reduzindo suas atividades ao mínimo para garantir a sobrevivência, e nada além disso. Isso faz sentido quando consideramos o que ocorre em nossas células e mitocôndrias durante a resposta celular ao perigo. Quando detectam que são incapazes de acompanhar a demanda, as células começam a entrar em colapso. Sem poder mais produzir tanta energia, o corpo precisa desligar sistemas, pois as reservas estão baixas. No nível celular, menos energia é produzida, enquanto no nível dos sistemas fisiológicos menos energia é utilizada. Ao usar menos energia, preservamos o pouco que ainda produzimos caso surja uma oportunidade de escapar.

No entanto, existe outra estratégia de sobrevivência nesse mecanismo de conservação de energia; ela cumpre um propósito específico de sobrevivência, instintivo para todos os mamíferos. Ao produzir menos energia, o corpo gera menos calor, tornando-nos mais difíceis de detectar. O fato de nossa respiração se tornar superficial e lenta durante a imobilização cumpre um propósito secundário semelhante: se não nos movermos, respirarmos o mínimo possível e não gerarmos calor, talvez não sejamos vistos.

Os efeitos dessa conservação de energia são profundos e impactam mente e corpo como um todo. Lembra-se de como Elena se sentiu fria e pesada após o acidente e de como Laura sentiu frio apesar de o dia estar quente? Lembra-se da névoa mental de Alex após o ocorrido na sala de reuniões, quando ele ficou olhando para o computador incapaz de se concentrar? Ou de como a fadiga crônica de Claire lhe dava a sensação de que suas “pilhas” tinham sido removidas? São expressões desse mecanismo de sobrevivência em ação: o corpo desligando para nos ajudar a sobreviver ao que não conseguimos superar.

É como se, depois de passar pelo congelamento e pelo apagão, todo o nosso corpo hibernasse. Assim como um animal hibernando diminui todas as funções não essenciais para sobreviver a condições adversas, nosso corpo desliga para sobreviver a circunstâncias emocionais ou físicas que parecem insuportáveis. Essa hibernação se manifesta de várias formas no corpo e na

mente. Você pode sentir calafrios apesar de estar calor, já que o metabolismo desacelera para economizar energia; ou o peso de uma exaustão e fadiga que parecem inexplicáveis e não passam mesmo depois de descansar. À medida que o cérebro desacelera, você pode sentir uma névoa mental se instalar, o que torna mais difícil pensar e tomar decisões. Pode se ver seguindo instruções sem resistência, em vez de desperdiçar energia lutando ou tentando entender o que está acontecendo (o corpo sabe que obedecer sem pensar pode ser a forma mais segura de sobreviver quando estamos impotentes).

O mecanismo de conservação de energia também pode deixar nosso rosto inexpressivo, à medida que os músculos usados para a interação social evitam gastar energia preciosa. O sistema digestivo reduz seu funcionamento para conservar energia; essa lentidão no processo de digestão e absorção de alimentos pode resultar em inchaço, desconforto, diarreia ou prisão de ventre. Durante uma sessão somática, quando perguntei à Elena o que seu corpo teve vontade de fazer durante suas experiências na infância, ela respondeu: “Apenas ficar em posição fetal.” Esse instinto de se encolher e conservar energia é algo comum, que está enraizado em nossa programação de sobrevivência.

Pode ser muito desconfortável sentir a mente e o corpo desligando. O mecanismo de sobrevivência diante da impotência é muitas vezes confundido com preguiça ou depressão. Laura, sentada no sofá cuidando não apenas do tornozelo machucado, mas também de sua sobrecarga interna, sentia culpa por “ser preguiçosa”. Claire, com sua fadiga, ficava frustrada com o próprio corpo, achando que ele estava se entregando.

Compreender a conservação de energia como um mecanismo de sobrevivência decidido pela nossa neurocepção explica por que não conseguimos simplesmente mudar a mentalidade, nos forçar a superar a fadiga ou “dar a volta por cima”. Nosso corpo não está sendo preguiçoso ou difícil; ele está usando seus mecanismos de sobrevivência mais poderosos para nos manter vivos diante da impotência.

RECONHECENDO ESSES MECANISMOS DE SOBREVIVÊNCIA NO COTIDIANO

Embora tenhamos explorado esses mecanismos de sobrevivência usando como exemplo experiências intensas, como o acidente de carro de Elena e a perda vivida por Sarah, eles costumam aparecer de forma mais sutil na vida diária. Na verdade, esses mecanismos são bem mais comuns em nosso cotidiano do que a maioria de nós percebe; simplesmente fomos ensinados a classificá-los como estresse, traços de personalidade ou estratégias de enfrentamento. Quando aprendemos a reconhecê-los, podemos identificar momentos em que nossa neurocepção percebe uma situação de impotência, mesmo que não estejamos conscientes disso. Vamos analisar como esses mecanismos de sobrevivência se manifestam no dia a dia.

A dissociação, definida como uma fuga mental ou emocional, pode surgir de formas que passamos a considerar normais. Observe momentos em que você não está totalmente presente, mas usando algo como uma forma de escape. Sua mente pode se distrair e vagar durante uma conversa, uma palestra ou enquanto lê um livro. Ficar rolando o feed no celular, evitar algo que precise fazer, começar a “viajar” enquanto assiste a um filme ou ter dificuldade em lembrar detalhes do seu dia porque você não estava totalmente presente: tudo isso são indícios de dissociação. Esses momentos de ausência mental, que muitas vezes subestimamos como simples cansaço ou distração, são sinais reconhecíveis de que estamos começando a ficar sobrecarregados.

A imobilização também aparece com frequência no cotidiano; ela se manifesta quando não conseguimos seguir adiante. Aquele projeto que você simplesmente não consegue começar? Procrastinação? Ficar sentado por horas, como se não precisasse ou não quisesse mexer o corpo? Tudo isso são situações que nos dão o que pensar. Será que não estão associadas a uma sensação interna de sobrecarga? A conservação de energia é muitas vezes confundida com preguiça, depressão ou falta de motivação, em vez de ser entendida como os mecanismos de sobrevivência do nosso corpo tentando nos ajudar.

Reconhecer expressões cotidianas desses três mecanismos de sobrevivência nos permite pensar de forma diferente sobre o corpo e sua experiência de estresse e trauma. Não limitaremos mais nossa visão do

trauma a algum evento impactante e terrível que só acontece com algumas pessoas. A resposta ao trauma do nosso corpo é o que nos torna humanos, e não é uma coisa ruim: é um mecanismo de sobrevivência.

Vários de nós carregamos mais sobrecarga, dor e medo do que temos consciência, muitas vezes menosprezando essas experiências como “apenas estresse” ou como se estivéssemos “sensíveis demais”. Quando começamos a “sair do ar” com frequência durante reuniões, a nos sentir paralisados diante de certas tarefas ou a experimentar uma fadiga inexplicável, talvez nosso corpo esteja nos dizendo algo importante sobre nosso estado interno de sobrecarga. A prevalência desses mecanismos de sobrevivência em nossa vida diária pode ser um alerta de que estamos vivendo com mais impotência do que reconhecemos. Como Elena descobriu, esses não são sinais de fraqueza, mas evidências dadas pelo nosso corpo de que ele se sentiu impotente e precisa que o ajudemos a se reparar, recuperar um senso de segurança e restaurar nossa capacidade de agir.

O CUSTO DA SOBREVIVÊNCIA

Os mecanismos de sobrevivência da dissociação, da imobilização e da conservação de energia são proteções magníficas e úteis em momentos de impotência. Eles são prova do compromisso profundo do nosso corpo em nos manter fisicamente vivos, seja qual for o custo. E sempre existe um custo.

O preço da sobrevivência afeta três aspectos centrais da nossa vida. Primeiro, há o custo para a conexão com nós mesmos e com os outros. Quando nos dissociamos para sobreviver, nos desconectamos de nossos sentimentos, necessidades e experiências. Mesmo passado um tempo, podemos nos perceber incapazes de nos envolver plenamente com entes queridos ou de nos sentirmos presentes em momentos importantes da vida. Segundo, há o custo para nosso senso de autonomia e poder. Quando nos rendemos por meio da imobilização, desistimos e cedemos para sobreviver. Deixamos de nos posicionar ou nos defender. Por fim, há o custo para nossa saúde e vitalidade. A conservação de energia, apesar de protetora, nos deixa com menos capacidade para a alegria, a criatividade e o envolvimento pleno com a vida.

Nosso sistema nervoso paga esses preços de bom grado quando a sobrevivência parece estar em jogo, o que faz sentido em situações críticas, como quando Elena sofreu o acidente de carro ou Sarah perdeu a mãe. Mas por que nosso corpo retém o trauma, de modo que esses mecanismos de sobrevivência se tornam não só respostas do passado como também custos que continuamos pagando até hoje, em detrimento da nossa saúde mental, emocional e física?

Ao avançarmos para a Parte 2, exploraremos por que o corpo retém experiências de medo, dor e sobrecarga, e como ele fica preso em um ciclo de retroalimentação somática do trauma que gera cinco padrões de trauma previsíveis. Compreendê-los se tornará nosso roteiro para uma jornada de cura individual, revelando o tipo de suporte de que nosso corpo precisa para restaurar a segurança, a conexão e a integridade.

Esses mesmos mecanismos de sobrevivência se tornam padrões previsíveis que podem nos informar se nosso corpo ainda está preso ao passado. Assim como a doença autoimune de Elena a levou de volta às experiências de impotência da infância, os padrões atuais que você vive podem ser sinais de que o seu corpo retém traumas do passado e ainda está tentando proteger você.

RESUMO

Ao longo deste capítulo, exploramos os três mecanismos de sobrevivência por trás do estado de trauma que nos mantêm vivos quando sofremos um apagão. Para serem eficazes, esses mecanismos de sobrevivência ocorrem em todos os níveis: mente, corpo e biologia. Compreendê-los como a sabedoria mais profunda do nosso corpo (em vez de fraqueza, preguiça ou distração) transforma a maneira como enxergamos nossas respostas a experiências que nos causam sobrecarga.

Refleta se você não vem subestimando as experiências de sobrecarga e impotência do seu corpo, chamando-as de “estresse” ou até de “estresse crônico”. Na Parte 2, exploraremos por que o corpo transforma uma resposta ao trauma aguda em uma resposta crônica.

PARTE 2

Como e por que o corpo retém o trauma

Jamais esquecerei o menino de 10 anos que vi em um vilarejo na Costa Rica. Eu havia sido enviada para o local com um grupo de terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos porque o menino não falava. Aos 4 anos, ele havia testemunhado um evento traumático envolvendo a morte da mãe. Era uma criança funcional, que ia bem na escola, mas nunca tinha dito uma palavra desde então. De que maneira uma experiência do nosso passado pode permanecer no momento presente?

Um menino na Costa Rica que não consegue ou não quer falar há seis anos.

Um executivo que não dorme sem verificar as portas três vezes, lembrando-se de um tempo em que não esteve seguro.

Uma mulher que ainda sente o coração disparar sempre que um supervisor quer “conversar”, mesmo que o chefe que a humilhou já tenha saído da empresa há muito tempo.

Um adulto que não consegue manter relacionamentos íntimos, protegendo-se por achar que sua confiança será traída.

Uma pessoa com doença autoimune, enxaquecas diante de conflitos e problemas digestivos quando se sente sob algum tipo de pressão por desempenho.

Um pai que não consegue regular suas emoções perante os filhos.

Um adolescente que não consegue se concentrar na escola após se envolver em um acidente de carro um ano antes.

Uma enfermeira que sofre com fadiga crônica após vivenciar um burnout durante a pandemia...

Nosso passado aparece no presente na forma como criamos os filhos, como trabalhamos, como amamos e como cuidamos de nós mesmos. Às vezes, os sintomas são óbvios, como ataques de pânico diante de gatilhos específicos. Mais frequentemente, eles são sutis: a necessidade constante de agradar os outros, a incapacidade de dizer não, uma dor persistente na cervical ou uma exaustão que nunca passa completamente.

Nosso corpo tem uma capacidade inata de se curar e de se reajustar após episódios de estresse ou trauma. Somos feitos para atravessar experiências e voltar a sentir segurança. Na verdade, quando tudo funciona como deveria, as experiências nos fazem crescer, como uma criança que, apesar do medo, desce pelo escorregador, comemora sua coragem com o pai ou a mãe e constrói confiança para desafios futuros. Mas o que acontece quando esse processo natural é bloqueado?

Esta parte do livro explora por que e como nosso corpo retém respostas de trauma do passado. Vamos descobrir como bloqueios iniciais no processo de desfecho criam um ciclo que mantém em nós a sensação de perigo. O desafio é que esse ciclo, que se alterna continuamente entre estresse e sobrecarga, se retroalimenta. Ao acionar mais respostas de trauma sempre que recuamos para o estado de sobrecarga e impotência, os três mecanismos de sobrevivência se transformam em padrões crônicos em nossa vida, nossa saúde e nossos relacionamentos; padrões que não conseguimos abandonar. Nossa biologia, agora movida pelo perigo e pela desregulação, torna-se justamente o bloqueio que impede o corpo de recorrer aos mecanismos inatos de cura que poderiam ajudar a restaurar o equilíbrio, a saúde e a integridade.

Com o conhecimento apresentado nesta parte do livro, ficará evidente por que abordagens convencionais que não incluem (ou que incluem exclusivamente) o componente biológico costumam

não ter sucesso. Não podemos ignorar como o trauma alterou nossa biologia e agora nos bloqueia. O caminho para a cura inata do corpo requer a base apresentada nesta parte sobre como e por que nosso corpo retém respostas traumáticas do passado. Vamos começar conhecendo Dana e, por meio de sua história, entender por que e como essa retenção acontece.

CAPÍTULO 7

Por que o corpo retém o trauma

O passado nunca morre. Nem sequer é passado.

– William Faulkner, *Requiem for a Nun*

— Não gosto de quem me tornei – sussurrou Dana, com os olhos fixos no chão. – Eu me sinto como uma sombra de mim mesma.

Aos 39 anos, Dana era uma médica de família bem-sucedida, mas ali estava ela, sentada no meu consultório carregando nas costas um peso invisível que nenhum diploma de medicina a havia preparado para entender. Embora soubesse que tinha traumas de infância não resolvidos, ela não compreendia por que seu corpo aparentava estar preso ao passado, manifestando isso por meio de dor pélvica crônica, problemas digestivos e oscilações de energia que pareciam piorar apesar de todos os seus esforços.

Essa era uma história contada tanto por suas palavras quanto pelo seu corpo. Em questão de minutos, observei o sistema nervoso dela alternar entre os estados de sobrevivência que exploramos na Parte 1: da ativação simpática quando falava sobre o trabalho ao apagão vagal dorsal quando tocava em emoções mais profundas.

Ela sofria com a dor pélvica, mas isso não era o que mais a preocupava.

– Meu intestino não funciona bem. É como se estivesse absorvendo todo esse estresse – disse ela com um sorriso forçado, abraçando a barriga num gesto protetor.

Suas próximas palavras revelaram mais sobre o trauma profundo que seu corpo ainda carregava.

– Seria o fim do mundo se eu engordasse! As pessoas iam saber que perdi o controle. Não quero que saibam que, por dentro, eu me sinto insegura, vazia e com raiva. Então eu escondo essa parte.

Seguindo um impulso, perguntei com delicadeza:

– Consegue recordar quando começou a ter problemas com o peso?

Sua resposta me proporcionou uma abertura para entender a dor retida no seu corpo.

– Eu me lembro de ter sentido vergonha do meu peso pela primeira vez quando tinha 12 anos. Comecei a me comparar com outras garotas da minha idade na escola. Ironicamente, foi também a primeira vez que tive prisão de ventre.

Então a história foi sendo revelada. Dana praticava muitos esportes; um dia, depois do treino, ela estava sozinha, ainda arrumando o cabelo, quando seu treinador, o Sr. S., entrou no vestiário. Ele passou a dizer, e depois a fazer, coisas que eram muito confusas para ela. Por ser seu treinador, Dana não resistiu; queria ser especial para ele. Nunca contou aos pais. Nunca contou a ninguém. Não sabia que deveria contar e tinha pavor das consequências se fizesse isso. O abuso sexual aconteceria mais algumas vezes ao longo dos três anos seguintes, até ela ir para o ensino médio.

Em todos os outros aspectos, a vida seguiu seu curso normalmente. Mas a vida não era mais a mesma para o corpo dela. Na cabeça de Dana, hoje uma mulher adulta, ela já deveria ter superado aquilo, mas seu corpo ainda retinha aquele trauma, esperando para completar a resposta de sobrevivência e voltar à segurança. Racionalmente, ela sabia que os eventos haviam acabado e que não era mais uma menininha vulnerável. Mas seu corpo continuava preso, como se ela ainda estivesse no vestiário.

A dor pélvica de Dana, o peso, a prisão de ventre e os problemas intestinais não eram aleatórios nem desconectados. Tampouco eram apenas sintomas de estresse. São consequências previsíveis quando o corpo retém experiências de sobrecarga. Os mecanismos de sobrevivência da dissociação, da imobilização e da conservação de energia, concebidos para serem soluções temporárias, haviam se tornado seus padrões crônicos.

Por que nosso corpo retém traumas do passado? Por que não nos curamos naturalmente e seguimos adiante? A resposta está em compreender do que o corpo precisa para completar uma resposta ao trauma e restaurar as configurações de segurança.

O MECANISMO INATO DA RESTAURAÇÃO

Nosso corpo retém o trauma porque está à espera de um desfecho para o que iniciou. Isso faz parte de sua sabedoria profunda. O corpo humano é feito para operar em ritmos e ciclos e concluir cada resposta que inicia. Por exemplo, cada vez que inspiramos, é preciso concluir o processo com a expiração. Se só inspirássemos sem expirar, não completaríamos o ciclo respiratório e não estaríamos prontos para a próxima inspiração. Essa necessidade programada de um desfecho se aplica também a cada resposta de sobressalto, estresse e trauma que temos. Quando um processo é concluído, como ao expirarmos, nosso corpo está pronto para a próxima experiência.

O corpo de Dana nunca recebeu o que precisava para concluir as respostas de sobrevivência desencadeadas no vestiário. Assim como cada resposta é uma resposta de corpo inteiro, a falta de resolução afeta todo o organismo, no nível sistêmico e no nível celular. Sem um desfecho e uma restauração, o cérebro e o sistema nervoso não conseguem arquivar uma experiência como algo do passado. Em vez disso, como um vinil arranhado que continua repetindo a mesma música, o passado permanece sendo a nossa realidade presente.

O que define uma restauração verdadeira?

Completar uma resposta para executar uma restauração significa retornar ao estado calmo-ativo após uma mobilização ou um apagão. Os dois elementos essenciais de uma restauração verdadeira são os estados “calmo” (experimentar segurança genuína) e “ativo” (ou seja, sentir-se pronto para o que virá). Encontrar o caminho para uma restauração após a sobrecarga não significa se esconder ou se retrair para um lugar seguro, mas sim retornar a uma sensação de prontidão.

Pense em um bombeiro após extinguir um grande incêndio. O desfecho dessa experiência não ocorre no momento em que o fogo se extingue, nem quando o bombeiro se retira do local. Embora o perigo imediato tenha passado, a experiência ainda pode estar viva no sistema nervoso do bombeiro. Uma restauração completa exige tempo e as atividades

necessárias para se recuperar, processar o ocorrido, se reabastecer e se preparar; o bombeiro precisa descansar, dormir, comer, reparar qualquer dano no equipamento e devolver tudo ao devido lugar. Só então, quando todas essas etapas são concluídas, ele está restaurado e verdadeiramente pronto para o próximo chamado.

Sem essa restauração, a sensação de vulnerabilidade persiste. Será que estamos realmente seguros? E se o próximo perigo vier agora, antes de termos nos recuperado do último?

Seja completando uma resposta de sobressalto, de estresse ou de trauma, o objetivo é sempre o mesmo: retornar ao estado calmo-ativo. Nosso sistema nervoso autônomo é projetado para orquestrar essa restauração automaticamente quando recebe as condições certas: tempo, segurança e energia. Concluir essas respostas e executar a restauração são etapas cruciais para nossa saúde e nossa capacidade. Quando a restauração acontece naturalmente, nossa biologia volta ao equilíbrio. A experiência é arquivada como um perigo passado, não presente; nossas reservas de energia são reabastecidas e nossa capacidade de lidar com desafios futuros é reconstruída – em alguns casos, até fortalecida.

Sem uma restauração de corpo inteiro após a impotência, nosso corpo continua condicionado para o perigo. Foi exatamente isso que aconteceu com Dana. Privada de um desfecho e de uma restauração após as experiências com o Sr. S., seu corpo continuou preso em seus mecanismos de sobrevivência. Os problemas digestivos, a dor pélvica crônica e as dificuldades de relacionamento eram evidências de que seu corpo nunca havia completado as etapas necessárias da restauração para as configurações de segurança. Ela precisaria de uma restauração em quatro níveis para que seu corpo recebesse a reparação necessária para a cura.

OS QUATRO NÍVEIS DE RESTAURAÇÃO PARA OBTER UM DESFECHO

Como a resposta ao trauma afeta todos os níveis do nosso organismo, das células aos sistemas, dos processos de autodefesa bloqueados a partes específicas de nós mesmos, cada nível precisa de recuperação e reparo para uma restauração às configurações de segurança.

Quando comecei a tratar meu próprio trauma, eu achava que abordar os pensamentos e emoções sobre meu passado seria suficiente. Mas descobri, assim como Dana, que a mente era apenas um dos níveis em que devia trabalhar. Criar mudanças profundas e duradouras exige elementos específicos para restaurar cada nível afetado: nossa mente (partes de nós mesmos), nosso corpo físico (somático), nossa biologia (sistemas e células) e, mais fundamentalmente, nossa neurocepção, que é o núcleo do sistema de resposta de sobrevivência.

Restauração no nível celular

Vimos no Capítulo 4 como nossas células acionam seu próprio freio de emergência por meio da resposta celular ao perigo quando a demanda excede sua capacidade homeostática. Essa resposta de perigo no nível celular precisa ser concluída. Existem sistemas naturais incorporados ao nosso código celular para recuperação, reparo e restauração. Quando uma célula não completa essa resposta, ela pode permanecer presa no modo de perigo. A consequência de um ciclo incompleto de resposta celular ao perigo é a manutenção de uma produção ineficiente de energia e proteínas, associada ao acúmulo de danos não reparados ao DNA, provocados pelo estresse oxidativo.

Essa restauração celular envolve vários elementos-chave, incluindo os sinais do sistema nervoso e da química sanguínea de que o perigo passou. Assim que sabem que estão seguras, as células precisam de nutrientes para reparar os danos às membranas, às proteínas e ao DNA. Precisam de energia para fazer uma “faxina”: eliminar o estresse oxidativo e corrigir desequilíbrios de eletrólitos. Esse reparo não pode acontecer se a célula permanecer no estado de apagão, em que a prioridade é apenas sobreviver.

Por isso, uma parte essencial dessa restauração no nível celular é restabelecer os processos de produção de energia. A questão é que voltar à plena produção de energia não é como apertar um botão. As células passam por determinadas etapas para recuperação, reparo e restauração.

A história de Claire ilustra o que acontece quando nunca damos às nossas células a chance de realizar essa restauração essencial. Sua fadiga crônica não vinha apenas de se exigir demais física e mentalmente; ela era o

resultado previsível de nunca permitir às células o tempo necessário para se recuperar. Ela comia às pressas, sem se sentir segura de verdade enquanto fornecia combustível ao corpo. Suas células nunca tinham a oportunidade de se reparar, pois isso só acontece no estado calmo-ativo. Considerando quanto ela sempre se forçou a ir além do limite, sem reservar tempo para o descanso, não surpreende que tenha desenvolvido fadiga crônica.

Restauração no nível dos sistemas biológicos

Enquanto as células estão fazendo individualmente a restauração, nossos sistemas fisiológicos, como o imunológico, o digestivo e o linfático, também precisam do seu próprio desfecho e restauração. Um dos aspectos muitas vezes ignorado porém crucial para esse desfecho no nível sistêmico é a restauração da adrenalina que inundou nosso organismo para ativar energia e movimento durante o estado de mobilização.

Essa enxurrada de adrenalina é consumida ao agirmos durante a resposta de estresse. Mas o que acontece quando passamos pelas etapas do muro, do congelamento e do apagão na resposta de trauma? Como nosso corpo faz a transição para o mecanismo de sobrevivência de conservação de energia, não nos movimentamos o suficiente para dar conta da quantidade de adrenalina que foi liberada.

Restauração biológica do estresse



Compare a adrenalina às calorias que ingerimos. As calorias precisam ser gastas e metabolizadas para que não sejam armazenadas como gordura. O ideal é ingerir uma quantidade de calorias que corresponda ao nosso nível de metabolismo e atividade física diária. Da mesma forma, quando não usamos toda a adrenalina por meio do movimento, o excesso desse hormônio continua ali e é armazenado em nossos tecidos.

Quando observamos os momentos posteriores às respostas traumáticas de Sarah e Elena, vemos esse acúmulo ocorrer de duas formas. Sarah, ao lado da mãe após a parada cardíaca, decidiu se forçar a seguir em frente, sem dar ao corpo o tempo necessário para uma restauração. Em vez de fazer algo que a ajudasse a descarregar a adrenalina não metabolizada, ela acabou obrigando o corpo a se empertigar, apesar de senti-lo pesado, pegar mais um café e se distrair com o trabalho; ou seja, o padrão que já conhecia como enfermeira de UTI. Já Elena começou a tremer enquanto estava na ambulância, mas conteve essa reação por vergonha. A doença autoimune que se desenvolveu um ano depois foi um sinal de que sua resposta ao trauma nunca havia sido concluída. Quando temos um desfecho, essas respostas não carregam o mesmo risco de causar doenças quanto aquelas em que não houve retorno à segurança. As respostas de trauma incompletas

de Dana se manifestaram em problemas digestivos e prisão de ventre.

Nossos músculos são feitos para nos ajudar nessa restauração; em conjunto, eles formam o maior órgão do corpo e consomem a adrenalina mais rápido que qualquer outro tecido. É por isso que o corpo pode começar a tremer naturalmente, já que esse é um modo intuitivo de descarregar a adrenalina liberada durante a mobilização e buscar a restauração.

A tireoide, as glândulas adrenais e o metabolismo precisam de tempo, energia e nutrientes para retornar a uma função metabólica equilibrada. O sistema digestivo precisa restabelecer a motilidade normal e a produção de enzimas. O sistema imunológico precisa sanar a inflamação e voltar ao equilíbrio. O sistema cardiovascular precisa retomar ritmos constantes de fluxo e pressão sanguínea.

Essa coordenação da restauração sistêmica é regida de forma precisa pelo sistema nervoso autônomo quando lhe são oferecidos os recursos e a segurança necessários. Enquanto não fornecermos aos sistemas biológicos o que eles necessitam, o impacto do trauma continuará presente; e mais cedo ou mais tarde ele se manifestará na forma de problemas de saúde.

Restauração no nível somático

Quando nosso corpo se vê diante do muro e todas as nossas tentativas de autodefesa se tornam inúteis, movimentos protetores incompletos ficam armazenados como memória somática. Concluir esses movimentos para criar uma memória de autodefesa bem-sucedida é necessário para uma restauração no nível somático.

Vou usar uma história pessoal para explicar como isso funciona. Aos 12 anos, vivi um momento aterrorizante em que um homem cobriu minha boca e ameaçou minha vida. Décadas depois, embora soubesse racionalmente que o evento havia acabado, aqueles movimentos de autodefesa incompletos continuavam armazenados no meu corpo. Eu entrava em pânico sempre que acordava no escuro deitada sobre o lado direito – a mesma posição em que estivera durante aquele episódio. A terapia verbal havia me ajudado a processar a memória explícita, mas não tinha me dado a conclusão somática. Meus músculos ainda guardavam a memória de querer reagir e não poder.

Quando completa movimentos de autodefesa que antes estavam bloqueados, o corpo restaura essa memória somática. Essa conclusão deve incluir os movimentos físicos propriamente ditos que nosso corpo quis fazer para se defender mas não conseguiu. E precisa ser feita com cuidado e no momento certo. Depois de um ano de capacitação somática e de construir uma base de regulação, eu sabia que meu corpo estava pronto. Recriei minuciosamente a posição e segui os impulsos do meu corpo. Deixei que se movesse de todas as maneiras que ele quis fazer na ocasião mas não pôde por medo. Continuei até sentir, dentro de mim, que havia vencido meu agressor. Naquele momento, meu corpo me mostrou, por meio de formigamentos, lágrimas de alívio e vários suspiros espontâneos e profundos, que eu finalmente tinha conseguido completar o movimento de autodefesa que não fui capaz de executar antes.

Movimentos físicos aleatórios ou catarses emocionais, por si sós, não nos darão uma restauração somática. Socar almofadas pode trazer alívio temporário, mas não oferece aos tecidos o desfecho específico de que necessitam. Os movimentos precisam vir dos próprios impulsos do corpo, seguindo o que ele quis fazer para se defender naquele momento de impotência. Primeiro, no entanto, temos que construir uma base de regulação e aprender a nos conectar com as mensagens do corpo antes de tentar uma conclusão somática por conta própria. Se tentarmos processar eventos passados antes da hora, corremos o risco de entrar em sobrecarga, o que nos traumatizará novamente.

Embora o desfecho somático seja necessário para uma restauração do corpo às configurações de segurança, também precisamos realizar uma restauração nas crenças que formamos, nos mecanismos de enfrentamento que desenvolvemos e nas partes de nós que foram criadas e fragmentadas.

Uma restauração de nossas crenças e de partes de nós mesmos

Em situações de sobrecarga, especialmente quando nossos mecanismos de sobrevivência de dissociação, imobilização e conservação de energia entram em cena, partes de nós podem se fragmentar e ficar presas naquela experiência. Embora a fragmentação tenha servido a um propósito crucial de sobrevivência, ajudando-nos a suportar o insuportável, essas partes

podem permanecer congeladas no tempo, à espera de um desfecho e de segurança.

Durante o seu processo na Jornada Estruturante, Dana começou, aos poucos, a trabalhar a parte jovem de si mesma que ainda estava presa naquele vestiário com o Sr. S. Essa parte se sentia tão sobrecarregada e confusa que queria morrer, apenas para que tudo parasse. Dana havia desenvolvido partes adaptativas que a ajudavam a funcionar, apesar da parte jovem dela que continuava sobrecarregada e presa naquele medo. Partes adaptativas são como as estratégias que desenvolvemos para andar com uma perna quebrada que nunca recebeu o cuidado necessário para se curar. A questão é que andar de forma anormal causa mais dores no processo. Essas partes adaptativas nos ajudam a funcionar, garantindo que não sintamos demais, não brinquemos demais, não sejamos barulhentos ou carentes demais. Mas não são estratégias saudáveis. Algumas partes adaptativas descobrem que comida ou álcool ajudam a distrair nossa mente da dor; outras nos mantêm desconectados por meio de uma ocupação constante ou do trabalho. O Dr. Richard Schwartz, criador do modelo dos Sistemas Familiares Internos, as chama de partes “protetoras”. Segundo ele, elas trabalham incansavelmente, embora muitas vezes por meio de mecanismos nada saudáveis, para impedir qualquer vulnerabilidade.

Essas partes também precisam de uma restauração às configurações de segurança e, enquanto isso não acontece, elas continuam direcionando nossas respostas a partir de um contexto de medo. Tentar simplesmente superar ou eliminar essas partes pela força de vontade não funciona. Elas surgiram por motivos de sobrevivência, portanto, precisam experimentar segurança para relaxar seus mecanismos de enfrentamento adaptativos.

Para Dana, a cura envolveu construir, pouco a pouco, uma relação com sua parte jovem que ainda estava apavorada, ajudando-a gradualmente a reconhecer que agora ela era uma adulta com os recursos e as competências necessários para proteger a si mesma que não tinha na infância. Essa restauração permitiu que ela acessasse todas essas partes de si mesma como adulta, em vez de permanecer fragmentada pelo passado.

A restauração essencial da neurocepção

Como a neurocepção rege nossos estados de funcionamento e calcula continuamente nossa capacidade em relação às demandas, uma restauração verdadeira do trauma exige, em última instância, uma mudança na forma como nosso sistema nervoso percebe a segurança. Mas existe aqui uma questão crucial. Lembra-se de como a neurocepção, como o painel sofisticado de um veículo, monitora múltiplos grupos de dados o tempo todo? Quando qualquer nível – seja ele celular, sistêmico, somático ou psicológico – permanece incompleto em sua restauração, ele continua a transmitir sinais de perigo. Uma mente que entende de modo racional “agora estou em segurança” fornece apenas um sinal de segurança em meio a muitos possíveis indicadores de perigo ainda vindos de uma inflamação biológica não resolvida, das memórias somáticas armazenadas ou das partes fragmentadas presas ao passado.

Isso explica por que o corpo de Dana, apesar de saber racionalmente que já não era a menina vulnerável no vestiário, continuava reagindo como se o perigo estivesse presente. Sua dor pélvica crônica, seus problemas digestivos e suas dificuldades de relacionamento enviavam sinais contínuos de perigo à neurocepção, impedindo uma restauração completa às configurações de segurança.

Essa é a mesma experiência de muitas pessoas que chegam à Jornada Estruturante em busca de uma mudança profunda e duradoura em algum padrão da própria vida. Elas já disseram a si mesmas que estão seguras, muitas vezes praticaram ioga e meditação com afinho ou fizeram décadas de terapia, tentando voltar à segurança por meio da racionalidade. Porém, quando eu as conduzo pelas práticas somáticas de autorregulação e pelos diálogos mente-corpo com suas partes adaptativas, elas começam a entender por que nunca alcançavam a sensação de segurança. Nossa mente não é capaz de convencer a neurocepção de como ela deveria se sentir. Podemos dizer a nós mesmos que não há nada a temer, mas, quando o corpo ainda reage como se estivesse com medo, sabemos que a neurocepção continua recebendo sinais de perigo.

Como saber, então, se tivemos êxito na restauração da nossa neurocepção? Não será por meio da lógica ou de cálculos analíticos, mas pela sensação de segurança no corpo. Quando recebe sinais suficientes de

segurança em todos os níveis, a neurocepção cria uma sensação visceral de estar ao mesmo tempo em segurança e em prontidão, ou seja, o estado calmo-ativo que exploramos anteriormente. Enquanto isso não acontece, podemos notar uma sensação persistente de perigo, de vulnerabilidade, de desconexão com as sensações do nosso corpo. Tudo isso é sinal de que a neurocepção ainda está à espera de um desfecho.

O QUE IMPEDE A RESTAURAÇÃO

Muitos de nós funcionamos com respostas incompletas, ainda à espera de um retorno à segurança. Embora nossa programação instintiva tenha sido desenvolvida para concluir até mesmo essas experiências de impotência, ocorre um bloqueio quando nosso corpo não tem do que precisa. Os desafios surgem, em parte, por causa do nosso mundo moderno. Em uma cultura baseada em ocupação constante, medo e desconexão, é mais difícil para o corpo conseguir os recursos necessários para completar uma resposta ao trauma.

As três coisas de que uma resposta ao trauma precisa para completar a restauração são tempo, energia e segurança; ou seja, justamente o que muitas vezes não temos em nossa vida. Por causa de nossa rotina atarefada, da enxurrada de notícias amedrontadoras, das notificações constantes no celular e do fluxo interminável de informação a que somos submetidos, nossa neurocepção praticamente *nunca* deixa de receber sinais de perigo.

A expectativa cultural de seguir em frente a qualquer custo cria outra barreira à restauração. Como um atleta de alto desempenho que nunca se permite se recuperar entre os treinos, somos ensinados que parar é sinal de fraqueza. Esse atleta talvez dependa de suplementos, bebidas proteicas e cafeína para aguentar o próximo treino ou o dia seguinte. Pode, inclusive, ter crenças sobre si mesmo que contribuem para que se force a ir além do limite, como a ideia de que não merece descanso.

É exatamente isso que acontece no nosso mundo moderno. Vamos de sobrecarga em sobrecarga, seguindo em frente à base de cafeína, açúcar ou outros suprimentos que entregam energia rapidamente. Comemos sob estresse, o que impede a digestão e a absorção adequadas de nutrientes. Além disso, nossas fontes de alimentos e água muitas vezes são repletas de

toxinas que aumentam o estresse celular e ainda são pobres nos nutrientes de que nossa biologia precisa para se recuperar. Nós negligenciamos o sono, que ajudaria a limpar resíduos oxidativos e a promover uma restauração biológica às configurações de segurança. Ao mesmo tempo, mantemos a expectativa de que, se não “superarmos” logo certas experiências e seguirmos adiante, há algo errado conosco, o que acrescenta vergonha ao fardo emocional.

Como se todos esses desafios não bastassem, outra razão pela qual muitas vezes não alcançamos o desfecho e a restauração é que não aprendemos como fazer isso; ou, para ser mais exata, não aprendemos como parar de atrapalhar e permitir que o corpo faça o que ele naturalmente sabe fazer. Não aprendemos que precisamos ajudar a acalmar a inflamação do cérebro. Não aprendemos que movimentos de autodefesa malsucedidos precisam ser completados, mesmo décadas depois. Não aprendemos como resgatar partes mais jovens de nós mesmos sem nos traumatizarmos de novo por voltarmos à nossa história de forma abrupta.

O resultado pode ser uma vida inteira de respostas incompletas acumuladas, o que responde à pergunta sobre por que nosso corpo retém traumas do passado. O que acontece quando essas respostas permanecem incompletas? As implicações são muito mais profundas do que se pode imaginar.

No próximo capítulo, vamos explorar como o corpo retém traumas do passado por meio de respostas incompletas criando um ciclo de retroalimentação somática do trauma, oscilando entre o estresse e a resposta de apagão até que ofereçamos ao corpo a recuperação, o reparo e a restauração verdadeira de que ele precisa para se curar.

RESUMO

O corpo humano foi concebido para concluir suas respostas de proteção e retornar à segurança, mas a vida moderna muitas vezes impede que esse processo natural de restauração aconteça. Sem os elementos essenciais de tempo, segurança e recursos, nossas respostas ficam incompletas. Em vez de se curar, o corpo retém essas experiências inacabadas.

As respostas incompletas nos afetam em todos os níveis: desde células

ainda em resposta de perigo, até músculos com memórias somáticas de movimentos bloqueados, passando por partes nossas que estão presas a episódios de sobrecarga do passado. Nossa neurocepção continua recebendo sinais de perigo de cada um desses níveis, mantendo padrões de proteção em vez de permitir uma restauração verdadeira às configurações de segurança.

Embora não tenhamos escolhido que nosso corpo retivesse dores e medos do passado, temos uma escolha agora. Resolver respostas de trauma de décadas atrás que nunca foram completadas leva tempo e exige habilidades específicas, mas podemos aprender a dar um desfecho a essas respostas no presente, evitando também acumular mais carga traumática daqui para a frente.

CAPÍTULO 8

Presos em um loop: a formação de uma biologia do trauma

Se a história se repete e o inesperado sempre acontece, quão incapaz é o homem de aprender com a experiência.

– George Bernard Shaw, dramaturgo irlandês

Sarah estava na UTI, sentada ao lado do leito da mãe. Poucos minutos antes, havia assistido ao coração dela parar de bater, sentindo-se impotente enquanto as tentativas de reanimação fracassavam. Mas, no fundo, aquela sensação de sobrecarga não era nova. No entanto, quase ninguém teria percebido isso, pois ela era a imagem do sucesso e tinha o cuidado de esconder os momentos em que sentia que sua vida estava desmoronando. As raízes do seu perfeccionismo e da necessidade de agradar os outros remontavam à infância e eram o motivo de ela não se sentir pronta para dizer adeus à mãe.

No capítulo anterior, descobrimos por que o corpo retém o trauma: porque não foi possível completar sua sequência instintiva de sobrevivência e restaurar as configurações de segurança. Mas o que acontece depois? Como respostas incompletas se transformam em padrões de uma vida inteira que parecem impossíveis de romper?

Sarah tinha orgulho de seus 20 anos de carreira como enfermeira de cuidados intensivos e era vista pelos colegas como alguém capaz de lidar com qualquer coisa. Seu perfeccionismo era útil na UTI, onde a atenção aos detalhes podia significar a diferença entre a vida e a morte. O que os outros não viam era como sua busca pela perfeição vinha de um medo subjacente de que, se ela não fosse perfeita, ficaria vulnerável a ser ridicularizada,

exatamente como quando era criança.

Quando Sarah tinha apenas 3 anos, sua mãe achava divertido fazer piadas às custas dela, até mesmo na frente de outras pessoas. Sarah fingia achar graça também, mas, por dentro, sentia-se envergonhada, traída e impotente por não conseguir fazer aquilo parar. Sem a segurança e o apoio de que precisava na época para completar essas respostas, o sistema nervoso de Sarah permaneceu em modo de perigo. Seu corpo continuava à espera de um desfecho que nunca veio.

Seus hábitos e sintomas de saúde contavam a história de alguém preso no que chamo de ciclo de retroalimentação somática do trauma, ou loop corpo-trauma. Mesmo quando as coisas iam bem em sua vida, no fundo ela se sentia ansiosa, esperando de maneira irracional que algo de ruim pudesse acontecer. Era desconfortável ficar parada e simplesmente existir. A correria que fazia dela uma excelente enfermeira de UTI também era o modo que seu corpo encontrara de se manter em movimento constante e evitar sentir a ansiedade que o silêncio podia trazer à tona. Café e exercício físico tinham se tornado mecanismos de enfrentamento inconscientes para lidar com a vulnerabilidade que ela sentia.

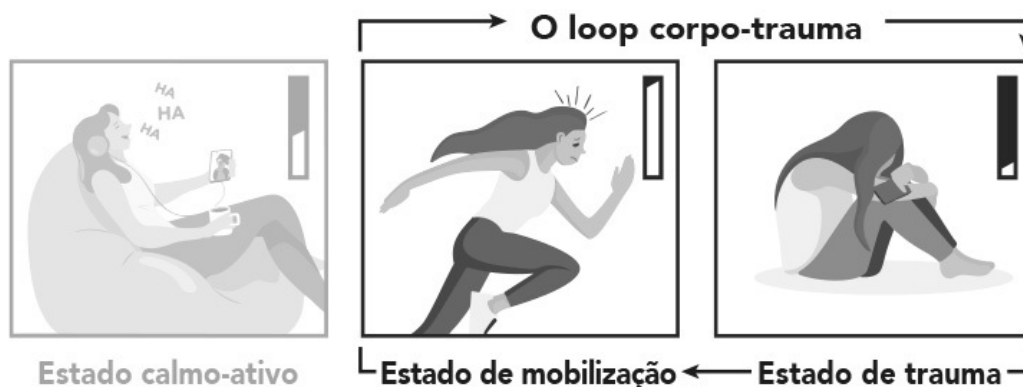
Embora anos de terapia a tivessem ajudado a entender racionalmente esses padrões, ela não conseguia mudá-los de forma consistente. Como velhos amigos, seus hábitos voltavam enquanto ela tentava administrar o ciclo diário entre a ansiedade matinal e a exaustão do fim do dia. Ela não dormia bem, e seus problemas digestivos só pioravam. Por mais que reconhecesse que esses padrões remontavam à infância, ela ainda não tinha compreendido que sua própria biologia a mantinha agarrada a eles. Seu corpo estava preso em um loop das etapas da resposta ao trauma.

O LOOP CORPO-TRAUMA

O sistema nervoso de Sarah contava sua história por meio dos ritmos da energia e do humor dela. Quando ela começou a registrar os estados do seu sistema nervoso no diário que apresentei no Capítulo 2, um padrão nítido emergiu. Ela não estava apenas vivenciando estresse ocasionalmente: estava presa em um ciclo repetitivo de estresse e sobrecarga. Seu sistema nervoso percorria sem parar as etapas da resposta instintiva ao trauma, passando

pela mobilização do sobressalto e do estresse até cruzar o limite crítico da sobrecarga e entrar em congelamento e apagão.

O loop corpo-trauma ocorre quando a resposta instintiva de trauma do corpo nunca é concluída. Dessa maneira, o impacto de uma resposta ao trauma original e incompleta vai se acumulando ao longo do tempo. É como colecionar pedras enquanto fazemos uma trilha. Talvez sintamos o peso da primeira pedra, dependendo do tamanho, mas carregá-la não é um problema. Porém, quando ficamos presos em um loop, a sobrecarga é vivenciada continuamente. Cada nova experiência de sobrecarga não concluída vai se somando à anterior. O que começou como uma só pedra vira uma mochila cheia, depois um carrinho de mão abarrotado, tornando cada passo adiante cada vez mais difícil.



Quando criança, o corpo de Sarah vivenciou respostas de trauma que, por nunca terem sido concluídas, foram tendo cada vez mais impacto e peso em sua vida. O perfeccionismo, a tendência a agradar os outros, a incapacidade de relaxar e a hipervigilância se tornaram mais intensos com o passar dos anos. A carga de trauma fica mais pesada com o tempo, não apenas por causa da resposta traumática original, mas também pelos anos de repetição contínua do ciclo.

É por isso que reações, mecanismos de enfrentamento e até sintomas de saúde com frequência pioram ao longo dos anos. Cada vez que passamos por uma experiência de sobrecarga sem que haja um desfecho, acrescentamos mais uma camada à resposta celular ao perigo e à desregulação sistêmica que nosso corpo carrega. Os sintomas digestivos que

mandavam Sarah para a cama cedo sentindo dor e cansaço, a ansiedade que a impedia de relaxar e as noites maldormidas que a deixavam exausta eram manifestações de um corpo que acumulava um fardo cada vez maior.

Criação de um loop corpo-trauma: as lentes da neurocepção tingidas pelo perigo

Quando a neurocepção recebe sinais de perigo de forma contínua, nosso sistema nervoso se mantém em um loop, alternando-se entre o estado de mobilização e o estado de trauma.

Quando Sarah começou a trabalhar comigo, ela disse: “Eu sempre sinto que alguma coisa ruim está prestes a acontecer.” Esse insight sobre sua ansiedade subjacente na verdade mostra como o loop corpo-trauma é criado, o que nos leva de volta à neurocepção, a condutora dos estados do nosso sistema nervoso. Desde a experiência de impotência na infância ao ser ridicularizada pela mãe, a neurocepção de Sarah tinha sido programada para ver o mundo através de lentes tingidas pelo perigo. Mesmo que tudo estivesse bem em sua vida, sem uma restauração às configurações de segurança, a percepção continuava a ser de perigo. Assim como dizemos que quem usa óculos com lentes cor-de-rosa vê tudo de forma positiva, a neurocepção de Sarah via perigo em todos os lugares, mesmo quando esse perigo não era real.

Isso gera dois problemas que criam e alimentam o loop corpo-trauma. Primeiro, a neurocepção nos fará sentir que estamos em perigo o tempo todo. Se temos capacidade para responder, ela nos mantém na parte superior do loop, no estado de mobilização, com ansiedade e estresse. Se não temos capacidade suficiente para o nível de perigo percebido – porque ele é muita coisa em pouco tempo ou pouca coisa por muito tempo –, passamos para a parte inferior do loop, o estado de trauma.

O segundo problema ocorre quando sinais normais de segurança são mal interpretados como sinais adicionais de perigo. Por causa das lentes tingidas pelo perigo, a neurocepção muitas vezes percebe ameaças em coisas ao nosso redor que, na realidade, não representam perigo, como ruídos de fundo. Até mesmo o contato com as pessoas ou a convivência em comunidade podem parecer perigosos para uma neurocepção que nunca fez

a devida restauração de volta à segurança.

Assim como Sarah, a neurocepção de Elena também usava lentes tingidas pelo perigo por conta da infância que ela teve. A falta de tempo, segurança e energia para completar as respostas à impotência quando era pequena fez com que seu corpo ficasse preso em um loop corpo-trauma. Quando outra resposta ao trauma sem conclusão se somou a isso, na forma de um acidente do qual foi difícil se recuperar emocional e mentalmente, não foi mera coincidência ela ter sido diagnosticada com uma doença autoimune.

Cada volta pelas etapas dos dois estados de perigo reforça ainda mais o loop, que acaba se tornando, por meio da neuroplasticidade, nosso hábito padrão: levar a vida alternando entre o estresse e a sobrecarga.

A automatização de um loop corpo-trauma: as vias da neuroplasticidade

“Neurônios que disparam juntos se conectam entre si” é uma frase bastante conhecida para descrever o que acontece conforme a neuroplasticidade automatiza um processo que realizamos com frequência. Seja fazer o trajeto diário até o trabalho, arrumar a cama ou escovar os dentes, a neuroplasticidade cria e fortalece vias neurais que usamos repetidamente para automatizar o processo.

A neuroplasticidade não quer saber se são padrões saudáveis que queremos repetir ou se são padrões prejudiciais dos quais gostaríamos de nos livrar. Qualquer coisa que se repita o suficiente será transformada em hábito, poupando-nos a energia de ter que pensar em como fazer o mesmo processo da próxima vez.

Infelizmente, a neuroplasticidade também pode levar padrões a se tornarem hábitos indesejados. Cada vez que passamos pelo loop, aprofundamos as vias neurais, transformando esse ciclo em resposta padrão, como escovar os dentes antes de dormir. Com o tempo, esse passa a ser o caminho de menor resistência: o loop assume o controle automaticamente como resposta a gatilhos, grandes e pequenos.

Entender o papel da neuroplasticidade na automatização do loop corpo-trauma em um hábito padrão influencia o tempo necessário para desfazer

esses padrões e criar novas respostas que nos atendam melhor. Assim como aconteceu com Sarah, quando respostas incompletas à impotência surgem cedo na vida, as vias neurais que nos mantêm alternando entre o estresse e o colapso são mais fortes do que se essas respostas incompletas tivessem começado a se acumular mais tarde. O número de vezes que o corpo percorreu esse loop também influencia o esforço necessário para repará-lo. Se você viveu experiências de impotência na infância mas teve ao menos uma pessoa que o fez se sentir genuinamente seguro, suas vias neurais para um loop corpo-trauma não serão tão fortes, e o processo de reprogramá-las será mais curto do que seria caso você não tivesse tido ninguém.

Além da neurocepção e da neuroplasticidade, há um terceiro elemento que contribui para nos manter presos nesse loop: nossa biologia.

MANUTENÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DO LOOP: A BIOLOGIA DO TRAUMA

Enquanto a neuroplasticidade automatiza o loop corpo-trauma, nossa biologia o sustenta e amplifica. Todas aquelas mudanças biológicas que ocorrem durante as respostas de trauma não desaparecem sem uma restauração às configurações de segurança. Em vez disso, elas criam um ambiente interno que nos mantém em estado de perigo, alternando entre o estresse e a sobrecarga. É um ciclo gerado pela própria biologia que alimenta a si mesmo continuamente.

As experiências de Claire, Elena e Sarah ilustram isso com perfeição: vivências da infância cresceram e se transformaram em fadiga crônica, doença autoimune, problemas digestivos, distúrbios do sono e ganho de peso. A biologia que criou esses sintomas estava mantendo o loop por meio da diminuição da capacidade celular, que se tornou um sinal constante de perigo para a neurocepção.

Vamos analisar agora a biologia que sustenta e amplifica esse loop ao longo do tempo, começando por um dos fatores mais poderosos: a inflamação cerebral.

Inflamação cerebral e priming das micróglia

Assim como nosso corpo possui células imunológicas que nos defendem de invasores externos, o cérebro tem suas próprias células imunes especializadas, chamadas micróglia. Os cientistas chamam essas células de “jardineiras” do cérebro, porque elas tanto nutrem quanto protegem nossos neurônios, mantendo o equilíbrio entre suporte e proteção contra invasores.

No entanto, experiências que os cientistas chamam de eventos de priming, ou sensibilização, mudam as micróglia de forma profunda. Esses eventos podem incluir infecções graves, lesões na cabeça (como concussões e traumatismos cervicais), períodos sem níveis de oxigênio ou fluxo sanguíneo adequados e até as próprias respostas de trauma.

Em vez de retornarem ao estado de equilíbrio depois de um evento de priming, essas células se tornam hipersensíveis. Qualquer coisa que exceda sua capacidade passa a ativá-las e desencadear uma inflamação no cérebro. Estresses cotidianos que antes pareciam administráveis se tornam gatilhos. Algo tão simples quanto demorar demais para comer, ter uma noite maldormida ou consumir um alimento que provoque uma resposta imunológica pode ativar essas micróglia em estado de priming. Até a sobrecarga emocional pode ser um gatilho para as micróglia.

Essa inflamação no cérebro nos mantém em um loop corpo-trauma por dois motivos. Primeiro, ela cria sinais constantes de perigo por conta da inflamação em torno dos neurônios. Segundo, diminui nossa capacidade de responder ao estresse, o que desloca nosso limite crítico da sobrecarga, fazendo com que o cruzemos mais cedo do que o habitual. A inflamação diminui nosso saldo da conta de capacidade por consumir bastante energia, reduzindo nossa tolerância geral ao estresse.

Sarah percebeu que, após a morte da mãe, os estresses diários do trabalho agora eram suficientes para provocar confusão mental e fadiga. Bastava comer algo que não caísse bem para acordar no dia seguinte com a sensação de que o cérebro não estava funcionando bem. Ela passou a ter sempre lanches proteicos, pois, se ficasse muito tempo sem comer, começava a sentir que sua mente ficava lenta, e não afiada como sempre tinha sido.

Conexão intestino-cérebro e inflamação

Nosso intestino desempenha um papel crucial em nos manter presos no loop corpo-trauma por conta de sua conexão íntima com o sistema nervoso. Lembra-se de como o nervo vago se estende do tronco encefálico até a pelve? Essa conexão torna o sistema digestivo particularmente sensível aos nossos estados de funcionamento, mas também significa que a disfunção intestinal se torna uma fonte poderosa de sinais de perigo enviados à nossa neurocepção.

A barreira intestinal comprometida, o chamado intestino permeável, permite que entrem na corrente sanguínea substâncias que desencadeiam inflamação quando chegam ao cérebro. Inflamações intestinais são um forte sinal de perigo, assim como uma microbiota desequilibrada e níveis alterados de neurotransmissores no intestino. Cada distúrbio digestivo diminui ainda mais o saldo da nossa conta de capacidade, ao mesmo tempo que envia sinais de perigo à neurocepção.

Comprometimento mitocondrial e esgotamento de energia

Nossas mitocôndrias são fundamentais na manutenção do loop corpo-trauma por meio de sinais diretos e indiretos de perigo enviados à neurocepção. Quando as respostas de trauma permanecem incompletas, essas usinas de energia ficam comprometidas, mantendo-nos presos no loop.

Pense no comprometimento mitocondrial como um dano no motor do seu carro. Da mesma forma que um motor com problemas não consegue converter combustível em potência, mitocôndrias comprometidas não conseguem mais produzir energia de maneira eficiente. Isso pode acontecer por vários motivos: elas podem ainda estar presas em sua resposta celular ao perigo, podem ter acumulado toxinas que não conseguem eliminar ou podem ter sofrido danos prolongados no mecanismo de produção de energia por conta do estresse oxidativo.

Quando nossas mitocôndrias estão comprometidas, a capacidade celular diminui, o que significa que nossas células conseguem lidar com menos estresse antes de entrar em sobrecarga. É aí que o loop se intensifica: nosso

corpo, vivenciando sinais internos constantes de perigo, precisa gerar respostas de alta energia com frequência por meio da ativação simpática. Porém, quando nossas mitocôndrias comprometidas não são capazes de suprir essa demanda energética, nós batemos de frente com o muro. Por conta da capacidade reduzida, o melhor que elas podem oferecer já não é suficiente.

A jornada de Claire, de “coelhinha da Duracell” à fadiga crônica, ilustra isso perfeitamente. No início, suas mitocôndrias ainda conseguiam acompanhar o ciclo constante entre estados simpáticos de alta energia e estados de apagão para conservação de energia. Porém, sem tempo para se recuperar e se reparar, elas foram ficando cada vez mais comprometidas. Como consequência, as células já não eram capazes de gerar energia suficiente nem para funções básicas. O corpo passou a não conseguir mais entrar em estado de mobilização, deixando-a presa no estado de apagão.

O comprometimento mitocondrial está entre os fatores que mais pesam no cálculo que a neurocepção faz entre capacidade e demanda. O déficit de energia se torna mais um sinal de perigo, e nossa capacidade celular reduzida faz com que qualquer demanda pareça esmagadora. É uma combinação perfeita para nos manter presos ao loop.

Acúmulo de estresse oxidativo

O estresse oxidativo é um subproduto natural da produção de energia celular, assim como gases de escape são o subproduto do motor de um carro. Em nosso estado calmo-ativo, as células contam com mecanismos antioxidantes para limpar esse “escape celular”. No entanto, quando os mecanismos de limpeza não funcionam bem, o estresse oxidativo se acumula, como ferrugem se espalhando por uma máquina. Essa “ferrugem” danifica componentes celulares – de proteínas e membranas a mitocôndrias e DNA –, criando outra oportunidade para que nossa biologia alimente o loop corpo-trauma. Cada resposta ao trauma incompleta acrescenta mais estresse oxidativo, tornando nossas células cada vez mais vulneráveis a novos estressores. À medida que esse dano celular se acumula, nossa capacidade continua a diminuir, o que amplifica ainda mais o loop.

Várias coisas contribuem para o excesso de estresse oxidativo que nos

mantém presos. Primeiro, a alternância rápida entre o estado de mobilização e o estado de trauma atrapalha os processos normais de limpeza das células. Na resposta de estresse, produzimos mais estresse oxidativo porque estamos gerando mais energia. No estado de apagação, não temos energia suficiente para uma limpeza adequada. Quando as respostas não são concluídas e não há uma restauração entre uma e outra, o estresse oxidativo se acumula continuamente.

O estresse oxidativo é uma toxina direta para as mitocôndrias, o que reduz ainda mais a produção de energia e compromete nossa capacidade. Também é tóxico para membranas, proteínas e DNA, acelerando o envelhecimento e contribuindo para doenças. A piora dos sintomas de Claire e Sarah ao longo do tempo sugere o acúmulo de uma carga oxidativa, que se torna um sinal direto e indireto de perigo para a neurocepção. A diminuição da tolerância de Claire ao exercício físico e a fadiga cada vez maior são sinais comuns de que as mitocôndrias e o DNA estão sofrendo sob o peso do estresse oxidativo. Até a doença autoimune de Elena está associada a uma carga excessiva de estresse oxidativo acumulada ao longo dos anos.

SISTEMAS FISIOLÓGICOS E O LOOP

Embora essas mudanças biológicas diretas criem e mantenham o loop corpo-trauma no nível celular, o impacto se espalha pelos sistemas do corpo. As alterações sistêmicas, por sua vez, também se tornam parte da biologia que nos deixa presos nesse ciclo, acumulando novas respostas de trauma.

Desequilíbrio imunometabólico

Dada a estreita conexão entre sistema nervoso, sistema imunológico e sistema metabólico, o desequilíbrio imunometabólico se torna um dos grandes motores dos diagnósticos crônicos e um dos principais mecanismos da conexão entre trauma e doença.

Esse desequilíbrio se torna caótico, preso no ciclo entre o estado de mobilização e o estado de trauma, uma vez que cada um deles possui

funções e fisiologias muito diferentes. No estado de mobilização, o sistema imunológico é direcionado e fortalecido com precisão, aumentando nossa capacidade de combater infecções, enquanto o cortisol mantém a inflamação sob controle. O sistema metabólico é gerido com rigor, coordenando múltiplos sistemas para acompanhar a necessidade de produção de energia.

Quando a neurocepção direciona nossa fisiologia de volta para o estado de trauma, perdemos o freio do cortisol. A inflamação agora está à solta, o que alimenta ainda mais o loop, já que, além de a inflamação sugar nossa capacidade, pois consome energia, também constitui um sinal direto de perigo. Nosso metabolismo entra em apagão, com as células fazendo o mínimo necessário para sobreviver. A glicemia e a temperatura corporal se tornam mais difíceis de estabilizar, fazendo com que precisemos comer com mais frequência e nos vestir com mais camadas de roupa. Juntos, sistema imunológico e sistema metabólico alimentam um loop que cresce e se transforma em caos fisiológico.

A tireoide, a grande reguladora do metabolismo, desempenha um papel muitas vezes subestimado na jornada de cura do trauma. Ela tende a reagir entrando em modo de conservação de energia, contribuindo para a sensação de esgotamento. Passa a produzir mais T3 reverso (rT3), que atua como um freio sobre o metabolismo, bloqueando a ação do hormônio tireoidiano ativo (T3). Embora essa tenha sido, inicialmente, uma resposta protetora para conservar energia após batermos contra o muro, ela reduz ainda mais a capacidade celular. Pode vir acompanhada de sintomas associados à baixa atividade da tireoide, como depressão, ganho de peso e prisão de ventre.

Outro participante importante nesse desequilíbrio imunometabólico são os mastócitos, células imunológicas presentes em praticamente todos os tecidos do corpo que agem como socorristas diante do perigo. Assim como as micróglia sob efeito de priming, os mastócitos ficam hipersensíveis na biologia do trauma. Tornam-se um sistema de alarme hiperativo, liberando sinais de perigo ao menor gatilho. Com mais de 200 tipos de receptores, eles respondem a *tudo*: emoções, alimentos, toxinas. Sinalizam o perigo por meio da liberação de histamina e outros indicadores inflamatórios. A histamina afeta a mente e o corpo de várias formas, atuando como proteína, mensageira e neurotransmissor. É responsável por liberar mais adrenalina e

inflamação e por gerar alterações de humor e energia, e tudo isso se soma aos sinais de perigo vindos da nossa biologia.

A resistência à insulina é uma característica fundamental do desequilíbrio imunometabólico que merece atenção na biologia do trauma. Ela ocorre quando as células deixam de responder à mensagem da insulina para absorver açúcar do sangue. Isso não só causa hiperglicemia como também prejudica a capacidade da célula de ter o açúcar necessário para produzir energia. As oscilações de glicose no sangue e os déficits de energia que resultam disso reforçam ainda mais o estado de sobrecarga. A resistência à insulina é mais um dado que sinaliza perigo no painel de controle da neurocepção.

A doença autoimune de Elena é um desfecho previsível desse desequilíbrio imunometabólico que persiste e cresce quando a fisiologia não consegue recuperar a sensação de segurança. As células imunológicas de Elena passaram a confundir partes das próprias células com ameaças. Em cada um dos pacientes citados neste livro, o desequilíbrio imunometabólico persistiu e se intensificou com o tempo, contribuindo para a dor crônica de Dana, a fadiga crônica de Claire e os problemas digestivos de Sarah.

Disfunção do sistema digestivo

O sistema digestivo é outro participante importante por meio de uma cascata de alterações que se alimentam mutuamente. O que começa como uma queda na função digestiva evolui para uma teia complexa de disfunções, que geram ainda mais sinais de perigo para a neurocepção.

A disfunção digestiva começa com o ácido estomacal, essencial para decompor proteínas e matar bactérias nocivas. Essa acidez pode ser reduzida quando estamos em estado de perigo. A baixa acidez estomacal, ou hipocloridria, cria o ambiente perfeito para que organismos oportunistas prosperem. Sem essa barreira ácida, bactérias podem migrar do intestino grosso para o delgado, gerando supercrescimento bacteriano do intestino delgado. O pH alterado também permite que fungos, como a cândida, se desenvolvam, uma vez que deixam de ser mantidos sob controle pelo ambiente ácido, alimentando-se fartamente de partículas de alimentos mal digeridos.

O pâncreas e a vesícula biliar, ao receberem sinais confusos de um sistema nervoso desregulado, reduzem a produção de enzimas digestivas e bile. Sem enzimas suficientes, os alimentos não são decompostos adequadamente. A diminuição do fluxo biliar não só prejudica a digestão das gorduras como também facilita ainda mais o supercrescimento bacteriano, já que a bile normalmente ajuda a controlar populações bacterianas. O resultado é uma absorção deficiente de nutrientes justamente quando as células mais precisam de recursos para se reparar.

Os alimentos passam rápido demais pelo sistema, gerando diarreia, ou devagar demais, causando prisão de ventre (às vezes alternando entre uma e outra condição). A prisão de ventre pode favorecer ainda mais o supercrescimento bacteriano e fúngico por conta da maior demora na motilidade, que propicia mais alimento para esses organismos. Nossa microbiota, ou seja, o conjunto de trilhões de bactérias benéficas que nos ajudam a digerir os alimentos e produzir neurotransmissores, fica gravemente desequilibrada. As bactérias “boas”, essenciais para manter a integridade da barreira intestinal e produzir substâncias calmantes como o GABA, não conseguem prosperar nesse ambiente de motilidade reduzida, pH alterado e inflamação. Em vez delas, assumem o controle organismos que produzem mais inflamação e até compostos que estimulam a ansiedade.

Todos esses desequilíbrios contribuem para a síndrome do intestino permeável. A piora progressiva dos problemas digestivos de Sarah foi resultado de um estado de sobrecarga que envolvia todo o seu corpo, deixando-a presa a um loop de sobrecarga por conta dos sinais diretos e indiretos de perigo que essa disfunção digestiva produzia.

Desregulação hormonal

O sistema endócrino, a rede de glândulas que produz e regula hormônios, também atua fortemente na manutenção do loop corpo-trauma. A alternância constante entre mobilização e apagão cria distúrbios profundos em nossos hormônios do estresse, metabólicos e sexuais, contribuindo para problemas na produção de energia, no sono, no humor e na fertilidade.

Nossas glândulas adrenais, que produzem diversos hormônios, incluindo adrenalina e cortisol, passam por uma alteração no seu padrão de produção

hormonal.

Após períodos prolongados de mobilização, as glândulas adrenais podem reduzir a produção de cortisol como parte do estado de trauma. Isso costuma ser chamado de fadiga adrenal. O cortisol não é apenas um “hormônio do estresse”, ele também nos dá energia, nos deixa alertas e nos ajuda a acordar pela manhã. Com níveis baixos de cortisol, temos a sensação de estarmos sempre cansados, especialmente pela manhã, quando mais precisamos de energia. É por isso que lutamos para sair da cama e nos sentimos “agitados porém exaustos” ao longo do dia. Sarah passava por isso: embora conseguisse aguentar os plantões na UTI com o estímulo da cafeína, seu corpo contava outra história quando tinha quedas de energia à tarde e dificuldade para acordar revigorado.

A desregulação adrenal cria um efeito cascata em todo o sistema hormonal. O chamado “roubo de cortisol” é o fenômeno mais conhecido, causado pela mobilização constante da resposta de estresse. Produzimos cortisol em excesso numa tentativa de atenuar a enxurrada de adrenalina. Essa alteração persistente no sistema de hormônios do estresse impacta diretamente os hormônios sexuais.

Nossos hormônios sexuais – estrogênio, progesterona e testosterona – ficam desequilibrados porque o corpo passa a priorizar a sobrevivência em detrimento da reprodução. Não é incomum que mulheres experimentem infertilidade e sintomas intensos de TPM, ou sintomas mais severos na perimenopausa, quando esses hormônios sexuais estão alterados. Mas a questão vai muito além da fertilidade, afetando humor, energia, sono e processos inflamatórios. Esses efeitos generalizados da desregulação hormonal são mais uma forma de a biologia nos manter alternando entre o estresse e a sobrecarga.

BIOLOGIA DO TRAUMA: DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA

Quando as respostas de trauma permanecem incompletas, as mudanças que ocorreram na nossa biologia não desaparecem simplesmente. Na verdade, a biologia do trauma resultante mantém nossa percepção interna de perigo, acionando novas respostas de trauma por meio dos mecanismos de proteção

da neurocepção.

Algumas dessas alterações persistentes na biologia geram sinais diretos de perigo para a neurocepção, como a inflamação cerebral. Outras reduzem nossa capacidade, e ainda há aquelas que sinalizam perigo das duas formas. O resultado é que, quando precisamos de uma resposta de estresse de alta energia, nossas células e sistemas biológicos comprometidos não conseguem atender à demanda. Batemos no muro mais rapidamente, entrando nos estados de congelamento e apagão. Nossa própria biologia se torna o fator que nos leva a ultrapassar o limite crítico da sobrecarga.

Talvez você se identifique com as descrições de como nossa biologia pode gerar esgotamento e desregulação, afetando a cura do trauma ao nos manter presos em ciclos de sobrecarga. Talvez esteja curioso para saber se possui uma biologia do trauma. Os três mecanismos de sobrevivência da resposta ao trauma, quando repetidos várias vezes no loop corpo-trauma, geram cinco padrões previsíveis que nos ajudam a identificar isso. Vamos explorar esses cinco padrões universais e previsíveis no próximo capítulo.

RESUMO

O loop corpo-trauma é criado por uma percepção contínua de perigo oriunda da neurocepção, automatizada pela neuroplasticidade e mantida (além de amplificada) pela nossa própria biologia. Uma biologia do trauma é aquela que foi moldada pelos efeitos crônicos do trauma e que, agora, nos mantém presos nessas mesmas respostas de trauma.

O loop corpo-trauma é um conceito-chave para entender como o corpo retém traumas não resolvidos; ele revela uma verdade essencial e útil para seguirmos adiante em nossa jornada de cura. Embora não possamos mudar o passado, podemos completar as respostas que foram interrompidas. Uma das melhores coisas a fazer por nossa saúde e bem-estar é começar a completar essas respostas: incluindo as de sobressalto, por menores que pareçam. Precisamos começar a largar as pedras que fomos acumulando pelo caminho e seguir viagem com mais leveza.

Para saber quais pedras podemos deixar para trás, é necessário aprender a reconhecer os padrões de trauma em nossa vida, algo que exploraremos no próximo capítulo.

CAPÍTULO 9

Padrões de sofrimento: reconhecendo o trauma armazenado no corpo

O trauma não é apenas um fato que ocorreu num momento do passado; é também a marca que essa experiência deixou na mente, no cérebro e no corpo.

— Bessel van der Kolk, médico, *O corpo guarda as marcas*

Todos os sinais estavam ali, evidentes. O perfeccionismo de Dana mascarava feridas mais profundas, que apareciam na forma de dor crônica e problemas digestivos. A resposta de congelamento de Alex na sala de reuniões revelava um sistema nervoso que ainda carregava a insegurança da criança desabrigada no passado. A reação de sobressalto exagerada de Laura ao abraço do filho não era apenas ansiedade: era um padrão de trauma. Cada uma dessas pessoas tinha uma história diferente, mas padrões semelhantes surgiam em sua vida, seus relacionamentos e sua saúde.

Aprender a reconhecer padrões é fundamental na minha formação e na minha prática médica. Sintomas que parecem não ter qualquer relação entre si podem compor um padrão significativo, que me ajuda a determinar o diagnóstico correto. Chegar a esse diagnóstico é crucial, pois é a única maneira de prescrever o tratamento adequado. Percebi que emoções, pensamentos e comportamentos aparentemente não relacionados são, na verdade, padrões previsíveis que emergem do trauma armazenado no corpo.

Tudo começou com a minha jornada com Miguel, meu filho adotivo. Seus traumas precoces geravam comportamentos que, num primeiro

momento, pareciam aleatórios e caóticos. Mas, à medida que eu estudava suas respostas, comecei a identificar padrões previsíveis e compatíveis com um sistema nervoso tomado pelo medo.

Passei a notar como os padrões dos meus pacientes formavam um todo coerente: sintomas isolados, traços de personalidade e mecanismos de enfrentamento eram como pontos precisando ser ligados para formar um desenho. Isso me ajudou a ver como o perfeccionismo de Dana estava relacionado a um padrão de trauma mais amplo, que se manifestava como dor física, problemas digestivos e dificuldades de relacionamento. Da mesma forma, a resposta de congelamento de Alex e o reflexo de sobressalto exacerbado de Laura vinham de um sistema nervoso em modo de sobrevivência, à espera de uma restauração das configurações de segurança.

Quando fui aos poucos reconhecendo esses padrões na minha própria vida, fiquei chocada. Apesar de ser médica, capacitada em fisiologia humana, eu nunca tinha vinculado minhas dificuldades nos relacionamentos e meus problemas de saúde ao trauma. Mas meu corpo contava outra história. A ficha começou a cair quando percebi como meu perfeccionismo, minha filosofia de dar conta de tudo custe o que custar, minha fadiga crônica e minha doença autoimune formavam um padrão previsível de trauma armazenado.

Concluí que, em vez de perguntar “Será que vivi algum trauma?”, é mais útil perguntar “Tenho padrões de trauma na minha vida hoje?”.

Essa mudança de foco, dos eventos do passado para os padrões atuais, transforma a maneira como nos vemos e como vemos nossos sintomas. O que antes entendíamos como manias, mecanismos de enfrentamento ou problemas de relacionamento se revela uma rede interconectada de padrões, todos emergindo de um sistema nervoso ainda em modo de proteção, à espera de segurança. Quando observamos com curiosidade o encaixe de nossas peças internas, conseguimos afastar a culpa e a vergonha de achar que somos loucos, incorrigíveis ou que simplesmente não estamos nos esforçando o suficiente para mudar. Podemos usar as ferramentas disponíveis para reparar esses padrões e iniciar o processo de cura.

Se isso soa surpreendente para você, deve ser por se afastar tanto do paradigma de diagnóstico padrão usado pela maioria dos profissionais da área da saúde. Mesmo aqueles que reconhecem a função do trauma tendem a procurar um “evento do passado” ou a avaliar o grau de dificuldade que o

paciente teve na infância com base em um questionário de experiências adversas. Mas os padrões atuais de trauma na vida dele fornecem um retrato muito mais completo.

Existem cinco padrões distintos que emergem quando o corpo retém o trauma: desconexão, ruptura, esgotamento, desregulação e doença. Esses padrões surgem diretamente dos três mecanismos de sobrevivência do estado de trauma que exploramos no Capítulo 6. Vimos que, quando o corpo vivencia uma dor insuportável, a dissociação, a imobilização e a conservação de energia nos ajudam a sobreviver. Nosso sistema nervoso continua tentando garantir a sobrevivência por meio desses mecanismos, que, com o tempo, se transformam em padrões crônicos. Esse modo de viver se torna tão natural para nós que muitas vezes não conseguimos nos lembrar de quando não nos sentíamos assim ou não éramos assim.

Os cinco padrões são essenciais para reconhecer o trauma armazenado. Eles nos permitirão descobrir a verdade sem a necessidade de desenterrar o passado.

DESCONEXÃO: IMPONDO DISTÂNCIA

Vamos analisar melhor como a desconexão surge na nossa relação com o corpo. Você pode ter dificuldade em identificar necessidades básicas como fome, sede ou cansaço até que elas se tornem extremas. Frases como “Esqueci de comer hoje” ou “Nem percebi que estava tão cansado” são comuns. Quando pergunto a meus pacientes como estão se sentindo, muitos respondem automaticamente “Estou bem”, mesmo quando seus sintomas e exames laboratoriais indicam o contrário. Quando ponho as mãos nos ombros deles e sinto todos os nós de tensão, sem que percebam o peso que carregam, isso me mostra que se tornaram tão desconectados do próprio corpo que empurrar o desconforto com a barriga virou algo habitual.

Esse padrão também se revela na forma como lidamos com as emoções. Muitas pessoas dão respostas rápidas e automáticas quando alguém pergunta como elas se sentem, tendo dificuldade para identificar ou descrever as próprias emoções com algo menos genérico que “Estou bem”. Ao mesmo tempo, não é raro que experimentem um vazio ou um entorpecimento constante por dentro, mesmo em momentos que deveriam

trazer alegria ou tristeza. Outras descobrem que precisam de álcool ou comida para ficar à vontade em situações sociais, ou usam o trabalho e a ocupação constante para evitar o contato com qualquer sentimento mais profundo. Afinal, quando nosso corpo retém trauma, parar se torna algo perigoso. É nos momentos de sossego e silêncio que as sensações vêm à tona, ameaçando nos inundar com emoções que a neurocepção considera capazes de nos sobrecarregar.

A própria mente pode ajudar a reforçar o padrão de sobrevivência da desconexão. O perfeccionismo funciona como um escudo contra a vulnerabilidade ou a rejeição, como aconteceu com Dana. Podemos desenvolver partes de nós que nos impulsionam sem cessar, transformando a capacidade de dar conta de tudo em motivo de orgulho enquanto o corpo é negligenciado.

Talvez o mais revelador seja como a desconexão surge nos nossos relacionamentos. Podemos manter as pessoas a uma distância emocional segura ou nos desconectar do nosso eu autêntico no intuito de preservar a conexão com o outro.

Quando estamos desconectados da vida, conseguimos nos sentir sozinhos mesmo cercados pela família ou por uma multidão. Algumas pessoas descrevem a sensação de serem observadoras da própria vida, como se vissem o desenrolar dos acontecimentos sem jamais participar totalmente deles. A ironia cruel é que essas tentativas de nos proteger por meio da desconexão acabam criando as experiências que mais tememos: a sensação de isolamento, de incompreensão ou de não estarmos vivendo plenamente.

O benefício da desconexão para a sobrevivência

A desconexão – de nós mesmos e dos outros – traz benefícios para nossa sobrevivência, e o maior deles é evitar a dor. Não se trata de fraqueza nem de falta de força de vontade, mas de um processo de proteção altamente sofisticado.

Pense em como a desconexão ajudou Dana a continuar exercendo a medicina apesar do seu passado, ou em como a desconexão de Alex permitiu que ele construísse uma aparência de sucesso, apesar da insegurança persistente desencadeada por uma infância em que se sentiu

impotente.

Podemos temer as próprias emoções e sensações, acreditando que, se nos permitíssemos sentir a dor que carregamos, iríamos desmoronar. Assim, ficamos presos à própria impotência diante dessa dor oculta, pois a neurocepção já percebeu que se trata de um perigo inevitável, capaz de ameaçar nossa sobrevivência. A sabedoria do corpo julga que o benefício de se manter funcional justifica o custo da desconexão.

O custo da desconexão

A questão é que, mesmo com todos os seus benefícios imediatos, a desconexão cobra um preço alto. Como uma película espessa que bloqueia não só uma luz forte, mas toda a luz, a desconexão não consegue ser seletiva em relação ao que bloqueia. Quando nos desconectamos da dor e do medo, também nos desconectamos da alegria e da conexão autêntica. Nossos relacionamentos sofrem, pois mantemos uma distância protetora que nos mantém seguros, mas também solitários.

O custo biológico é igualmente significativo. À medida que nos desconectamos do corpo e das sensações, os sistemas naturais de alerta do organismo são silenciados. Deveríamos, por exemplo, perceber quando o corpo sente fome ou sede. Porém, quanto mais desconectados estamos, mais difícil se torna ouvir essas mensagens. Ao ficar tempo demais sem receber o que precisa, o corpo passa por níveis desnecessários de estresse.

Como saber se estamos desconectados? Nosso sistema nervoso pode se tornar tão bom em nos desconectar que nem nos damos conta de que estamos fazendo isso. Se a desconexão sempre foi uma constante em nossa vida, não conhecemos outro jeito de viver. Como Sarah na UTI, podemos estar tão acostumados a passar por cima dos sinais físicos e emocionais que já nem os notamos. Muitos dos meus pacientes, quando começam a reparar a conexão com o corpo, ficam surpresos ao se darem conta de quão desconectados estiveram.

É natural que, à medida que nos desconectamos de nós mesmos, dos outros e do mundo à nossa volta, nosso caminhar pela vida perca a fluidez. Isso nos leva ao próximo padrão de trauma que vamos examinar: a ruptura.

RUPTURA: O PADRÃO DE BLOQUEIO DO MOVIMENTO

O segundo padrão de trauma é a ruptura: o bloqueio do movimento no nosso corpo. Ele surge da imobilização, a estratégia de sobrevivência que cria uma paralisação temporária para evitar sermos vistos ou ouvidos. Embora essa estratégia seja adaptativa quando usada por um breve período, torna-se problemática quando se torna crônica.

Quando não agir para resolver os problemas se torna nossa resposta padrão, esse efeito reverbera por várias áreas da vida. Nossa fisiologia revela essa diminuição de movimento por meio de rupturas nas funções básicas: circulação comprometida; redução do fluxo linfático, dificultando a eliminação de toxinas; e problemas de motilidade digestiva na forma de diarreia ou prisão de ventre. Até nossos músculos podem achar mais confortável permanecer cada vez mais sedentários, sem o impulso natural de estar o tempo todo ativos.

Podemos ficar presos em padrões de pensamento e retidos em estados emocionais como o ressentimento. Como no caso de Alex, nossas reações talvez revelem que temos lembranças, emoções e medos armazenados que nunca processamos; a falta de uma restauração bloqueia esse processamento. Podemos nos tornar emocionalmente congelados, como uma criança assustada dentro de um corpo adulto. O bloqueio do movimento se manifesta de muitas formas na nossa vida, e frequentemente encontramos velhos padrões que nos mantêm presos a uma visão rígida de nós mesmos e do mundo, o que leva à autossabotagem e à resistência a mudanças.

Manifestações cotidianas da ruptura

Os profissionais que tratam o trauma costumam usar o termo “congelamento funcional crônico” para descrever como esse padrão surge na vida diária. Ele retrata dois elementos importantes: um estado interno crônico de imobilização coexistindo com a capacidade de seguir funcionando. Em graus variados, todos somos funcionais em nosso cotidiano (ou pelo menos damos essa impressão) para quem olha de fora.

Enquanto isso, internamente, ainda nos sentimos pesados e estagnados, pois estamos em um estado de trauma.

Podemos reconhecer o congelamento funcional crônico quando usamos uma quantidade de energia extra para nos adaptar e nos forçar a agir de modo que, por fora, nada pareça errado. Mas a tensão e a energia adicionais exigidas internamente para isso cobrarão seu preço adiante.

Muitos de nós, como Dana, construíram uma vida impressionante ao redor de nossas partes congeladas. Dana tinha uma aparência impecável, condizente com o papel de médica muito bem-sucedida. Por trás desse exterior funcional, ela estava tentando segurar as pontas e evitar a sobrecarga emocional. Sarah se destacava como enfermeira de UTI, tendo construído sua vida e sua profissão em torno da capacidade de se manter ocupada. Alex ergueu muralhas de segurança e estabilidade enquanto tentava se proteger de um congelamento funcional persistente.

Eu também vivi dessa forma, descobrindo em mim mesma um grau considerável de congelamento funcional crônico que me levou a iniciar uma formação em terapia do trauma para aprender como resolvê-lo. Eu havia passado por cima da sensação de que estava apenas tapando o sol com a peneira, até que a fadiga me forçou a buscar estratégias melhores para viver dali em diante. Ainda assim, consegui terminar a faculdade de medicina, obter dois mestrados e completar mais de três anos de residência em cirurgia antes que se tornasse impossível continuar ignorando o problema e me manter funcional.

O grau de sucesso com que nos adaptamos a esse padrão é justamente o que torna difícil reconhecê-lo. É como a pessoa que aprende a andar com uma perna quebrada e se acostuma tanto com isso que esquece que poderia se locomover com mais facilidade e menos dor. Desenvolvemos maneiras sofisticadas de nos mantermos funcionais apesar das nossas partes congeladas, às vezes enganando até nós mesmos: perfeccionismo disfarçado de realização; necessidade de agradar os outros parecendo gentileza; o acúmulo de conquistas se transformando em nossa fonte de amor-próprio.

O benefício da ruptura para a sobrevivência

O benefício da ruptura para a sobrevivência é profundo: quando nosso

corpo retém o trauma, o movimento em si pode parecer perigoso. Estar vivo demais, visível demais, soa ameaçador. Nossa neurocepção, ainda enxergando o mundo pelas lentes da impotência do passado, interpreta o movimento adiante como um possível risco. Sob essa perspectiva, sermos vistos e ouvidos nos torna vulneráveis, de modo que nosso organismo bloqueia instintivamente qualquer progresso. Isso se transforma em um malabarismo: se ficarmos presos demais, chamaremos atenção; se formos capazes demais ou nos destacarmos demais, também chamaremos atenção. Quando ser notado afeta o nosso senso de segurança, a ruptura nos aprisiona o suficiente para nos sentirmos seguros.

O custo da ruptura

O custo da ruptura está na forma como ela nos impede de evoluir, fazendo-nos repetir os mesmos padrões negativos indefinidamente. O efeito é generalizado, afetando nossos relacionamentos, prejudicando nossa saúde e sabotando nosso sucesso. Muitas vezes, só percebemos esse padrão por meio da dor que ele causa em nossa vida. É quando começamos a ver que precisamos mudar. Até esse momento chegar, nos contentamos com relacionamentos que não nos satisfazem, ignoramos os sinais sutis de alerta do corpo e seguimos cegamente padrões comportamentais cujos resultados jamais escolheríamos de modo intencional.

O congelamento funcional crônico pode surgir quando tentamos aprofundar nossos relacionamentos para além da zona de conforto, ou quando tentamos fazer mudanças que exigem vulnerabilidade emocional. Às vezes, ele aparece em situações que pedem presença genuína em vez de competência performática, ou quando nos vemos incapazes de ser criativos e espontâneos. O custo pode ser abrir mão de uma saúde melhor, de uma parentalidade mais compassiva, de um relacionamento afetivo saudável ou do sucesso profissional. Além disso, nosso corpo consome recursos preciosos para manter partes de nós congeladas, impedindo-nos de alcançar maturidade emocional e realização pessoal.

ESGOTAMENTO: QUANDO A CONSERVAÇÃO DE ENERGIA SE TORNA CRÔNICA

O que começou como a estratégia brilhante do corpo para conservar energia em momentos de impotência pode se transformar num padrão crônico de esgotamento. Como uma bateria que nunca recarrega por completo, o esgotamento persiste, nos mantendo indefinidamente no modo de economia de energia. Ele se torna um padrão que afeta nosso organismo em todos os níveis, desde a produção de energia celular até nossa capacidade de envolvimento com a vida.

O esgotamento muitas vezes é confundido com depressão ou falta de motivação. Mas, se tentarmos entender melhor o motivo pelo qual não queremos fazer o jantar, responder e-mails ou tomar decisões, veremos que é porque estamos conservando energia. Uma atitude de indiferença nem sempre significa que estamos mesmo indiferentes: pode ser que se importar com determinada coisa exija uma energia que não queremos gastar.

Manifestações cotidianas do esgotamento

O esgotamento crônico costuma aparecer de maneira sutil no início, se intensificando com o tempo. Embora o esgotamento também seja reconhecível por si só, muitos acham mais fácil perceber as estratégias cotidianas que desenvolvemos para lidar com essa sensação contínua de prostração. Não é que nos sintamos cansados: a vida é que começa a parecer difícil. Podemos começar a ficar dispersos durante as conversas, ter dificuldade para nos concentrar ou para tomar decisões. Todas essas são formas comuns pelas quais o esgotamento se manifesta.

Desenvolvemos várias estratégias para continuar forçando a barra mesmo nesse estado, e nos recusamos a reconhecer nosso abatimento. Podemos depender de estimulantes para gerar uma energia artificial, usar o estresse dos prazos apertados para acessar a adrenalina ou o excesso de ocupação para mascarar a exaustão subjacente. Sem perceber, entramos em um ciclo de nos forçar além do tolerável, até o ponto em que desmoronamos.

Já vivi esse padrão. Quase todo dia eu caía na mesma rotina: começava

com cafeína e altos níveis de estresse e ia me arrastando até não poder mais fugir da exaustão. Havia desenvolvido, inconscientemente, várias estratégias para gerenciar minha energia, como ingerir alimentos nocivos para o meu organismo porque a resposta de histamina e adrenalina me fornecia energia rápida. Usei essa estratégia nos primeiros anos da universidade, depois na faculdade de medicina e durante a residência, percebendo uma dificuldade crescente para sustentar esse ritmo. Eu precisava me esforçar cada vez mais para não entrar em colapso. Se tivesse prestado atenção no meu corpo, eu teria percebido a fadiga crônica chegando.

Talvez você também tenha se tornado um especialista em gerenciar energia, racionando cuidadosamente seus recursos ao longo do dia, de modo a reservar energia para quando ela é indispensável. Pessoas que não administram constantemente seus níveis de energia como nós não entendem nossas mudanças de disposição, foco ou intensidade ao longo do dia ou da semana. Em um momento, podemos estar totalmente engajados e focados; no seguinte, ficar apáticos, como se nada nos importasse.

O benefício do esgotamento para a sobrevivência

Assim como os outros padrões, o esgotamento serve a um propósito de sobrevivência. Quando nosso corpo retém o trauma, a vitalidade plena pode parecer perigosa. Operar em capacidade reduzida nos ajuda a permanecer abaixo do limite crítico da sobrecarga, controlando nosso grau de envolvimento com a vida. Assim como a desconexão nos protege de sentir demais e a ruptura nos protege de progredir demais, o esgotamento nos protege de experimentar as coisas com intensidade demais.

Pense em como isso ajudou Claire a continuar ativa quando seu corpo sinalizava que precisava de descanso, ou como o estado de esgotamento de Alex após o episódio na sala de reuniões o protegeu de ter que lidar com a sobrecarga emocional. A sabedoria do corpo entende que permanecer esgotado é mais seguro do que ter vitalidade plena.

O custo do esgotamento

O preço da conservação crônica de energia é um paradoxo problemático:

justamente as coisas que poderiam nos trazer cura e prosperidade – conexão, criatividade, diversão, alegria – passam a parecer dispendiosas demais em termos de energia. Podemos desejar relacionamentos mais profundos, mas nos sentimos esgotados demais para mantê-los. Queremos perseguir nossos sonhos, mas não temos ânimo para dar o primeiro passo. Até o autocuidado pode parecer um fardo, criando um ciclo em que ficamos cada vez mais esgotados porque não temos energia para as próprias atividades que poderiam nos restaurar.

Esse esgotamento afeta inevitavelmente nossa biologia. As células mantêm um estado de energia mais baixo, o metabolismo permanece reduzido e o sistema imunológico funciona na capacidade mínima. Como um carro que roda o tempo todo na reserva, calculamos o tempo todo se temos combustível suficiente para o próximo trajeto. Esse déficit contínuo de energia nos torna mais suscetíveis a doenças, retarda nossa recuperação e cria as condições para o quarto padrão: a desregulação.

DESREGULAÇÃO: QUANDO AS RESPOSTAS NÃO CONDIZEM COM A SITUAÇÃO

Enquanto os padrões anteriores que exploramos (desconexão, ruptura e esgotamento) surgem diretamente de nossos mecanismos de sobrevivência, a desregulação ocorre quando nosso corpo fica preso no loop corpo-trauma e passa a reagir de maneira exagerada ou insuficiente às situações que se apresentam.

A resposta de sobressalto acentuada de Laura quando Nick abraçou suas pernas ilustra o padrão hiper-reativo. A reação dela foi desproporcional ao que a situação pedia. A resposta insuficiente da desregulação, por outro lado, acontece quando observamos passivamente em vez de dar a resposta apropriada. A desregulação se define pela *qualidade* das nossas respostas a novas informações; tanto as respostas exageradas quanto as insuficientes expressam um padrão de desregulação.

Quando comecei a aprender sobre desregulação, fiquei constrangida ao perceber que eu apresentava os dois tipos de resposta. Havia momentos em que eu reagia exageradamente a um comentário ou a um olhar, ou até ao simples fato de não gostar do jeito de alguém dirigir. Mesmo sem conhecer

todo o contexto da situação, eu reagia como se fosse algo muito grave, só para descobrir depois que não era nada daquilo e que eu tinha exagerado. Em resposta a essas minhas reações desproporcionais, eu recorria a válvulas de escape para acalmar aquela intensidade: ingerir comidas pesadas, fazer uma corrida bastante puxada ou percorrer um trajeto longo de bicicleta. Eu não gostava que as pessoas vissem minhas reações intensas e fazia o possível para escondê-las. Em outros momentos, eu mal reagia, especialmente durante o estado de apagão. Um alarme disparava e eu nem me mexia, ou caminhava devagar até o fogão enquanto uma panela transbordava, dando respostas insuficientes para o que a situação exigia.

A desregulação era um tema recorrente entre meus pacientes, e você talvez se reconheça nas reações excessivas ou insuficientes que eu observava com frequência. Embora essa desregulação pudesse ser observada fisiologicamente – a glicemia disparava quando eles comiam e então caía de modo brusco quando eu administrava insulina, por exemplo –, era a forma como os pacientes reagiam aos resultados dos exames que me intrigava. Alguns ficavam vermelhos, aflitos, se levantavam e começavam a andar de um lado para outro, ou me diziam, irritados, que eu devia estar errada. Outros simplesmente permaneciam sentados, impassíveis, e eu nem tinha certeza se tinham me ouvido.

O que é desregulação?

Ao trabalhar com Miguel em sua jornada de cura, uma terapeuta que seguia a teoria do apego compartilhou uma metáfora poderosa que me ajudou a entender as reações aparentemente desproporcionais dele. Ela disse que cada pessoa nasce com uma “bolsinha preta” dentro de si. Ao longo da vida, sempre que vivenciamos medo, dor ou sobrecarga que não conseguimos processar naquele momento, essas experiências vão para dentro dessa bolsinha. No caso de Miguel, experiências precoces de negligência e medo foram se acumulando nela. Mais tarde, episódios de constrangimento na escola, medo do abandono e momentos de impotência a encheram ainda mais.

A terapeuta explicou que, quando essa bolsinha preta fica abarrotada, não é preciso muito para alguém esbarrar nela e fazer tudo se espalhar. Essa

explicação ajudou Miguel a entender por que, às vezes, ele reagia com tanta intensidade a gatilhos aparentemente pequenos: o problema não era apenas o que acontecia no presente, mas toda a sobrecarga armazenada ali dentro, que transbordava ao menor esbarrão em sua bolsinha.

Manifestações cotidianas da desregulação

A desregulação se manifesta como uma montanha-russa nas nossas respostas, que se tornam ou excessivas, ou insuficientes, nunca na medida certa do que a situação pede. Isso ocorre tanto em nossa fisiologia quanto em nossas emoções ou comportamentos.

No corpo, isso fica claro quando o coração dispara diante de estressores mínimos ou quando nossa digestão se torna imprevisível, oscilando entre extremos ao enfrentarmos um novo estresse no dia. Ou, como no caso de Laura, podemos ter uma resposta de sobressalto exagerada; ou às vezes não nos sobressaltamos quando deveríamos. Nossa temperatura corporal pode ficar desregulada, obrigando-nos a usar mais camadas de roupas ou a carregar sempre um casaco porque estamos ora com muito calor, ora com muito frio. Enxaquecas, insônia e pensamentos acelerados também podem ser sinais de desregulação fisiológica.

Emocionalmente, podemos nos sentir sempre pisando em ovos para não acordar nosso “monstro” interior, com medo de provocar sem querer uma explosão emocional. Em outros momentos, podemos até sentir que cutucamos o monstro, mas ele apenas vira para o outro lado e volta a dormir. Em indivíduos empáticos e altamente sensíveis, essas respostas exageradas podem ser causadas até pela energia e pelas emoções das pessoas à sua volta.

A dica para reconhecer a desregulação é perceber que estamos andando em uma corda bamba e que é muito fácil cair dela direto para uma resposta desregulada. Somos capazes de tudo para nos mantermos equilibrados nessa corda bamba.

O benefício da desregulação para a sobrevivência

Assim como as explosões de Miguel serviam para protegê-lo de supostas

ameaças, a desregulação mantém nosso corpo pronto para o perigo. Reagir rapidamente significa não sermos pegos de surpresa. Até a reação insuficiente tem seu propósito – quando nossa neurocepção determina que não somos capazes de lidar com alguma coisa, provocar um apagão nos sistemas é uma forma de preservar energia preciosa.

No entanto, a desregulação muitas vezes cria mais problemas que resolve. Como um sistema de alarme hiper-reativo que dispara ao menor movimento ou falha, ela torna especialmente difícil lidar com as questões do cotidiano, nossos relacionamentos e nosso próprio mundo interno.

O custo da desregulação

O preço que pagamos pela desregulação contamina todos os aspectos da nossa vida, afetando especialmente nossa relação com nós mesmos e com as outras pessoas. Quando Miguel começou a entender sua desregulação por meio da metáfora da bolsinha preta, isso transformou seu relacionamento consigo mesmo. Em vez de se enxergar como um “menino problema” que não conseguia controlar as próprias reações, ele passou a compreender que suas respostas faziam sentido ao levar em conta o peso que seu sistema nervoso carregava.

No campo dos relacionamentos, a desregulação gera desafios específicos, como na experiência de Laura, em que a família precisava sempre tomar cuidado para não ativar sua resposta de sobressalto. Nossas respostas desreguladas tornam mais difícil que outras pessoas se sintam seguras conosco, da mesma forma que é difícil para nós confiar em nossas próprias reações. No trabalho, como vimos no caso de Alex, podemos acabar reagindo com exagero a mudanças pequenas ou ficar paralisados diante de decisões importantes.

Mais grave ainda é o fato de que a desregulação constante afeta nossa biologia, criando um terreno propício ao desenvolvimento de condições crônicas de saúde. Quando o sistema nervoso não consegue encontrar seu ritmo natural de resposta e restauração, os sistemas fisiológicos começam a mostrar sinais de desgaste. A mesma desregulação que faz Laura se sobressaltar com sons inesperados afeta também seu sono, sua digestão e sua função imunológica.

O paradoxo da desregulação

Talvez o aspecto mais insidioso da desregulação seja a forma como acabamos encontrando um nível de desregulação que se torna nossa zona de conforto. Assim como alguém que vive numa cidade barulhenta pode se sentir desconfortável com o silêncio, podemos nos acostumar tanto à desregulação que a regulação começa a parecer estranha e desconcertante. O drama e a intensidade dos estados desregulados se tornam familiares, e passamos até a preferi-los, enquanto a calma e a estabilidade nos soam entediadas ou até geram ansiedade.

Sarah descobriu que preferia o caos quando começou a aprender sobre ferramentas de regulação. “Se as coisas estão calmas”, contou, “fico mais ansiosa do que quando está tudo caótico. Pelo menos no caos eu sei o que esperar. Talvez isso explique por que decidi ser enfermeira de cuidados intensivos.” Esse paradoxo ajuda a explicar por que muitos de nós, inconscientemente, inventamos dramas para nossa vida ou buscamos situações de alta intensidade. Assim como podemos nos tornar dependentes de cafeína, podemos nos tornar dependentes de certo nível de estresse, adaptando-nos a ele como nosso estado de funcionamento normal e, sem nos darmos conta, atraindo-o ou até criando-o.

A desregulação coexiste com os outros padrões. Dana é um exemplo disso. Ainda em estado de congelamento funcional crônico por causa das experiências de abuso sexual na infância, seu perfeccionismo constante não era apenas desconexão. Ao se impor prazos e pressionar a si mesma para fazer tudo bem-feito, ela mantinha um determinado nível de intensidade. A intensidade já conhecida do estresse era mais confortável que o território desconhecido da calma e o peso opressor de uma resposta de apagão.

Com todo o estresse que a desregulação impõe ao corpo, sem falar na contribuição dos outros padrões de trauma, o surgimento do quinto e último padrão não só é previsível como inevitável. Já não é uma questão de *se*, mas de *quando*. No próximo capítulo, vamos explorar o último padrão de trauma, a doença, e ver como ela nos leva à raiz do problema: o trauma armazenado.

RESUMO

Por meio dos padrões de desconexão, ruptura, esgotamento e desregulação, conseguimos reconhecer como o trauma armazenado se manifesta em nossa vida atual. Assim como as maçãs em uma árvore nos informam que a árvore é uma macieira, esses padrões na nossa vida revelam as raízes do problema.

Entender os padrões, porém, nos traz esperança, permitindo que vejamos até que ponto nossa mente e nosso corpo tentaram nos proteger, e não nos prejudicar ou nos trair. Aquilo que você talvez tenha considerado traços de personalidade ou fraquezas pessoais são, na verdade, respostas sofisticadas de proteção. O perfeccionismo que nos impulsiona, a fadiga que nos limita, as reações que nos confundem... tudo isso são os sinais de um corpo fazendo tudo o que pode para nos poupar enquanto espera por reparo e por uma restauração de volta à segurança. A desconexão nos defende ao criar distância de um mundo interno que parece perigoso e das pessoas, lugares e coisas que geram emoções desconfortáveis. A ruptura nos mantém pequenos por segurança, bloqueando qualquer movimento de progresso. O esgotamento garante a sobrevivência ao impedir que façamos mais do que conseguimos suportar. A desregulação nos mantém reativos, incapazes de encontrar o equilíbrio, o que acabará levando ao último padrão do trauma armazenado: a doença.

Reconhecer esses padrões em nós reforça o fato de que nosso corpo ainda retém o trauma, mas também mostra que, agora que os compreendemos melhor, somos capazes de receber o tratamento adequado, já que finalmente temos o diagnóstico correto.

CAPÍTULO 10

Quando o trauma se torna doença: o quinto padrão do trauma armazenado

O que você julga ser o problema tem sido, na verdade, a solução para ele.

— Vincent Felitti, médico-pesquisador, refletindo sobre a descoberta que mudaria a compreensão médica sobre doenças crônicas

Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tenho uma doença autoimune?!

Como médica, eu havia passado anos estudando como o corpo funciona. Durante três anos de residência em cirurgia, passei a compreender em profundidade como estabilizar a fisiologia humana. E, ainda assim, lá estava eu, em junho de 2014, incapaz de sair da cama no meu apartamento em Portland, a poucos quarteirões do hospital universitário onde trabalhava. A fadiga crônica que vinha aumentando pouco a pouco finalmente chegara ao limite. Entrei em um estado de apagão completo e não conseguia mais sair dele.

Olhando para trás, os sinais sempre estiveram ali. O que começou com uma infecção viral na faculdade evoluiu para episódios recorrentes de fadiga que apresentavam sempre os mesmos sintomas: dor forte e persistente acompanhada de uma névoa mental que tornava quase impossível permanecer acordada. Ao longo dos anos, esses episódios se tornaram mais frequentes e duradouros. Em 2014, eu havia desenvolvido ansiedade, depressão, prisão de ventre crônica e dores abdominais cíclicas. Estava mais

de 13 quilos acima do peso e sofria com uma dor crônica no ombro direito causada por uma fratura na clavícula no ano anterior. Quando os exames de sangue revelaram níveis elevados de autoanticorpos, ou anticorpos que atacavam minhas próprias células, fiquei em choque.

Fui obrigada a tirar uma licença médica de três meses da residência. Durante essa imobilidade forçada, comecei a ter alguns insights. Passei a notar um padrão por trás daquilo tudo. Meus distúrbios não eram aleatórios ou desconectados; eram sinais de que meu corpo estava armazenando trauma. Como muitas pessoas, eu não achava que havia sofrido trauma algum. Minha infância parecia ter sido tranquila comparada à de outras crianças. Ainda assim, meu corpo apresentava um quadro semelhante ao de alguém que havia tido uma infância difícil. Ele estava me mostrando outra forma de reconhecer o trauma armazenado: por meio de um padrão preciso de sintomas e problemas físicos.

Esse padrão de doença, que hoje reconheço como o quinto padrão do trauma armazenado, é talvez a forma mais profunda de o corpo comunicar algo do passado que não foi resolvido.

A HISTÓRIA E A CIÊNCIA POR TRÁS DA CONEXÃO ENTRE TRAUMA E DOENÇA

A conexão entre trauma e doença não foi descoberta em um laboratório nem por meio de pesquisa genética. Surgiu de um padrão intrigante que frustrava um médico de medicina preventiva tentando ajudar seus pacientes com obesidade. Em 1985, o Dr. Vincent Felitti comandava um renomado programa de perda de peso em San Diego, Califórnia, quando percebeu algo que não fazia sentido: seus pacientes mais bem-sucedidos estavam desistindo e recuperando depressa todo o peso perdido.

Quando o Dr. Felitti perguntou a eles o que estava acontecendo, as respostas abriram uma porta para compreender a raiz não apenas da obesidade, mas de doenças crônicas como um todo. Um paciente após o outro revelou históricos de trauma na infância, muitos por abuso sexual. O peso não era o problema; era a solução que eles haviam desenvolvido. Como explicou uma paciente, o excesso de peso a protegia da atenção indesejada. Quando ela emagreceu e se tornou mais atraente, começou a se ver cada vez

mais ansiosa. O peso funcionava como uma camada de proteção, fazendo com que se sentisse mais segura no mundo. Ela desistiu do programa e recuperou rapidamente todo o peso original, e ainda engordou mais alguns quilos.

Essa descoberta pôs em xeque tudo o que os profissionais da área da saúde acreditavam saber sobre doenças crônicas. A visão predominante era a de que comportamentos associados ao estilo de vida, como hábitos alimentares, exercícios, tabagismo e consumo de álcool, eram os principais causadores de doenças. Eram, também, escolhas conscientes que as pessoas poderiam decidir mudar. Mas os números mostraram que isso não era verdade. Um dos achados mais surpreendentes do estudo de Experiências Adversas na Infância (Adverse Childhood Experiences, ACE) foi que adversidades nessa fase da vida aumentavam o risco de doenças na vida adulta *independentemente* dos fatores comportamentais. Mesmo em pacientes que não fumavam, não bebiam e não tinham dificuldades em manter um peso saudável, um histórico de adversidades na infância ainda sinalizava taxas mais altas de doenças cardíacas, câncer, doenças autoimunes, transtornos de humor, diabetes, distúrbios digestivos e outros problemas crônicos que levavam a uma morte precoce. O estudo ACE revelou outro padrão crucial: quanto mais experiências adversas alguém tinha, maior era o risco de desenvolver múltiplas condições crônicas. Essa relação dose-resposta sugeria que o impacto do trauma na saúde não é aleatório, mas sistemático e previsível.

Além de identificar um problema, o estudo ACE possibilitou uma nova compreensão científica das origens da doença crônica. O trauma não criava doença apenas por meio de estratégias de enfrentamento nocivas. Ele mudava algo fundamental na nossa biologia, algo que se desenvolvia de modo subjacente por anos e, muitas vezes, décadas antes de se manifestar como doença. Embora minha crise de saúde parecesse ter surgido do nada, não havia nada de aleatório nela. Era fruto de um processo de três décadas, desde minha primeira infância, exatamente como a doença autoimune de Elena não vinha apenas do acidente de carro no ano anterior, mas de décadas de sobrecarga. Nossas condições crônicas refletem um problema mais profundo: o bloqueio prolongado das nossas capacidades naturais de cura. Muitas doenças crônicas são o resultado de uma biologia do trauma e têm em sua raiz um sistema nervoso desregulado.

Essa nova compreensão transforma a maneira como enxergamos as condições crônicas e o que elas podem nos dizer. O trauma retido pelo corpo cria uma vulnerabilidade a doenças. A dor crônica após minha fratura não estava ali apenas por causa de danos ao tecido, da mesma forma que a depressão e a ansiedade que eu tratava com medicamentos não se limitavam a baixos níveis de serotonina. A doença autoimune de Elena não se devia somente ao seu histórico familiar. A fadiga crônica de Claire não era fruto apenas de uma alimentação inadequada e excesso de exercícios. Essas condições refletiam um corpo preso a traumas não resolvidos.

A seguir, vamos detalhar algumas condições crônicas que emergem do trauma armazenado e entender seus mecanismos. Quero, porém, transmitir a mesma mensagem de esperança que recebi ao compreender essa ciência. Embora possa ser desanimador descobrir uma condição crônica, mais desanimador ainda é ter uma condição crônica e receber a notícia de que nada pode ser feito para impedir sua progressão (foi exatamente isso que o reumatologista me disse sobre a minha condição autoimune). Quando entendemos a ciência por trás do que causa nossas condições crônicas, podemos ter esperança, pois há algo que somos capazes de fazer para melhorar. Muitas pessoas conseguiram reverter suas doenças. Embora um sintoma crônico revele um iceberg mais profundo de trauma acumulado sob a superfície, ele também indica o caminho para a jornada de cura por meio de um processo estruturado, com ferramentas de reparo específicas.

A ESCALA DA CRISE: UM PANORAMA ESTATÍSTICO

O médico canadense Gabor Maté afirma: “A condição de saúde mais prevalente que a medicina enfrentará nas próximas décadas não é uma doença específica, mas o acúmulo de traumas manifestado como doença crônica.”

As estatísticas confirmam essa realidade preocupante: aquilo que antes era considerado raro tornou-se comum. Estamos diante de uma epidemia de doenças crônicas – as mesmas associadas a experiências adversas na infância que a medicina convencional tem dificuldade em explicar ou tratar de modo eficaz. Elas são causadas principalmente por desregulação do

sistema imunológico, do metabolismo e da epigenética. Desde síndrome metabólica e doenças autoimunes até dor crônica, distúrbios digestivos, síndrome do intestino irritável, síndromes pós-infecciosas e fadiga crônica, todas compartilham raízes comuns na biologia do trauma.

Doenças autoimunes, que são um desequilíbrio do sistema imunológico, acometem atualmente 1 em cada 3 adultos, tornando-se mais comuns do que câncer e doenças cardíacas combinados. Mais de 100 dessas condições autoimunes já foram identificadas, com outras ainda sendo descobertas. No mundo, a incidência anual de doenças autoimunes vem crescendo cerca de 19%, com o aumento mais acentuado ocorrendo entre adolescentes. E há ainda milhões de pessoas que têm autoanticorpos no sangue mas ainda não receberam diagnóstico de uma condição autoimune específica.

A síndrome metabólica é outra expressão da biologia do trauma, refletindo desequilíbrios no metabolismo e no sistema imunológico. Pense nela como um conjunto de sinais de alerta que frequentemente aparecem juntos: acúmulo de gordura abdominal, pressão alta, glicose elevada e níveis de colesterol preocupantes. A incidência dessa combinação de sintomas saltou de 25,3% dos adultos nos Estados Unidos em 1994 para cerca de 1 em cada 3 adultos em 2025, subindo para 40% entre pessoas na faixa dos 60 anos. [Os números no Brasil são bem parecidos.] De forma semelhante, a prevalência global de doença hepática esteatótica metabólica (DHEM) atingiu níveis alarmantes: um estudo de 2022 estima que 32,4% dos adultos no mundo têm a condição, um salto expressivo em relação aos 25,5% encontrados em 2005.

A síndrome da fadiga crônica é uma doença difícil de quantificar, pois muitos casos não são diagnosticados e, quando são, isso acontece por exclusão, ou seja: quando todas as outras possíveis causas foram afastadas. Ainda assim, estimativas sugerem que até 2,5 milhões de pessoas sofrem da condição nos Estados Unidos (com quatro vezes mais mulheres afetadas do que homens). [No Brasil não há dados oficiais, mas o número é estimado em mais de 2,6 milhões de pessoas.] Algo em torno de 1 em cada 5 adultos nos Estados Unidos, cerca de 51,6 milhões de pessoas, relata dor crônica. [No Brasil, a prevalência é de 40% da população.] Estudos mostram que indivíduos com histórico de experiências adversas na infância têm mais que o dobro de chances de desenvolver dor crônica. Distúrbios digestivos tornaram-se tão comuns que quase são considerados normais. A síndrome

do intestino irritável sozinha afeta entre 25 e 45 milhões de americanos, principalmente mulheres [e até 17% dos brasileiros]. Estudos mostram que até 50% das pessoas com essa condição relatam trauma na infância ou experiências adversas precoces.

A ascensão das síndromes pós-infecciosas acrescenta outra dimensão inquietante ao panorama da disfunção imune. Estimativas sugerem que até 30% dos sobreviventes de covid-19 desenvolvem sintomas de covid longa, representando milhões de novos casos crônicos. Ainda mais preocupante, doenças relacionadas a mofo afetam cerca de 10 milhões de americanos, ao passo que a doença de Lyme crônica ganha centenas de milhares de novos casos todos os anos.

A raiz comum a esses distúrbios aparece com clareza quando percebemos que a maioria das pessoas que tem uma condição crônica também tem outra. Cerca de 75% dos pacientes com doença autoimune apresentam sintomas de mais de uma condição crônica, sendo o mais comum a fadiga crônica. Já 60% das pessoas com dor crônica também apresentam distúrbios digestivos, e 80% daquelas com fadiga crônica demonstram sinais de desregulação imune – alguns especialistas afirmam que esse número chega a 100%. Se fossem condições isoladas, não haveria uma associação dessa magnitude. Elas coexistem porque compartilham a mesma raiz: uma biologia moldada pelo trauma.

Se você tem uma dessas condições, saiba que isso é a regra, não a exceção. Nesse sentido, estamos todos juntos. A biologia do trauma não se manifesta apenas em pessoas com diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Ela se expressa até em pessoas com vida boa, que nem sequer imaginam ter sofrido trauma algum. É isso que torna a doença um padrão tão poderoso para revelar a verdade que o corpo carrega mesmo quando não temos consciência do trauma que armazenamos nele.

A seguir, veremos como nossas condições crônicas podem espelhar a desregulação criada pelo loop corpo-trauma, que está por trás do surgimento das doenças.

OS MECANISMOS PRIMÁRIOS DA CONEXÃO ENTRE TRAUMA E DOENÇA

Quando nosso sistema nervoso está sempre entrando em apagão, os quatro padrões de trauma causadores de doenças passam a operar em segundo plano. Claire, Elena e Sarah, por exemplo, ficaram presas nessa conexão entre trauma e doença. Suas histórias revelam como os padrões traumáticos criam as condições para o adoecimento por meio de três mecanismos fundamentais: disfunção metabólica, disfunção imunológica e epigenética.

Disfunção metabólica

Vamos começar pelo mecanismo da disfunção metabólica, observando como Claire, antes uma “coelhinha da Duracell”, sucumbiu à fadiga crônica. O metabolismo é um componente essencial da homeostase, e qualquer perturbação na produção e no uso de energia gera impactos significativos em vários sistemas. Quando nosso corpo fica preso no loop, pressionado por hormônios do estresse e estados de mobilização simpática e apagão, ocorre uma mudança crucial nos processos metabólicos que transforma tudo: a resistência à insulina. Você provavelmente conhece a insulina por seu papel no diabetes e na redução dos níveis de açúcar no sangue. Ela é um hormônio produzido pelo pâncreas que se liga a receptores nas células e permite que o açúcar entre nelas para ser convertido em energia.

A resistência à insulina vem se revelando um dos principais causadores de adoecimento. Hoje, sabe-se que ela está envolvida em muitos sintomas que antes não eram considerados metabólicos, como ansiedade e depressão. As células de Claire, ao receberem sinais de perigo de um sistema nervoso desregulado após décadas em que ela exigiu demais de si mesma, foram perdendo progressivamente a capacidade de captar glicose e produzir energia. Fazer dieta não resolveria os quilos que ela ganhava na região da cintura, pois eles eram resultado de um problema metabólico grave, sinal de um trauma armazenado.

Essa disfunção metabólica é agravada pelo comprometimento mitocondrial, a redução na produção de energia *mesmo quando a célula dispõe de tudo que precisa para produzi-la*. Isso pode ocorrer porque as

células estão presas na resposta celular ao perigo e pela presença de toxinas mitocondriais graças a problemas no mecanismo de limpeza, bem como pelo acúmulo de estresse oxidativo, o que compromete a produção de energia. A fadiga de Claire não piorou apenas porque ela não priorizava o descanso e a recuperação. Inicialmente, parecia ser apenas um cansaço relacionado aos exercícios, pois ela já não conseguia manter o mesmo nível de atividade física sem se sentir acabada. Porém, mesmo depois de reduzir a carga de exercícios, a fadiga só aumentou. O treino forte não era a causa da sua fadiga, mas sim o fato de que suas células já não conseguiam produzir tanta energia quanto antes.

Disfunção imunológica

O segundo mecanismo básico pelo qual o trauma gera doenças está intimamente relacionado à disfunção metabólica: a disfunção imunológica. Os sistemas nervoso e imunológico estão em comunicação contínua. Assim, a desregulação do sistema nervoso cria um estado pró-inflamatório, estabelecendo as condições para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Um tipo específico de célula imunológica especializada assume o controle quando o corpo permanece em estado de perigo: os mastócitos, presentes em praticamente todos os tecidos, que funcionam como os “socorristas” do nosso corpo. Com mais de 200 tipos de receptores e usando as lentes tingidas pelo perigo da neurocepção, eles passam a reagir exageradamente a *tudo*: emoções, alimentos e estímulos ambientais. Diante do menor gatilho, liberam histamina, um mediador inflamatório e neurotransmissor que provoca inflamação e ansiedade. Mastócitos hiperativos favorecem o surgimento de sensibilidades a produtos químicos e síndromes pós-infecciosas.

Uma proteína chamada galectina-3 também atua na disfunção imunológica durante um estado de perigo. Em condições normais, ela ajuda na reparação tecidual. Porém, na fisiologia do trauma crônico, deixa de ter função protetora para assumir um papel destruidor, promovendo inflamação e alterações nos tecidos que perpetuam o estado de doença ao redor das células.

Epigenética

O terceiro mecanismo pelo qual o trauma se transforma em doença é a epigenética, isto é, alterações nas formas como nossos genes se expressam. Esse processo é em grande parte impulsionado pelo estresse oxidativo não eliminado quando nossa neurocepção nos mantém em estado de perigo.

Os sintomas cada vez piores de Sarah ao longo dos anos não eram apenas resultado do acúmulo de estresse – seu DNA vinha sendo danificado de maneiras que seu corpo não conseguia reparar, já que estava preso no modo de sobrevivência. A epigenética é um fator determinante para certas condições como TEPT, câncer e envelhecimento precoce.

O estresse oxidativo está envolvido nesses três mecanismos causadores de doenças. Quando o sistema nervoso permanece em modo de perigo, as células produzem mais estresse oxidativo do que conseguem limpar. Essa “ferrugem” danifica as mitocôndrias, agravando a disfunção metabólica. Ela também sustenta processos inflamatórios, amplificando a desregulação imunológica, além de danificar o DNA, causando alterações epigenéticas que podem deflagrar doenças e até ser transmitidas como trauma geracional.

Cada mecanismo alimenta e amplifica os outros, criando um ciclo autossustentável de adoecimento. Isso explica por que doenças crônicas raramente aparecem isoladas. A fadiga de Claire veio acompanhada de distúrbios digestivos. A doença autoimune de Elena, de dor e névoa mental. Os sintomas de Sarah passaram a afetar vários sistemas. Não eram problemas distintos que deviam ser tratados por diferentes especialistas: eram resultado de processos de adoecimento gerados pela desregulação do sistema nervoso.

Embora, naturalmente, outros processos biológicos também participem da formação das doenças, os quatro padrões do trauma, especialmente a desregulação, desencadeiam esses três principais mecanismos. E toda condição crônica apresenta pelo menos um deles como parte do processo de adoecimento.

O maior preditor de doenças não é o peso, o estilo de vida nem sequer a genética: é quanto de carga traumática o corpo carrega. Vamos examinar como esses mecanismos se manifestam em doenças específicas, lembrando que cada uma delas reflete essas mesmas forças subjacentes de

maneiras diferentes.

DOENÇAS DA DESREGULAÇÃO

A desregulação pode levar a problemas de saúde e se expressar como doença de várias maneiras. As condições específicas que cada pessoa desenvolve surgem da combinação de muitos fatores, mas sempre aparecem onde há maior vulnerabilidade. Por exemplo, quando nosso estilo de vida ou ambiente nos expõe a toxinas, isso abre espaço para certas doenças; mas essas doenças se manifestariam de forma diferente se houvesse predisposição genética para desenvolvê-las. É importante compreender que não são as vulnerabilidades que causam a doença: é a desregulação que transforma em problema crônico o que poderia ser apenas uma fraqueza. Vamos observar algumas das principais condições.

Autoimunidade: um espelho do medo na primeira infância

Doenças autoimunes não dizem respeito apenas a inflamação ou um sistema imunológico hiperativo. A autoimunidade ocorre quando o sistema imunológico perde a capacidade de reconhecer o que deve atacar. Em vez de proteger seu corpo contra invasores externos, ele passa a atacar seus próprios tecidos como se fossem inimigos.

Algumas doenças autoimunes afetam órgãos específicos, como a tireoide na tireoidite de Hashimoto ou as articulações na artrite reumatoide. Outras atacam praticamente todas as células, impactando vários sistemas do organismo, como o lúpus. O diagnóstico de lúpus de Elena após o acidente de carro ilustra bem como esse processo evolui ao longo de décadas e finalmente irrompe diante de um gatilho. Doenças autoimunes não surgem da noite para o dia; o acidente não causou sua doença: foi apenas a gota d'água. Durante décadas, a desregulação imunológica vinha se acumulando em uma fisiologia cronicamente traumatizada. A fadiga e a névoa mental que ela sentia havia anos não eram meros sinais da idade, mas indicadores de uma disfunção metabólica e imunológica que crescia sob a superfície.

O processo frequentemente ignorado que vai se desenvolvendo antes do

diagnóstico é chamado de autoimunidade preditiva. Ele pode ser confundido com outros sintomas ou descartado por profissionais da área da saúde como algo irrelevante. Isso também costuma ocorrer com a neuroautoimunidade, quando anticorpos atacam diferentes partes do sistema nervoso. Um exemplo é a esclerose múltipla, em que o alvo é a mielina, a camada de gordura que envolve os axônios. Existem muitos outros processos de autoimunidade neurológica ainda não reconhecidos, como quando anticorpos atacam regiões do cérebro, entre elas o cerebelo e a amígdala (áreas que regulam nossas reações emocionais e influenciam diretamente a neurocepção). Nossas variações de humor e nossas reações emocionais não se devem apenas a inflamação cerebral, mas também a condições autoimunes em centros emocionais do cérebro.

Síndrome metabólica e DHEM: para além da alimentação e do estilo de vida

A síndrome metabólica e a doença hepática esteatótica metabólica (DHEM) são distúrbios metabólicos muitas vezes mal compreendidos como simples consequências do tipo de alimentação e estilo de vida. A realidade é mais complexa e bem mais grave.

A síndrome metabólica é um estado pró-inflamatório que engloba todo o organismo, afetando vários sistemas e levando a várias doenças. Ela é diagnosticada quando estão presentes três ou mais dos seguintes desequilíbrios metabólicos: pressão arterial elevada, níveis altos de açúcar no sangue, excesso de gordura abdominal (visceral), baixos níveis do colesterol “bom” (HDL) e triglicerídeos elevados. Mesmo antes de cumprir os critérios diagnósticos de síndrome metabólica, a pessoa pode apresentar sintomas gerais como insônia, refluxo, ganho de peso e fadiga. Embora essas condições possam progredir, ao longo do tempo, para doenças como diabetes, hipertensão e obesidade, elas já são sinais claros de uma desregulação causadora de um caos metabólico que precisa ser identificado de forma precoce.

Infelizmente, esse não é o diagnóstico que em geral recebemos dos profissionais da área da saúde, que tendem a repetir o que ainda lhes é ensinado. Se o quadro é obesidade, o paciente será orientado a se exercitar

mais e comer menos. No entanto, a obesidade é o resultado, não a raiz do problema da síndrome metabólica. Um sistema nervoso desregulado está causando desequilíbrios metabólicos, imunológicos e epigenéticos, gerando resistência à insulina, gordura abdominal fortemente pró-inflamatória e comprometimento mitocondrial.

A doença hepática esteatótica metabólica é outro diagnóstico de desregulação metabólica e imunológica. A DHEM é o acúmulo anormal de gordura no fígado e, atualmente, a causa mais comum de doença hepática crônica, além de ser a segunda maior indicação para transplante de fígado. Esse aumento rápido da doença coincidiu com o crescimento alarmante do número de casos de obesidade e diabetes tipo 2, doenças também impulsionadas pela desregulação metabólica e imunológica e do sistema nervoso.

A progressão da DHEM para lesão, fibrose e falência do fígado se dá por meio de uma interação complexa de fatores gerados pela desregulação, incluindo estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, resistência à insulina e inflamação crônica de baixo grau. O fígado, normalmente hábil em processar e armazenar gorduras, fica sobrecarregado. Alex, que congelou ao ouvir a notícia da reestruturação na sala de reuniões, descobriria que tinha DHEM depois de começar a trabalhar comigo. Ele sabia que estava um pouco acima do peso, mas não fazia ideia de que sua saúde física estava expressando seu passado, do mesmo jeito que sua reação imediata à insegurança financeira. Laura, com sua resposta de sobressalto exacerbada, também descobriria ser portadora de DHEM quando fizemos exames para avaliar sua biologia do trauma. Ela ficou muito surpresa, pois era muito magra e achava que aquela era uma doença exclusiva de pessoas com sobrepeso.

Dor crônica: quando a proteção se torna prisão

A dor crônica tem menos a ver com tecido danificado e mais com um sistema nervoso descalibrado que criou desregulação metabólica e imunológica nos circuitos neurais. Um ano após minha fratura na clavícula, eu já não tinha lesão tecidual, mas ainda assim sentia dor. Dana também não tinha dano tecidual pélvico, mas sentia dor crônica.

A dor crônica é um desequilíbrio metabólico e imunológico impulsionado por um sistema nervoso se alternando entre o estresse e a sobrecarga. Estudos mostram que as emoções influenciam a percepção da dor. A dor crônica de Dana costumava piorar em períodos de estresse emocional. Sarah, em seu trabalho na UTI, tinha crises de dor lombar intensa uma ou duas vezes por ano, e sempre supôs que a causa fosse o fato de não seguir corretamente o protocolo de movimentação de pacientes. Ao explorar esse padrão de doença comigo, ela percebeu que havia muitas situações em que movia pacientes da mesma forma e não sentia dor. Já Dana concluiu que o verdadeiro gatilho de sua dor pélvica crônica era uma sensação inconsciente de impotência, relacionada à mesma impotência que sentira no vestiário na experiência com o técnico esportivo.

A crença habitual de que basta encontrar e corrigir a causa estrutural da dor ignora o fato de que a fisiologia do trauma cria dor crônica por meio de vários mecanismos. Microinflamação, tensão muscular e até comprometimento mitocondrial contribuem para a dor persistente, impulsionados por um sistema nervoso emperrado no modo de proteção.

Fadiga crônica: quando a pilha acaba

Fadiga crônica não é simplesmente estar cansado ou precisar de mais repouso; trata-se de uma ruptura fundamental na forma como o corpo produz e gerencia energia. A progressão de Claire, que passou de “coelhinha da Duracell” a não conseguir executar tarefas básicas do dia a dia, mostra como essa condição é causada pela desregulação de diversos sistemas.

No cerne da fadiga crônica está a disfunção mitocondrial mantida pela fisiologia do trauma. Essa disfunção vem acompanhada de outros sintomas, como névoa mental, apatia, depressão, sono não reparador e mal-estar pós-esforço, termo correto para quando até atividades leves desencadeiam colapsos de energia devastadores que podem durar dias.

O que torna a fadiga crônica particularmente desafiadora é o ciclo vicioso que se instala. Quanto menos energia disponível, mais o corpo percebe perigo, levando a um apagão protetor, o que compromete ainda mais a produção de energia. Isso explica por que apenas o gerenciamento do estresse ou suplementos energéticos muitas vezes não produzem melhora

duradoura.

SII e problemas digestivos: o segundo cérebro em modo de sobrevivência

Problemas digestivos como a síndrome do intestino irritável (SII) não se resumem a um “intestino delicado”. Eles refletem um sistema nervoso reativo que torna o intestino mais sensível a emoções, alimentos e infecções. Nosso sistema nervoso entérico, frequentemente chamado de segundo cérebro, contém mais neurônios que a medula espinhal e opera seus próprios reflexos e processamento sensorial.

Tanto o estresse quanto a fisiologia do trauma alteram profundamente a função intestinal. No entanto, o alternar frequente entre a mobilização simpática e o apagão vagal dorsal, no ciclo de estresse-sobrecarga, é o que provoca o maior dano e parece ser o principal causador dos sintomas da SII. Mais importante ainda, a fisiologia do trauma crônico afeta a barreira intestinal, levando ao aumento da permeabilidade, o que é conhecido como síndrome do intestino permeável. Isso contribui de forma considerável para o estado pró-inflamatório que colabora para o desenvolvimento de resistência à insulina, a inflamação cerebral e a autoimunidade.

O mito de que basta identificar alimentos-gatilho ou controlar o estresse não leva em conta quão profundamente a fisiologia do trauma afeta nossa função digestiva. Um sistema nervoso desregulado cria um ambiente intestinal que favorece a presença de parasitas, o supercrescimento bacteriano e o desequilíbrio da microbiota. Também prejudica a digestão e a absorção de nutrientes, contribuindo para o esgotamento energético. Por fim, alimenta reações emocionais, já que o intestino é um grande centro de produção de neurotransmissores, como a serotonina, nossa molécula do bem-estar. O intestino, por sua conexão íntima com o sistema nervoso, absorve tudo.

Saúde mental: a conexão entre corpo e mente

Embora a ansiedade e a depressão sejam frequentemente vistas como condições puramente psicológicas, elas refletem os mesmos mecanismos

subjacentes que causam as doenças físicas. Estudos têm demonstrado que transtornos de humor (incluindo o TEPT) muitas vezes são transtornos metabólicos impulsionados por inflamação, comprometimento mitocondrial e alterações epigenéticas. Isso explica por que sintomas de saúde mental muitas vezes surgem acompanhados de problemas físicos e por que tratá-los como se fossem males separados costuma fracassar. Todas as pessoas cujas histórias compartilhei neste livro enfrentaram sintomas de ansiedade e depressão. Esses sintomas fazem parte do pacote de como o trauma armazenado inevitavelmente gera doenças no corpo.

RECONHECIMENTO E VALIDAÇÃO: AS MENSAGENS DO CORPO

Se você se reconheceu nesses padrões ao refletir sobre o próprio histórico de saúde, é provável que esteja sentindo uma mistura de emoções: talvez alívio por enfim compreender essas conexões ou frustração por ter passado tanto tempo sem saber disso tudo. Independentemente da sua etapa atual no processo de adoecimento, se já recebeu um diagnóstico formal ou apenas tem sintomas persistentes, seu corpo está comunicando uma mensagem por meio da desregulação: ele tem um trauma armazenado.

Muitas pessoas provavelmente já passaram pelo que chamo de “trauma médico”, ou seja, serem desacreditadas por profissionais da área da saúde, ouvirem que “é tudo coisa da sua cabeça” ou receberem a prescrição de medicamentos que apenas aliviam sintomas, sem tratar a causa. Podem ter até parado de procurar respostas, resignando-se a aceitar seus sintomas como o novo normal. A validação, no entanto, não vem ao receber um diagnóstico, mas ao finalmente entender o *porquê*.

Essa compreensão muda a forma como abordamos a cura, especialmente se você está trabalhando com um terapeuta do trauma enquanto lida com condições de saúde crônicas. Sua jornada de cura precisa ser diferente da de alguém que não tem manifestações físicas. Ao fazer um trabalho emocional e psicológico do trauma, você pode perceber pioras nos sintomas físicos. A terapia verbal tradicional, sozinha, talvez não seja suficiente. Seu corpo precisa de abordagens que tratem tanto os padrões psicológicos quanto os fisiológicos que se desenvolveram.

Pode ser desconcertante perceber a profundidade do efeito do trauma em nós, que vai até o nível celular e causa doenças que só vão se manifestar décadas depois. Isso nos leva a uma pergunta crucial: o que torna algumas pessoas mais suscetíveis ao trauma? Existe algo que possamos fazer para impedir esse processo? No próximo capítulo, vamos explorar como nosso filtro preexistente dita nossa vulnerabilidade ao trauma e qual é o fator-chave em nossa jornada de cura e reparo.

RESUMO

Ao explorar o quinto padrão do trauma armazenado, a doença, descobrimos que adoecer não é aleatório: é o desfecho previsível, e praticamente inevitável, de uma desregulação crônica. A pesquisa sobre experiências adversas na infância nos ajudou a entender que existe uma conexão entre trauma e doença, e a ciência nos revela o porquê. Os mecanismos específicos dessa conexão incluem disfunção metabólica, desequilíbrio imunológico e alterações epigenéticas. O aumento alarmante do número de casos de doenças crônicas mostra até que ponto o trauma armazenado se disseminou na nossa sociedade. Está claro que não recebemos as ferramentas necessárias para lidar com o impacto do trauma no corpo. Individualmente e como sociedade, precisamos de soluções melhores.

A doença é o resultado previsível de respostas de trauma incompletas que ficaram armazenadas e nos mantiveram em uma biologia do medo, em vez de nos permitir retornar a uma fisiologia da segurança. Agora que esse processo está evidente, os mesmos mecanismos que criam o problema podem se tornar cruciais para a solução.

E se a solução for compreender nosso filtro preexistente, um filtro interno formado por padrões biológicos, somáticos e do sistema nervoso que predizem se os desafios da vida apenas nos dobrarão temporariamente ou se nos quebrarão? Entender essa matriz interna não apenas explica nossas respostas atuais ao trauma, como também revela nossos maiores trunfos para mudarmos e construirmos um futuro melhor.

CAPÍTULO 11

Vulnerabilidade ao trauma: infância e filtros preexistentes

O que importa não é o que lhe acontece, mas como você reage a isso.

– Epicteto, filósofo grego

Elena estava sentada no consultório do reumatologista, olhando para os resultados de exames que confirmavam o diagnóstico de doença autoimune. Embora já desconfiasse de que havia algo errado, a notícia a atingiu como um soco no estômago. Seu coração disparou enquanto ela congelava com o papel nas mãos. Não ouviu uma só palavra do que o médico dizia enquanto ele apontava para o número na folha de papel. Apesar de normalmente ter um foco aguçado e uma postura profissional impecável de executiva bem-sucedida, ela não conseguia processar o que o médico falava.

A história de Elena tinha começado muito antes daquele momento no consultório médico. Seu parto difícil resultou em sofrimento fetal, e ela precisou de reanimação. Passou suas primeiras 24 horas na UTI neonatal, separada da mãe. Essas horas iniciais, tão críticas, não foram vividas no aconchego do contato pele com pele, mas sob luzes fortes, enfrentando procedimentos dolorosos sem qualquer correção que ajudasse seu sistema nervoso a se recuperar. Esse padrão inicial de desregulação sem reparo estabeleceria as bases para suas futuras respostas aos desafios da vida.

A infância trouxe outras experiências que moldariam as matrizes do seu sistema nervoso. A mãe, sobrecarregada por longas jornadas de trabalho para criá-la sozinha, muitas vezes não percebia os apelos sutis de Elena por conexão e regulação. A presença do namorado às vezes violento da mãe

fazia com que o sistema nervoso em desenvolvimento de Elena precisasse ficar em alerta constante. Ela aprendeu cedo que ter necessidades a tornava vulnerável e que conquistar o sucesso era o único caminho seguro para ter valor.

Agora, aos 45 anos, Elena havia construído o que parecia ser uma vida bem-sucedida. Como diretora de operações da sua empresa, tinha criado a segurança externa que nunca tivera na infância. No entanto, apesar das conquistas profissionais, enfrentava dificuldades para manter relacionamentos íntimos. Divorciada havia cinco anos e criando duas filhas sozinha, estava cansada de repetir padrões que a faziam se sentir vazia e desconectada. As palavras finais do ex-marido ainda ecoavam em sua mente: “Você é sensível demais, intensa demais. Eu nunca soube dar o que você precisava.”

Enquanto outras pessoas talvez absorvessem o diagnóstico como uma notícia estressante, porém administrável, o corpo de Elena cruzou imediatamente o limite crítico da sobrecarga. Seu sistema nervoso, vendo o mundo por meio das lentes tingidas pelo perigo, percebeu essa ameaça à saúde como um risco grave e inescapável. Em questão de segundos, ela passou pelas etapas da resposta ao trauma até o estado de apagão.

Por que ela se sentiu não só estressada, mas sobrecarregada por essa notícia? A resposta não estava no diagnóstico em si, nem sequer na forma como o médico o comunicou (embora nenhum dos dois tenha ajudado). Estava em algo presente, porém invisível: um filtro através do qual todas as experiências eram interpretadas. A atuação do estado preexistente como filtro é um conceito central da teoria polivagal e da nossa vulnerabilidade ou resiliência a novas experiências. Elena precisava entender seu filtro interno, seus componentes e como ele, além de prever sua resposta de apagão naquela consulta, poderia também apontar seu caminho de volta à saúde.

FILTRO PREEXISTENTE: O SELETOR DAS NOSSAS RESPOSTAS

Na minha formação em medicina, entender as condições preexistentes de um paciente é crucial para prever prognósticos. Duas pessoas podem ter a mesma apendicite e encarar consequências drasticamente diferentes

dependendo da biologia prévia de cada uma. Aquelas com sistema imunológico comprometido ou doenças crônicas demoram mais para se recuperar da cirurgia. Um indivíduo com diabetes ou doença cardíaca tem respostas mais graves a infecções. Não é a cirurgia ou o vírus em si, mas as condições preexistentes que definem a resposta do corpo.

O mesmo princípio se aplica à previsão de nossas respostas às experiências da vida. É o nosso filtro preexistente que influencia se algo será um estressor que apenas nos dobrará temporariamente ou um trauma que nos quebrará.

Os quatro principais componentes do nosso filtro preexistente

Quatro componentes principais se integram para formar o filtro através do qual experimentamos a vida e a partir do qual nossas respostas automáticas são geradas.

O primeiro componente é o **estado atual do nosso sistema nervoso**; ou seja, se já estamos em estresse, em apagação ou, mais raramente, no estado calmo-ativo. O segundo é a nossa **biologia** e o sinal cumulativo de segurança ou perigo que ela envia à nossa neurocepção. O terceiro componente é formado por nossas **crenças programadas**, as redes neurais fortalecidas por décadas de repetição. O quarto componente é a **memória somática** das sensações e dos movimentos que o corpo registra como seguros ou perigosos.

Esses quatro componentes se combinaram para formar o filtro preexistente de Elena, que previu sua resposta ao trauma naquele dia no consultório médico. Muito antes de atravessar a porta da clínica, ela já vivia em um estado crônico de esgotamento. Como mãe divorciada e única responsável pelas filhas, estava constantemente no limite da sobrecarga. A sensação onipresente de responsabilidade já havia fragilizado seu sistema nervoso naquela manhã. Por trás disso tudo, estava uma biologia de trauma enviando sinais de perigo à sua neurocepção por conta da inflamação decorrente da doença autoimune que seria diagnosticada naquele dia. Suas crenças programadas de que precisava aguentar tudo sozinha e não teria ninguém para ajudá-la faziam parte desse filtro preexistente. Era previsível que Elena cruzasse o limite crítico da sobrecarga ao receber o diagnóstico.

Podemos resumir esses quatro componentes nos seguintes elementos: mente (crenças), corpo (somático), biologia e neurocepção. Psicologia, memória somática, biologia e o estado do sistema nervoso se unem para formar o filtro preexistente; ou seja, **aquilo que determina tanto a percepção da nossa capacidade para responder a um perigo quanto a percepção da gravidade dele.**

APEGO: A MATRIZ PARA SAÚDE, RELACIONAMENTOS E RESPOSTAS

O que é apego? É a forma como vemos a nós mesmos, aos outros e ao mundo. Podemos ter um apego seguro, ou seja, uma visão de que o mundo é, em geral, seguro e bom, ou um apego inseguro, que vê o mundo como, em geral, perigoso e difícil. Isso não é uma versão da psicologia positiva, em que escolhemos como ver o mundo, mas sim uma “verdade” arraigada que nosso sistema nervoso registra internamente antes mesmo de aprendermos a falar. Pense no apego como o esquema que determina os quatro componentes do nosso filtro preexistente. Nossa configuração de apego cria a matriz da nossa neurocepção, da nossa biologia, das nossas crenças e das nossas memórias somáticas.

Essa matriz é formada por necessidades específicas de desenvolvimento que precisam ser atendidas nos primeiros meses e anos de vida. Quando essas necessidades universais não são suficientemente atendidas, criam o que chamo de “feridas de apego”: padrões que persistem tanto nas nossas respostas emocionais quanto na nossa saúde física ao longo da vida.

Feridas de apego

O desenvolvimento inicial do nosso sistema nervoso depende de certas necessidades serem atendidas em uma sequência previsível.

Nossa necessidade mais básica é sermos segurados no colo e acolhidos. Nas horas, dias e semanas iniciais de vida, ser acalentado não é apenas uma questão de conforto; é como sobrevivemos. Quando não somos acalentados o suficiente para nos sentirmos totalmente seguros para descansar, surge

nossa primeira ferida de apego: “Me acolha.” O choro de um bebê é a primeira forma de comunicação que ele possui para expressar suas necessidades e entender que elas importam. Quando ninguém vem ou quando a resposta se torna imprevisível, surge a segunda ferida de apego: “Me escute.”

Nossa necessidade de movimento vem em seguida, se manifestando desde o tempo que passamos de braços sob supervisão até o engatinhar e caminhar. Assim, desenvolvemos não apenas habilidades físicas, mas também nosso senso de autonomia e autorregulação. Quando não temos o apoio necessário para nos movimentar como precisamos, surge a terceira ferida: “Me apoie.” À medida que desenvolvemos ainda mais nossa autonomia, descobrindo que somos um ser humano “separado”, e precisamos ser verdadeiramente vistos. Essa necessidade é atendida por meio de contato visual, tempo e sintonia; e é também assim que internalizamos que somos dignos de existir. Se essa necessidade não é suficientemente acolhida, cria-se a quarta ferida de apego: “Me veja.”

Quando nossa necessidade de nos sentirmos amados simplesmente por existirmos, e não pelo que fazemos ou conquistamos, não é atendida, surge a ferida “Me ame”. A última ferida de apego no nosso desenvolvimento inicial é “Me compreenda”, quando não sentimos que nos encaixamos, que pertencemos a um grupo ou que somos compreendidos.

Quando olhamos para o filtro preexistente de Elena pelas lentes do apego, percebemos que suas respostas foram muito além dos desafios atuais como mãe solo ou do estado pró-inflamatório em que se encontrava. A ferida de apego primária “Me acolha” atravessava todos os níveis do seu ser: mente, corpo e biologia. Embora as avaliações deixassem evidente que essa era sua ferida de apego principal, a origem só podia ser inferida. Para Elena, saber que nasceu com a síndrome do bebê azul e por isso precisou ir para a UTI neonatal, onde não recebeu colo, foi uma revelação profunda. Isso a ajudou a entender como o seu primeiro dia de vida ainda podia influenciar suas respostas hoje por meio do impacto duradouro sobre seu filtro preexistente.

Para compreender a importância das feridas de apego no nosso filtro, precisamos explorar os três pilares que formam nossa configuração de apego: sintonização, neurodesenvolvimento e biologia. Cada um deles tem um papel vital na criação da nossa matriz interna, tornando alguns de nós

mais vulneráveis do que outros à sobrecarga mesmo diante de desafios idênticos.

OS TRÊS PILARES DO APEGO

Existem três pilares para a formação do apego e, assim como em um banquinho de três pernas, uma fraqueza em qualquer um deles compromete a estabilidade de todo o sistema. Sintonização, neurodesenvolvimento e biologia compõem juntos nossa experiência interna de segurança ou perigo nos primeiros meses e anos de vida. São eles que estabelecem o grau de regulação com que saímos da infância, minha definição prática de “apego”.

Sintonização: a dança da correção

O apego não é uma questão apenas de vínculos emocionais; é uma questão de sobrevivência. Nascemos antes que nosso sistema nervoso esteja plenamente desenvolvido, por isso dependemos do sistema nervoso mais maduro da nossa mãe. O que vem “de fábrica” está desenvolvido o suficiente para nos manter vivos, dando conta da respiração, dos batimentos cardíacos e de outras funções fisiológicas, mas nem mesmo esses estão totalmente regulados. Nossa fisiologia é calibrada por meio do vínculo de apego. Isso explica por que a separação dos cuidadores nos primeiros dias de vida não é apenas um estresse emocional. Para um bebê que precisa de ajuda para regular a respiração e os batimentos cardíacos, é uma ameaça à sobrevivência.

O sistema nervoso dos bebês regula sua fisiologia por meio da correção. Isso se dá por meio de milhares de interações diárias, como a forma como são acalentados, o tom de voz que ouvem e o contato visual. Quando a mãe está cronicamente estressada, distraída ou lutando com a própria desregulação, o sistema nervoso do bebê recebe essa informação.

A ciência mostra o efeito profundo da sintonização para a correção. Com 2 meses de vida, bebês de mães com depressão pós-parto já apresentam diferenças mensuráveis no comportamento: são mais irritadiços e menos ativos fisicamente. Aos 3 meses, seus padrões cerebrais já se

assemelham aos de adultos com depressão. Com 1 ano, surgem lacunas nítidas em marcos de desenvolvimento; aos 3 anos, há diferenças perceptíveis no desenvolvimento cognitivo e na linguagem.

A sintonização perfeita, no entanto, também não é saudável para o sistema nervoso do bebê. São as rupturas esporádicas seguidas de reparo que ajudam a construir a flexibilidade e a regulação de um sistema em desenvolvimento. Todo cuidador faz o melhor que pode com o que tem. Nenhuma mãe escolhe compartilhar sua desregulação com seu bebê, da mesma forma que ninguém escolhe ter depressão ou ansiedade pós-parto. Mas acontece. Saber se isso foi parte da nossa história nos mostra o que precisa de reparo em nós.

Quando começou a trabalhar sua programação de apego comigo, Claire descobriu que a mãe havia tido depressão pós-parto. Ao explorarmos o filtro preexistente da mãe, que tornava a depressão pós-parto previsível, Claire enfim sentiu compaixão pela mãe, compartilhando com ela o que estava aprendendo sobre biologia. Isso acabou por ajudar sua mãe a identificar um excesso de cobre no organismo, presente em mais de 95% das mães com depressão pós-parto. Claire entendeu que, como bebê, ela provavelmente olhou para um rosto materno inexpressivo e de olhos vazios, o que a levou a registrar memórias somáticas da conexão como algo perigoso, pois “não tinha ninguém ali”.

No caso de Elena, sua matriz de apego na infância foi moldada por uma regulação inconsistente. A sobrecarga da mãe impedia-a de perceber os apelos sutis de Elena por conexão. Cada vez que a mãe estava assoberbada demais para notá-la, o sistema nervoso de Elena tinha que recorrer à única opção que um sistema infantil tem: passar para uma resposta ao trauma e ao apagão. Quando o namorado da mãe entrou em cena, a matriz de Elena já estava formada, levando-a a se fechar em vez de buscar a conexão materna.

Sarah teve a experiência oposta na infância: em vez de ausência emocional, sua mãe era carente demais e exigia conexão constante. Isso também é falta de sintonização, pois os bebês precisam alternar entre fazer contato visual para se conectarem e poder afastar o olhar para evitarem uma hiperestimulação. Como a mãe buscava conexão o tempo todo, Sarah criou vias neurais que associavam conexão a hiperestimulação e sobrecarga. Não surpreende que ela tenha desenvolvido o hábito inconsciente de se manter ocupada, sem se permitir sentir vontade de se conectar com as pessoas.

A sintonização também explica por que tanto o “bebê bonzinho” quanto o bebê com cólicas frequentes são motivo de preocupação. Elena ficou surpresa ao saber que quase não chorava e dormia a noite inteira após a primeira semana de vida. Um bebê que não chora pode já estar em estado de sobrecarga, tendo aprendido que é inútil expressar suas necessidades. Bebês expressam suas necessidades por instinto, confiando implicitamente que elas serão atendidas. Por outro lado, o bebê com cólicas que chora demais age assim por alguma razão; mas, até que a causa seja encontrada, ele exige tanta correção que poucos pais conseguem oferecê-la de modo sustentável. A ideia aqui não é atribuir culpas, mas mostrar que isso pode criar experiências internas recorrentes que formam uma matriz de apego inseguro.

Neurodesenvolvimento: os alicerces da regulação

O neurodesenvolvimento é a evolução dos movimentos, da fala e da função cognitiva ao longo da infância. É muito mais que marcos registrados na tabela do pediatra. Os padrões neurológicos de desenvolvimento, incluindo engatinhar e andar, são tão importantes para a regulação quanto a sintonização emocional com a mãe.

Nosso cérebro se desenvolve dos sistemas mais simples para os mais complexos, começando pelo tronco encefálico, e cada estágio exige tipos específicos de movimentos e experiências para se organizar adequadamente. Quando o desenvolvimento inicial é interrompido ou apressado, isso cria lacunas que afetam a capacidade de se regular e se conectar ao longo da vida.

A história do parto de Elena nos dá uma ideia de quão cedo esses padrões se iniciam. Seus primeiros minutos de vida foram marcados pelo pânico da sobrevivência, e não pela conexão regulada. Embora a intervenção médica tenha lhe salvado a vida, o tempo na UTI neonatal, com suas luzes fortes e toques dolorosos, criou o que chamamos de ativação global de alta intensidade, um padrão de sensibilidade e reatividade extremas do sistema nervoso que teria forte influência sobre o filtro preexistente dela.

A ativação global de alta intensidade se desenvolve quando o bebê, nos

primeiros meses de vida, passa por níveis elevados de medo que exigem que seu corpo recorra ao apagão. Seja por trauma de parto, procedimentos médicos ou regulação inconsistente, esse padrão cria um sistema nervoso que oscila rapidamente entre as respostas de sobrecarga e de luta ou fuga. Na vida adulta, isso se manifesta como reações extremadas em situações de estresse, oscilação rápida entre a sobrecarga e respostas de luta ou fuga, e uma janela de tolerância estreita para qualquer tipo de emoção, mesmo as positivas. Isso explica por que Elena passava de executiva competente ao apagão total com tamanha velocidade: seu sistema nervoso tinha um esquema de agravamento rápido para o pânico e o apagão.

O primeiro nível do neurodesenvolvimento acontece no tronco encefálico, na região da ponte. Engatinhar e outros movimentos de bruços no chão durante os primeiros 6 meses desenvolvem nossa capacidade de reconhecer sensações básicas de sobrevivência, como calor, frio, dor, fome e sede. A primeira infância de Claire nos ajuda a entender por que seu neurodesenvolvimento definiu uma matriz de desconexão e de forçar seu corpo ao limite. Durante os primeiros 6 meses, ela teve infecções de ouvido recorrentes que exigiram vários procedimentos médicos, reduzindo seu tempo de atividade no chão, com a barriga para baixo. Como não sentia muito bem o corpo, não percebia quando tinha fome e precisava comer ou quando estava cansada e precisava descansar. Algumas pessoas manifestam essas lacunas por meio de comportamentos de risco; outras, ignorando lesões e seguindo com suas atividades apesar delas; e outras por meio de agressividade física ou transtornos alimentares. Não são decisões conscientes, mas reflexos de como o sistema nervoso se organizou em torno de lacunas de desenvolvimento nas primeiras fases da infância.

Formamos nossa capacidade de interação social por meio do reconhecimento facial e da leitura de emoções. Isso ocorre dos 6 aos 12 meses, com o engatinhar apoiado nas mãos e nos joelhos. Claire, estimulada a andar cedo por pais bem-intencionados, perdeu aspectos importantes dessa fase. Aqueles que saltam a fase do engatinhar, ou passam por ela de forma acelerada, geralmente apresentam padrões semelhantes na vida adulta: dificuldade em compreensão leitora, em interpretar expressões faciais e em entender os próprios estados emocionais.

Assim como a sintonização possibilitada pela correção favorece um apego seguro, o neurodesenvolvimento saudável também fortalece a

regulação e o apego seguro. Quando vivenciamos rupturas sem reparo nesses dois pilares, esses padrões começam a formar uma matriz de apego inseguro.

Um último fator influencia nossa matriz de regulação desde a primeira infância: o pilar biológico, que completa a tríade determinante do nosso tipo de apego.

Biologia: a influência oculta sobre o apego

Embora o apego seja frequentemente discutido sob a ótica dos relacionamentos, forças biológicas poderosas estão em ação desde o nosso primeiro sopro de vida. Nossa bioquímica é projetada para promover vínculo e conexão. Assim como o coração do recém-nascido sabe bater e seus pulmões sabem respirar, sua biologia é talhada para o apego. Mas essa mesma biologia também pode criar vulnerabilidades que afetam nossa capacidade de conexão e regulação. Ela pode nos tornar menos capazes de receber amor e sintonização, mesmo quando ambos estão presentes. Pode também tornar nosso sistema nervoso mais sensível ou “carente”, de modo que o nível de correção de que precisamos para nos sentirmos seguros ultrapassa o que os pais conseguem oferecer.

A neuroquímica do vínculo

Três neuroquímicos centrais coordenam a dança do apego: ocitocina, dopamina e serotonina. A ocitocina, muitas vezes chamada de “hormônio do vínculo”, faz muito mais do que criar uma sensação calorosa. Ela ajuda o cérebro em desenvolvimento do bebê a formar vias neurais específicas que dizem: “Esta é minha pessoa de confiança.” A dopamina, nosso neurotransmissor da recompensa, cria a sensação de que essa conexão é algo prazeroso e que vale a pena buscar. Quando as necessidades de um bebê são atendidas por meio de um cuidado sintonizado, o cérebro dele é inundado de dopamina, programando seu sistema nervoso para associar conexão com prazer. Isso ajuda a gerar uma espécie de “dependência” saudável da figura cuidadora principal, de forma que a separação na primeira infância, além de ser emocionalmente difícil, também causa sintomas de abstinência

semelhantes aos experimentados com opiáceos, tanto no bebê quanto na mãe. A serotonina, nosso neurotransmissor do bem-estar, facilita nossa conexão com os outros e nos torna mais satisfeitos com ela. O funcionamento desses químicos molda nossa matriz para os relacionamentos de toda a vida.

Quando temos uma atividade reduzida desses neurotransmissores (por diversos fatores), não recebemos as mensagens de segurança, alegria e merecimento nas interações com outras pessoas. Assim, não nos sentimos tão motivados a buscar conexão, e as vias neurais naturais de apego e vínculo são prejudicadas. O poder desses neuroquímicos explica por que separações no início da vida são tão impactantes. Quando eles constroem uma matriz de apego seguro, o efeito é duradouro.

A genética tem um papel menor nos neurotransmissores do que se imaginava, e determinados desequilíbrios bioquímicos podem desregulá-los. A pirrolúria, que Elena descobriu ter, provoca uma perda crônica de zinco e vitamina B₆, nutrientes cruciais para a produção dos neuroquímicos do vínculo. Isso explica por que ela se sentia tantas vezes sobrecarregada pela conexão emocional, mesmo quando racionalmente a desejava; sua biologia tornava mais difícil manter a regulação nos relacionamentos. Identifiquei outros dois desequilíbrios bioquímicos que muitas vezes contribuem para a insegurança de apego: hipometilação e excesso de cobre. Todos os três abalam a atividade normal dos neuroquímicos e aumentam a desregulação, afetando o apego.

A inflamação cerebral também impacta a regulação e, portanto, o apego. Ela pode surgir ainda no início da vida, quando um evento nos causa sobrecarga, seja por um motivo físico, como falta de oxigênio, ou por um estresse emocional tóxico. Um acontecimento desse tipo na primeira infância sensibiliza as micróglias (células imunológicas do cérebro), tornando-as mais reativas. O parto difícil de Elena indica que ela provavelmente teve um evento de priming, como lesão de cabeça, diminuição de oxigênio por uso de fórceps, nascimento prematuro ou circular de cordão. O estresse intenso da separação da mãe após o parto, por si só, já é suficiente para causar inflamação cerebral. Essa maior sensibilidade à inflamação e ao estresse em um cérebro em desenvolvimento contribui para a desregulação e a insegurança de apego.

Assim como as lacunas no neurodesenvolvimento relacionadas ao movimento, nossa biologia interna influencia diretamente nossa programação de apego. Por meio da neuroquímica, de desequilíbrios bioquímicos, da inflamação cerebral e de outros fatores, a biologia pode influenciar de maneira muito específica nossa capacidade de estabelecer vínculos, nos autorregular e ter relacionamentos saudáveis.

Compreender esse pilar biológico do apego, bem como sua bioquímica específica, trouxe esperança para Elena. Foi algo que mudou sua perspectiva, pois ela deixou de ter vergonha dos seus padrões de relacionamento e da sua “sensibilidade” para enfim compreender que seu sistema nervoso precisava de um suporte biológico específico. Ela não podia mudar o passado nem as experiências da primeira infância, mas não estava condenada a repetir para sempre os mesmos padrões de apego.

A biologia atua com a sintonização e o neurodesenvolvimento para criar nossa matriz de apego para toda a vida. Em conjunto, os três pilares determinam se desenvolveremos um estilo de apego seguro ou inseguro, que se tornará o fio condutor do nosso filtro interno. Vamos ver agora como esses padrões de segurança ou insegurança de apego se manifestam de maneiras que nos ajudam a reconhecê-los em nós mesmos.

COMO O APEGO SE TORNA NOSSA MATRIZ

Os estudos realizados pelo Dr. Ed Tronick, em que bebês reagiam mal quando a mãe ficava com o rosto inexpressivo e não lhes dava atenção, demonstram que o apego começa a funcionar como matriz para nossas respostas já aos 4 meses de vida. Dinâmicas familiares, o ambiente em que vivemos e nossa própria biologia continuam a produzir experiências que reforçam essa estrutura até que ela se torne uma “verdade” evidente por si mesma, o fio que atravessa todo o nosso filtro preexistente. Vamos analisar um dos fatores relacionados: o estado do nosso sistema nervoso.

Aprendemos que a neurocepção é a condutora do nosso sistema nervoso e que ela decide em qual dos três estados estaremos em cada momento, com base em sinais de perigo e segurança, na percepção da nossa capacidade de enfrentamento e na gravidade do perigo. Nossa matriz de apego calibra a avaliação que a neurocepção faz tanto da segurança quanto da nossa

capacidade. Deixe-me explicar melhor.

Quando as experiências no início da vida nos ensinam que a conexão traz regulação e reparo, desenvolvemos uma matriz que percebe desafios como coisas administráveis e a conexão como um recurso. No entanto, quando as experiências iniciais nos ensinam que não podemos confiar na ajuda dos outros, desenvolvemos uma matriz que associa desafios à sobrecarga e a conexão ao medo.

O caso de Elena ilustra isso perfeitamente. Ao receber o diagnóstico, sua matriz de apego inseguro influenciou sua resposta em vários níveis.

Primeiro, na percepção do próprio desafio. Com suas lentes tingidas pelo perigo, após experiências precoces em que a segurança era incerta, o diagnóstico lhe pareceu não só preocupante, mas catastrófico. Sem um senso interno de “vou ter ajuda para lidar com isso”, sua neurocepção classificou imediatamente a situação como uma ameaça que superava sua capacidade de enfrentamento. Em vez de buscar apoio, sua matriz ativou padrões familiares de congelamento e apagão, pois ela não via a conexão como um recurso.

A matriz de Sarah se manifestou de forma diferente, embora tivesse a mesma raiz no apego inseguro. Até mesmo em seu trabalho como enfermeira de UTI, a atenção constante às necessidades dos outros, ignorando as próprias, refletia uma matriz desenvolvida precocemente em que a sintonização era condicionada ao desempenho. A reação de sobrecarga diante da morte da mãe era previsível, pois acionou suas feridas de apego: querer se conectar mas ao mesmo tempo sentir que o contato com as pessoas era algo intenso demais para ela.

Naturalmente, nossa matriz de apego fica ainda mais evidente na forma como lidamos com o estresse, com as mudanças e com nossos relacionamentos. A facilidade de Elena em ter sucesso profissional somada à dificuldade em construir relacionamentos íntimos refletia muito bem a matriz que desenvolvera no início da vida. No trabalho, em que não se exigia dela vulnerabilidade emocional, podia viver de forma plenamente racional, acumulando conquistas e apresentando ótimo desempenho. Já nos relacionamentos, nos quais a conexão emocional pode ser confusa e implicar vulnerabilidade, sua matriz de apego fazia com que ela congelasse e se retraísse. Talvez nossos gatilhos e inseguranças sejam diferentes, mas podemos ser como Elena: bem-sucedidos na vida profissional porém

impotentes diante de emoções intensas nos relacionamentos.

O FILTRO QUE PREVÊ NOSSAS RESPOSTAS

Agora que entendemos o papel do apego como base dos quatro elementos do nosso filtro preexistente, podemos observar como essa estrutura orienta nossas respostas. Para cada estímulo, há uma resposta, e a resposta passa antes por um filtro.

Esse filtro opera de modo constante; não podemos excluí-lo quando é inconveniente. Além do mais, ele está sempre mudando: de acordo com a qualidade do nosso sono na noite anterior, com o que comemos naquele dia, com quantos abraços recebemos. Isso explica por que a mesma situação pode nos sobrecarregar em um dia e parecer administrável em outro.

Agora chegamos a uma questão essencial: se nossas respostas são determinadas por esse filtro interno, o que fazemos quando queremos mudar nossa vida? Quando queremos ser uma versão melhor de nós mesmos ou viver de forma mais autêntica? Teremos que mudar o filtro. Na próxima parte deste livro, você aprenderá exatamente como fazer isso. É verdade que o corpo retém o trauma, o que pode nos tornar mais vulneráveis a novos traumas graças a esse filtro. Mas, ao aprender a usar ferramentas de reparo para alterá-lo, podemos criar um futuro diferente para nós: um futuro que inclua saúde, conexão e amor.

RESUMO

Nosso filtro preexistente é mais do que um conjunto de experiências do passado: ele orienta nossa resposta a qualquer estímulo. Ele opera por meio de quatro componentes integrados: o estado atual do nosso sistema nervoso, os sinais de segurança ou perigo emitidos pela nossa biologia, nossas crenças programadas e nossas memórias somáticas. Juntos, eles criam o filtro pelo qual a neurocepção determina a percepção tanto da nossa capacidade de enfrentamento quanto da gravidade do perigo.

Compreender esse filtro interno transforma a maneira como analisamos as respostas que tivemos no passado, inclusive aquelas de que sentimos

vergonha. A subjugação de Elena no consultório e o colapso de Sarah junto ao leito da mãe não foram uma surpresa; tampouco a dissociação de Alex na sala de reuniões, a fadiga crônica de Claire e a dor pélvica persistente de Dana. Todas foram respostas previsíveis de uma neurocepção organizada em torno da desregulação e construída sobre uma base de inseguranças.

Quando entendemos isso, torna-se mais fácil encontrar soluções e perceber por que tantos tratamentos, terapias e abordagens acabam falhando a longo prazo. Não considerar o filtro preexistente que gera a resposta é como tentar cultivar uma planta saudável em um solo infértil. Antes, precisamos alterar o solo. Para tanto, é preciso aprender a mudar os fatores que compõem nosso filtro interno. Na Parte 3, exploraremos exatamente como mudar esse filtro preexistente garantindo reparo em seus níveis essenciais: mente, corpo, biologia e neurocepção.

PARTE 3

Como o corpo se cura

Ao longo deste livro, compreendemos a profundidade com que o corpo vivencia e retém o trauma – ou a sobrecarga, se preferir esse termo. Vimos como essas experiências nos afetam em vários níveis: desde a neurocepção até a biologia, da memória somática de bloqueio do movimento às crenças programadas. Não se trata apenas do impacto imediato: o corpo se agarra ao passado, mantendo-o vivo. Ficamos presos em padrões de trauma, tentando lidar com dores emocionais e reatividade que criam problemas, como o desencadeamento de sintomas físicos.

Pode ser desanimador olhar para o problema e perceber o tamanho do fardo traumático que o corpo carrega. Existe esperança? Essa foi a pergunta que fiz a mim mesma quando percebi como meu corpo estava sobrecarregado de trauma armazenado, a ponto de eu já ter desenvolvido vários problemas de saúde crônicos. O meu medo era que esse se tornasse o novo normal para o resto da vida. Os efeitos se espalham por todas as esferas da nossa existência: sintomas físicos, respostas emocionais, relacionamentos e senso de identidade. É natural questionar se esse acúmulo de respostas de trauma, que criou padrões tão profundos de sobrevivência, pode algum dia ser realmente reparado.

A resposta, conforme exploraremos na Parte 3, é *sim, com toda a certeza*. Podemos mudar nosso filtro preexistente, que

determina nossas respostas com base em um cálculo interno que relaciona demanda e capacidade, perigo e segurança. Mas eis algo crucial: não basta contar nossa história, ter uma testemunha ou usar abordagens cognitivo-comportamentais para tentar mudar nossas respostas a gatilhos. Nossa biologia alterada nos puxa para trás, mantendo sinais de perigo e esgotamento energético no nível celular. Para realmente nos curarmos, precisamos de uma abordagem integrativa que atue em todos os níveis do nosso organismo que se encontram travados – mente, corpo e biologia.

Esta parte do livro oferece um mapa baseado em evidências científicas, bem como princípios e um conjunto de ferramentas que serão úteis nessa jornada de cura. O mapa é uma sequência essencial em três fases que mostra como o corpo volta a se abrir para a vida após o apagão. As ferramentas são aquilo que você usará para reparar o que foi danificado e impediu seu corpo de exercer sua capacidade inata de processar, se recuperar e crescer a partir das respostas de trauma. Vou guiar você pelo modelo que nos permite priorizar e personalizar essas ferramentas para sabermos quais usar, e em qual ordem, com base no ponto em que o corpo está agora. Por fim, os princípios nos ajudam a permanecer no caminho certo e aperfeiçoar a arte de estabelecer uma amizade com o corpo, alinhando-nos às suas forças naturais e às suas capacidades inatas de cura.

Esta parte não é sobre gerenciar sintomas ou lidar com gatilhos. Vai além do trauma e da cura. Gira em torno de aprender uma nova forma de criar intencionalmente as experiências de que precisamos, com a precisão necessária para acelerar a jornada de reparo e construir uma vida mais plena. Mesmo que a desregulação, a desconexão e a sobrecarga tenham sido a sua realidade durante décadas, a cura é possível. Vamos explorar o mapa, o modelo de reparo e os princípios para começar nossa jornada rumo à saúde e à melhor versão de nós mesmos.

CAPÍTULO 12

O mapa e o modelo para a jornada

É perigoso, Frodo, sair porta afora. Quando você põe o pé na estrada, se não sabe bem onde pisa, não há como saber onde pode parar.

— J.R.R. Tolkien, *O senhor dos anéis*

Sarah estava sentada em seu carro, diante do consultório da terapeuta, prestes a encarar sua primeira sessão, sentindo-se desconfortável, inquieta, desejando estar em qualquer outro lugar. Estava decidida, mas também hesitante. A morte da mãe havia rachado alguma coisa dentro dela. Sarah sabia que algo não estava bem e que os livros de autoajuda não seriam suficientes. Era hora de encarar o passado, mas ela também temia o que poderia sair dali. Havia anos que vinha reprimindo lembranças e sentimentos.

Ela se sentia especialmente vulnerável por não ter certeza se havia escolhido a terapeuta certa, ou até o tipo de terapia certo. Simplesmente consultara a lista de profissionais que aceitavam seu plano de saúde, telefonando até encontrar alguém que aceitasse novos pacientes. O nó no estômago era o mesmo que sentia no trabalho quando um paciente chegava pela primeira vez à UTI sem diagnóstico ou plano de tratamento. Ela detestava não saber qual era o plano. Os protocolos e manuais eram a bússola que lhe diziam exatamente o que fazer.

Ainda assim, ali estava ela: prestes a iniciar sua própria jornada de cura sem plano, sem mapa, sem princípios para guiar seu caminho. Como saber se aquilo iria ajudar? E se piorasse tudo? Ela balançou a cabeça, tentando

afastar esses pensamentos. Já estava ansiosa o bastante. Por fim, sentindo que não tinha outra opção além de tentar, respirou fundo e se obrigou a entrar no consultório.

O medo de Sarah era legítimo. Mesmo com boas intenções, podemos piorar as coisas. Apesar de toda a minha formação como médica, esse foi o meu ponto de partida. Eu havia aprendido protocolos para cuidar de pacientes e auxiliar sua cura física após cirurgias invasivas, mas não existia um protocolo para me orientar em uma jornada de cura do trauma. Quando busquei respostas para ajudar Miguel, o meu maior desejo era ter um mapa. Eu me perguntava o que estava fazendo de errado ao ver abordagens tradicionais e baseadas em evidências piorarem a reatividade emocional dele. Quando descobri meu próprio trauma armazenado e oculto, o processo terapêutico veio acompanhado de vários tropeços que, algumas vezes, chegaram a aumentar minha ansiedade, sobrecarga e fadiga, além dos problemas digestivos e da doença autoimune.

Cada pessoa chega para trabalhar o trauma de um jeito. Alguns decidem “resolver tudo de uma vez” internando-se em centros de terapia intensiva e recorrendo a substâncias que alteram a consciência. Outros escolhem uma verdadeira salada de modalidades como dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares, psicoterapia, ioga, programa de processamento em grupo (como o dos 12 passos) ou até terapia com cavalos. Além de confuso, é fácil se exceder e acessar dores e medos profundos rápido demais. Podemos nos sentir perdidos, estagnados ou até nos traumatizarmos novamente no que deveria ser uma jornada de cura.

Então, como saber por onde começar? Como devemos nos portar na terapia e trabalhar corretamente o trauma?

A ciência da resposta instintiva ao trauma, com suas cinco etapas de como o corpo entra em resposta traumática, nos fornece a sequência e os passos para sair dela. Existem princípios e um modelo que podemos usar como guia. Vamos começar com a sequência essencial, ou seja, os três passos que levam nosso corpo a se abrir de novo com segurança para tudo o que a vida tem a oferecer.

A SEQUÊNCIA ESSENCIAL

A natureza codificou em nosso sistema nervoso não apenas a maneira como respondemos ao perigo, mas também como retornamos à segurança e ao crescimento. Não precisamos ensinar o corpo a fazer isso. A sequência instintiva da resposta ao trauma está embutida no nosso programa de sobrevivência. O corpo foi talhado de modo a completar suas próprias respostas ao trauma. Somos nós que atrapalhamos, levando-o a reter, em vez de processar e liberar, a experiência de sobrecarga.

O corpo sai de uma resposta traumática seguindo a mesma sequência pela qual entrou nela: sobressalto, estresse, o muro, o congelamento e o apagão, porém na ordem inversa, até retornar plenamente à vida.

Esse trajeto invertido é o que chamo de sequência essencial, composta por três passos que permitem ao nosso corpo liberar o trauma armazenado. Princípios seguros e um modelo de reparo com ferramentas específicas nos ajudam nesse processo, evitando que fiquemos empacados em algum ponto do caminho.

A metáfora de acelerar e frear um carro nos ajuda a entender essa sequência de liberação da resposta ao trauma. No apagão, o freio de mão está totalmente puxado; por mais que você pise no acelerador, o freio impede qualquer movimento. Assim, o primeiro passo é a **segurança**: informar à neurocepção que não estamos mais encurralados diante do muro e impotentes. Esse movimento começa a soltar o freio, retirando-nos da etapa de apagão.

À medida que a sensação de segurança nos permite sair do apagão, ocorre um fenômeno para o qual poucos estão preparados. Como o corpo precisa refazer o caminho inverso, o estado de mobilização que precedeu o apagão começa a emergir. O freio de mão não eliminou a mobilização simpática do pânico e da ansiedade; apenas se sobrepôs a ela na forma de apagão. É nesse ponto que o segundo passo, o **suporte**, se torna crucial. O suporte é o que nos permite cruzar a etapa do estresse sem ultrapassar novamente o limite crítico da sobrecarga e voltar ao estado de trauma.

Quando conseguimos oferecer suporte ao estresse e tirar o pé do acelerador, nossa neurocepção muda o corpo para o estado calmo-ativo, ou seja, o estado em que descansamos, nos recuperamos e criamos. É nele que

acessamos o terceiro passo da sequência essencial, a **expansão**, quando reforçamos nossa capacidade e começamos a viver mais plenamente do que antes.

Um erro comum que sabota todo o processo é não seguir essa ordem ao trabalhar o trauma. Quando embarcamos em terapias e intervenções profundas, intensas ou narrativas, sem antes ter estabelecido segurança e suporte, acabamos sobrecarregando o corpo.

Foi o que aconteceu com Sarah. Em sua primeira sessão, ela foi logo falando sobre a morte da mãe. Saiu de lá achando que havia feito um bom trabalho, mas estava exausta física e emocionalmente. À noite, fez o que se tornaria um hábito após as sessões de terapia: comprou brownies, sorvete e uma garrafa de vinho, e, em casa, passou horas rolando o feed das redes sociais no celular com a TV ligada ao fundo. Estava cansada, porém agitada. Esses eram sinais evidentes de que seu corpo não se sentia seguro com o que havia sido explorado na terapia, mas ela ainda não sabia decodificar essa mensagem.

A sequência essencial não é arbitrária nem opcional. São os princípios que o corpo segue naturalmente ao sair de qualquer estado de apagão, seja causado por um trauma físico, como depois de uma cirurgia ou uma concussão, seja causado por um trauma fisiológico, como aquele induzido por abuso de substâncias. Quando meus pacientes acordavam de uma anestesia, seguiam essa mesma sequência: primeiro olhavam ao redor para avaliar se estavam seguros; quando o corpo começava a tremer, recebiam nosso suporte; só então eram capazes de interagir, conversar e descansar. Em seguida, iniciavam a fase de recuperação, que consistia em aumentar suas forças para alcançar uma versão mais saudável de si mesmos. Isso também acontecia com pacientes que eu ajudava em processos de desintoxicação e abstinência.

Não podemos pular etapas ou decidir fazer as coisas em uma ordem diferente e esperar resultados positivos. O corpo possui processos de sobrevivência inatos para nos ajudar a recuperar o equilíbrio; portanto, deixar de segui-los prejudicará a cura.

PASSO 1 DA SEQUÊNCIA ESSENCIAL: SEGURANÇA

O Passo 1 concentra-se em encontrar nossa zona de segurança, ou seja, o intervalo no qual nosso sistema nervoso consegue se estabilizar e começar a desacelerar o loop corpo-trauma. Como em um carro que derrapa e foge do controle, o primeiro objetivo é parar de girar. Só então podemos nos orientar e retomar o movimento: desta vez com segurança, na direção certa. Começamos interrompendo nosso próprio ciclo exaustivo de “forçar a barra” e entrar em colapso. Não conseguimos avançar quando estamos sempre nos estados reativos e de apagão. Nesse primeiro passo, nos concentramos apenas em estabilizar nosso sistema. Para tal, é preciso criar uma sensação interna de segurança.

A experiência de Sarah é um exemplo do que muitos de nós descobrimos em nossa jornada de cura. Ela entrou na terapia já mergulhando de cabeça no processo. Como resultado, ficava exausta após cada sessão. “Sempre que eu ia à terapia, me sentia tão esgotada depois que acabei simplesmente desistindo”, contou ela. Seu corpo já estava enviando mensagens claras de que precisava de segurança primeiro, mas ela ainda não estava pronta para entender isso.

É imprescindível ir devagar nesse início. Para algumas pessoas, não parece seguro sentir segurança. Assim que começam a relaxar, o corpo se sobressalta e entra em hipervigilância, pois qualquer calma aciona uma crença arraigada de que não podem baixar a guarda. Mesmo que comecemos criando micromomentos de segurança, de apenas 30 segundos, a segurança deve ser o ponto de partida para todos nós. Ela forma a base de que precisamos para os outros passos, especialmente quando entrarmos na próxima fase, em que mobilização, ansiedade e pânico surgirão à medida que refizermos, no sentido inverso, os passos da sequência instintiva da resposta ao trauma.

Encontrar nossa zona de segurança exige impor limites precisos em relação ao que escolhemos não fazer durante esse passo. Existem coisas que escolheremos sabiamente adiar. Processar lembranças e histórias guardadas lá no fundo, ou tentar superá-las, são coisas que deverão esperar. Talvez seja necessário recusar certos compromissos, mudar de ares ou limitar a exposição a determinadas pessoas. Nesse passo, ainda não estamos em um estado saudável o suficiente para decidir se esses limites serão permanentes

ou não. Eles são apenas uma proteção necessária para nossa estabilização inicial.

Não conseguimos convencer a nós mesmos a nos sentirmos seguros com alguém. A segurança não pode existir apenas no nível psicológico; ela precisa ser sentida visceralmente e se consolidar em todos os níveis para que nossa neurocepção receba a mensagem de que pode sair do apagão. Com o tempo, aprendemos a confiar nas mensagens do corpo dizendo que não se sente seguro. Em vez de duvidarmos de nós mesmos, nossa prioridade passa a ser criar segurança interna durante o Passo 1, ouvindo o que nosso corpo diz.

Mesmo assim, muitas vezes perderemos a sensação de segurança nessa fase inicial de estabilização, pois a reconexão com quem somos, com as outras pessoas e com a vida ainda poderá nos parecer insegura. Se formos perfeccionistas e tentarmos permanecer na nossa zona de segurança a todo custo, isso só vai nos atrapalhar.

A fadiga crônica de Claire, apesar de todas as suas técnicas de gerenciamento do estresse e autocuidado, mostra outro aspecto dessa necessidade de segurança. “Eu insistia em buscar mais formas de autocuidado”, relatou ela, “mas meu corpo precisava de algo mais fundamental. Precisava sentir que estava *seguro*. Mas ele nunca havia sentido segurança suficiente para sair do modo de sobrevivência.”

Como saber se estamos realmente criando segurança? Nosso corpo nos fornece sinais claros. Para começar, podemos notar que o apagão se torna mais previsível, em vez de caótico e constante. Em algumas ocasiões, talvez pela primeira vez, conseguimos nos sentir realmente presentes com alguém, talvez até com nós mesmos. Passamos a sentir e a ouvir nosso corpo, como no começo de uma amizade. Sintomas físicos, como problemas digestivos ou distúrbios do sono, podem começar a melhorar. Todos esses são indícios de que estamos estabelecendo segurança interna em nosso corpo.

À medida que aprendemos a ler e a responder às mensagens de segurança do nosso corpo, preparamos o terreno para o surgimento natural da mobilização. É aqui que começamos a entender o papel crucial do suporte em nossa jornada de cura.

PASSO 2 DA SEQUÊNCIA ESSENCIAL: SUPORTE

O Passo 2 da sequência essencial para se abrir de novo para a vida surge naturalmente à medida que estabelecemos segurança suficiente para soltar o freio de mão. A maioria das pessoas, sem saber que o corpo refaz seu caminho de volta pela sequência instintiva da resposta ao trauma, fica surpresa com a ansiedade, a energia e até a raiva que surgem quando emergimos do apagão e retornamos ao estado de estresse. Descobrimos que o pânico e a ansiedade do estresse do momento em que atingimos o muro nunca desapareceram; tinham apenas sido subjugados pela resposta ao trauma mais intensa do congelamento e do apagão.

Essa constatação abalou Claire. À medida que aprendia as habilidades de segurança, ela esperava que fosse apenas se sentir cada vez melhor. “Quando comecei a sentir ansiedade depois de tanto tempo sem sentir nada, achei que estivesse piorando”, disse. Como muita gente, a princípio ela interpretou aquele estresse como um retrocesso. “Eu não conseguia entender que estava tendo essa reação porque meu corpo finalmente se sentia seguro o suficiente para começar a se libertar dos antigos padrões.”

Há dois aspectos que tornam esse passo particularmente desafiador, podendo bloquear nossa cura. Conforme o sistema nervoso retorna ao estresse rumo ao estado calmo-ativo, é preciso saber se ele é capaz de superar o estresse e completar a resposta ao trauma. É aqui que o suporte se torna crucial; sem ele, nossa neurocepção perceberá que nada mudou, ou seja, que o perigo ainda excede nossa capacidade, e assim voltaremos ao muro da impotência, ao congelamento e, por fim, ao apagão.

Quando Sarah chegou a esse passo, percebeu que estava mais ansiosa. Dana notou ter ficado mais inquieta. Elena sentiu raiva, o que gerou ansiedade, por conta de sua necessidade crônica de agradar os outros. A pressão arterial de Claire subiu, ao passo que Laura teve necessidade de fazer corridas mais longas. Elas nunca tinham aprendido a conviver com o estresse; tudo o que sabiam era como tentar evitá-lo. Esse novo estado exigia aprender novas habilidades e oferecer suporte ao corpo de maneiras que nunca haviam feito antes. Precisavam aprender a coexistir com o estresse, a ansiedade e a raiva, e vivenciar esses sentimentos até o fim, sem permitir que as levassem de volta à mesma sobrecarga e ao apagão de antes.

O segundo desafio é a própria abrangência de tudo o que necessita de

reparo. Não precisamos apenas aprender a lidar com respostas de estresse e completá-las, mas também reparar o que foi danificado. Muitas vezes, a lista de reparos é extensa. Tomemos como exemplo Sarah, quando foi para sua primeira sessão de terapia. Por mais que ela precisasse de ajuda para reparar movimentos somáticos e sua parte criança, e reprogramar seu apego, também era necessário algum suporte para seus problemas intestinais e de sono, suas mitocôndrias e seus neurotransmissores. Todo esse reparo não pode – e não deve – ocorrer de uma só vez; o importante é priorizar as ferramentas disponíveis. É aqui que o modelo da Biologia do Trauma se torna crucial, pois ele nos ajuda a identificar quais ferramentas de reparo usar e em que ordem.

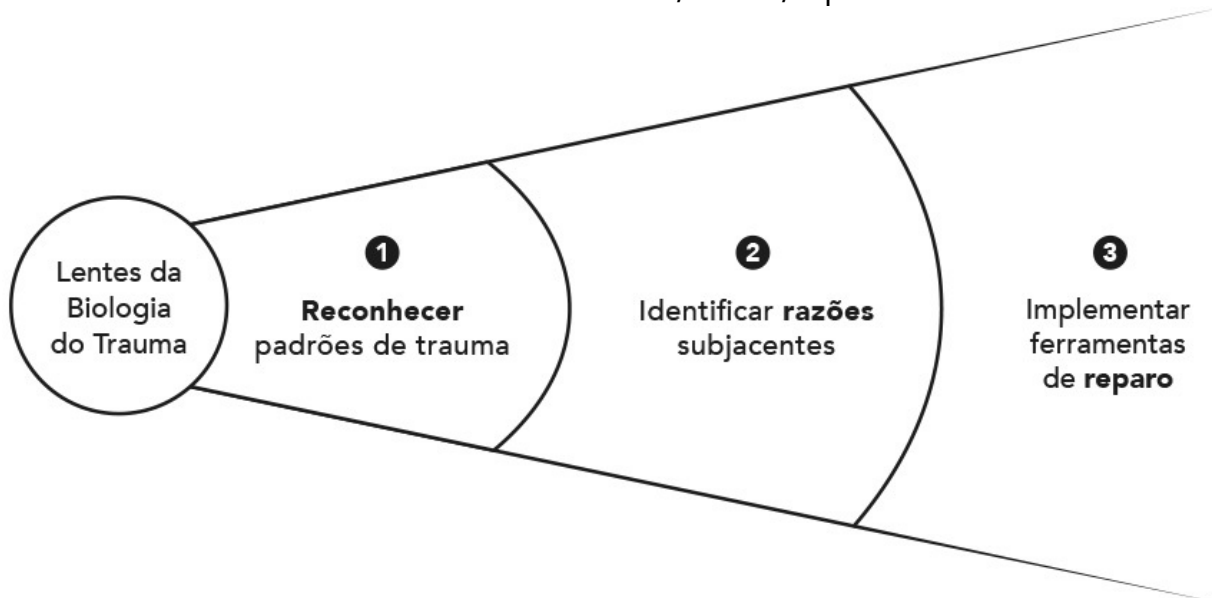
O modelo da Biologia do Trauma: orientando o suporte

À medida que eu trabalhava mais com o trauma armazenado, fui descobrindo um número crescente de fatores biológicos que podiam bloquear o processo de cura do corpo. Embora essa compreensão mais profunda fosse valiosa, também tornava a personalização do suporte mais complexa. Eu precisava de uma forma sistemática de organizar e priorizar todos esses fatores para apoiar de modo eficaz a jornada única de cura de cada pessoa. Foi essa necessidade que me fez desenvolver o modelo da Biologia do Trauma.

Concebido para me ajudar a fazer uma triagem das diferentes formas de reparo que dão suporte à regulação, esse modelo nos ajuda a saber qual ferramenta usar e em que ordem. Existem três etapas que nos permitem priorizar e personalizar o suporte para avançar na sequência essencial: reconhecer padrões de trauma, identificar razões subjacentes e implementar ferramentas de reparo.

As lentes do modelo da Biologia do Trauma

Os 3 Rs: reconhecimento, razões, reparo



Reconhecimento

A primeira etapa do modelo é reconhecer a presença de um ou mais padrões de trauma em nossa vida atual. Em vez de irmos atrás de eventos passados ou sintomas isolados, buscamos padrões presentes em várias áreas da nossa vida. Seja desconexão, interrupção do movimento, esgotamento de energia, desregulação ou doença crônica: todos indicam que nosso corpo está preso ao trauma e aos seus padrões de sobrevivência. Se temos uma doença crônica que indica desregulação, será que existem também outros padrões de sobrevivência, como desconexão nos relacionamentos, cansaço extremo ou crenças limitantes sobre nós mesmos?

Quando observamos sintomas pelas lentes da biologia do trauma, vemos como eles se conectam. O perfeccionismo de Sarah, a maneira como se mantinha atarefada para evitar emoções e seus problemas digestivos apontavam para um padrão de desregulação, alternando-se entre estresse e apagão. Claire apresentava um padrão de doença na forma de uma fadiga crônica ligada a padrões mais profundos de esgotamento, com isolamento nos relacionamentos e sensação de fracasso. A doença autoimune de Elena estava ligada a um padrão mais amplo de desconexão, que incluía névoa

mental, tendência a evitar intimidade e sobrecarga emocional frequente que a levava a se retrair.

O diário do sistema nervoso que recomendei no Capítulo 2 é uma ferramenta prática para identificar um padrão de trauma armazenado. Ao registrar os estados do seu sistema nervoso, você pode reconhecer a alternância entre mobilização e apagão, ou a predominância do apagão.

Razões

Em seguida, identificamos as razões subjacentes que mantêm esses padrões mesmo após alcançarmos uma segurança básica. Lembra-se de como nosso filtro interno, que vimos no Capítulo 11, influencia todas as respostas? Devemos buscar as razões pelas quais estamos presos no loop corpo-trauma que perpetua os padrões de trauma que acabamos de reconhecer. Algumas serão sinais diretos de perigo para nossa neurocepção. Outras atuarão de forma indireta ao reduzirem nossa sensação de capacidade.

Identificar as razões subjacentes nos permite evitar o erro de focar apenas em um problema que não passa de um sintoma, como comer por estresse ou dificuldade em demonstrar afeto. O perfeccionismo de Sarah e as dificuldades de intimidade de Elena eram apenas sintomas; as razões subjacentes precisavam ser identificadas e então reparadas para garantir uma mudança duradoura.

Reparo

Ao saber quais razões subjacentes têm maior influência em nossos padrões de trauma, podemos ser estratégicos ao passarmos para a terceira etapa do modelo: o reparo. Usaremos três tipos de ferramentas de reparo: a somática, a psicológica e a biológica. A integração simultânea das três cria uma abordagem equilibrada e holística, que trata mente, corpo e biologia juntos, e não separadamente. A precisão dessa abordagem integrativa permite acelerar a jornada de cura com segurança, em comparação com abordagens tradicionais, que não são integrativas nem precisas.

As ferramentas são organizadas com base em seu impacto e praticidade. Vou priorizar as de maior impacto, equilibrando as realidades de tempo,

dinheiro e energia. A lista de prioridades é simplificada para conter apenas as coisas realmente praticáveis. É melhor aplicar com sucesso uma ferramenta de reparo do que ter uma lista de 10 ótimas ideias e não colocar nenhuma em prática.

Quando Elena analisou o modelo comigo, decidiu que seu plano de reparo começaria com três intervenções escolhidas criteriosamente: práticas somáticas para manter sua sensação interna de segurança, apoio psicológico para trabalhar seu perfeccionismo e suporte específico para suas mitocôndrias comprometidas. Essas ferramentas foram selecionadas não apenas pelo potencial de eficácia, mas também por serem viáveis na vida de Elena.

Quando implementamos o modelo de modo eficaz, nosso corpo fornece muitos sinais de que o suporte está dando resultado. Sintomas de saúde começam a mudar, não apenas temporariamente, mas de maneira sustentável. A energia se torna mais estável, a inflamação diminui e, em vez de entrar imediatamente em apagão quando estressados, conseguimos permanecer presentes por mais tempo. Desenvolvemos habilidades para não temer o congelamento e o apagão, sabendo concluir esses estados assim como concluímos o estado de estresse. Começamos a sentir que a vida é um fluxo, e não uma batalha diária morro acima como antes.

Esse é o sinal de que estamos prontos para entrar na expansão, o terceiro passo da sequência essencial.

PASSO 3 DA SEQUÊNCIA ESSENCIAL: EXPANSÃO

Depois de criarmos uma base sólida de regulação com segurança e suporte, podemos entrar no último passo da sequência essencial com confiança. A expansão é nosso crescimento para níveis mais profundos de conexão, saúde e vitalidade. Pense nela como o desenvolvimento de um patinho dentro do ovo, que é uma analogia perfeita de como queremos que nossa expansão aconteça: de dentro para fora.

Quando o patinho está dentro do ovo, ele precisa de duas coisas fundamentais: uma casca segura e quente para protegê-lo e todos os nutrientes adequados para sustentar seu crescimento. Dentro de seu recipiente seguro (sua zona de segurança), ele se desenvolve no ritmo ideal.

Quando está forte o suficiente, cria a pressão necessária para romper a casca por dentro. Se quebrássemos essa casca por fora antes que o patinho estivesse pronto, mesmo com a boa intenção de “ajudar”, na verdade o prejudicaríamos. A escolha do momento certo e a pressão precisam vir de dentro.

É exatamente assim que nossa jornada de cura funciona. Quando tentamos nos forçar a “processar tudo agora” ou a “superar isso logo”, estamos quebrando o ovo por fora. Em vez disso, precisamos criar para nós mesmos esse tipo de ambiente seguro e acolhedor: uma base de segurança e suporte que permita à nossa capacidade natural de cura se desenvolver em seu próprio ritmo. Nosso trabalho não é forçar o crescimento, mas gerar as condições que nos façam crescer sem nos quebrar.

O estado calmo-ativo torna-se a base para o nosso crescimento. Se não conseguimos entrar nesse estado e permanecer nele, isso indica que ainda não estamos prontos para avançar para a expansão e para novos territórios. A confiança em nossas habilidades de mudar de estado e criar experiências internas que nos deem segurança e suporte é o indicativo de que estamos prontos para a expansão.

Esse esforço nos faz avançar para além do que é confortável, mas sempre atentos à capacidade do corpo e dentro do que é *seguro o suficiente*. Às vezes, pode parecer que estamos perdendo a chance de fazer grandes avanços por seguirmos um ritmo mais lento, mas as mudanças duradouras vêm dessa expansão constante e controlada da nossa capacidade. Um desvio de apenas um grau é capaz de mover um transatlântico.

As pessoas geralmente ficam surpresas com a magia dessa expansão suave. O que começa como uma necessidade, como quando Elena teve que lidar com uma doença autoimune, se torna uma descoberta de maneiras totalmente novas de existir. “Eu já não estou apenas controlando sintomas”, declarou ela. “Estou descobrindo o que significa realmente me sentir viva dentro do meu corpo.” Um ano depois, ela notaria mudanças ainda mais profundas: seu sistema nervoso havia desenvolvido uma resiliência natural, capaz de ser ativada quando necessário, mas sem perder o caminho de volta ao estado calmo-ativo – como um instrumento bem afinado retornando à sua harmonia natural.

A sequência essencial não se resume a entender conceitos; ela exige o desenvolvimento de habilidades práticas. Precisamos delas para rastrear os

estados do nosso sistema nervoso, criar segurança no momento presente, oferecer suporte ao nosso corpo com ferramentas de reparo, completar respostas e ajustar a expansão à nossa capacidade atual. A informação, sozinha, não gera mudança. É necessário aprender a trabalhar com os processos naturais do corpo por meio da experiência direta e da prática. Existem princípios orientadores que podem nos ajudar a fazer isso.

PRINCÍPIOS

A sequência essencial nos fornece o mapa, mas, como em qualquer jornada, o sucesso depende da forma como viajamos. Temos o equipamento certo? Sabemos voltar ao caminho se nos desviarmos dele? Certos princípios naturais e da neurociência podem nos guiar nesse sentido.

Integração dos elementos essenciais

O desenvolvimento infantil é um exemplo de como a natureza demonstra a necessidade de integração: para uma criança crescer bem, não basta que receba apenas nutrição, apenas educação ou apenas conexão emocional. Cada uma supre uma necessidade; somadas, permitem um desenvolvimento equilibrado e saudável. Esse mesmo princípio de equilíbrio, por meio da integração do suporte em vários níveis, deve ser aplicado à nossa jornada de cura.

Quando abordamos simultaneamente os diferentes níveis que estão bloqueados – mente, corpo e biologia –, nos permitimos seguir em frente. Se algum desses níveis permanece incapaz de avançar, os sinais que ele envia à nossa neurocepção travam todo o sistema. Ao integrarmos abordagens de mente, corpo e biologia ao mesmo tempo, possibilitamos que todos os níveis mudem juntos. Isso leva à aceleração da fase de suporte e explica por que este é um princípio que nos levará a mudanças bem-sucedidas.

Estabelecimento de bases antes de mergulhar fundo

Assim como não faríamos uma cirurgia sem a preparação adequada, não

devemos mergulhar no processamento de traumas sem antes garantirmos uma estabilização e regulação básica. Esse princípio nos protege do erro comum de abrir feridas que ainda não temos capacidade de sentir, o que nos levaria de volta à sobrecarga, e não ao processamento e à cura.

Experiências acima da informação

O princípio de que experiências, e não apenas informações, mudam nossos circuitos neurais está amplamente consolidado na neurociência. Uma experiência desencadeia um padrão sucessivo complexo de disparos neurais, a liberação de neurotransmissores e até mudanças de expressão gênica que a simples absorção de informações não produz. É por isso que podemos saber racionalmente que estamos seguros, mas ainda assim nos sentirmos ansiosos; ou que não deveríamos comer por estresse, mas o fazemos do mesmo jeito quando ele surge. Se isso acontece, é porque o caminho da aprendizagem experiencial ainda não foi ativado para reconfigurar a resposta emocional.

Embora compreender o impacto do trauma no corpo ajude, somente novas experiências podem trazer mudanças duradouras. Claire se viu diante desse princípio quando, mesmo depois de aprender tantas coisas, percebeu que esse conhecimento não adiantava nada. Adquirir informações não mudaria padrões arraigados de sobrevivência.

Não devemos esperar que outras pessoas nos tragam essas novas experiências de bandeja, ou que a vida as crie para nós. A mudança interna ganha impulso quando começamos a criar nós mesmos as experiências que queremos: experiências que informam ao corpo que as coisas mudaram e que ele pode abandonar seus padrões de sobrevivência.

Neuroplasticidade por meio da constância

Uma única experiência de segurança ou suporte não é suficiente para gerar uma mudança duradoura. Nem mesmo concluir um programa é suficiente se não dermos continuidade às práticas. Nosso cérebro se reconfigura por meio de experiências repetidas, e não de avanços ocasionais. O princípio da neuroplasticidade, ou seja, o de que “neurônios que disparam juntos se

conectam”, significa que a prática constante e suave é muito mais eficaz para criar mudanças duradouras do que esforços intensos e esporádicos.

Trabalho com o corpo, não contra ele

Quando temos um trauma armazenado, é tentador usar nossas estratégias antigas de sobrevivência: nos esforçar demais, tentar mudar na marra ou buscar saídas racionais. Mas essas estratégias costumam criar mais resistência, não menos. Quando trabalhamos com o corpo, alinhados aos seus princípios naturais, ouvindo-o e nos aliando a ele, avançamos mais rápido em nossa jornada de cura do que quando tentamos forçar o processo.

Autorresponsabilidade

É assumindo plena responsabilidade por nós mesmos e por nossa cura que criamos as condições para o empoderamento. Quando aprendemos o que podemos fazer por nós mesmos com as habilidades e ferramentas certas, nos tornamos agentes de mudança em nossa própria vida. Ao nos conectarmos com nosso corpo, rastreamos os estados do sistema nervoso e desenvolvermos ferramentas para mudar de estado, criamos as próprias experiências necessárias para a mudança. Ninguém pode trilhar esse caminho por nós. Outras pessoas talvez compartilhem o que aprenderam, sirvam de mentores ou guias e indiquem o próximo passo, mas ninguém pode dar esse passo por nós.

Embora não possamos mudar o que nos aconteceu nem o impacto que teve sobre nós, podemos escolher ser responsáveis pela maneira como reagimos a isso atualmente. Podemos escolher aprender as habilidades e ferramentas que criarão a mudança que queremos. Autorresponsabilidade é a base da autonomia essencial para o sucesso da jornada de cura. Isso não significa independência extrema, mas sim uma responsabilidade radical por nossas reações, sem esperar que os outros façam por nós o que podemos fazer por nós mesmos. É uma forma de recuperar nossa autonomia após termos experimentado tanta impotência no passado.

Um ritmo controlado reforça a capacidade

Todo sistema tem sua janela de capacidade, ou o intervalo no qual consegue lidar com desafios sem se desregular. Trabalhar dentro dessa janela, respeitando os limites da nossa capacidade, nos permite permanecer na zona de crescimento. Como isso limita a intensidade de uma intervenção ou a profundidade de uma sessão terapêutica, podemos ter a sensação de que nos atrasa, mas, quando excedemos nossa capacidade, cruzamos o limite crítico da sobrecarga. E, quando estamos sobrecarregados, não conseguimos crescer.

Comunidade

Como o trauma surge graças à sensação de estarmos completamente sozinhos, a cura acontece em comunidade, não em isolamento. Isso não substitui o trabalho interno que cada um de nós precisa fazer. Tampouco as experiências que aprendemos a criar para nós mesmos substituem a necessidade de criar novas experiências com outras pessoas. Ao longo desse processo, podemos descobrir como nos reconectar com nosso corpo e nos abrir aos outros de forma segura.

Todos esses princípios funcionam juntos como marcos orientadores. Não são regras rígidas, mas formas de permanecermos no caminho certo. Cada princípio sustenta e fortalece os outros, o que nos ajuda a evitar o erro comum de usar velhas estratégias de sobrevivência na esperança de que elas nos curem. Mas como colocamos tudo isso em prática? Como passamos pelos três passos da sequência essencial aplicando o modelo, as ferramentas de reparo e os princípios? No próximo capítulo, veremos como integrar tudo isso acompanhando Laura ao longo do primeiro passo da sequência essencial e mostrando como você também pode empreender sua jornada rumo à segurança.

RESUMO

Do mesmo jeito que nosso corpo segue passos específicos para entrar em estado de trauma, ele requer uma sequência precisa para se curar. A

sequência essencial (segurança, suporte e expansão) é nosso mapa para sair dos padrões de trauma e do loop corpo-trauma em que nos encontramos. Como Sarah, que escolheu um terapeuta aleatoriamente, muitos de nós tentamos trabalhar nosso trauma sem um mapa, muitas vezes ficando estagnados ou até piorando, apesar das boas intenções.

Ter uma sequência serve como guia, nos ajudando a criar segurança em primeiro lugar. Isso nos permite progredir para o suporte por meio de ferramentas de reparo que, quando integradas de forma precisa e estratégica e personalizadas com base em um modelo, levam o corpo a se abrir com mais segurança e rapidez do que imaginávamos. O corpo segue passo a passo, traçando seu caminho de volta ao estado calmo-ativo e chegando à expansão para construir nossa capacidade e criar a vida da qual (quase) havíamos desistido. Os princípios garantem que não vamos sair do caminho certo; mas, mesmo se sairmos, temos o mapa e as habilidades para criar experiências que nos permitirão voltar a ele.

Conhecer o mapa, no entanto, é apenas o início. Como começar verdadeiramente essa jornada? Como encontrar a zona de segurança que torna possível uma cura mais profunda? É o que veremos no próximo capítulo.

CAPÍTULO 13

Como começar com segurança

É preciso prática para mudar nossos hábitos de sobrevivência. Um insight não basta para criar uma mudança duradoura.

— Janina Fisher, psicóloga, *Transforming the Living Legacy of Trauma*

— Querida, você precisa fazer alguma coisa – disse Sean com a voz embargada.

Minutos antes, Laura tinha, mais uma vez, se sobressaltado quando Sean disse “Eu te amo”. Sem conseguir se recompor, ela o rejeitou quando ele se aproximou para abraçá-la. Na semana anterior, Laura tinha perdido o controle depois de se assustar e gritado com os filhos por algo sem importância.

– Não podemos viver assim – continuou Sean. – As crianças precisam que você seja carinhosa. E eu preciso do seu amor de novo.

Sean disse isso da forma mais gentil possível, mas ouvi-lo foi doloroso para Laura.

– Tá bom, eu vou fazer – sussurrou ela.

Tentou dizer “Eu também te amo”, mas as palavras ficaram presas na garganta... como de costume. Sempre tivera dificuldade em expressar afeto; não só com Sean, mas com qualquer pessoa. Ela se sentia mais confortável com conversas neutras. Encontrara outras formas de demonstrar carinho: um toque suave, um olhar atento, tempo de qualidade com os filhos quando era possível. No entanto, parecia fisicamente incapaz de dizer palavras de ternura. Ela conteve as lágrimas de frustração. Por que aquelas simples palavras de amor eram tão difíceis de botar para fora?

Como professora de ioga, era no tapete que se sentia mais segura e alcançava níveis mais profundos de relaxamento. Mas, assim que saía dele, lá no

fundo, voltava a perceber a mesma inquietação de sempre. Sentia-se envergonhada pelo que considerava fracassos pessoais: suas respostas de sobressalto e sua dificuldade de expressar afeto. Cada vez mais, Laura se via como uma impostora como instrutora de mindfulness, temendo que os alunos descobrissem que não conseguia manter a conexão entre corpo e mente que ela própria ensinava.

A experiência de Laura reflete o que tenho visto em diversos pacientes e participantes dos meus cursos: a dificuldade de criar uma sensação interna de segurança que se mantenha fora da sessão de meditação ou ioga. É como se faltasse algo mais fundamental, algo mais profundo que as camadas de práticas que vamos adicionando na tentativa de criar segurança. Até encontrarmos isso, nossos padrões vão persistir com a neurocepção nos mantendo em modo de sobrevivência. Nosso corpo não vai se livrar de seus padrões de trauma protetores até saber, em um nível profundo, que é realmente seguro fazer isso.

RECONHECENDO A NECESSIDADE DE SEGURANÇA

Para reconhecer que nosso corpo não se sente seguro é necessário aprender a ler sua linguagem. Ele nem sempre fala com palavras ou da forma como esperaríamos. Embora grandes reações emocionais sinalizem claramente a angústia do corpo, sinais mais sutis muitas vezes passam despercebidos em nossos pensamentos, sensações, palavras e ações do dia a dia.

“Eu não percebia o quanto me sentia insegura até experimentar uma segurança verdadeira”, contaria Laura mais tarde, quando começou a trabalhar comigo no meu programa.

Como muita gente que passou anos alternando entre o estresse e a sobrecarga, ela havia normalizado sua experiência cotidiana. Como professora de ioga, pensava já estar bastante sintonizada com o próprio corpo. “Eu achava que estava lidando bem com a questão”, relatou. “Tinha minha rotina de ioga, corrida e aulas, mas agora vejo que meu corpo vinha mandando muitas outras mensagens, além da minha resposta de sobressalto e da dificuldade de demonstrar carinho.” Costumamos minimizar esses sinais mais sutis, chamando-os de traços de personalidade ou manias, até

aprendermos a reconhecê-los como a forma que o corpo encontra de comunicar que não se sente seguro.

À medida que começou a olhar para suas inclinações através das lentes do sistema nervoso, Laura foi reconhecendo os sinais. A tendência de ficar “aérea” durante os jantares em família não era apenas distração. A sensação de nunca conseguir relaxar completamente, exceto quando estava no tapete de ioga, não era apenas por ter uma personalidade acelerada, competitiva e impaciente.

A jornada de cada pessoa começa por reconhecer seus próprios sinais. Sarah percebeu seu padrão de pedir desculpas o tempo todo e assumir plantões extras no trabalho. Elena aprendeu a ver que as crises de autoimunidade eram uma forma de o corpo falar. A fadiga recorrente de Claire se tornou a mensageira do corpo. Alex reconheceu que sua dificuldade de se concentrar no trabalho era um sinal. Até comentários no meu canal do YouTube revelam esses padrões: “Sou adotado e tenho 55 anos. Nunca consegui desenvolver amizades ou relacionamentos.” Essas pessoas finalmente entenderam que o corpo delas não estava se sentindo seguro.

Os sinais do corpo podem aparecer em situações comuns, como sentir o coração acelerado em conversas rotineiras, não conseguir parar de mexer as mãos em reuniões, tensão nos ombros. Podemos notar que estamos roendo as unhas, sentindo um nó no estômago ou um aperto no peito. Às vezes, a mensagem vem na forma de pensamentos acelerados que não nos deixam dormir, ou de exaustão após mais um dia puxado. Podemos nos pegar rolando a tela do celular sem parar quando as emoções parecem intensas demais ou quando ouvimos uma voz interna dizer “você nunca é bom o bastante”. Em geral, sempre que parecemos estar distraídos, evitando algo ou anestesiados, isso é o corpo dizendo que não se sente seguro.

Uma vez que reconhecemos que nosso corpo não se sente seguro, seja de forma geral, seja em momentos específicos, precisamos cuidar disso. Esses sinais têm implicações mais profundas para todo o organismo, até o nível celular. Vamos analisar agora o processo de como criar segurança para o corpo.

POR ONDE COMEÇAR: O PROCESSO DE CRIAR SEGURANÇA

Assim como todo paciente internado no hospital passa pelo mesmo processo inicial de colocar um acesso venoso, colher exames e iniciar a administração de soro, o processo de encontrar nossa zona de segurança segue uma sequência padronizada. Há variações de pessoa para pessoa (por exemplo, um paciente pode receber o acesso no braço esquerdo; outro, no direito), mas o procedimento fundamental é o mesmo. Algumas pessoas consideram essas etapas difíceis, como quem tem medo de agulhas ou tem veias difíceis de achar. Para outras, é relativamente fácil. Seja como for, os elementos de que um corpo precisa para ter segurança interna são universais.

Vamos começar trazendo dois dos elementos essenciais para criar segurança interna: as práticas somáticas de autocuidado e os diálogos mente-corpo. Esses elementos trabalham juntos para ajudar nosso sistema nervoso a reconhecer que não está mais preso a padrões de sobrevivência. Por meio das práticas somáticas, aprendemos a rastrear os estados do sistema nervoso e a criar experiências sensoriais para nós mesmos. Os diálogos mente-corpo nos permitem construir uma relação com o corpo em que respondemos às suas mensagens, em vez de apenas notá-las. O objetivo não é apenas nos conectar com o corpo, mas estabelecer uma relação dinâmica de mão dupla em que nos conectamos, escutamos e respondemos.

Muitas pessoas acham esse processo desafiador porque ou nunca se conectaram de fato com o próprio corpo, ou só se conectaram por meio de práticas de mindfulness, sem saber que precisavam responder às mensagens dele. Laura acreditava ter uma conexão forte com o corpo. No entanto, à medida que avançava nesses elementos, descobriu que não o escutava nem respondia ao que ele queria.

Assim como Laura, muitos que começam a trabalhar comigo já têm alguma prática de mindfulness. Outros passaram anos, às vezes décadas, em diferentes formas de terapia. Todos estavam prontos para uma abordagem precisa e eficiente para trabalhar esses elementos, de modo a avançar para o Passo 2 da sequência essencial – o suporte –, iniciando o trabalho de reparo mais profundo, sobretudo da própria biologia. Percebi então que precisava criar um processo estruturado, como o que eu usava no hospital, que os

ajudasse a não perder mais tempo e encontrar logo sua zona de segurança. Foi aí que desenvolvi a Jornada Estruturante, um percurso de seis semanas de práticas somáticas guiadas de autocuidado e diálogos mente-corpo. O processo segue a estrutura da sequência essencial, desenvolvendo sistematicamente práticas somáticas de segurança, suporte e expansão controlada, por meio da sintonização. Com isso, as pessoas aprendem a escutar e responder ao corpo, rompendo a sensação de isolamento.

Laura decidiu entrar no próximo grupo da Jornada Estruturante em vez de tentar descobrir sozinha os elementos e habilidades necessários. O processo ajudou-a a desenvolver uma relação dinâmica com o próprio corpo, dando as respostas que ele pedia em vez de apenas se conectar a ele. Ela passou a valorizar a prática somática e o trabalho corpo-mente na companhia de outras pessoas que tinham experiências semelhantes. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha em seus desafios internos, medos e frustrações. “Nunca imaginei que tanta gente também lutasse para se sentir verdadeiramente segura, expressar sentimentos e vencer a síndrome do impostor”, compartilhou ela com o grupo.

Práticas somáticas de autocuidado

Para Laura, essa etapa começou com o aprendizado diário de uma nova prática somática sequencial de autocuidado. No primeiro dia, aprendeu a rastrear seu sistema nervoso, desenvolvendo a habilidade de reconhecer em qual estado se encontrava sempre que parava para escutar o próprio corpo. No exercício de 10 minutos, ela descobriu que seu corpo tinha dificuldade em chegar ao estado calmo-ativo. Ao criar um pouco de estresse e então reduzi-lo, notou que seu corpo ia diretamente para o estado de energia mais baixa, o apagão. Esse foi o primeiro indício de que a mudança seria mais difícil do que ela imaginava.

Após adquirir essa nova habilidade de rastrear seu estado interno, ela seguiu para o segundo dia, em que aprendeu a reconhecer quando estava ancorada fisicamente no presente e, caso não estivesse, como fazer isso. Já conhecia o conceito e até o mencionava em suas aulas de ioga, mas nunca havia se perguntado: “Como eu sei que estou ancorada no presente?” Atenta

à sensação da gravidade, com os pés firmes no chão e o quadril alinhado, começou a perceber seu corpo de um modo inédito. Ficou intrigada com a ciência do ato de estar ancorada, que levou sua conexão com o corpo a um novo nível. Não sabia que o corpo tem neurônios proprioceptivos, receptores sensoriais especializados que comunicam nossa localização, posição e movimento no espaço, e que ela poderia utilizá-los para criar sinais específicos de segurança para sua neurocepção.

Evoluindo a cada dia, à medida que aumentava sua curiosidade sobre o próprio corpo e a sabedoria contida nele, ela aprendeu a se orientar no ambiente de uma forma específica, buscando e confirmando a ausência de perigo. Isso permite ao cérebro receber evidência visual, em vez de depender de suposições. Ela aprendeu as seguintes práticas, que pareceram estranhas no início mas logo a surpreenderam com o poder de gerar uma mudança imediata para o estado calmo-ativo: criar espaço físico ao seu redor, o que, por sua vez, cria espaço mental para pensar e pausar; “demarcar o território”, tocando fisicamente o espaço ao seu redor; e murmurar um som específico que faz vibrar o nervo vago atrás das cordas vocais. Esses exercícios vão além da ioga, enviando diretamente sinais potentes de segurança ao seu sistema de sobrevivência interno. E ela conseguiu sentir a diferença imediata no corpo, que respondia com suspiros profundos, bocejos ou uma respiração espontaneamente mais profunda.

Conforme foi avançando no processo, entrando nas práticas somáticas de suporte específicas, Laura descobriu novas camadas de consciência. “Nunca pensei que meus pés precisassem de suporte”, compartilhou ela. “Ou que meus olhos, pescoço, costas e até meu coração pudessem precisar de atenção.” O entusiasmo era evidente em sua voz. A cada novo exercício, ela fazia descobertas sobre si mesma enquanto explorava seu mundo interno. Estava aprendendo, na prática, as formas sutis pelas quais podemos criar experiências internas intencionais.

Outras habilidades somáticas para criar segurança interna envolviam compreender seus limites para encontrar sua zona de segurança. Ela praticou controlar a respiração, a alegria, o desconforto e até mesmo a raiva, chegando ao que lhe pareciam quantidades exatas de cada uma dessas sensações. Aprendeu a alternar a atenção entre elas, de modo a administrá-las melhor, usando movimentos suaves da mandíbula para acessar apenas a quantidade útil de raiva ou alegria, sem exageros. Ela estava aprendendo a

explorar a fronteira entre situações seguras e seguras o suficiente, entre conforto e crescimento, sabendo exatamente por quanto tempo podia permanecer presente diante de algo desconfortável antes de escolher transferir sua atenção para algo mais agradável.

Com as habilidades somáticas básicas para a sequência essencial assimiladas, ela estava pronta para adicionar o próximo elemento: os diálogos mente-corpo.

Diálogos mente-corpo

Laura então iniciou o processo estruturado de identificar diferentes partes de si mesma. Ela descobriu que cada parte tem um papel. No caso dela, algumas gostavam de se esconder; outras queriam ser brincalhonas, fazer as coisas acontecerem ou criticar. Ela começou a entender que aquilo que antes parecia uma guerra interna de desejos conflitantes, ou uma indecisão exaustiva, vinha, na verdade, de partes diferentes suas que queriam coisas diferentes.

O processo a levou a perceber como diferentes sensações corporais se conectavam a partes específicas, com suas emoções e padrões de pensamento. A tensão na garganta era a parte que sentia medo de expressar amor. Um nó na boca no estômago era uma parte sua mais jovem que se sentia assustada. Uma dor de cabeça de tensão estava associada à sua crítica interna, que lhe dizia que ela era uma impostora.

Identificar as partes é apenas o primeiro passo; ela aprendeu também as habilidades necessárias para dialogar com elas, escutando seus medos, desejos e necessidades. Essa compreensão lhe deu a capacidade de responder, oferecer o que precisavam ou negociar com elas quando estavam bloqueando seu progresso por puro medo. Assim como acabara de aprender a fazer com o corpo, ela não apenas se conectava a essas partes, mas as escutava e respondia. Todas as partes passaram a ser acolhidas à medida que ela aprendia a se comunicar com elas. Laura praticou a habilidade de permitir que seu eu autêntico fosse uma espécie de diretor bondoso das demais partes, coordenando-as para trabalharem em harmonia.

Ao final das seis semanas do processo, as mudanças eram marcantes. Ela percebeu que um dos principais motivos para isso era o fato de o processo

ter sido desenhado de modo a criar uma prática diária, algo que ela se empenhou em continuar fazendo. A relação com seu corpo e com suas diferentes partes precisava de atenção e cuidado constantes para manter o senso de segurança e conexão que ela estava construindo.

TRANSFORMANDO A SEGURANÇA EM PRÁTICA DIÁRIA

Assim como acontece com qualquer habilidade nova, seja tocar um instrumento ou aprender um idioma, criar segurança segue uma progressão específica e requer uma prática diária para gerar os melhores resultados. A neurociência e a experiência confirmam: 10 minutos todo dia são melhores que uma hora uma vez por semana.

“Eu não entendia por que precisava ser algo diário até começar”, comentou Laura. “Aprendi que, além de não me sentir segura no meu corpo, eu perdia muito depressa o senso de segurança que conseguia alcançar depois da aula.” Ela descobriu que precisava trazer seu sistema nervoso de volta à segurança repetidas vezes. Embora seja frustrante para alguns (e triste para outros) ver a rapidez com que o corpo retorna ao modo de perigo, essa prática de voltar à segurança é o conjunto mais importante de habilidades e circuitos neurais que devem ser desenvolvidos nesse passo inicial.

Como praticava ioga, Laura teve mais facilidade em se conectar com o corpo, direcionando a atenção para diferentes sensações. Para pessoas que não têm essa experiência, pode ser difícil e desconfortável. Nesses casos, é ainda mais importante iniciar e manter uma prática diária. Começamos criando momentos muito curtos de conexão, que chamo de “microdoses de segurança”. Esses micromomentos diários nos darão mais ritmo que fazer uma sessão longa uma vez por semana.

Ao longo dessa progressão diária, Laura desenvolveu as habilidades fundamentais necessárias para o trabalho de cura mais profundo. As sessões diárias em grupo eram úteis, mas o mais importante foi o compromisso que ela assumiu consigo mesma dia após dia. À medida que passou a fazer todos os dias uma prática somática e outra de conexão com suas diferentes partes, percebeu o quanto seu corpo tinha a dizer e quais respostas podia dar a ele.

Em vez de apenas seguir com um exercício diário, Laura passou a escutar as mensagens do corpo ao longo do dia, oferecendo suporte a ele enquanto dirigia, cozinhava ou passava tempo com os filhos. “Pode parecer estranho”, disse ela, “mas estou virando amiga do meu corpo, algo que antes eu nem imaginava ser possível.”

Encontrar nossa zona de segurança exige mais do que compreensão racional; requer desenvolver novas habilidades por meio da prática diária e criar a experiência de se sentir seguro o suficiente. Essa base prepararia Laura para o próximo nível da segurança, em que seria abordado algo ainda mais fundamental do que as experiências somáticas: os sinais biológicos que seu corpo recebia constantemente.

ESTABELECENDO OS FUNDAMENTOS DA SEGURANÇA BIOLÓGICA

Embora esses dois elementos, por meio de um processo estruturado, possam deslocar nosso sistema nervoso para o estado calmo-ativo, nossa biologia pode nos empurrar de volta ao perigo. Às vezes, ela está tão desregulada que alguns sistemas precisam ser estabilizados antes mesmo de avançarmos para o Passo 2, o de suporte. Esse próximo passo trará a reparação mais complexa, mas ajustes simples que criem estabilização biológica já podem ser úteis durante o primeiro passo para encontrarmos nossa zona de segurança.

Nem tudo precisa ser abordado de imediato: começamos pelo que é urgente e fácil de implementar. Para Laura, isso significou se concentrar em algumas áreas-chave que criavam desregulação constante, deixando outras para o trabalho posterior de reparo mais profundo.

A instabilidade glicêmica de Laura a atrapalhava todos os dias. Ela nunca havia associado a ansiedade no meio da manhã e a fadiga à tarde às suas escolhas alimentares. Quando começou a observar o próprio corpo por meio das práticas somáticas, esses padrões ficaram evidentes. Laura iniciava o dia com o que acreditava ser um café da manhã saudável: aveia com frutas e mel. Isso gerava picos de glicose, seguidos de quedas bruscas, que seu corpo interpretava como perigo. Ela então comia um sanduíche para continuar tocando sua rotina, mesmo sabendo que tinha intolerância ao

glúten. Fizemos ajustes simples para estabilizar a glicemia: introduzimos um café da manhã rico em proteínas e gorduras saudáveis, com carne vermelha orgânica ou salmão selvagem com abacate, brócolis e óleo de coco. Ela trocou o pão por barrinhas proteicas.

Alguns suplementos também ajudaram. Embora as avaliações e exames laboratoriais detalhados pudessem ficar para depois (na etapa de suporte), magnésio, zinco e vitamina B₆ são geralmente seguros, e Laura começou com esses três, o que ajudou a estabilizar a produção de energia e reabastecer um sistema esgotado pelo loop corpo-trauma.

O sono era outra área em que mudanças simples poderiam gerar grande impacto. Embora fôssemos deixar os reparos mais específicos para o próximo passo, Laura implementou medidas básicas: passou a dormir no mesmo horário todos os dias e a sair para se expor à luz natural assim que acordava. Instalou cortinas blackout e passou a refrigerar o quarto à noite.

Embora ainda fossem intervenções pequenas, e não algo personalizado com base em exames, o impacto foi evidente. Laura acordava mais revigorada, tinha menos sobressaltos durante a manhã e deixou de sentir que passava o dia usando a comida para aumentar seus níveis de energia.

Mesmo mudanças básicas – adicionar algumas coisas, remover outras, alinhar-se aos nossos ritmos naturais – favorecem um processo mais profundo e eficiente para criar segurança interna, o que nos prepara para o Passo 2 de suporte. Essa base seria essencial quando Laura começasse a criar experiências totalmente novas de segurança em sua vida diária.

CRIANDO NOVAS EXPERIÊNCIAS DE SEGURANÇA

Um dos princípios que estabelecemos para nossa jornada de cura foi que são as experiências, e não as informações, que nos transformam. O sistema nervoso se adapta ao que vivencia e ao fato de essas experiências criarem perigo ou segurança. O poder da sequência essencial está em construir ativamente novas experiências de segurança em vários níveis ao mesmo tempo: o somático, o relacional e o biológico. As mudanças não são passivas; elas exigem escolhas conscientes para criarmos as experiências de que o corpo precisa para poder abrir mão das suas estratégias de sobrevivência.

Laura notou muitas mudanças por meio das experiências de segurança que passou a criar de forma constante para o corpo durante esse primeiro passo da sequência essencial. Ela se surpreendeu com o resultado. “Foi só quando aprendi a criar uma nova experiência para o meu corpo que as mudanças se tornaram fáceis”, contou. “Na verdade, elas simplesmente começaram a fluir.”

Esse princípio da neurociência atua continuamente em segundo plano. Nosso sistema nervoso vai sempre se adaptar ao ambiente, seja ele externo ou interno. Criar um novo ambiente interno exige constância, mas ele se fortalece quando estabelecemos segurança em todos os níveis ao mesmo tempo. Laura começou a criar ativamente essas novas experiências ao longo do dia. Em vez de forçar seu corpo a avançar apesar do cansaço enquanto dava aula, ela passou a fazer uma pausa para entender do que seu corpo precisava. Em vez de apenas observar as sensações durante a ioga, agora respondia a elas, ancorando-se, criando espaço para si ou usando a voz para trazer seu sistema nervoso de volta à sensação de segurança. Cada resposta oferecia ao corpo uma nova experiência em que ele era ouvido e cuidado, em vez de calado ou negligenciado.

Criar experiências de segurança exigiu que ela limitasse seu mundo em muitos aspectos, mas ela se dispôs a fazer isso temporariamente, pois sabia dos benefícios de longo prazo. Otimizar o sono, mudar a alimentação e recusar um compromisso social para não ultrapassar seus limites de energia foram algumas das estratégias que usou para encontrar sua zona de segurança.

Ela passou a praticar a criação de segurança interna nas relações com outras pessoas. Ao notar que ficava ansiosa antes de dizer “Eu te amo” para Sean, ela parou de se forçar a pronunciar essas palavras. “Eu não sei por que uma parte de mim tem dificuldade de dizer isso, mas é o que acontece.” Por sorte, Sean foi compreensivo, o que permitiu a Laura mostrar o quanto o ama de outras formas, ao mesmo tempo que criava segurança para essa parte dela.

O programa em grupo da Jornada Estruturante ofereceu a Laura uma experiência de comunidade que ela jamais tivera na vida. Ao estabelecer cinco compromissos específicos, Laura foi pela primeira vez capaz de se sentir segura em um espaço compartilhado. “Esses compromissos criaram a experiência de segurança de que eu precisava para conseguir fazer qualquer

coisa coletivamente”, explicou. “Eu não estava sendo traumatizada outra vez por histórias pesadas, porque nós não compartilhamos histórias, apenas experiências sentidas pelo corpo no momento presente. Para o meu sistema nervoso, esse foi um nível totalmente novo de segurança.”

Por meio dessas escolhas deliberadas de criar novas experiências, desde responder às sensações do corpo até lidar com os relacionamentos de forma diferente, Laura reconfigurou a forma como seu sistema nervoso entendia a segurança. Ela não estava apenas aprendendo novas técnicas ou conceitos, mas sim fornecendo ao corpo evidências concretas de que a segurança era possível. À medida que seu filtro preexistente foi alterado por conta dessas experiências acumuladas, as respostas dela à vida naturalmente se transformaram. Mas as mudanças mais profundas ainda estavam por vir, uma vez que Laura descobriu que atuar a partir desse novo alicerce de segurança abria possibilidades que ela nem imaginava existirem.

A MAGIA DE UM FILTRO INTERNO DIFERENTE

Quando mudamos nosso filtro interno por meio de novas experiências de segurança, a transformação acontece organicamente. Isso não é magia; é neurociência. Quando o filtro está calibrado para o perigo, gastamos uma quantidade enorme de energia para gerenciar nossas respostas. Mas, quando o recalibramos por meio de experiências constantes de segurança, nossas respostas mudam automaticamente. As transformações reverberam por todo o sistema, afetando tudo: da resposta de sobressalto à digestão, dos relacionamentos ao sono. Essas mudanças parecem mágicas porque não exigem força de vontade ou escolha consciente; elas acontecem de maneira natural, pois surgem de outro tipo de estado de funcionamento.

Como médica, fico impressionada com a rapidez com que o corpo muda quando proporcionamos a ele uma sensação de segurança mesmo somente com as práticas somáticas de autocuidado. Passei a coletar dados sobre as mudanças que as pessoas relatavam ao final dos 21 dias da parte somática da Jornada Estruturante, em que elas aprendem sete exercícios para segurança, sete para suporte e mais sete para habilidades de sintonização e expansão. Em 21 dias, cada pessoa de um grupo considerável apresenta em média: uma redução de 26% na dor física diária; uma redução de 28% na fadiga e

nos problemas digestivos; e uma redução de 30% nos problemas de sono, na ansiedade e nos sintomas depressivos.

As mudanças pelas quais Laura passou nesse primeiro passo da sequência essencial pareciam mágicas, mas eram o resultado natural da mudança do seu filtro preexistente. Ao criar experiências de segurança interna, Laura alterou esse filtro. Aquilo que antes exigia tanto esforço mental para ser controlado passou a fluir. Ela não precisava mais pensar em responder melhor; apenas respondia.

“Notei que eu não estava tão reativa na rotina matinal com as crianças”, contou ela ao grupo da Jornada. “No começo, achei que só estava mais decidida a ser paciente. Depois, percebi que aquilo era o resultado natural do meu sistema nervoso agora no estado calmo-ativo.” Não se tratava de força de vontade, nem apenas das técnicas específicas que ela havia aprendido. O corpo de Laura, depois de acumular experiências de segurança, passara a funcionar em um contexto de segurança. Os abraços de Nick em sua perna e as saudações de Sean agora passavam por um sistema nervoso que se sentia mais seguro para receber e expressar amor.

As mudanças não acontecem da noite para o dia, mas vão se espalhando aos poucos por todo o organismo, de maneiras que podem parecer mágicas justamente por não exigirem esforço consciente. Alguns participantes do meu programa descrevem essas alterações como “momentos espontâneos de alegria” ou “perceber as cores do outono com mais intensidade”. Outros descobrem que conseguem abrir uma porta sem a dor habitual no punho ou vivenciam um momento sublime no supermercado quando um comentário de um estranho, que normalmente seria um gatilho, passa batido. Em cada um desses “momentos mágicos”, a reação é sempre a mesma: ficam impressionados ao perceber que o padrão de respostas mudou sem nem se darem conta.

Como professora de ioga, Laura percebeu que conseguia dar mais apoio aos alunos quando eles experimentavam catarses emocionais. Ela passou a ter ferramentas concretas para compartilhar, capazes de oferecer suporte naquele momento e guiá-los quando entravam em respostas de congelamento. Aprofundou sua capacidade de criar segurança para outras pessoas. “Falar com sinceridade sobre a minha caminhada aprofundou minhas conexões com os alunos”, observou. “Estamos todos aprendendo juntos.”

Esse é apenas o primeiro passo da sequência essencial. A jornada, na verdade, está só começando. Neste momento, nós nos tornamos menores para ficarmos seguros, mas não queremos continuar dessa forma. O próximo passo nos ajuda a fazer o trabalho de reparo, para então podermos expandir em direção a mais possibilidades e a um crescimento maior do que pensávamos ser possível. No próximo capítulo, vamos descobrir como explorar com sucesso o segundo passo: o suporte.

RESUMO

Quando aprendemos a reconhecer as mensagens do corpo sobre sua necessidade de segurança e exploramos um processo estruturado para atendê-la, ficamos aliviados ao saber que não estamos presos para sempre no estado atual. Entendemos como criar segurança interna pode seguir um processo estruturado e gerar resultados que parecem *mágicos* por meio de microdoses de segurança que passamos a gerar para nós mesmos.

Vimos também maneiras de estabilizar nossa biologia para ajudar no processo de encontrar nossa zona interna de segurança. Aprendemos que criar segurança deve ser uma prática diária, como quando aprendemos qualquer habilidade nova. Ainda assim, encontrar nossa zona de segurança é só o começo. Embora esse primeiro passo crie a base, precisamos de suporte para reparar verdadeiramente o impacto do trauma em nosso corpo. No próximo capítulo, vamos descobrir como Elena vivenciou o segundo passo da sequência essencial – o suporte –, assegurando seu crescimento e a expansão em sua rotina, sua saúde e seus relacionamentos.

CAPÍTULO 14

Suporte: alcançando a regulação por meio do reparo

É impressionante quantos problemas psicológicos envolvem dificuldades com sono, apetite, toque, digestão e libido. Qualquer tratamento eficaz para o trauma precisa abordar essas funções básicas de manutenção do corpo.

— Bessel van der Kolk, psiquiatra, autor de *O corpo guarda as marcas*

Elena fitava o pedido de demissão de um funcionário na mesa com o coração acelerado. Ela era diretora de operações de uma clínica de saúde mental que já tinha sido bem-sucedida, mas agora enfrentava uma crise. Nos últimos três meses, quatro dos dez terapeutas haviam tirado licença médica prolongada alegando burnout. Outros dois davam sinais de seguir pelo mesmo caminho. Pacientes reclamavam da qualidade das sessões e desmarcavam em cima da hora. A clínica estava perdendo rios de dinheiro, enquanto Elena lutava para mantê-la de pé.

Ela havia avançado durante as seis semanas em que trabalhamos juntas na Jornada Estruturante. O programa lhe dera habilidades para monitorar seu sistema nervoso e encontrar sua zona de segurança. Mas ela não conseguia manter a regulação, percebendo que ultrapassava seu limite crítico da sobrecarga várias vezes por semana por causa das pressões em casa e no trabalho. A névoa mental e a inflamação autoimune, combinadas à sobrecarga emocional, faziam com que ela não conseguisse pensar com clareza, tomar boas decisões ou estar presente para sua equipe de terapeutas. Eles inclusive apontaram a falta de apoio como um dos principais motivos do burnout.

Naquela noite, a orientadora escolar telefonou para falar sobre sua filha de 13 anos, Sofia. “Elena”, disse baixinho ao telefone, “Sofia veio conversar comigo hoje. Ela disse que tem tido ideação suicida, mas não se sente à vontade para falar com você sobre isso porque você tem estado distante e cansada nos últimos tempos.” A orientadora parou por aí, mas Elena ouviu a verdade não dita. Ela estava emocionalmente indisponível da mesma maneira que a própria mãe estivera. Isso aumentou sua motivação para continuar trabalhando na própria regulação por meio do próximo passo da sequência essencial: o suporte.

As palavras a machucaram profundamente, e qualquer ilusão de controle desapareceu. Ela se sentiu um fracasso como mãe. Elena reconheceu o impulso familiar e intenso de entrar no estado de apagão, como costumava fazer desde a infância. Mas outra parte dela não queria mais fazer isso. Suas filhas precisavam dela. A clínica precisava dela. Seu corpo precisava dela. E ela precisava de algo mais que apenas retornar à sua zona de segurança: precisava conseguir permanecer regulada.

Naquela noite, Elena escreveu em seu diário: “Não posso continuar desaparecendo e me diminuindo apenas para ficar segura. Sei que está na hora de mudar isso.” Com a segurança estabelecida, ela estava pronta para aprender como apoiar a capacidade inata de cura do corpo em todos os níveis: da energia celular à inflamação cerebral, dos padrões de apego ao trabalho com sua criança interior. Precisaria dominar as habilidades do Passo 2 da sequência essencial, o suporte, para manter a regulação e não perdê-la diante das pressões do trabalho e da família.

QUANDO A SEGURANÇA NÃO É SUFICIENTE

Ter a habilidade para encontrar nossa zona de segurança é vital, assim como parar um carro descontrolado. Mas, se quisermos uma vida melhor, o Passo 1 (estabilização) é apenas o começo. Não queremos ficar parados; queremos ajeitar o carro para a direção certa e retomar nosso trajeto. O Passo 2 da sequência essencial nos ajuda exatamente nisto: seguir rumo à vida mais plena que desejamos. As habilidades de segurança nos tiram da sobrecarga e do apagão crônico, mas, para manter esse progresso, precisamos dar suporte ao nosso corpo para que ele refaça seus passos do estresse até o estado

calmo-ativo, em vez de retornar ao apagão.

A Jornada Estruturante de Elena para estabelecer segurança interna foi desafiadora de um jeito diferente do que havia sido para Laura, que já possuía conexão com o corpo graças à ioga. Para Elena, o desafio era se conectar sem entrar em apagão. Inicialmente, ela precisou tornar as práticas mais curtas, lentas e compactas, como microdoses de segurança, até conseguir permanecer no presente.

Ao se manter constante e conseguir alcançar aos poucos o estado calmo-ativo, ela começou a ver mudanças. Sua energia melhorou, mas isso trouxe emoções que ela não gostava de sentir, especialmente raiva, já que agradar os outros era seu padrão automático. A segurança que ela havia criado era benéfica e abria espaço para a energia reprimida do estado de mobilização emergir. A raiva era desconfortável, mas evidenciava que seu sistema nervoso estava saindo do apagão crônico. Seu corpo estava refazendo o caminho de volta ao estado de mobilização e preparado para o suporte e o reparo mais profundo. Mas a incapacidade de tolerar a intensidade da raiva a empurrava de volta ao estado já familiar de apagão.

É aqui que o suporte, o segundo passo da sequência essencial, se torna crucial. O suporte serve para reparar o que está impedindo o sistema nervoso de retornar ao estado calmo-ativo como seu estado padrão. Para isso, o corpo precisa sair do loop corpo-trauma e receber dois tipos de suporte: completar as respostas de estresse e reparar a biologia que reduz nossa capacidade e nos mantém presos nesse ciclo.

Elena ainda não conseguia sustentar a demanda de alta energia do estado de mobilização. Embora já soubesse encontrar sua zona de segurança e sair do apagão, logo retornava a ele quando qualquer estresse a fazia ultrapassar o limite crítico da sobrecarga. Seu corpo permanecia preso no loop corpo-trauma, pois ela não era capaz de passar da mobilização para o estado calmo-ativo.

É possível que você reconheça sua própria versão desse padrão. Talvez seu corpo não vá tão rápido para o apagão, mas você note o ciclo de esforço excessivo seguido de colapso ou de estresse seguido de sobrecarga. É assim que sabemos que precisamos do Passo 2 para fortalecer nossa capacidade de ir da mobilização ao estado calmo-ativo, sem voltar ao apagão.

O modelo da Biologia do Trauma nos oferece um sistema de triagem para esse trabalho de reparo, ajudando a identificar e priorizar exatamente

do que o organismo precisa para quebrar esse loop. Vamos explorar como esse modelo guiou a jornada de Elena, que deixou de lutar com a sobrecarga frequente e se tornou capaz de construir uma regulação sustentável.

APLICANDO O MODELO DA BIOLOGIA DO TRAUMA

O modelo da Biologia do Trauma nos ajuda a identificar as razões específicas pelas quais a capacidade natural do corpo de retornar ao estado calmo-ativo está bloqueada. Quando aplicamos esse modelo, descobrimos uma verdade importante, embora, para muitos, surpreendente: nunca é uma coisa só nos impedindo de avançar. Vários níveis e sistemas biológicos estão envolvidos, cada qual funcionando como uma razão subjacente que reforça as outras.

O corpo humano foi feito para manter a saúde por meio de vários sistemas de backup. Esses sistemas funcionam com redundância de modo a garantir a sobrevivência mesmo quando algumas partes não estão funcionando perfeitamente. Por exemplo, ele pode produzir energia usando três fontes: açúcar, proteína e gordura. Quando um caminho falha, outros compensam. Várias proteínas podem eliminar toxinas. Quando um gene está comprometido, o sistema de redundância entra em ação para que outros mantenham a saúde. Também a neuroquímica possui diferentes neurotransmissores que se ajustam para manter o equilíbrio caso um deles falhe.

Essa redundância biológica nos diz algo fundamental: quando estamos presos em padrões de sobrevivência apesar desse mecanismo natural de retorno à saúde, deve haver vários bloqueios ao mesmo tempo. Para que o corpo permaneça preso em padrões traumáticos, diversos fatores subjacentes precisam impedir o retorno ao estado calmo-ativo. Portanto, não estamos buscando uma causa única e não existe uma solução mágica.

Vamos observar como o modelo nos ajuda a identificar e priorizar esses diversos fatores subjacentes para saber quais ferramentas de reparo usar e em que ordem.

Razões subjacentes

Com base em nossa compreensão de como o trauma nos afeta em vários níveis, conseguimos identificar razões subjacentes que mantêm nosso corpo preso em padrões de trauma. Cada uma representa um ponto de alavancagem no qual podemos aplicar ferramentas de reparo para criar mudanças duradouras.

No nível mental, nossos pensamentos e crenças são guiados por partes que carregam estratégias específicas de sobrevivência. Essas partes podem criar bloqueios internos: como uma parte que acredita que “ser visto é perigoso” e drena nossa energia em situações públicas, ou uma parte perfeccionista que nos leva sempre a buscar a aceitação, mas acaba sendo um gatilho para a vergonha e, por fim, o apagão.

Nosso corpo guarda memórias somáticas de respostas protetoras não concluídas, o que é outra categoria de razões subjacentes. Essas memórias implícitas se manifestam de forma diferente em cada pessoa, como a resposta de sobressalto exagerada de Laura, a tensão crônica de Dana e a resposta de congelamento de Alex. Cada uma delas reflete uma resposta ao trauma incompleta em busca de resolução. Até mesmo a fadiga crônica de Claire continha memórias somáticas que contribuíam para seus padrões persistentes de trauma.

Fatores biológicos constituem diversas razões subjacentes, desde comprometimento da energia celular até efeitos inflamatórios em cascata que sustentam padrões de sobrevivência no nível celular. Essas alterações fisiológicas criam bloqueios concretos à regulação que exigem estratégias específicas de reparo.

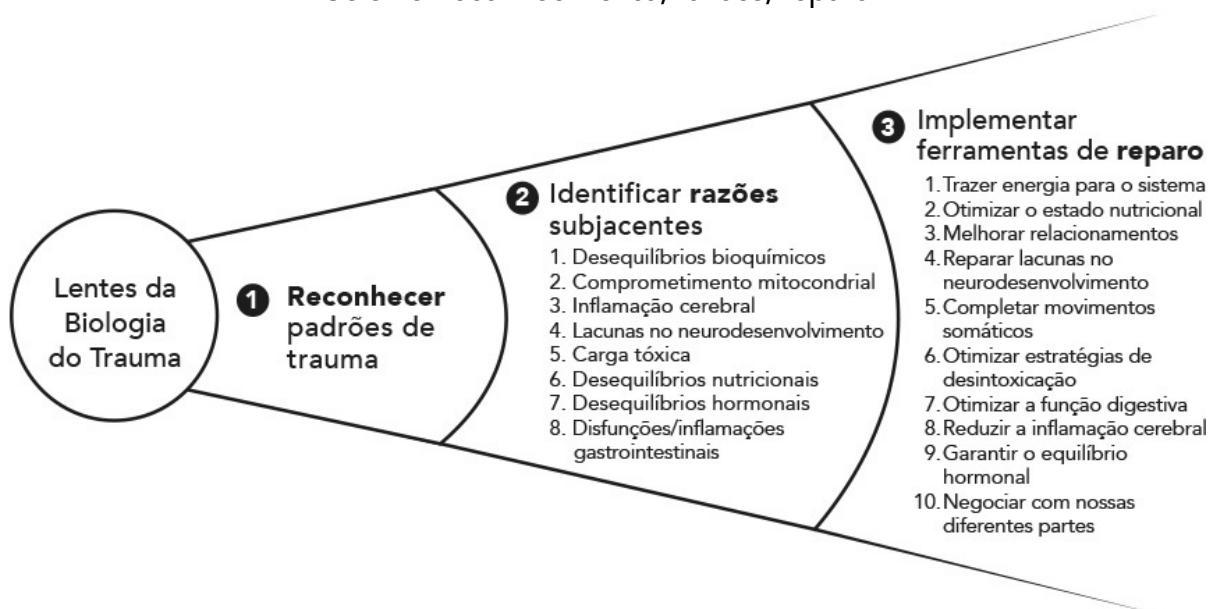
As feridas de apego formam outra categoria fundamental de razões subjacentes, sendo particularmente importantes por influenciarem nosso filtro interno. Essas lesões emocionais desenvolvidas na primeira infância constituem os fundamentos de nossa matriz neural, criando a percepção do que é seguro e do que é perigoso em relação a nós mesmos e aos outros. É o fio condutor que atravessa todos os níveis: mente, corpo, biologia e neurocepção.

Embora o modelo da Biologia do Trauma abranja todas essas categorias de razões subjacentes, vamos nos concentrar principalmente nos fatores biológicos, pois eles representam uma peça essencial que está ausente da

terapia de trauma atual. Outras modalidades abordam componentes mentais, somáticos e de apego, mas a parte biológica costuma ser negligenciada. Vamos explorar as categorias de razões biológicas subjacentes, entendendo que elas atuam em interação constante com todos os outros níveis.

As lentes do modelo da Biologia do Trauma

Os 3 Rs: reconhecimento, razões, reparo



Categorias de razões biológicas subjacentes

A inflamação cerebral, como resultado de micróglia hipersensíveis, torna-se um gatilho para o apagão por meio dos sinais de perigo, além de comprometer nossa energia e nossos neurotransmissores. A névoa mental e a incapacidade de tomar decisões, que resultam em esquecimentos e erros, podem disparar outros padrões de trauma, como autocrítica e vergonha. Tudo isso nos leva a cruzar o limite da sobrecarga com mais facilidade.

O comprometimento mitocondrial afeta nossa capacidade fundamental de sair tanto do apagão quanto da mobilização, tornando-se um dos principais influenciadores da desregulação contínua. Quando as mitocôndrias estão comprometidas, vivemos em um estado de esgotamento de energia constante, sempre próximos do limite crítico da sobrecarga, de

modo que até pequenos estresses podem exceder nossa capacidade.

A química cerebral é um fator crucial por causa do equilíbrio dos neurotransmissores. Esses mensageiros químicos (como a serotonina para o humor, a dopamina para a motivação e o GABA para a calma) afetam o modo como lidamos com o estresse e mantemos a estabilidade emocional. Quando estão em desequilíbrio, podemos ficar ansiosos, sentir desânimo ou ter problemas de concentração, o que torna mais difícil permanecer regulado sob pressão.

O sistema imunológico pode se tornar outra fonte de desregulação. Seja por um estado pró-inflamatório generalizado ou por condições específicas, como doença autoimune, os desequilíbrios imunológicos são sinais de perigo para nossa neurocepção.

O estresse oxidativo é como ferrugem se acumulando no corpo; ele acontece quando há moléculas prejudiciais (radicais livres) demais e antioxidantes de menos para limpá-las. Esse dano pode levar a mais inflamação, o que mantém o corpo em estado de estresse.

Três desequilíbrios bioquímicos fundamentais – problemas de metilação, excesso de cobre e pirrolúria – podem afetar profundamente nossa regulação. Essas condições, sejam herdadas ou desenvolvidas por causa do estresse, influenciam desde a maneira como nos desintoxicamos até como produzimos substâncias químicas cerebrais para o humor. A pirrolúria, por exemplo, cria um sistema nervoso hipersensível ao esgotar nutrientes cruciais para a calma e gerar excesso de estresse oxidativo, o que aumenta o esgotamento de energia e a suscetibilidade a doenças.

Nosso intestino merece atenção especial como razão subjacente porque, assim como o cérebro, ele tem uma linha direta com a neurocepção. Trata-se de uma via de mão dupla: a desregulação compromete a saúde intestinal, ao passo que o desequilíbrio intestinal envia sinais de perigo ao sistema nervoso. Seja por um intestino permeável e inflamação, parasitoses ou desequilíbrios bacterianos, a disfunção intestinal drena nossa energia, desorganiza nossa química cerebral e pode nos manter presos na alternância entre estresse e apagão.

Toxinas ambientais criam sobrecargas adicionais para nossa biologia. Da poluição do ar aos contaminantes na água, dos químicos dos plásticos aos pesticidas nos alimentos, essas toxinas exigem energia para serem processadas e eliminadas. Quando nossos sistemas de desintoxicação não

conseguem dar conta da demanda, as toxinas acumuladas nos aproximam ainda mais do limite crítico da sobrecarga.

Deficiências de nutrientes muitas vezes passam despercebidas como razões subjacentes para a desregulação. Estresse e trauma aumentam a necessidade de nutrientes como magnésio, zinco, vitaminas do complexo B e vitamina D. Sem níveis adequados, nossas células têm dificuldade para manter a produção de energia, e nosso sistema nervoso perde recursos necessários para permanecer calmo.

Por fim, ter uma das feridas de apego básicas, que surgem de experiências na primeira infância em que não nos sentimos constantemente apoiados ou seguros, pode nos deixar com a sensação de não sermos dignos, de não podermos ser amados ou com medo constante de abandono. Com o tempo, esses sentimentos moldam nossa forma de reagir ao estresse e de nos conectar com os outros, gerando padrões que são consolidados pela neuroplasticidade e se tornam difíceis de reprogramar.

Para Elena, as razões subjacentes criavam uma teia complexa que a mantinha presa em padrões de trauma apesar de todos os seus esforços. A inflamação cerebral decorrente do trauma no nascimento e do acidente de carro recente a tornavam hipersensível ao estresse. O comprometimento mitocondrial a deixava sem energia para manter a regulação. Desequilíbrios em sua química cerebral, com baixa atividade de serotonina, GABA e endorfina, faziam com que o equilíbrio emocional fosse quase impossível. Seu padrão de ativação global de alta intensidade, bem como a ferida de apego primária “Me acolha” que carregava desde cedo, se manifestavam como um retorno cíclico ao apagão. Sua doença autoimune, o estresse oxidativo, o desequilíbrio bioquímico da pirrolúria, o intestino permeável e as toxinas acumuladas dificultavam que seu corpo mantivesse a regulação.

Entender que existem múltiplas razões subjacentes para a desregulação nos ajuda a reformular nossa expectativa de encontrar uma única solução mágica que resolva tudo. **Em vez de tentar achar uma única “causa raiz”, podemos ver como nosso sistema precisa de suporte em diversas categorias e níveis.** Essa percepção pode parecer uma montanha impossível de se escalar. Mas não precisamos lidar com tudo de uma vez; podemos priorizar as razões subjacentes conforme o impacto que elas têm em nossa desregulação e a facilidade com que podem ser trabalhadas. Agindo dessa

forma, conseguimos saber quais ferramentas de reparo, e em que ordem, nos trarão mais benefícios.

Priorizando ferramentas de reparo biológico

A etapa final do modelo da Biologia do Trauma é determinar por onde começar. Precisamos identificar quais razões subjacentes estão bloqueando mais ativamente nossa regulação, enquanto consideramos quais reparos nos darão o maior retorno em relação ao investimento de energia.

Para Elena, três áreas surgiram como prioridades: inflamação cerebral, comprometimento mitocondrial e desequilíbrios de neurotransmissores. Esses não eram seus únicos problemas, mas criavam os sinais de perigo mais intensos para sua neurocepção e, ao mesmo tempo, eram relativamente fáceis de se trabalhar.

A inflamação cerebral se tornou prioridade máxima porque talvez crie o sinal de perigo mais forte para nossa neurocepção. Quando a inflamação envolve nossos neurônios, o corpo interpreta isso como uma ameaça inescapável à vida, disparando estados automáticos de apagão. O apagão pode ser consequência de hábitos que não associaríamos prontamente à inflamação cerebral (como comer alimentos ultraprocessados ou deixar a glicose cair rápido demais ou para níveis baixos demais), o que nos leva a atribuir esse estado erroneamente às pessoas ou às situações da vida.

A névoa mental de Elena surgia em ciclos que duravam vários dias, decorrente de micróglia sensibilizadas desde o nascimento. Sua experiência na UTI neonatal havia gerado o padrão de ativação global de alta intensidade, deixando seu sistema nervoso permanentemente sensível. A sobrecarga emocional ativava essas células em estado de priming, tornando impossível permanecer presente em situações desafiadoras e a obrigando a esperar dias até que a mente voltasse a clarear.

Seu comprometimento mitocondrial agravava o problema. Quando as células precisavam de mais energia para lidar com o estresse, elas simplesmente não conseguiam produzi-la. Nenhuma força de vontade poderia superar essa realidade biológica – suas células não tinham capacidade para manter a regulação sob pressão.

A terceira prioridade surgiu a partir da avaliação dos

neurotransmissores, que revelou baixa atividade de serotonina, GABA e endorfina. Isso não só causava oscilações de humor, como afetava todo o seu organismo. Os níveis baixos de serotonina prejudicavam a função intestinal, o GABA reduzido aumentava a tensão muscular e pouca endorfina a deixava mais sensível tanto à dor emocional quanto à dor física. Embora esses desequilíbrios não ativassem de modo direto respostas de trauma como a inflamação cerebral fazia, eram relativamente fáceis de tratar com ferramentas específicas de reparo, o que os tornava um bom ponto de partida.

FERRAMENTAS DE REPARO PARA DANOS NO NÍVEL CEREBRAL E MITOCONDRIAL

Vamos analisar em detalhe as três categorias de razões subjacentes e suas ferramentas de reparo.

Inflamação cerebral

Podemos reconhecer a inflamação cerebral como uma razão subjacente para nossos padrões de trauma persistentes entendendo tanto o que sensibiliza nossas micróglia quanto os sintomas de inflamação ativa. As micróglia chegam ao estado de priming por traumas físicos, como concussões ou traumatismos cervicais, falta de oxigênio durante o nascimento ou cirurgias, infecções do sistema nervoso e até inflamação intestinal. Intoxicação por metais pesados e choques elétricos também podem gerar esse efeito.

Vivenciamos a inflamação cerebral por meio de sintomas que surgem em ciclos de vários dias. Durante esses ciclos, podemos sentir que nosso cérebro está menos aguçado, de um jeito diferente de quando estamos apenas cansados. Luzes e sons podem se tornar irritantes, mesmo em ambientes que em geral não nos incomodariam. Encontrar palavras fica difícil e tomar decisões parece exaustivo. Muitas pessoas descrevem a sensação de que o cérebro “sai do ar”, sobretudo durante conversas importantes que exigem atenção sustentada. Estudos mostram que, se você tem sintomas de depressão, ansiedade ou TEPT, há uma chance de existir inflamação

cerebral. Até dores de cabeça, problemas de equilíbrio e reflexos lentos podem ser sinais de inflamação no cérebro.

Se você se identifica com esses sintomas ou percebe que eles pioram com o estresse ou, como no caso de Elena, após uma lesão na cabeça em um acidente, é provável que as células imunológicas do seu cérebro precisem de suporte. O cérebro e as micróglia respondem bem a ferramentas específicas de reparo, e, após uma ou duas semanas, já é possível notar uma diferença. O primeiro objetivo é diminuir a inflamação, ajudando as micróglia a retornarem ao seu “estado de repouso”. Em seguida, o foco passa a ser evitar que voltem a ser acionadas e inflamadas. Conseguimos isso por meio de nutrientes, sono e suporte energético, cientes de que precisamos fazer mais quando estamos tentando refrear uma inflamação já instalada do que quando estamos apenas tentando prevenir novos gatilhos.

Embora todo mundo saiba que o sono é importante, ele é essencial para curar a inflamação cerebral. O cérebro faz a maior parte da “faxina” inflamatória durante o sono, mas precisa das condições adequadas: um quarto fresco, completamente escuro e sem ruídos perturbadores. Mesmo pequenas quantidades de luz ou barulho podem impedir esse processo crucial de limpeza. Precisamos melhorar tanto a quantidade quanto a qualidade do sono, o que pode ser potencializado com cochilos no início da tarde. Cochilos no meio ou início da tarde fazem parte de um descanso sensorial que recarrega a energia do cérebro para o resto do dia. Mesmo que um cochilo completo não seja possível, o descanso sensorial pode ser feito encontrando um lugar silencioso, escurecendo o ambiente ou usando uma máscara nos olhos, deitando-se e eliminando ruídos. Muitas pessoas aproveitam esse momento para fazer terapia com luz vermelha em casa, aplicar calor na coluna para acalmar a cadeia simpática e a ansiedade ou usar um cobertor ponderado (com peso) para se sentirem mais ancoradas.

O suporte nutricional pode ajudar consideravelmente a diminuir a inflamação. Alguns dos principais nutrientes são a N-acetilcisteína, ou NAC, por suas propriedades anti-inflamatórias, e o magnésio L-treonato, que tem a particularidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Outros nutrientes de suporte incluem luteolina, GABA, resveratrol e cúrcuma – todos ajudam a manter as micróglia em seu estado de repouso.

Uma ferramenta simples mas poderosa é o reflexo oculocardíaco. Ao pressionar suavemente os olhos fechados, você ativa o nervo vago, o que

pode gerar uma sensação imediata de calma. Essa prática pode ser usada ao longo do dia para proporcionar descanso visual e evitar a sobrecarga antes que ela se agrave.

Se você tem névoa mental frequente ou se sente sobrecarregado por ruídos, luzes ou decisões do dia a dia, considere investigar a hipótese de inflamação cerebral. Caso saiba que teve um evento de priming, seja por lesão na cabeça ou outro motivo, é importante aprender a manter suas micróglia em repouso. Comece otimizando seu ambiente de sono e incorporando descansos sensoriais regulares e cochilos. Considere também o uso de suplementos enquanto monitora os sintomas para ver o que ajuda no seu caso.

Comprometimento mitocondrial

Podemos reconhecer o comprometimento mitocondrial como uma razão subjacente para a continuidade de nossos padrões de trauma quando entendemos o que causou esse comprometimento e aprendemos a identificar os sintomas de ineficiência energética. As mitocôndrias são comprometidas pelo apagão, por exposição a toxinas, por infecções virais e por deficiências de nutrientes. A má qualidade do sono, especialmente com ritmos circadianos desregulados, também pode impactar consideravelmente sua função.

Sentimos o comprometimento mitocondrial em vários sistemas, pois todas as células (exceto as hemácias) usam mitocôndrias para produzir energia. No cérebro, experimentamos fadiga mental, aquela sensação generalizada de peso que não vai embora. Podemos notar intolerância aos exercícios, quando já não conseguimos tolerar o mesmo nível de esforço físico de antes.

A boa notícia é que as mitocôndrias respondem bem ao suporte. É importante tanto melhorar nossa produção de energia quanto remover aquilo que a drena. Nutrientes são importantes, assim como fornecer uma quantidade estável de açúcar e oxigênio por meio do fluxo sanguíneo e garantir um sono de qualidade.

Para o suporte nutricional, nos concentramos em nutrientes que ajudam as mitocôndrias a produzir mais energia. A maioria das pessoas responde

bem a suplementos como ubiquinol, Coenzima Q10 e PQQ (quinona pirroloquinolina). As vitaminas do complexo B também nos ajudam a produzir mais energia, particularmente a B₁ e a B₂. O selênio protege as mitocôndrias contra danos e favorece o crescimento de novas mitocôndrias. O magnésio, particularmente em sua forma malato, ajuda a estabilizar o ATP produzido pelas mitocôndrias. O NAD⁺ (nicotinamida adenina dinucleotídio), uma das melhores ferramentas de longevidade, é um dos indutores da produção de energia mitocondrial mais poderosos e sua forma de utilização mais eficaz (embora com cautela) é por via intravenosa, sob orientação médica.

A terapia com luz vermelha é outro recurso potente pois estimula as mitocôndrias a produzir energia com mais eficiência, ao mesmo tempo que reduz o estresse oxidativo. O movimento, quando dosado de maneira adequada, ajuda a fortalecer a função mitocondrial, mas deve ser cuidadosamente equilibrado para evitar o esgotamento de um sistema já comprometido.

Se você descobriu que seu corpo entra em apagão com frequência, o comprometimento mitocondrial é uma importante razão subjacente. Um bom ponto de partida é uma combinação de magnésio malato e glicinato com alfacetoglutarato, além de outras combinações de suplementos como rodiola, ubiquinol, Coenzima Q10 e PQQ, e vitaminas B₁ e B₂. Considere procurar um profissional que possa aplicar NAD⁺ intravenoso se seu nível de energia estiver tão baixo que seja difícil até começar qualquer coisa. Recorra a um profissional da área da saúde capacitado para personalizar esse suporte.

Desequilíbrios de neurotransmissores

Podemos reconhecer desequilíbrios de neurotransmissores como uma razão subjacente para a continuidade de nossos padrões de trauma quando entendemos tanto aquilo que os abala quanto os sintomas que produzem. Os neurotransmissores entram em desequilíbrio por inflamação cerebral, disfunção intestinal, estados crônicos de estresse e flutuações na glicemia. Até mesmo certos desequilíbrios bioquímicos e má qualidade de sono afetam a produção e a função dessas substâncias.

Experimentamos desequilíbrios de neurotransmissores por meio de padrões distintos, dependendo de quais sistemas estão afetados. O desequilíbrio de serotonina surge como uma sensação de desânimo mesmo quando está tudo bem com a vida, o que costuma vir acompanhado de questões digestivas, já que o intestino produz a maior parte da nossa serotonina. A qualidade do sono piora e temos dificuldade em nos sentir satisfeitos ou gratos. Já a baixa atividade de GABA cria uma ansiedade constante, com pensamentos acelerados e tensão física difícil de aliviar. Quando a atividade de endorfina está reduzida, a dor emocional e física parece mais intensa, e muitas vezes recorremos à comida ou outros alívios rápidos para obter conforto.

Se você se identifica com qualquer um desses padrões ou nota reações de trauma persistentes apesar de já ter habilidades de segurança, é provável que sua química cerebral precise de suporte. Os neurotransmissores respondem rapidamente a esse ajuste. É importante melhorar sua produção e função atuais, ao mesmo tempo que trata os fatores que bloqueiam seu equilíbrio natural. Isso pode ser feito por meio de aminoácidos, nutrientes cofatores e mudanças no estilo de vida que apoiem seus ritmos naturais.

Para o suporte de neurotransmissores, começamos fornecendo os alicerces por meio de aminoácidos específicos. Para serotonina, podemos usar triptofano ou 5-HTP (privilegiando o 5-HTP se houver inflamação cerebral ativa). Suplementar o GABA ajuda a acalmar a ansiedade e a tensão, enquanto a tirosina dá suporte à dopamina para a motivação e o foco. Igualmente importantes são os cofatores necessários: vitamina B₆, magnésio e vitamina C ajudam a garantir que o corpo consiga usar esses alicerces de forma eficaz.

A exposição regular à luz solar, especialmente pela manhã, é crucial para a produção de serotonina. Uma glicemia estável por meio de refeições regulares ajuda a manter a função equilibrada dos neurotransmissores. Um sono de qualidade é essencial, já que o cérebro usa o sono profundo para reabastecer os estoques de neurotransmissores.

Se você sofre de ansiedade persistente, depressão ou sensibilidade emocional que parecem desproporcionais às situações, considere tratar um possível desequilíbrio de neurotransmissores. Comece estabilizando a glicemia, tomando sol pela manhã e estabelecendo padrões de sono

constantes, enquanto trabalha com um profissional da área da saúde capacitado para desenvolver um protocolo direcionado de aminoácidos. Embora o suporte aos neurotransmissores possa trazer alívio rápido, o equilíbrio duradouro exige tratar os fatores que criaram o desequilíbrio.

Personalização

Para Elena, implementar essas ferramentas de reparo gerou mudanças que a surpreenderam. Ela começou com o suporte para a inflamação cerebral usando suplementos como magnésio L-treonato, luteolina, huperzina A e 2.000mg de N-acetilcisteína por dia. Também passou a priorizar o sono, deixando o quarto completamente escuro e fresco à noite, fazendo um descanso sensorial no meio do dia e usando a prática somática do reflexo oculocardíaco. Em pouco tempo essas ações a ajudaram a permanecer presente em vez de entrar em apagação no trabalho.

O suporte ao seu desequilíbrio bioquímico, a pirrolúria, começou com a otimização da suplementação. Ela parou de usar o multivitamínico que não tinha dosagens eficazes de nutrientes e iniciou uma suplementação direcionada com zinco e vitamina B₆. Ciente do aumento de estresse oxidativo causado pela pirrolúria, acrescentou 1.000mg de vitamina C ao dia e antioxidantes ao tratamento.

Para sua ferida de apego “Me acolha”, originada na primeira infância, ela começou a realizar o exercício diário de engatinhar durante 5 minutos e movimentos no nível da ponte (no tronco encefálico) para reprogramar seu neurodesenvolvimento. Encontrou um envoltório ponderado (com peso) para o pescoço, cuja sensação de contenção ajudou a estabilizar seu padrão de ativação global de alta intensidade, tornando-a menos reativa. Passou a dormir com um cobertor ponderado, o que permitiu que seu sistema nervoso relaxasse ainda mais profundamente durante o sono, ajudando-a a acordar mais revigorada. Trabalhar com sua criança interior se tornou mais fácil conforme ela aprendia a conter as emoções que eram disparadas.

Com o tempo, ela passou a sentir que conseguia direcionar melhor seu sistema nervoso, em vez de ficar à mercê dele. Usou o recurso terapêutico da narrativa artística para dar desfechos a histórias específicas do passado, como seu nascimento, o acidente de carro e os episódios com o namorado

violento da mãe, coisas que antes não tinha regulação suficiente para processar. Ao se libertar dessas histórias, sentiu mais energia, como se mantê-las reprimidas houvesse lhe custado um enorme gasto energético.

Ela ainda precisava se esforçar para permanecer conectada ao próprio corpo, mas encontrou maneiras de apoiar o movimento corporal. Agora que entendia a relação do corpo com o estresse, podia agir para descarregar a adrenalina. Levou uma bola de ioga e uma esteira para o escritório e passou a fazer mais pausas para caminhar, tomando cuidado para não exagerar e ultrapassar sua capacidade.

O suporte mitocondrial tornou-se mais estruturado. Visitas semanais a uma clínica de medicina integrativa incluíam oxigenoterapia hiperbárica e terapia com luz vermelha. As mudanças alimentares foram abrangentes, eliminando glúten, laticínios, ovos e amêndoas. Mesmo sem sensibilidade ao glúten, ela entendeu seu impacto sobre a saúde intestinal e a autoimunidade. Aumentou o consumo de alimentos ricos em antioxidantes, como mirtilo e salmão, e passou a usar mais cúrcuma para apoiar o sistema imunológico e reduzir a inflamação cerebral. Para o suporte de neurotransmissores, manteve um formulário de avaliação em sua mesa, usando-o para orientar o horário de uso de GABA e DLPA (DL-fenilalanina) para endorfinas e 5-HTP para serotonina em vez de triptofano, sabendo que a inflamação cerebral afetaria sua conversão. Em poucas semanas, os ciclos de névoa mental encurtaram e sua capacidade de tomar decisões melhorou.

No trabalho, ela transformou o estúdio de ioga em um espaço multiuso, disponibilizando-o entre as aulas para sessões de apego e neurodesenvolvimento. Reestruturou o programa para pacientes, priorizando práticas somáticas e de diálogo mente-corpo antes de qualquer trabalho de processamento ou sessões em grupo. Apoiar sua equipe também se tornou prioridade: ela trocou os lanches industrializados do consultório por alimentos integrais ricos em proteína e estabeleceu períodos diários de 30 minutos de descanso sensorial para cada terapeuta.

Em casa, as descobertas continuaram. À medida que a energia e a presença de Elena melhoravam, ela conseguia garantir as conexões íntimas de que as filhas precisavam. Reparar seus relacionamentos, algo que ela tanto ansiava por fazer, finalmente se tornara possível. As filhas comentaram que sua “cara fechada” havia sumido, uma impressão que ela nem se dava

conta que transmitia. Também houve mudanças físicas: sua nova frequência cardíaca de repouso à noite passou a ser 45, em vez de 50. Ela passou a perceber quando sentia fome ao longo do dia, em vez de comer apenas porque “estava na hora”.

Outro ponto de inflexão surgiu durante um momento estressante no trabalho. Pela primeira vez, Elena não entrou automaticamente em apagação. Ainda sentiu que ele estava se aproximando, mas, dessa vez, pareceu quase uma escolha. Ficou entusiasmada com a mudança: as transformações estavam acontecendo internamente, sem que precisasse forçá-las. Sua equipe começou a notar a diferença, passando por sua sala de modo espontâneo, apenas por que queriam estar com ela.

Embora estivéssemos concentradas no suporte à inflamação cerebral, às mitocôndrias e aos neurotransmissores, outros fatores subjacentes de Elena ainda precisavam de atenção. Se não trabalhássemos seu sistema imunológico, os desequilíbrios bioquímicos, as toxinas e as deficiências de nutrientes, seu progresso acabaria estagnando. No próximo capítulo, veremos outros três fatores biológicos comuns que se tornam razões subjacentes para nos manter presos em nosso trauma, mesmo quando auxiliados por uma terapia.

RESUMO

Com o Passo 2 da sequência essencial, iniciamos o reparo crucial que libera a capacidade inata do corpo de encontrar o caminho de volta ao estado calmo-ativo e se abrir plenamente para a vida outra vez. É aqui que aprendemos a dar suporte para uma regulação sustentada e para a flexibilidade por meio da mudança de estado, indo além de apenas encontrar nossa zona de segurança.

A história de Elena revela três fatores biológicos centrais como razões subjacentes para a estagnação apesar de nossos esforços: a inflamação cerebral, que cria sinais constantes de perigo; o comprometimento mitocondrial, que nos deixa sem energia para a mudança; e desequilíbrios de neurotransmissores, que afetam nossa resiliência emocional. Esses fatores muitas vezes criam um bloqueio que a terapia não consegue vencer, nos impedindo de avançar mais porque nossa biologia não tem capacidade para

criar vias neurais. Por outro lado, essas razões subjacentes também podem nos ajudar a criar um amanhã melhor para nós mesmos.

Podemos agir de forma estratégica ao apoiar a reconfiguração do nosso sistema nervoso rumo à regulação. O modelo da Biologia do Trauma está disponível na página deste livro na internet (BiologyofTrauma.com/book). Lá também incluo os protocolos específicos que uso em mim mesma para inflamação cerebral e suporte mitocondrial [em inglês].

No próximo capítulo, veremos outros três motivos biológicos comuns que podem estar impedindo você de avançar. Usando como exemplo a história da fadiga crônica de Claire, analisaremos as razões subjacentes para desequilíbrios bioquímicos, carga tóxica e deficiências de nutrientes, bem como estratégias específicas para repará-los.

CAPÍTULO 15

A química interna da desregulação

O segredo da mudança é concentrar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo.

— Sócrates, filósofo grego

“**E** stá tudo bem, mãe. Pode descansar que eu te conto tudo quando voltar.” O coração de Claire se partiu ao ver a filha de 14 anos, Emma, ajeitar o edredom grosso em volta dos seus ombros. A manhã havia começado como tantas outras recentemente: o corpo pesado, a cabeça aérea, aquele cansaço profundo que nenhum tempo de descanso parecia aliviar. Mas hoje deveria ter sido diferente. Ela até tinha separado sua camiseta de torcedora na noite anterior, determinada a ver a filha mais velha competir em sua primeira seletiva de atletismo.

No entanto, lá estava ela, na cama, com mais um episódio de fadiga. Uma onda familiar de vergonha tomou conta de Claire quando Emma beijou-lhe a testa. “Eu cuido de você quando voltar”, acrescentou Emma com um sorriso que parecia maduro demais para seu rosto tão jovem. “O papai está esperando no carro. Tenho que ir.” Claire conseguiu assentir de leve, segurando as lágrimas até ouvir a porta da frente se fechar. Então elas caíram livremente, quentes e amargas, em uma mistura de frustração e vergonha. Ela odiava estar no estado de apagão.

A ironia não lhe escapava: antes uma “coelhinha da Duracell”, agora não conseguia sequer sair do quarto após um dia longo ou até uma sessão de terapia. A sessão do dia anterior a deixara novamente nesse estado familiar: sentindo-se pesada, confusa e esgotada, apesar de uma noite inteira de sono.

Sua estante estava cheia de certificados de cursos na área da saúde, e seu iPad, abarrotado de anotações sobre regulação do sistema nervoso. Mas tanto conhecimento não adiantava de nada.

Claire havia concluído a Jornada Estruturante comigo e aprendido tudo sobre encontrar sua zona de segurança. Quando limitava suas atividades, ela se sentia melhor, mas era fácil ultrapassar sua capacidade sem perceber, até que o corpo a avisava com um episódio de fadiga. Há mais de um ano que evitava intimidade sexual com o marido, Mark, com medo de desencadear outro episódio. O casamento sofria não apenas pela distância física, mas também pelo esforço financeiro gerado pelos cursos e pelas certificações que ela fazia.

O Passo 1 da sequência essencial levou mais tempo do que ela imaginava, exigindo que desacelerasse e fizesse a Jornada Estruturante duas vezes. Embora tivesse conseguido, ela não podia se apeguar para permanecer segura. Estava pronta para aprender como oferecer suporte ao corpo por meio de ferramentas específicas de reparo. Não suportava mais assistir ao seu casamento se deteriorar, perder momentos importantes do crescimento das filhas ou ver Emma assumir o papel de cuidadora.

Ao iniciar a fase de suporte, Claire descobriria vários fatores biológicos que mantinham seu corpo preso no ciclo entre estresse e apagão. Reparar os desequilíbrios bioquímicos, a sobrecarga de toxinas e as deficiências nutricionais faria com que o apagão deixasse de ser algo recorrente, permitindo que ela fosse a profissional, mãe e esposa que desejava ser.

QUANDO A MUDANÇA EXIGE ENERGIA

Sem energia não há mudança. Seja ao construir novas vias neurais, completar respostas de trauma armazenado ou reparar danos celulares, nosso corpo precisa de energia para a transformação. Isso cria um paradoxo desafiador quando o esgotamento se torna um de nossos principais padrões de trauma.

A experiência de Claire ilustra esse paradoxo com perfeição. “Eu continuava tentando, me esforçando”, compartilhou ela, “mas meu corpo entrava em apagão depois das sessões de terapia ou sempre que eu tentava ir além da minha zona de conforto.” Sem energia, ela não conseguia eliminar

toxinas do organismo nem fazer as mudanças que desejava desesperadamente em sua saúde e em seus relacionamentos.

Pode ser que você reconheça esse padrão em si mesmo. Talvez tenha se culpado por “falta de força de vontade” quando os insights da terapia não se converteram em mudanças duradouras. Ou talvez tenha sentido frustração quando seu corpo pareceu resistir às mudanças pelas quais você trabalhou tão arduamente. O que está acontecendo é algo mais fundamental: a mudança exige uma quantidade de energia que seu corpo pode não ter no momento.

A limitação energética afeta o modo como avançamos no processo de cura. Cada pessoa percorre a sequência essencial conforme a capacidade única do próprio corpo. No caso de Claire, o corpo comunicava seus limites por meio de episódios de fadiga. O corpo de Elena falava por meio de surtos autoimunes: dores articulares e manchas avermelhadas em forma de borboleta no rosto. O de Laura enviava sinais por meio de respostas de sobressalto mais intensas e desejo por alimentos que fornecem energia rápida. Nosso corpo geralmente comunica sua capacidade por meio dos mesmos sintomas e comportamentos associados ao trauma que nos levam a buscar mudança.

Se você percebe que continua esbarrando nos mesmos limites físicos, mentais ou emocionais, o esgotamento de energia pode ser um padrão primário a ser tratado. A solução não é continuar forçando a barra – não podemos sobrepujar a saúde celular por meio da força de vontade ou do conhecimento intelectual. Precisamos identificar o que está drenando nossa energia e, ao mesmo tempo, ajudar o corpo a produzir mais dela. Essas ações se tornam a base para mudanças duradouras.

Quando usamos o modelo para priorizar a fase de suporte de Claire, reparar seu esgotamento de energia tornou-se a prioridade máxima. Começamos identificando as razões subjacentes da sua condição, removendo o que sugava sua energia e ajudando seu corpo a gerar mais dela.

Já vimos algumas razões subjacentes e ferramentas de suporte para o esgotamento de energia no capítulo anterior. Agora, vamos analisar as três outras questões que precisavam ser priorizadas no caso de Claire: desequilíbrios bioquímicos, sobrecarga de toxinas e deficiências nutricionais.

DESEQUILÍBRIOS BIOQUÍMICOS: OS CONDUTORES OCULTOS DA DESREGULAÇÃO

A química do nosso corpo influencia profundamente nossa capacidade de regulação e mudança. Três desequilíbrios bioquímicos específicos – excesso de cobre, pirrolúria e problemas de metilação – criam barreiras invisíveis à cura que nenhuma psicoterapia consegue derrubar.

Para esses três desequilíbrios bioquímicos, recorro ao trabalho do Dr. William Walsh, ph.D., bioquímico e fundador do Walsh Research Institute. Seu trabalho original com Carl Pfeiffer, bioquímico nutricional e médico pesquisador, demonstrou uma prevalência maior desses desequilíbrios em pessoas com sintomas relacionados ao humor. Desde então, sua pesquisa tem feito descobertas significativas sobre o mecanismo por trás dos sintomas do transtorno bipolar, um problema de saúde mental caracterizado por oscilações extremas de humor. Ao estudar com o Dr. Walsh, comecei a notar a prevalência elevada desses desequilíbrios em meus pacientes com dependência química, naqueles presos em um loop corpo-trauma e naqueles com comportamentos mais intensos de reatividade de apego. Para minha surpresa, descobri que eu mesma tinha os três desequilíbrios. Isso se mostrou um achado comum entre os participantes de uma sessão de coaching de cura da Biologia do Trauma.

Claire soube que tinha excesso de cobre e um quadro de submetilação como razões subjacentes para seu bloqueio persistente. Essa descoberta, como ocorre com muitas outras pessoas, deu-lhe a oportunidade de aplicar ferramentas de reparo precisas a fim de alcançar as mudanças que até então pareciam fora do seu alcance. No caso de Elena, o desequilíbrio a reparar veio na forma da pirrolúria.

Vamos analisar cada desequilíbrio e aprender como saber se temos um deles, com base em características comuns que podem indicar a necessidade de exames laboratoriais.

Excesso de cobre

O cobre, embora essencial para a saúde, torna-se uma poderosa neurotoxina quando em excesso. Isso pode ocorrer de duas maneiras: por uma

proporção elevada de cobre em relação ao zinco no sangue ou por altos níveis de cobre “livre” circulando no organismo. O corpo possui mecanismos sofisticados para lidar com o cobre, incluindo proteínas que se ligam a ele e vias para eliminá-lo. Quando esses sistemas são comprometidos por estresse, deficiências nutricionais ou sobrecarga, o cobre pode se acumular em níveis tóxicos.

Os efeitos do excesso se espalham por todo o sistema, criando caos nos neurotransmissores e reduzindo a dopamina enquanto aumenta hormônios do estresse como noradrenalina e adrenalina. Essa mudança bioquímica cria um estado de mobilização interna constante – ansiedade, irritabilidade, reatividade emocional e exaustão tornam-se experiências diárias. Muitas pessoas com excesso de cobre percebem sinais específicos: zumbido nos ouvidos, sensibilidade a metais baratos ou etiquetas de roupas, dificuldade para dormir e infecções frequentes por comprometimento imunológico.

Para Claire, descobrir que tinha excesso de cobre trouxe revelações inesperadas sobre sua história familiar. A depressão pós-parto da mãe de repente fez sentido. Como mencionei no Capítulo 11, estudos mostram que mais de 95% das mães com depressão pós-parto apresentam níveis elevados de cobre. Claire tivera ansiedade pós-parto após as duas gestações, mas, como havia se manifestado como ansiedade e não depressão, ela nunca relacionou sua experiência à da mãe. E tinha desenvolvido a fadiga crônica após a segunda gravidez, quando mudanças hormonais normalmente aumentam os níveis de cobre.

“Sempre acompanhei meu ciclo menstrual porque sabia que ficaria mais irritada e com menos energia em certas semanas”, contou Claire ao seu grupo da Jornada Estruturante. “Mas eu não sabia que esse não era um sintoma normal da TPM e que indicava um desequilíbrio bioquímico mais profundo que eu poderia tratar.” Exames de sangue confirmaram suas suspeitas: sua proporção cobre-zinco era 1,5, acima da proporção ideal, inferior a 1,3, necessária para estabilidade emocional e regulação do sistema nervoso.

Tratar o excesso de cobre requer uma abordagem cuidadosa; se formos rápido demais, podemos piorar temporariamente os sintomas, assim como acontece quando trabalhamos questões emocionais com muita pressa. Claire começou com doses baixas de zinco, iniciando em 50mg por dia e

aumentando gradualmente até 125mg. Ela adicionou 200mg de vitamina B₆, divididos entre a forma regular e sua forma ativada, P5P. Ciente do estresse oxidativo causado pelo excesso de cobre, ela também incorporou antioxidantes ao tratamento.

Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrirem as origens da exposição ao cobre. Algumas mulheres descobrem que seu DIU de cobre está contribuindo para os sintomas. Outras percebem que seus utensílios de cozinha de cobre ou uma alimentação pobre em proteínas são parte do problema. Até mesmo infecções virais crônicas podem reduzir os níveis de zinco, o mineral que equilibra naturalmente o cobre.

Assim como ocorreu com Claire, não é incomum apresentar vários desequilíbrios bioquímicos ao mesmo tempo. Saber quais estão presentes determina as dosagens específicas que devemos receber e a maneira de auxiliarmos nossa bioquímica.

Pirrolúria

A pirrolúria é uma condição genética que afeta a forma como o nosso corpo decompõe o anel de ferro nas hemácias. Quando esses anéis não são degradados adequadamente, os fragmentos maiores arrastam consigo zinco e vitamina B₆ enquanto são filtrados pelos rins e eliminados na urina. Essa deficiência de zinco e vitamina B₆ torna o sistema nervoso mais sensível e reativo. No entanto, o impacto vai além. A pirrolúria cria um estresse oxidativo que reduz nossos níveis de energia e causa danos ao DNA, podendo levar a doenças. Além disso, ela desregula a química cerebral, resultando em níveis mais baixos de serotonina, dopamina e GABA. Esses efeitos se tornam mais significativos em períodos de estresse, e ter pirrolúria torna muito mais fácil ultrapassar nosso limite crítico da sobrecarga.

As características de pessoas com pirrolúria são previsíveis. Elas tendem a ser menos tolerantes ao estresse emocional e à sobrecarga sensorial causada por luzes, sons e até mesmo radiação e campos eletromagnéticos. Podem ser altamente sensíveis à energia dos outros e geralmente se sentem drenadas em ambientes com muita gente por conta do excesso de estímulos sensoriais. Características físicas comuns incluem mais suscetibilidade a

queimaduras solares e pouco apetite pela manhã. O estresse oxidativo da condição pode levar ao embranquecimento precoce dos cabelos, e pesquisas demonstraram forte associação entre pirrólúria e condições autoimunes.

Elena nunca pensara em avaliar sua bioquímica para explicar sua sensibilidade; ela simplesmente se identificava como uma pessoa empática e altamente sensível. No entanto, ao avaliar comigo esses traços característicos, tivemos grandes suspeitas de que ela poderia sofrer de pirrólúria, o que se confirmou com um exame de urina. Os níveis normais de pirróis na urina ficam abaixo dos 10mcg/dL: os dela eram 40. Quando começou a tomar 100mg de zinco e 100mg de vitamina B₆ diariamente, em uma semana ela notou que estava menos sensível. Para tratar o aumento do estresse oxidativo, ela incluiu de forma disciplinada antioxidantes em sua alimentação e em seu plano de suplementação.

Metilação

A metilação é um dos processos biológicos mais fundamentais do nosso corpo, atuando como um regulador-mestre de múltiplos sistemas. Atua em diversos processos, como desintoxicação, energia e humor. Também é uma forma de o corpo controlar a expressão gênica, adicionando ou removendo grupos com base nos genes que devem ser expressos. Nosso status de metilação é algo que herdamos, influenciado tanto por nossa herança ancestral quanto pelo estado nutricional materno durante a gestação. Pesquisas têm associado desequilíbrios na metilação a uma ampla gama de condições, incluindo depressão, ansiedade, TDA/TDAH, transtornos do espectro autista, esquizofrenia e várias doenças autoimunes. Esses desequilíbrios também podem afetar a saúde cardiovascular, o equilíbrio hormonal e a função cognitiva.

Não é surpresa que desequilíbrios na metilação se tornem um obstáculo à capacidade inata do corpo de completar respostas de estresse e trauma. Pesquisas mostram que, nas últimas décadas, tornou-se mais comum ter um quadro de submetilação, no qual há menos metilação do DNA como um todo. Essa condição cria um padrão reconhecível de traços relacionados aos efeitos desse desequilíbrio na biologia. As principais razões para os traços comuns da submetilação são a histamina e o glutamato. A histamina, um

sinal tanto para o sistema imunológico quanto para o cérebro, pode levar a alergias e sensibilidades digestivas, mas também a uma disposição interna voltada a realização, perfeccionismo e até tendências obsessivas e aditivas. O excesso de glutamato cria inquietação interna e aumenta a probabilidade de inflamação cerebral. Não é incomum haver menor atividade de dopamina e serotonina na submetilação; a ansiedade também vem acompanhada de atividades que geram adrenalina e uma depressão de fundo. Quando não se está ciente da submetilação, o quadro geral pode parecer confuso, pois essas pessoas geralmente dão a impressão de serem tranquilas e equilibradas, embora descrevam altos níveis de ansiedade interna.

Quando Claire e eu analisamos os sinais de submetilação, muitas peças de seu quebra-cabeça começaram a se encaixar. Ela sempre fora competitiva e perfeccionista. Vários indícios físicos apontavam para níveis elevados de histamina: era alérgica a gatos, intolerante a certos alimentos (como tomate e pimentão) e seu nariz escorria durante a prática de exercícios físicos. Ela até notava que seus olhos lacrimejavam mais que os de outras pessoas quando se expunha à luz do sol. Também tomava cloridrato de sertralina para ansiedade e depressão, o que é comum em pessoas com submetilação, já que geralmente apresentam níveis mais baixos de serotonina. Como esses traços coincidiam com sua experiência, decidimos testar seus níveis sanguíneos de histamina. Os resultados confirmaram a submetilação: seu nível era 120ng/mL, quase o dobro da faixa normal de 40-70ng/mL.

Para tratar a submetilação é preciso fornecer ao corpo grupos metil, o que pode ser realizado por meio do suplemento SAME (S-adenosil-L-metionina). Embora o SAME tenha demonstrado ser útil para distúrbios como depressão e dores, mudar o status de metilação leva tempo, normalmente um mês ou mais. Claire começou com uma dose diária de manutenção de 400mg de SAME.

Esses desequilíbrios, além de afetarem nosso humor, também criam barreiras reais à regulação. O excesso de cobre impacta nossa resposta ao estresse ao aumentar a adrenalina e o estresse oxidativo. A pirrolúria reduz os níveis de nutrientes essenciais para a produção de neurotransmissores e para a resiliência ao estresse. Os problemas de metilação afetam tudo, desde nossa produção de energia até a capacidade de processar emoções.

Esses fatores bioquímicos não contam toda a história, mas formam uma base crucial para interromper o esgotamento constante de energia. Agora,

vamos explorar como as toxinas constituem outro bloqueio à nossa jornada de cura e como podemos combatê-lo.

TOXINAS: O FARDIO OCULTO SOBRE A CURA

A presença de toxinas no corpo cria um dos obstáculos mais desafiadores para a cura do trauma. Assim como o trauma afeta nossa biologia, as toxinas afetam nossa capacidade de mudança de três maneiras fundamentais. Primeiro, elas danificam diretamente nossas usinas de energia celular, comprometendo a capacidade de produzir a energia necessária para a cura. Segundo, disparam sinais constantes de perigo para o sistema nervoso, mantendo-nos em modo de proteção. Terceiro, sobrecarregam os recursos do corpo, dificultando a manutenção da regulação mesmo quando estamos fazendo tudo “certo”.

Claire descobriu sua sobrecarga de toxinas quando uma suposta exposição anterior ao mofo surgiu nos exames atuais, além de níveis elevados de mercúrio provenientes de tratamentos odontológicos e de anos consumindo atum. Seu corpo não estava apenas cansado; estava ativamente gerenciando uma carga tóxica considerável enquanto **tentava** se curar do trauma. Como ocorre com muitas pessoas presas nesse ciclo, sua bioquímica tornava a situação mais desafiadora. O quadro de submetilação indicava que certas vias de desintoxicação não estavam funcionando plenamente, o que tornava mais difícil eliminar essas toxinas de forma natural.

A conexão entre toxinas e trauma cria um ciclo que se retroalimenta. O esgotamento de energia causado pelo trauma armazenado, acompanhado da desregulação do sistema imunológico e da alteração do fluxo de substâncias como a linfa, dificulta a eliminação de toxinas. Por sua vez, a presença de toxinas cria desregulação e esgotamento, tornando-nos mais suscetíveis às respostas de trauma. Conhecer os tipos de toxinas presentes no corpo nos ajuda a diminuir a exposição a elas e a entender quais ferramentas de reparo usar para ajudar o corpo a liberar essas toxinas, sejam elas físicas ou emocionais.

Infelizmente, em nosso mundo moderno, evitar toxinas é impossível. Do ar que respiramos aos alimentos que ingerimos, nosso corpo entra em contato com mais toxinas diariamente do que qualquer geração anterior.

Categorias de toxinas

No dia a dia, estamos em contato com inúmeras substâncias que podem se tornar tóxicas quando a capacidade do corpo de processá-las é excedida. Compreender as diferentes categorias de toxinas nos ajuda a reconhecer possíveis fontes de sobrecarga e seus efeitos sobre nossa capacidade de cura, para que possamos reduzi-las quando possível e ajudar o corpo a eliminar outras.

Metais pesados são um tipo de toxina e incluem mercúrio, flúor e chumbo. O mercúrio é diretamente tóxico para nossas mitocôndrias, reduzindo os níveis de antioxidantes cruciais que protegem contra o estresse oxidativo. Fontes comuns incluem amálgamas dentários, peixes e algumas vacinas. O chumbo afeta a função cognitiva e a produção de energia, sendo encontrado frequentemente em tintas antigas, solo contaminado e alguns sistemas domésticos de armazenamento de água. O arsênico, outro metal pesado comum, perturba a produção de energia celular e costuma estar presente em níveis baixos na água e no arroz, especialmente no arroz integral. O flúor, adicionado à água nos Estados Unidos desde 1945 [e no Brasil desde 1974], é uma neurotoxina, causando estresse oxidativo, inflamação e danos aos neurônios e à química cerebral. O cloro é um desinfetante que mata bactérias nocivas, mas também mata nossa microbiota intestinal, causando comprometimentos imunológicos, deficiências nutricionais e desequilíbrios de neurotransmissores.

Também podemos ser expostos a toxinas biológicas, sendo as mais comuns o mofo, a doença de Lyme transmitida por carrapatos e infecções virais como a covid-19. O mofo produz micotoxinas, compostos invisíveis que respiramos, reduzindo o fluxo sanguíneo para o lobo frontal e desencadeando inflamação generalizada por meio da ativação de mastócitos. Estudos mostram que exames de imagem do cérebro de pacientes com toxicidade por mofo podem ser praticamente indistinguíveis daqueles com esclerose múltipla, uma condição autoimune que ataca os neurônios. Infecções como a doença de Lyme e até infecções virais como a covid-19 geram sintomas graças às toxinas liberadas que nosso corpo é incapaz de superar e eliminar.

O motivo pelo qual muitas vezes não conseguimos vencer essas toxinas infecciosas é o fato de estarmos expostos a uma enorme quantidade delas

diariamente na vida moderna: poluição do ar, pesticidas nos alimentos, plásticos como BPA, ftalatos que desregulam hormônios e produtos que aplicamos na pele. Solventes e produtos comuns de limpeza geralmente contêm compostos neurotóxicos absorvidos pela respiração ou através da pele. São especialmente tóxicos os produtos de limpeza com amônia ou água sanitária, aromatizadores contendo ftalatos e itens de cuidados pessoais com parabenos – todos contribuem para nossa carga tóxica diária. Especialmente quando a capacidade de desintoxicação do nosso corpo já está comprometida pela desregulação, essa carga pode se tornar grande demais, adicionando um fardo tóxico ao nosso fardo traumático.

Talvez o mais prejudicial seja o que colocamos dentro do corpo por meio de alimentos tóxicos. Não são apenas os pesticidas em nossos vegetais; corantes alimentícios e xarope de milho rico em frutose são tóxicos, criando erros de leitura de DNA, perturbando o metabolismo e causando danos hepáticos que reduzem ainda mais a capacidade do corpo de eliminar toxinas. Ambos os ingredientes estão notadamente associados a alterações de humor e doenças, como câncer e DHEM.

O açúcar processado também é uma toxina para o sistema nervoso e o imunológico. Pesquisas mostram que ele ativa as micróglia, gerando inflamação cerebral, e desregula a química cerebral, tornando-nos viciados naquilo que nos prejudica. Quando em excesso, os açúcares se ligam às células imunológicas, tornando-as ineficazes. O álcool também é uma neurotoxina – mesmo o consumo moderado ativa inflamação cerebral e danifica mitocôndrias. Estudos demonstram que o álcool altera a barreira hematoencefálica, permitindo que mais toxinas alcancem nossos neurônios. Os estudos mais recentes indicam que não existe quantidade segura de álcool.

Para Claire, a noção da quantidade de toxinas às quais estava exposta diariamente, somadas às exposições anteriores, ajudou-a a entender por que estava estagnada no processo de cura do trauma. As toxinas a mantinham travada nos estados de desregulação e esgotamento, criando sinais constantes de perigo para sua neurocepção e prendendo-a em padrões de sobrevivência apesar de todo o seu esforço para melhorar.

Reconhecendo a sobrecarga de toxinas

Uma sobrecarga de toxinas muitas vezes se revela por meio de padrões, e não de sintomas isolados. Como as toxinas afetam vários sistemas – dos neurônios às mitocôndrias e células de gordura –, esses padrões podem parecer desconectados inicialmente. Ainda assim, compreendê-los nos ajuda a saber se há toxinas contribuindo para nossas respostas de trauma.

A toxicidade por mofo cria um dos padrões mais característicos por meio de seu efeito sobre os mastócitos e o cérebro, resultando em névoa mental, perda de memória e dificuldade de foco que podem variar conforme o nosso ambiente, até que se tornem crônicos. Dor nevralgica aleatória e inchaço articular em diferentes partes do corpo, junto com problemas recorrentes de sinusite, podem sugerir toxinas infecciosas de Lyme ou de mofo.

Problemas digestivos como inchaço, cólicas, diarreia ou prisão de ventre são comuns, e o impacto sobre o humor é quase universal. Quando ansiedade ou depressão parecem não ter uma causa evidente, ou serem mais intensos do que a situação justificaria, pode ser sinal de toxinas infecciosas, especialmente quando acompanhadas de esquecimento, coordenação motora ruim e episódios de exaustão após esforço físico ou emocional. Sensibilidades a produtos químicos muitas vezes indicam uma sobrecarga tóxica mais ampla. O que começa como sensibilidade a perfumes ou produtos de limpeza pode piorar e passar a incluir reações a alimentos, medicamentos ou campos eletromagnéticos. Essa reatividade aumentada se dá por conta da hiperativação dos mastócitos, que tentam nos proteger de supostas ameaças.

O desafio é que a ansiedade e a depressão, juntamente com problemas intestinais e sintomas físicos aleatórios, como dor nevralgica, espasmos ou inchaço articular, são comuns em pessoas com respostas de trauma persistentes. Pode parecer contraintuitivo associar esses sintomas às toxinas e não às próprias respostas de trauma. Como muitas toxinas são armazenadas em células de gordura, a piora dos sintomas após uma perda rápida de peso graças a alguma dieta restritiva é outra pista. A perda de peso despeja toxinas de volta na corrente sanguínea, o que causa estragos.

Claire reconheceu muitos desses padrões em si mesma, embora anteriormente os tivesse atribuído ao estresse ou à falta de autocuidado.

Entender como as toxinas afetavam sua biologia a levou a fazer mudanças estratégicas: eliminar o vinho que tomava toda noite, escolher alimentos orgânicos e criar um ambiente doméstico menos tóxico, com filtros de ar e produtos de limpeza naturais. Essas mudanças não eram apenas para ela; ela se sentiu fortalecida por saber que estava criando um ambiente mais saudável também para as filhas. Apenas reduzir a exposição a toxinas já melhorou sua capacidade, mas ainda seria preciso fazer mais, de maneira bastante controlada, considerando o grau de sobrecarga tóxica e de esgotamento que ela apresentava.

Reparo das vias de desintoxicação

Vemos a necessidade de uma sequência ordenada para a cura não apenas no trauma retido, mas também nas toxinas armazenadas, já que uma desintoxicação segura exige uma abordagem precisa. Claire aprendeu isso da maneira difícil quando decidiu fazer um jejum, tomando apenas sucos para perder peso depressa antes das festas de fim de ano. Sentiu-se tão mal que precisou parar. Supondo que o período festivo tinha sido o gatilho para o seu trauma, ela nem sequer imaginou que a culpa do mal-estar havia sido a perda de peso rápida, que colocara toxinas para circular de novo em seu sangue. Ela caiu em outro episódio de fadiga; seus tornozelos e pulsos ficaram inchados, e dores nevralgias começaram a surgir aleatoriamente por suas pernas. Apressar um processo de eliminação de toxinas pode sair pela culatra quando o corpo não tem recursos e canais abertos para se livrar delas.

A desintoxicação natural do corpo segue três fases distintas, e, quando aprendemos como agir ao longo dessas fases, podemos quebrar o ciclo trauma-toxinas. Assim como a sequência essencial começa pela segurança para evitar nos traumatizarmos novamente, a desintoxicação começa pelo fornecimento de recursos celulares e segurança para evitar a sobrecarga causada por protocolos de limpeza agressivos.

A primeira fase se concentra em abastecer nossas células com energia, o que inclui reduzir a exposição a toxinas mas também remover aquilo que drena energia e ajudar as mitocôndrias a produzirem mais dela. Para Claire, isso significaria tratar deficiências de nutrientes que bloqueavam vias de

desintoxicação. Assim como acontece ao encontrarmos a zona de segurança do sistema nervoso, essa fase cria um ambiente celular no qual se torna possível liberar o que nos faz mal.

Somente quando nossas células se sentem abastecidas passamos à segunda fase: abrir os canais de eliminação. As toxinas são eliminadas principalmente por meio do suor, da urina e das fezes. A prisão de ventre crônica de Claire fazia com que seu sistema pusesse as toxinas novamente em circulação. Ela preferia tomar café em vez de água, então ficava desidratada, o que reduzia a eliminação de toxinas. Como não conseguia mais se exercitar como antes, ela não se lembrava da última vez que havia suado, o que também impedia a saída de toxinas do organismo. Abrir esses canais, garantindo evacuações regulares, hidratação adequada e sudorese, enquanto se melhora o fluxo linfático e a circulação sanguínea, criaria vias livres para o corpo liberar toxinas.

Somente na terceira fase é que trabalhamos na remoção ativa de toxinas. Como ao limpar a casa depois que uma panela pegou fogo no fogão, devemos abrir portas e janelas primeiro, para depois fazer uma limpeza profunda nas superfícies, o que libera ainda mais toxinas no ar. Nessa fase, utilizamos agentes ligantes ativos, como a clorela, o carvão ativado e outros compostos capazes de se ligar às toxinas e promover sua eliminação de forma mais intensa. Isso só é feito após termos fortalecido o organismo e aberto adequadamente as vias de excreção, de modo a evitar que o processo gere ainda mais esgotamento e desregulação.

Claire aprendeu a reconhecer quando seu corpo estava pronto para uma desintoxicação mais ativa monitorando sua energia, digestão e estabilidade emocional. Começar com ligantes suaves, como a clorela, enquanto mantinha seu suporte de base permitiu um progresso sustentável sem sobrecarregar o sistema. À medida que Claire estabelecia essa base, sua energia se tornou mais estável; seu pensamento, mais claro e o sistema nervoso, mais regulado. Isso criou um ciclo positivo em que uma regulação melhor favorecia uma desintoxicação melhor, que por sua vez resultava em ainda mais regulação, derrubando pouco a pouco a barreira que as toxinas haviam imposto ao seu processo de cura.

Sem saber quais deficiências de nutrientes reparar para apoiar seu corpo, ela teria continuado presa no ciclo trauma-toxinas, incapaz de concluir com sucesso as fases 2 e 3 de uma desintoxicação segura.

Deficiências nutricionais

Não consigo pensar em uma só pessoa que tenha vindo trabalhar seu trauma comigo e que não tivesse ao menos algumas deficiências de nutrientes. Nosso corpo consome muitos nutrientes para gerar respostas de estresse, e o estado de apagação afeta nossa capacidade de absorvê-los e utilizá-los. Ao ficar preso alternando entre estresse e sobrecarga, o corpo se torna cada vez mais pobre em nutrientes essenciais, o que envia sinais de perigo à neurocepção. Apoiar nossa resposta de estresse ao reparar deficiências de nutrientes é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para ajudar nosso trabalho interno com o trauma.

Muitas possíveis deficiências de nutrientes podem ser identificadas com testes funcionais, como exames de micronutrientes que mostram níveis intracelulares e não apenas sanguíneos. Porém, mesmo sem testes, já podemos começar a reparar os recursos celulares. Por exemplo, sabemos que o magnésio se esgota quando estamos sob estresse e sobrecarga há muito tempo. A vitamina C, as vitaminas do complexo B, o selênio e até ácidos graxos essenciais, necessários para a função cerebral e regulação da inflamação, também costumam estar reduzidos em estados de estresse e sobrecarga.

Claire começou com um suporte básico de magnésio, vitamina C, ômega-3, vitamina B₆ e tiamina até conseguir realizar exames laboratoriais. Quando o médico habitual de Claire solicitou exames básicos, tudo veio “normal”. Foi só quando fez um teste de micronutrientes que ela descobriu deficiências significativas em vitamina B₃, colina, coenzima Q10 e selênio. Quando viu os resultados, tudo fez sentido. Níveis baixos de selênio afetam o hormônio da tireoide, contribuindo para a fadiga, o ganho de peso e a sensação de frio – todos sintomas que ela vinha apresentando. A deficiência de vitamina B₃ contribui para fadiga e fraqueza; a de coenzima Q10, também para fadiga; e a de colina, para a estabilidade da membrana celular e problemas de memória.

LIBERAR ESPAÇO PARA A ALEGRIA

As toxinas não são apenas físicas, como os microplásticos nos alimentos, ou biológicas, como as toxinas provenientes do mofo. Para a desintoxicação fisiológica do corpo, precisamos olhar para os relacionamentos em nossa vida e para as crenças sobre nós mesmos que também podem ser tóxicos. Sejam substâncias químicas, relacionamentos nocivos ou excesso de autocrítica, precisamos nos libertar desses padrões para poder substituí-los por alegria e autenticidade.

Todos sabemos como pode ser difícil nos libertar de relacionamentos e até mesmo de hábitos de autocrítica, mesmo quando sabemos que são tóxicos. Seria muito bom se pudéssemos tomar um suco detox e, com isso, nos livrar do relacionamento tóxico com nossa família de origem, com amigos que reforçam nossos hábitos negativos e com a crença tóxica de que não somos bons o bastante.

O motivo para nos agarrarmos a algo tóxico é haver algum benefício nisso para nós. Permanecemos em relacionamentos tóxicos porque nos perguntamos: “O que seria de mim se eu não tivesse essas pessoas?” Ficamos agarrados a lembranças do passado que hoje são tóxicas para nosso crescimento porque elas nos permitem não estar completamente presentes na vida atual. Mantemos nosso crítico interno tóxico porque ele nos lembra que devemos “nos diminuir para ficar seguros”, ou porque preferimos nos atacar antes de ouvir isso de outra pessoa. A esposa agredida que continua no relacionamento pode estar fazendo o que lhe parece melhor para sua sobrevivência, levando em conta a energia e os recursos que tem.

Ao trabalhar para eliminar toxinas, devemos integrar as práticas somáticas de autocuidado e o diálogo mente-corpo que apoiem esse processo em todos os níveis necessários para a cura. Sem a integração entre mente, corpo e biologia, nossa capacidade de nos libertar é muito limitada.

Claire trabalhou comigo para aprender práticas somáticas específicas capazes de criar experiências internas que respeitassem o ritmo de liberação do seu corpo. Começando pelo coração e pelo intestino, ela aprendeu a criar um senso de segurança e suporte para o ato de liberação, em vez de forçar o processo. Práticas simples, como colocar as mãos em cima e ao lado do coração, ajudavam a relaxar seu corpo. Concentrar-se nos ombros e no quadril, áreas que frequentemente tensionamos quando não queremos

largar algo, permitiu que seu corpo iniciasse o processo de liberação.

No entanto, práticas somáticas sozinhas não bastavam. Ela passou a identificar partes de si mesma que tinham pavor da ideia de se libertar, convencidas de que reter padrões nocivos era o que a mantinha segura. “Descobri que havia uma parte infantil de mim que acreditava que manter esses padrões era o único jeito de sobreviver e não me machucar novamente”, contou Claire. “E outra parte que tinha certeza de que me libertar significaria perder o controle e ficar sem nada.” Trabalhar essas partes exigiu paciência e compreensão, até ela conseguir enxergar que era possível fazer isso de forma gradual e segura.

Claire percebeu como seu trabalho terapêutico para se libertar de relacionamentos e discursos internos tóxicos estava ligado aos episódios de fadiga. Na primeira vez em que o trabalho somático e de diálogo mente-corpo em torno da libertação de padrões tóxicos desencadeou um episódio de fadiga, ela achou que fosse coincidência. Mas, à medida que trabalhava metodicamente na desintoxicação, percebeu que sua capacidade de suportar sensações e emoções desconfortáveis aumentava e que podia fazer mais com as memórias implícitas do corpo e com as partes de si que também precisavam de apoio para se libertarem.

Essa integração em três vias criou um caminho de cura para Claire que anos de aprendizado teórico e participação em cursos não haviam possibilitado. As práticas somáticas forneceram o aspecto físico da libertação. O diálogo mente-corpo abordou a sabedoria emocional de se manter agarrada ao que era conhecido. O suporte biológico garantiu energia e recursos suficientes para a transformação. Cada elemento apoiou os outros dois, criando um movimento de libertação que respeita as necessidades do corpo de ir tão devagar quanto for preciso, ao mesmo tempo que abre espaço para a alegria e a autenticidade.

Para Claire, isso bastou para que seu corpo saísse da fadiga crônica ao longo dos 12 meses seguintes, integrasse o que ela vinha fazendo e lhe permitisse estabelecer relacionamentos saudáveis com as pessoas ao seu redor. Para Sarah, não foi suficiente; no seu caso, a insegurança de apego e seu sistema imunológico haviam programado padrões que exigiriam reparos específicos. Como ela poderia reprogramar o apego definido na primeira infância e seu sistema imunológico? Isso era algo que teria que descobrir para mudar seus padrões de trauma e evitar doenças associadas. O

próximo capítulo explora como nosso apego e nosso sistema imunológico nos mantêm presos a programações antigas, criando outra camada que precisa ser trabalhada para uma transformação duradoura.

RESUMO

Desequilíbrios bioquímicos, toxinas e deficiências de nutrientes criam barreiras na nossa jornada de cura, e elas permanecem invisíveis até sabermos como reconhecê-las. Cada uma dessas categorias contribui para o nosso filtro preexistente, tornando-nos mais suscetíveis a uma resposta ao trauma quando o estresse chega. Quanto mais tempo permanecemos em um loop corpo-trauma, mais nosso filtro preexistente atrai desequilíbrios, toxinas e deficiências. Isso explica por que muitas pessoas são expostas diariamente a toxinas e infecções, mas nem todas desenvolvem condições crônicas e síndromes por isso. É quando nosso filtro preexistente já está comprometido por um sistema nervoso desregulado que ficamos mais suscetíveis a uma condição crônica provocada por essas exposições.

Para quem deseja reparar sua biologia do trauma, examinar níveis de nutrientes, desequilíbrios bioquímicos e toxinas pode ser uma ferramenta útil. Quando reparamos de forma intencional os bloqueios que encontramos, começamos a mudar nosso filtro interno.

Para Claire, avaliar, examinar e reparar desequilíbrios, deficiências e toxinas mudou totalmente seu quadro de fadiga e apagão. No entanto, para algumas pessoas isso ainda não será suficiente, como foi o caso de Sarah, que veremos no próximo capítulo.

CAPÍTULO 16

Reparando a programação de medo da primeira infância

Nossos pensamentos são controlados principalmente pelo subconsciente, que em grande parte se forma antes dos 6 anos. Não é possível mudar a mente subconsciente apenas com a força do pensamento. É por isso que o poder do pensamento positivo não funciona para a maioria das pessoas. A mente subconsciente é como um toca-fitas. Enquanto você não trocar a fita, nada vai mudar.

— Bruce Lipton, ph.D., biólogo celular

Quando Sarah entrou com o carro na garagem de casa, não pôde mais segurar as lágrimas que vinham se acumulando o dia inteiro. Dominada por uma raiva inexplicável que ela era simplesmente incapaz de afastar, tinha saído mais cedo do plantão na UTI para colocar a cabeça no lugar. Mas, agora que estava em casa, não conseguia se forçar a entrar. Não queria que o marido a visse naquele estado. Aquelas lágrimas eram diferentes das que já havia derramado antes: não expressavam tristeza, mas sim uma raiva e um ressentimento que pareciam não ter limites.

Sarah sempre foi do tipo que priorizava a felicidade dos outros em detrimento das próprias necessidades. Isso havia se tornado tão habitual que ela mal conseguia reconhecer que suas necessidades não estavam sendo atendidas. Mas, agora que tinha feito o trabalho para encontrar sua zona de segurança, estava começando a sentir todas as emoções reprimidas por tantos anos. Ela nunca se sentira à vontade com a raiva; a simples ideia de o marido vê-la daquele jeito criava uma vontade quase insuportável de se esconder.

Nos meses seguintes à morte da mãe, lembranças, medos e emoções que ela nem sabia que existiam estavam vindo à tona, e ela buscava consolo – ou pelo menos distração – no trabalho. Manter-se ocupada funcionava até certo ponto, mas, no momento em que ficava quieta, tudo voltava como uma enxurrada. O perfeccionismo que mantivera tudo “nos conformes” por tanto tempo agora começava a parecer uma prisão. Ela sabia que precisava criar padrões novos, mas abrir mão dos antigos ainda era extremamente desconfortável.

Na sessão de terapia na semana anterior, Sarah tinha, mais uma vez, defendido as críticas constantes e a necessidade de atenção da mãe. Quando percebeu o padrão familiar em que estava caindo, sentiu raiva de si mesma primeiro e, em seguida, da mãe, por ter causado tanto estrago em sua psique.

Parecia que o corpo dela também estava desmoronando. No trabalho, naquele dia, enquanto ajudava uma colega a transferir um paciente para outro quarto, percebeu uma dor incomum nas pernas. Ao puxar o paciente em sua direção sobre o leito, sentiu linfonodos inchados nas axilas. Quando foi conferir o inchaço no banheiro, notou uma vermelhidão no peito. A princípio, ficou surpresa. Esses sintomas não surgiam desde que tivera uma infecção pelo vírus Epstein-Barr na faculdade. Depois se lembrou de que um vírus pode ficar adormecido nas células e ser reativado décadas depois por “estresse”.

Agora que o corpo tinha chamado sua atenção, Sarah refletiu sobre outras coisas que haviam mudado em sua condição física recentemente. Ela vinha apresentando mais sensibilidade aos produtos de limpeza que usava nos leitos da UTI, acordando com inchaço sob os olhos quase todas as manhãs e sentindo ansiedade e dor de cabeça depois de comer.

O que Sarah estava começando a descobrir, à medida que avançava da segurança (Passo 1) para o suporte (Passo 2) na sequência essencial, era quanto sua raiva, sua ansiedade e seus sintomas atuais eram expressões de uma programação definida na primeira infância. Seus padrões de apego, formados ao longo de milhares de experiências iniciais com a mãe, haviam criado uma “fita” que tocava em seu sistema nervoso dizendo: “Conexão é demais, é sufocante.” Ao mesmo tempo, seu sistema imunológico, intimamente conectado ao sistema nervoso, havia absorvido e se adaptado ao medo e à sobrecarga daquelas experiências iniciais. Agora, isso se

manifestava como inflamação, hipersensibilidade e a reativação de um vírus adormecido.

Com um estado preexistente comprometido, não era de admirar que ela estivesse desmoronando, especialmente com tantas emoções vindo à tona. Estas disparavam cada uma das crenças de sobrevivência dentro dela, que lhe mandavam continuar calada, invisível e apenas a serviço dos outros. Ela ainda sentia a vergonha das humilhações públicas da mãe e queria continuar invisível. Encontrar uma segurança básica tinha sido essencial para Sarah, como é para todos, mas, para criar a mudança que realmente desejava, ela precisaria seguir para o Passo 2 e dar suporte à capacidade inata do corpo de reparar a programação inicial gravada em suas feridas de apego e em seus desequilíbrios imunológicos.

Também seriam necessárias ferramentas de reparo específicas para reescrever os programas que estavam rodando dentro dela havia décadas. À medida que aprendia os conceitos que veremos neste capítulo, toda a abordagem de Sarah começou a mudar. Ela também encontrou uma nova motivação ao descobrir que esses sistemas *podiam* ser reparados, o que lhe deu, pela primeira vez em muito tempo, esperança de que sua vida, sua saúde e seus relacionamentos poderiam ser diferentes.

QUANDO A SEGURANÇA ABRE ESPAÇO PARA A RAIVA REPRIMIDA

A jornada de Sarah pelo Passo 1 da sequência essencial levou seu sistema nervoso, de forma bastante previsível, a sair do apagão para o estado de mobilização. Mas isso também criou um paradoxo inesperado para ela – ao usar as novas habilidades para criar segurança interna, ela *também* abriu a porta para algo que passara a vida inteira evitando: a raiva.

Antes de aprender essas habilidades, Sarah encontrava uma sensação de segurança na ocupação constante, no perfeccionismo e em permanecer invisível – estratégias que desenvolveu para sobreviver à infância. Voltar a raiva contra si mesma, em vez de contra a mãe, foi a maneira mais adaptativa de evitar comprometer esse vínculo de apego com a figura materna, um relacionamento fundamental para sua sobrevivência.

Isso lhe soa familiar? Talvez você também tenha encontrado segurança

em estar sempre ocupado, tentando fazer tudo perfeitamente ou ficando invisível. Esses padrões costumam surgir quando aprendemos, muito cedo, que expressar nossas necessidades autênticas, sobretudo a raiva, parece ameaçar relacionamentos importantes. Porém, conforme criamos uma segurança interna verdadeira, nosso sistema emerge de um estado crônico de apagão e entra em mobilização simpática, em que conseguimos sentir toda a ansiedade e a raiva que antes estavam anestesiadas.

Para Sarah, a ansiedade não a incomodava tanto, pois ela sempre convivera com uma tensão interna. Consequia dar conta de tudo usando suas estratégias de enfrentamento habituais: se ocupar o tempo todo e buscar a perfeição. Mas e quanto à raiva? Só de pensar em expressar raiva para alguém, o corpo dela disparava uma resposta instintiva de trauma. Do mesmo modo que aprendeu na infância a reprimir suas necessidades para manter a conexão com a mãe, seu sistema adulto ainda escolhia o apagão em vez de qualquer coisa que se aproximasse dessa expressão.

As mudanças foram acontecendo de maneiras sutis: primeiro, ela começou a conseguir expressar raiva, mas depois reagia e recuava instintivamente para padrões antigos. Por exemplo, reclamava com uma colega sobre a mãe e sobre como, quando ligava para ela ou a visitava, tudo girava em torno dela e nunca de Sarah. “Ela não consegue ver que eu também tenho necessidades?”, dizia. Mas, quando a colega sugeria que talvez a mãe fosse narcisista, Sarah a defendia com veemência.

O corpo dela conhecia bem o roteiro: culpe a si mesma, diminua-se, mantenha a conexão a qualquer custo. O que Sarah estava descobrindo, com o surgimento desses novos sintomas físicos, era que essa programação inicial não era apenas psicológica; ela também estava codificada em sua biologia, mais especificamente em seu sistema imunológico. O mesmo padrão de suprimir o eu autêntico para manter o apego criara um padrão paralelo em seu sistema imunológico. A reativação do vírus Epstein-Barr e um novo diagnóstico de síndrome de ativação mastocitária eram expressões do desequilíbrio imunológico programado em sua primeira infância, disparado por aqueles medos iniciais.

Sarah não é exceção; a experiência dela é bastante comum. Há uma grande quantidade de pesquisas demonstrando a conexão entre traços de personalidade e função imunológica. O perfeccionismo, por exemplo, tem sido associado a doenças inflamatórias crônicas, como colite ulcerativa ou

doença de Crohn. Pessoas que se sentem solitárias apresentam função imunológica pior e maior probabilidade de desenvolver síndrome metabólica, uma condição com estado pró-inflamatório, e diabetes tipo 2. Experiências adversas na infância levam à inflamação crônica, que já sabemos predispor a diversos problemas de saúde, incluindo distúrbios metabólicos, cardiopatias, transtornos mentais e maior risco de mortalidade por todas as causas. O perfeccionismo, a necessidade de agradar os outros e uma tendência a suprimir ou até reprimir inconscientemente emoções por meio da dissociação são sintomas de uma programação precoce que se enraizou profundamente em nossos sistemas nervoso e imunológico e na epigenética.

Assim, os mesmos mecanismos que ajudaram Sarah a sobreviver às feridas de apego também criaram um modelo biológico para inflamação, reativação viral e sensibilidade imunológica elevada. Mas a programação precoce se manifesta de formas diferentes em pessoas diferentes, dependendo de suas adaptações específicas. Os mecanismos de sobrevivência de apego de Elena vieram acompanhados de um diagnóstico de lúpus, uma doença autoimune, na vida adulta. Laura desenvolveu inflamação crônica no cérebro. Alex apresentou síndrome metabólica. Claire manifestou uma inflamação crônica de baixo grau associada à fadiga crônica.

Embora tomar consciência desses padrões fosse importante, Sarah descobriu que não conseguia mudá-los apenas com as habilidades que tinha para criar segurança interna. Programações de sobrevivência profundamente enraizadas não podem ser curadas apenas por nos conscientizarmos delas. Se não passarmos pelas etapas adequadas de reparo e suporte, as questões de apego continuarão sendo acionadas por tudo em nossa vida que possa comprometer nossa conexão com nós mesmos ou com os outros.

Precisamos de habilidades adicionais para apoiar um processo de reparo abrangente dentro do corpo, indo além da reposição de nutrientes e das mudanças alimentares. Devemos aprender habilidades para completar, e não interromper, as respostas de estresse que surgem com a raiva, saber como descarregar o excesso de adrenalina que circula no sangue e, mais importante ainda, redesenhar o padrão tanto da impotência aprendida quanto de nossas feridas de apego específicas. Esse trabalho exigirá novas

experiências em todos os níveis, desde movimentos do neurodesenvolvimento até a reprogramação do sistema imunológico no nível celular.

Talvez você sinta certa apreensão ao se deparar com a profundidade dessas questões e com o que significa mudar padrões tão arraigados. Ou talvez esteja sentindo certo alívio por entender que seus sintomas físicos e padrões de relacionamento fazem sentido à luz da sua história. Ambas as reações são completamente normais e válidas. Uma das coisas mais incríveis sobre nosso sistema nervoso e nosso corpo é a forma como eles continuam a se adaptar a novos ambientes e experiências, não importa a idade. É possível reparar nossa programação de apego. Vamos ver agora como foi essa experiência para Sarah.

REPARO DO APEGO: RECONFIGURANDO NOSSA PROGRAMAÇÃO CENTRAL

Quando começamos a reparar o nosso apego, precisamos encarar uma verdade importante: não temos como voltar atrás e mudar o que aconteceu, mas podemos criar um ambiente interno que satisfaça as necessidades que temos hoje e que ficaram anos, às vezes décadas, à espera de serem atendidas. É fácil cair na armadilha de acreditar que vamos reparar nosso apego ao encontrar o parceiro perfeito ou o terapeuta perfeito. Mas nada externo vai reescrever nossa programação por nós. Precisamos aprender a criar esse reparo dentro de nós mesmos.

Isso não significa escolher autossuficiência em vez de conexão; significa construir uma base interna que abra espaço para relacionamentos genuinamente expansivos, e não relacionamentos de dependência. Até aprendermos a enxergar, acolher e amar a nós mesmos, continuaremos buscando que outros façam esse trabalho de cura por nós, muitas vezes recriando os padrões dos quais estamos tentando escapar.

Os três pilares do reparo

Da mesma forma que nosso modelo inicial de apego é formado por três

pilares simultaneamente (sintonização, neurodesenvolvimento e biologia), um reparo genuíno também exige que trabalhem os três ao mesmo tempo. Insights sobre nossos padrões de apego, gatilhos e reações automáticas – algo que geralmente se obtém na terapia verbal tradicional – muitas vezes não são suficientes para produzir mudanças duradouras. Nossa programação precoce não é só mental ou mesmo emocional: ela está entrelaçada no tecido biológico dos nossos padrões de movimento, nas respostas do sistema nervoso e na memória imunológica.

O reparo real e permanente acontece quando ouvimos a sabedoria do corpo. Enquanto nossa mente pode esquecer ou reprimir recordações difíceis, o corpo guarda a verdade das nossas experiências internas. Isso se manifesta por meio de reações físicas imediatas, como um calafrio repentino quando alguém faz um comentário incômodo, o nó na garganta ao tentar falar ou o congelamento diante de um conflito. Outra forma de manifestação são sintomas e doenças físicas, como a reativação viral de Sarah e a doença autoimune ou os problemas digestivos recorrentes de Elena. Quando o corpo treme, congela ou reage de formas que parecem fora do nosso controle, ele está apontando para algo retido à espera de ser reparado.

A autossintonização é a base desse reparo: a capacidade de ouvir, compreender e responder tanto às mensagens imediatas do corpo quanto aos padrões de saúde de longo prazo, de forma tão cuidadosa quanto faríamos com uma criança pequena.

Autossintonização: quando nos tornamos quem estávamos esperando

A autossintonização representa um novo tipo de relacionamento com nós mesmos. Ela estabelece a base do reparo por meio da criação de novas experiências internas. Aprender a nos sintonizar com nós mesmos permite criar a experiência de ser acolhido, escutado, apoiado, visto, compreendido e amado, reparando cada uma das feridas de apego que possamos carregar. Podemos proporcionar a nós mesmos a atenção e o cuidado constantes de que precisamos para alcançar a regulação.

Como as experiências de Sarah na primeira infância ensinaram ao seu

organismo que ser vista era perigoso, o reparo genuíno exigia criar experiências em que ela pudesse ser vista com segurança – primeiro e, principalmente, por ela mesma. Para tanto, foi preciso aprender práticas específicas para perceber e responder às suas necessidades, como fazer uma pausa a fim de verificar as sensações do corpo ou colocar a mão sobre o coração quando se sentia sobrecarregada. Essas práticas começaram a criar vias neurais novas de autoconexão.

As mudanças mais profundas de Sarah vieram da integração dessas abordagens com o diálogo mente-corpo. Por meio desse diálogo, ela descobriu uma criança interior que acreditava que ser vista significava ser ridicularizada. Em vez de tentar convencer essa parte de si mesma de que agora estava em segurança, ela aprendeu a criar experiências reais de segurança por meio do movimento e da sintonização. Quando a raiva surgia, ela combinava um exercício de rastejar suavemente com a barriga contra o chão enquanto dizia a essa criança interior: “Estou vendo que você está com raiva. Não tem problema se sentir assim.”

Havia outra parte de Sarah que morria de medo de ser vista e entrava em apagão para evitar isso. Além disso, novas facetas tinham se desenvolvido para proteger essa parte: uma perfeccionista, uma multitarefas e uma que usava o humor para desviar a atenção. Ao aprender a identificar, se comunicar e negociar com cada uma dessas partes, ela pôde apoiar as adaptações, ajudando-as a se sentir seguras o suficiente para não entrar em ação enquanto ela se comunicava com sua criança interior, fornecendo a sintonização e o reparo de que precisava.

Trabalhar com essas partes requer um equilíbrio delicado. Não podemos simplesmente descartar as partes protetoras que nos mantiveram seguros por tanto tempo, nem avançar rápido demais em direção às partes mais jovens e vulneráveis. Em vez disso, Sarah aprendeu a criar segurança para todas as facetas de si mesma. Ela reconhecia o medo da parte perfeccionista de perder o controle, ao mesmo tempo que ajudava, com delicadeza, sua criança interior, a parte mais jovem, a se sentir vista e compreendida.

Com o tempo, sua prática somática diária se transformou em um diálogo contínuo com o corpo, ouvindo as mensagens antes que precisassem ser gritadas, como um bebê que passa a chorar mais alto para ser atendido. Em vez de analisar o passado e a relação com a mãe, ela passou a vivenciar amor-próprio e uma conexão melhor com o marido por meio das

habilidades de autossintonização somática e do diálogo mente-corpo.

Embora o amor-próprio seja algo maravilhoso, as inseguranças de Sarah também estavam programadas em seus padrões de movimento e nas vias neurais sensoriais. Do mesmo jeito, estes precisariam de reparo.

Neurodesenvolvimento: reparo por meio do movimento

Antes de conseguirmos falar ou pensar de forma complexa, organizamos nosso sistema nervoso por meio do movimento. É ele que sustenta a regulação, a consciência corporal e o processamento sensorial. Influências sobre nossa capacidade de autorregulação nas quais hoje nem precisamos pensar, como nosso senso de equilíbrio e nossa percepção do próprio corpo, desenvolvem-se por meio de movimentos específicos nos primeiros 18 meses de vida.

Os padrões de movimento do neurodesenvolvimento da primeira infância estão intimamente ligados ao apego, pois ocorrem ao mesmo tempo que somos vistos, ouvidos e acolhidos por aqueles que cuidam de nós. Experiências de sobrecarga relacional e as sensações de estar sozinho, com medo ou de ser inadequado afetam nosso senso de segurança e a liberdade de nos movimentar do modo necessário para um neurodesenvolvimento saudável. A restrição dos movimentos afeta nossa capacidade de autorregulação. Uma das melhores formas de reparar traumas de apego da primeira infância é reorganizar as vias neurais afetadas com movimentos específicos de neurodesenvolvimento, como engatinhar, nos embalar e rolar.

Sarah descobriu de quais tipos específicos de movimentos de neurodesenvolvimento precisava para reorganizar seu sistema fazendo um exercício simples de rastejar de barriga em um piso liso. Seus padrões de movimento revelaram lacunas na região da ponte do tronco encefálico, que impacta a capacidade de notar sensações físicas como fome e sede.

Se você tem pouca consciência de sinais básicos do corpo, como fome, sede, temperatura ou cansaço, ou se ambientes com excesso de estímulos sensoriais fazem com que se sinta sobrecarregado (por exemplo, dificuldade em se concentrar ou perder a conexão com o corpo quando há muitas luzes, sons ou toques), talvez tenha uma ou mais feridas de apego. Essas vias

neurais podem ser reparadas com movimentos específicos que acessam memórias implícitas poderosas de impotência e sobrecarga na primeira infância. Eles podem acionar de maneira espontânea reflexos primitivos e liberar memórias ou emoções armazenadas.

Para Sarah, isso significou combinar o movimento de rastejar de barriga contra o chão cinco minutos por dia e falas gentis dirigidas à sua criança interior. Essa prática ajudou seu sistema a aprender, em um nível visceral, que sentir o corpo e as emoções podia ser algo seguro. Com o tempo, ela passou a fazer esse exercício duas ou três vezes por dia, acrescentando 5 minutos em que engatinhava, de modo a trabalhar também suas lacunas do mesencéfalo, área do tronco cerebral associada ao movimento.

Quando integrados com uma prática de autossintonização, os padrões de movimento criam novas vias neurais para segurança e conexão. No entanto, esses movimentos de reorganização neural precisam ser trabalhados com cuidado, garantindo que só façamos o que o corpo está pronto para suportar. Primeiro, precisamos ter as habilidades para retornar à segurança e estar sintonizados o suficiente com o corpo para permanecer dentro da nossa janela de tolerância antes de iniciar esse tipo de movimento, pois, caso contrário, eles podem causar dano. Para reconfigurar totalmente sua capacidade de conexão, Sarah também precisaria cuidar da biologia que havia contribuído para que seu sistema estivesse indisponível para a conexão quando criança.

Biologia: como apoiar a capacidade do sistema para a conexão

Da mesma forma que um bebê precisa de uma química cerebral específica para estabelecer vínculos, na vida adulta nossa biologia pode tanto favorecer quanto atrapalhar a conexão. Os mesmos neurotransmissores que facilitam o vínculo – serotonina, dopamina e ocitocina – são prejudicados pela inflamação cerebral, pelos desequilíbrios bioquímicos e pelos problemas intestinais. Quando nossa biologia interna está repleta de adrenalina, inflamação, toxinas ou estresse oxidativo, isso ativa respostas de sobrevivência e dificulta a conexão.

Sarah tinha muitos motivos biológicos para estar presa em seus padrões de apego. Com pirrolúria e um estado de submetilação, ela sofria com

baixos níveis de GABA, serotonina e dopamina. Laura e Elena precisavam reduzir a inflamação cerebral para manter a regulação e ter energia mental para conexões autênticas. Todos os motivos biológicos subjacentes que promovem padrões de trauma também prejudicam o reparo do apego, uma vez que padrões de trauma impedem conexões autênticas.

Falta de nutrientes, sobrecarga de toxinas e comprometimento mitocondrial contribuem para um estado de esgotamento. É impossível nos conectarmos com outras pessoas quando mal temos energia para algo além da sobrevivência. Isso cria um ciclo em que o esgotamento biológico sustenta padrões de trauma, tornando mais difícil nos conectarmos mesmo quando queremos fazer isso de modo consciente. Talvez você até compreenda racionalmente seus padrões, mas ainda sinta que a conexão emocional é algo esmagador. Ou talvez deseje relacionamentos mais próximos, mas perceba que interações sociais sugam sua energia, ou até acabe afastando as pessoas por conta da sua reatividade emocional. Em vez de fracassos pessoais, esses são sinais de que sua biologia precisa de suporte específico para estar plenamente disponível para a conexão.

Feridas de apego decorrentes de medo e sofrimento na primeira infância aumentam o risco de desenvolvermos doenças. Aprender a apoiar a capacidade inata do corpo de promover a cura do sistema imunológico por meio de ferramentas de reparo torna-se uma peça importante do quebra-cabeça, mesmo para aqueles que pensam não ter sintomas. O sistema imunológico registra e mantém os padrões da primeira infância criando mais uma camada que, quando reparada, ajuda a reativar nossas estratégias de cura para o apego e a conexão.

DESEQUILÍBRIO IMUNOLÓGICO: REPROGRAMANDO OS ESTADOS DE FUNCIONAMENTO

Assim como os padrões de apego são programados por experiências da primeira infância, nosso sistema imunológico desenvolve seus próprios modelos de funcionamento. Tendo registrado cada exposição desde o nascimento, ele recorda e mantém padrões de proteção quando o sistema nervoso fica preso na desregulação. O vírus Epstein-Barr reativado de Sarah

e as sensibilidades surgidas após a morte da mãe mostraram que seus sistemas imunológico e nervoso, trabalhando juntos para protegê-la, ficaram estagnados em padrões de sobrevivência e precisavam de reparo.

Nosso sistema nervoso alterna entre estados de funcionamento distintos, e isso também acontece com o sistema imunológico. Quando nos sentimos seguros o suficiente, o sistema nervoso repousa no estado calmo-ativo de equilíbrio. Sob estresse, ele entra no modo de alta energia; se chegarmos à sobrecarga, ele entra em apagão. O sistema imunológico espelha esses mesmos três estados por meio de vias de sinalização nos níveis nuclear e celular.

Três vias principais coordenam esses estados imunológicos, trabalhando juntas como diferentes seções de uma orquestra. No nível celular, as células imunológicas podem ficar altamente reativas ou manter respostas equilibradas. No nível nuclear, interruptores moleculares nas células dão ordens para inflamação ou para reparo. E, por meio de sinalização na membrana celular, mensagens se espalham pelo corpo para promover inflamação ou cura. Vamos ver como a experiência de Sarah após a morte da mãe revela esses estados de funcionamento em ação.

O choque emocional inicial de Sarah ativou não apenas o sistema nervoso, mas todo o seu exército imunológico. O que começou como problemas digestivos e fadiga logo evoluiu para novas sensibilidades a alimentos e produtos químicos que antes ela tolerava. Para alguns, a desregulação imune se torna autoimunidade; para outros, se torna sensibilidade a mofo, doença de Lyme, síndromes virais de longa duração, diabetes tipo 2, câncer, etc. Nada disso ocorrerá exatamente da mesma forma para todo mundo, pois depende do nosso estado preexistente. Não são os padrões de sobrecarga e estresse do sistema nervoso que causam essas doenças. Porém, por causa da relação entre os dois sistemas, a desregulação do sistema nervoso nos torna mais suscetíveis quando somos expostos a esses riscos.

Já falamos sobre duas peças cruciais dessa “orquestra” do sistema imunológico: as micróglia no cérebro e os mastócitos por todo o corpo. Quando sobrecarregadas por experiências na primeira infância, essas células se tornam hipersensíveis, reagindo de modo exagerado a pequenos gatilhos. Para Laura e Elena, isso se manifestou como ciclos de inflamação cerebral em consequência de sobrecarga emocional. No caso de Sarah, foi a

reatividade excessiva dos mastócitos, liberando histamina em resposta a produtos de limpeza que nunca a haviam incomodado antes.

Ativadores dos estados imunológicos

Em cada célula do nosso corpo existe um centro de controle, o núcleo, onde dois interruptores importantes ajudam a estabelecer se estamos em um estado de estresse e inflamação ou em um estado de cura e reparo. Esses interruptores moleculares, chamados “fatores de transcrição”, determinam quais genes são ligados ou desligados em resposta ao que está acontecendo dentro e ao redor de nós.

O primeiro interruptor, NF- κ B (pense nele como nosso “interruptor de estresse”), liga o sistema de alarme do corpo. Quando é ativado por estresse, infecção ou lesão, ele sinaliza que as células devem produzir compostos inflamatórios, como se chamasse as tropas para uma batalha. Essa resposta é fundamental diante de ameaças reais – o problema é quando o sistema nervoso permanece desregulado. Nesse caso, o interruptor de inflamação pode ficar travado na posição “ligado”, mantendo um estado pró-inflamatório mesmo depois de a ameaça ter passado.

A contrapartida desse interruptor é o Nrf2 (pense nele como nosso “interruptor de reparo imunológico”). Enquanto o NF- κ B convoca as tropas para a inflamação, o Nrf2 convoca a equipe natural de reparo do corpo. Ele ativa genes que ajudam a limpar os danos da inflamação e a proteger as células do estresse oxidativo. O equilíbrio entre esses dois interruptores – o de inflamação e o de reparo – determina o equilíbrio geral do nosso sistema imunológico e se iremos desenvolver inflamações crônicas associadas a doenças.

Existe mais uma via de sinalização primária que define o estado do sistema imunológico ao se comunicar com as células para coordenar um estado integrado do organismo. Presente nas membranas celulares, o ácido araquidônico atua como um mensageiro que pode seguir por uma via inflamatória ou por uma via de cura, dependendo do sinal que recebe. O ácido araquidônico é a forma de o sistema imunológico se conectar a outros sistemas; ele afeta os vasos sanguíneos e a coagulação, a inflamação da pele, a digestão e as articulações. Quando nossa alimentação contém ácidos

graxos ômega-6 em excesso, vindos de alimentos processados e óleos, o ácido araquidônico tende a produzir mais sinais inflamatórios. Em contrapartida, ácidos graxos ômega-3 de fontes como óleos de peixe ajudam a direcionar o ácido araquidônico para vias anti-inflamatórias.

A experiência de Sarah com sensibilidades crescentes a produtos químicos e alimentos após a morte da mãe ilustra como essa sinalização pode nos afetar. A combinação de estresse emocional com o aumento do consumo de alimentos processados (para não precisar cozinhar) conduziu o ácido araquidônico na direção da inflamação.

Talvez você tenha notado que certos alimentos causam inflamação no seu corpo, que surge como dor articular, problemas digestivos ou de pele. Ou talvez tenha percebido que o estresse emocional agrava suas manifestações específicas de inflamação, como excesso de histamina, erupções cutâneas ou dores de cabeça. Esses não são sintomas aleatórios que devem ser mascarados com anti-inflamatórios paliativos: são mensagens de que o sistema imunológico está respondendo ao que percebe como perigo.

REPARO IMUNOLÓGICO

Nosso sistema imunológico, assim como o sistema nervoso, é altamente adaptável quando recebe o suporte certo. Se quisermos reparar nossa desregulação imunológica, não devemos nos concentrar na última parte do processo (os padrões de comportamento), mas sim ir à fonte para alterar o estado do sistema nervoso; ou seja, a causa do estado pró-inflamatório. Podemos usar ferramentas de reparo para deslocar nosso estado imunológico para um estado de equilíbrio. Assim como a resposta ao estresse não é “ruim” e não deve ser desativada, a inflamação também não o é: queremos apenas que ela esteja equilibrada e ofereça uma resposta adequada ao problema. Podemos fazer isso aplicando ferramentas de reparo às vias de sinalização: o equilíbrio NF- κ B/Nrf2 e o ácido araquidônico.

São muitas as ferramentas naturais de reparo à nossa disposição, e devemos começar pelas mais fáceis de implementar. Podemos reduzir o sinal do NF- κ B consumindo alimentos ricos em antioxidantes, como frutas vermelhas; limitando a ingestão de ultraprocessados, açúcar e álcool; e adicionando nutrientes via suplementação com magnésio, vitaminas C, D,

B₆ e B₁₂, coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, boswellia e ashwagandha. Podemos aumentar o sinal do Nrf2 com vegetais crucíferos como brócolis e repolho, bem como com chá-verde, quercetina e alecrim. As ferramentas de reparo mais potentes são as que atuam tanto no NF-κB quanto no Nrf2 para promover equilíbrio, como curcumina e resveratrol.

É possível reparar a sinalização do ácido araquidônico com mudanças alimentares que aumentem os níveis de ômega-3 e reduzam os de ômega-6, e consumindo alimentos preparados de tal forma que direcione o ácido araquidônico para a via de cura. Prefira salmão selvagem e óleo de krill ricos em ômega-3, evitando gorduras vegetais ricas em ômega-6 encontradas em refeições ultraprocessadas e fast-food. Carne de animais alimentados com pasto tem uma quantidade consideravelmente menor de ácido araquidônico do que a carne de animais alimentados com grãos.

Embora eu tenha me concentrado nos recursos alimentares, algumas das ferramentas de reparo mais poderosas para o sistema imunológico são o sono de qualidade, o exercício físico e a conexão social – especificamente, abraços. Desenvolver uma rotina regular de sono, por mais difícil que seja, é uma das melhores maneiras de apoiar não só o sistema imunológico mas também o sistema nervoso e a regulação do humor. Indícios mostram que criar um motivo para levantar de manhã, fazer exercícios com regularidade e dar e receber abraços ajudam a trazer um sistema imunológico desregulado de volta ao equilíbrio.

O reparo de Sarah começou com o uso de nutrientes específicos para ajudar a equilibrar a atividade de NF-κB e Nrf2. Ela fez acréscimos simples à alimentação e à suplementação, com cúrcuma, resveratrol e quercetina. Sarah também ofereceu suporte intencional às vias do ácido araquidônico, abrindo mão de refeições e lanches rápidos cheios de gorduras pró-inflamatórias e escolhendo alimentos ricos em ômega-3, como peixes selvagens e carnes de animais criados soltos, além de óleo de krill como suplemento. Começou a assar ou cozinhar as carnes em vez de grelhá-las e fritá-las, preservando gorduras benéficas. Passou a dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, reservando um tempo com o marido para caminhar e ficarem abraçados, sabendo que estava investindo não apenas em seu sistema imunológico, mas também em seu relacionamento.

Ela fez um trabalho simultâneo em várias frentes: reparo do apego,

trabalho somático e diálogo mente-corpo, reescrevendo seu padrão de neurodesenvolvimento para desenvolver a capacidade de sentir de maneira segura e lidar com a raiva que surgia. As mudanças foram profundas, e o resultado, impressionante: ela começou a perceber que o sistema imunológico sempre esteve conectado a seus gatilhos emocionais, à raiva reprimida e ao perfeccionismo. Em poucas semanas, notou que os linfonodos estavam menos inchados e que as sensibilidades começaram a diminuir. A ativação do sistema imunológico em resposta a gatilhos associados a relacionamentos diminuiu. Sentiu-se mais capaz de trabalhar seu trauma e até revisitou algumas histórias antigas, o que trouxe ainda mais segurança interna e regulação. Avançou de vento em popa na reescrita da sua programação da primeira infância, conquistando novas habilidades para conexões autênticas.

Em seu processo de recuperação e autodescoberta, havia ainda uma camada que a mantinha presa no luto e na desregulação: seus problemas digestivos. Nunca tinha pensado que o sistema digestivo estivesse conectado a suas respostas emocionais, à raiva reprimida e à resolução do luto, mas isso se tornou a próxima razão subjacente a ser reparada.

No próximo capítulo, veremos duas das principais razões subjacentes que aprisionam o corpo a respostas ao trauma. Então, aprenderemos como repará-las para gerar grandes avanços no nosso processo de cura, revertendo a conexão entre trauma e doença.

RESUMO

Nossas experiências na infância criam padrões profundos e respostas programadas em nossos relacionamentos e na saúde que simplesmente não desaparecem quando reconquistamos a segurança. Na verdade, essas respostas podem, de maneira paradoxal, trazer à tona emoções contidas por muito tempo, em especial a raiva. Ao longo do processo de cura, descobrimos como nossas emoções e respostas de apagão estão intimamente conectadas ao sistema imunológico. O vírus Epstein-Barr reativado de Sarah e suas novas sensibilidades a levaram a entender como a raiva e as memórias reprimidas eram aterrorizantes para o seu corpo.

Vimos que é possível reparar tanto a programação do apego quanto a

programação imunológica. Podemos trabalhar com os três pilares do apego – sintonização, neurodesenvolvimento e biologia – para reescrever o roteiro, bem como aprender a mudar nossas vias de sinalização imunológica (equilíbrio NF- κ B/Nrf2 e ácido araquidônico) para ativar programações inatas de cura. Escolhas de estilo de vida e alimentação nos ajudam a reconfigurar essas programações da infância, alcançando o equilíbrio e desenvolvendo a regulação.

À medida que aprendemos a nos sintonizar com nós mesmos e a ganhar consciência corporal, também conseguimos mudar tendências como o perfeccionismo, a necessidade de agradar os outros e de nos forçar a seguir em frente a qualquer custo. Nosso sistema imunológico tem a chance de se tornar menos reativo ao estresse emocional e mais capaz de se autorregular. Somos capazes de nos abrir com segurança para uma vida mais repleta de autenticidade, amor e conexão.

CAPÍTULO 17

Reparando a programação para a disfunção e a doença

A mudança dói, mas nada dói tanto quanto permanecer preso em um lugar ao qual você não pertence.

— Mandy Hale, escritora e palestrante

Dana olhou para o relógio. Ainda faltavam 10 minutos para a consulta em que receberia o resultado da biópsia da mama. Tempo suficiente para pegar um antiácido no porta-luvas, um hábito que tinha se tornado tão automático quanto o café pela manhã. O remédio oferecia um alívio temporário para a agitação no estômago, mas a necessidade de tomar antiácido a incomodava. Instintivamente, ela passou a mão na barriga. Havia algo acontecendo que ela não entendia. Refluxo, inchaço e dor tinham se tornado companheiros constantes, assim como a dor pélvica crônica com a qual lutava desde a adolescência.

Como médica que se orgulhava de passar por cima do desconforto, ela havia dominado a arte de ignorar esses sinais. Porém, agora que vinha se conectando com o próprio corpo e criando segurança interna, já não conseguia fazer isso tão bem. O que ela considerava um superpoder estava enfraquecendo; ela percebia o quanto seu aparelho digestivo estava alterado, e que isso sempre piorava quando se sentia insegura, como agora, enquanto aguardava para saber se tinha câncer de mama.

A descoberta do nódulo a havia abalado profundamente. Ela conhecia as estatísticas e a pesquisa que associa traumas sexuais na infância a um risco elevado de câncer. Suspirou e levou a mão ao coração ao sentir a tristeza por não ter agido antes para curar aquela ferida. Seria tarde demais? Ela

começaria um tratamento oncológico em breve?

Dana começava a entender que seu sistema digestivo era mais do que o mecanismo mecânico que havia estudado na faculdade de medicina. Ele estava retendo e revivendo a sobrecarga do passado. Seu intestino lhe dizia que precisava de um suporte mais profundo. Os sintomas eram mensagens de décadas de dano celular e de programação biológica que poderiam ser reparados com suporte intencional. Ela estava pronta para o Passo 2 e para mudar os padrões de disfunção e desregulação que causavam doenças e a mantinham presa em padrões emocionais e biológicos de sobrevivência. Sua jornada a levaria a descobrir coisas que não aprendeu na faculdade de medicina, como por que o câncer é mais prevalente em pessoas com experiências adversas na infância e o que pode ser feito para reverter esses efeitos do trauma sobre a biologia.

Apesar do trabalho que fez no Passo 1 ter aumentado sua sensação de segurança interna, a biologia de Dana mantinha um estado de perigo por meio de dois mecanismos poderosos: disfunção digestiva e estresse oxidativo. O resultado da biópsia foi negativo, mas o susto foi importante para ela despertar. A jornada de Dana revelaria duas das maneiras mais poderosas pelas quais o corpo manifesta traumas não resolvidos e como podemos oferecer suporte intencional, por meio de ferramentas de reparo, para sair das estratégias de sobrevivência e voltar às estratégias inatas de cura.

DA SEGURANÇA AO SUPORTE PARA UMA CURA MAIS PROFUNDA

Se você já descartou sintomas físicos como “apenas estresse” ou como parte do processo de envelhecimento, a história de Dana pode lhe parecer familiar. O nódulo na mama foi o que finalmente chamou sua atenção, mas os sinais sempre estiveram lá. Olhando para trás, ela percebeu como o corpo vinha tentando se comunicar por meio de sintomas que ela aprendeu a varrer para debaixo do tapete, como muitos de nós fazemos. Como médica de família, Dana tinha sido treinada a ver problemas digestivos, depressão e câncer como condições separadas, que exigiam tratamentos distintos. Porém, à medida que ela avançava no Passo 1 da sequência essencial,

oferecendo segurança para o seu sistema nervoso pela primeira vez, foi observando o surgimento de um padrão diferente.

“Comecei a notar como sentia minha barriga se contrair antes de conversas que pareciam conflituosas, como discutir com um colega sobre o plano de tratamento de um paciente”, compartilhou Dana. “O refluxo piora quando eu fico estressada, e o inchaço aparece quando estou muito deprimida e só quero me esconder do mundo.” Dez anos antes, recebera a prescrição de um antidepressivo quando se pegou pensando em como seria bom não estar viva. Esses pensamentos desapareceram, mas ela manteve o medicamento por causa dos sintomas de abstinência, que incluíam dor e inchaço no estômago.

Os problemas digestivos tinham começado de forma sutil na adolescência, mais ou menos na época do abuso sexual. Primeiro veio a prisão de ventre, depois anos de sintomas de intestino irritável que os médicos atribuíram ao estresse. Na faculdade, ela já alternava entre diversos antiácidos e laxantes. “Eu pensava que era apenas o estresse de ser médica”, explicou ela. “Nunca associei isso ao abuso sexual.”

O corpo dela, no entanto, não havia esquecido. Após o resultado negativo da biópsia, ela fez uma avaliação completa da biologia do trauma e exames de sangue abrangentes para identificar as razões subjacentes que alimentavam seus padrões de trauma. Os exames revelaram marcadores de estresse oxidativo elevado, inflamação sistêmica, desequilíbrios na microbiota intestinal e suspeita de uma parasitose. Esses achados desenharam um quadro nítido do que chamamos de “corpo de trauma”: quando o sistema nervoso fica preso por tanto tempo no ciclo estresse-sobrecarga que a desregulação crônica gera doença.

A conexão não era aleatória; era como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Dana começou a ver como toda a história da sua vida era interconectada: dos padrões emocionais aos sintomas físicos. Ela reconheceu que sua capacidade de ignorar o corpo e seguir em frente não era, afinal, uma força; era um sinal de trauma de apego. Essa programação da primeira infância tinha preparado o terreno para o que veio depois: no momento do abuso sexual cometido pelo técnico esportivo, ela já carregava padrões profundamente enraizados que lhe diziam para não se manifestar, que ela não valia o esforço e que não podia ser amada.

O abuso sexual era apenas mais uma razão, junto à programação de

apego, que a levava a se desconectar do corpo – o mesmo corpo que mais tarde tentou protegê-la por meio de problemas de saúde física. Os distúrbios intestinais e a dor pélvica crônica nunca tiveram uma causa médica clara. A fadiga de anos alternando entre estresse e sobrecarga também havia causado deficiências de nutrientes e acumulado toxinas. Até seus desequilíbrios de neurotransmissores faziam mais sentido agora; o intestino, responsável por produzir a maior parte da serotonina do corpo, tinha ficado preso em seu próprio padrão de trauma, e a inflamação cerebral e o desequilíbrio bioquímico da submetilação contribuíam para os baixos níveis de serotonina e dopamina.

Ao trabalhar comigo, Dana começou a enxergar como esses padrões biológicos a mantinham em um estado de alerta contra o perigo mesmo enquanto ela desenvolvia mais segurança no sistema nervoso. A inflamação cerebral afetava o intestino por meio do nervo vago. A digestão comprometida não conseguia fornecer os nutrientes de que as mitocôndrias precisavam para produzir energia. O estresse oxidativo de anos se forçando além do limite danificava a capacidade de reparo das células. No entanto, ela não tinha explicação para a parasitose; nem para o desequilíbrio da microbiota intestinal. Como isso tinha acontecido? O que significava? Teria algo a ver com seu humor, os níveis de energia e o nódulo na mama?

Embora aliviada com o resultado negativo da biópsia, Dana entendia agora que criar segurança no sistema nervoso era apenas o primeiro passo. Seu corpo precisava de ferramentas específicas de reparo para transformar as programações biológicas que a mantinham refém do modo de sobrevivência. Duas razões subjacentes para a desregulação persistente se tornaram prioridades para ela: reparar a disfunção digestiva e o estresse oxidativo. Se você tem problemas intestinais, ou quer evitá-los, também deve fazer isso.

A LINGUAGEM OCULTA DO INTESTINO

Quando foi informada sobre o desequilíbrio da microbiota intestinal e a possibilidade de uma parasitose, Dana ficou desconfiada. Como médica, tinha sido treinada a procurar infecções óbvias ou processos de adoecimento evidentes. Por outro lado, também já havia sentido uma

agitação no estômago em momentos de estresse ou náusea antes de provas, evidência de que seu sistema digestivo também respondia a emoções.

Pense no sistema digestivo não apenas como um tubo para processar alimentos, mas como um segundo cérebro. Alguns especialistas inclusive o consideram nosso cérebro primário por conta da extensão de sua atividade neural. É um ecossistema intrincado que ao mesmo tempo cria nosso estado interno de segurança ou perigo e responde a ele. Quando o corpo fica preso em padrões de trauma, esse sistema desenvolve saídas que fazem sentido para a sobrevivência, mas que, na prática, mantêm estados de disfunção.

Se você já teve problemas digestivos, talvez reconheça alguns dos cinco padrões básicos de disfunção descritos a seguir. Cada um representa uma forma diferente de o corpo se adaptar ao estresse crônico e ao trauma.

Capacidade digestiva reduzida

O refluxo crônico de Dana não se devia apenas ao excesso de ácido, mas a desequilíbrios nos grupos musculares do esfíncter e no ácido gástrico. Assim como o trauma pode nos levar ao apagão emocional, ele também pode causar um apagão em nossos processos digestivos. Baixa acidez estomacal, menor produção de enzimas digestivas e fluxo biliar reduzido são formas de o corpo conservar energia quando está em modo de sobrevivência.

Disbiose e supercrescimento

O desequilíbrio nas bactérias intestinais de Dana conta uma história que muitos de nós conhecemos. Anos de estresse, má digestão e padrões de sobrevivência promovem um ambiente propício para organismos nocivos. Esses desequilíbrios criam ciclos viciosos que afetam tudo, do humor à função imunológica. Seja o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, com seus sinais característicos de inchaço na parte superior do abdome e sensibilidades alimentares, ou um supercrescimento fúngico como a candidíase oral, que surge como uma camada branca na língua e um desejo descontrolado por alimentos doces, esses desequilíbrios criam seus próprios ciclos viciosos de inflamação e sintomas. Eles desregulam

neurotransmissores, esgotam nutrientes cruciais e liberam toxinas que podem contribuir para condições mais graves, incluindo risco de câncer.

Infecções ocultas

O parasita encontrado nos exames de Dana destacou outra forma pela qual o sistema digestivo fica comprometido. Como muitos de nós, Dana achava que parasitoses eram um risco apenas em populações sob condições de vida mais precárias. “Eu ficava pensando: como posso ter uma parasitose se me preocupo tanto com a segurança alimentar?”, recordou ela. No entanto, o que encontrou desafia esse equívoco comum. Infecções por parasitas são bastante comuns, e um sistema nervoso desregulado nos torna mais suscetíveis a elas. Alguns dos sinais são problemas intestinais recorrentes que não melhoram, bruxismo, problemas de pele inexplicáveis, distúrbios do sono ou oscilações de humor. Quando aparecem, eles podem alimentar estados de inflamação e perigo no corpo, criando todo tipo de sintomas, de dores de cabeça a inchaços.

Disfunção na barreira intestinal

Trauma e estresse crônico podem comprometer a barreira protetora do intestino, o que muitas vezes é chamado de intestino permeável. Não se trata apenas de partículas alimentares que entram na corrente sanguínea, mas também de bactérias e suas toxinas, chamadas de lipopolissacarídeos. Quando a barreira intestinal está comprometida, cria-se um estado constante de ativação imunológica e inflamação que envia sinais intensos de perigo ao sistema nervoso. Surgem sensibilidades alimentares, que por sua vez afetam os mastócitos e as micróglia, desencadeando inflamação cerebral para além da inflamação intestinal. Quando desenvolvemos novas intolerâncias alimentares, nos sentimos inflamados após as refeições ou temos sintomas aparentemente não relacionados (como dor articular, névoa mental ou oscilações de humor), nossa barreira intestinal pode estar comprometida.

Alteração na motilidade

O sinal mais visível de disfunção digestiva muitas vezes surge na forma como o alimento se move pelo organismo. A disfunção na motilidade intestinal é um problema muito comum; ainda assim, as pessoas geralmente só buscam ajuda quando ele se torna grave a ponto de afetar seu dia a dia. A prisão de ventre de Dana não seria resolvida apenas com mais hidratação ou consumo de fibras; era a resposta do seu corpo preso em respostas repetidas de estresse e apagão. Tanto os nervos simpáticos quanto o nervo vago afetam a motilidade intestinal, o que explica a conexão entre estados emocionais e a prisão de ventre ou a diarreia.

Embora tratamentos convencionais como antiácidos, laxantes ou antidiarreicos possam oferecer alívio temporário, eles não tratam a causa que leva o sistema digestivo a ficar aprisionado em padrões de trauma. Mesmo tratamentos direcionados como probióticos, antibióticos ou antifúngicos são meros paliativos se os padrões subjacentes persistirem.

A boa notícia é que identificar esses tipos de disfunção no corpo é o primeiro passo para reconhecer a disfunção digestiva como uma razão subjacente para respostas persistentes de trauma. Quando ligamos os pontos considerando os sintomas “aleatórios” que vínhamos tendo, podemos fazer testes gastrointestinais para identificar problemas específicos.

Criando uma base para a regulação intestinal

Dana já havia tentado inúmeras soluções, incluindo probióticos, desintoxicações e dietas restritivas, sempre se frustrando porque nada parecia funcionar a longo prazo. Por mais que o problema parecesse insolúvel, a motivação para mudar sua suscetibilidade à doença e ao câncer foi mais forte. Ela então descobriu que lhe faltavam alguns elementos fundamentais. E, embora fosse necessário um reparo mais específico, essas mudanças já ajudariam a manter seu sistema nervoso regulado por mais tempo.

Estabelecer um ritmo diário para o corpo é um dos fundamentos mais simples e úteis. O sistema nervoso pede rotina, e o sistema digestivo funciona melhor quando temos horários regulares. Os novos hábitos de

dormir, se exercitar e fazer refeições no mesmo horário todos os dias já melhoraram o inchaço e a prisão de ventre de Dana. Além disso, ela passou a se empenhar em entrar no estado calmo-ativo antes de cada refeição.

“Eu nunca tinha pensado em criar calma e segurança para o meu sistema digestivo”, disse ela. Além de comer por volta do mesmo horário todos os dias, Dana reservou tempo para que as refeições não fossem apressadas. Parou de comer dirigindo, trabalhando ou curvada sobre o computador, promovendo calma para a digestão. Como parte da nova rotina, ela fazia uma pausa antes de comer para realizar uma prática somática, como emitir o som “vu” enquanto expirava para ativar o nervo vago, que inerva o estômago e o sistema digestivo. Passou a mastigar os alimentos com atenção antes de engolir, sabendo que o estômago não processa tão bem pedaços grandes de comida. “No começo, parecia impossível dedicar esse tempo a mais”, admitiu Dana. “Mas entendi que essa intencionalidade era um sinal de segurança fundamental para minha digestão.”

Essa base de segurança e regulação conscientizou Dana de que era preciso um reparo mais profundo para que a disfunção intestinal deixasse de bloquear seu progresso no trabalho com trauma, ou mesmo que causasse doenças sem que ela percebesse. Era hora de avançar para esse reparo específico.

REPARO DA DISFUNÇÃO INTESTINAL

É hora de explorar formas de reparar disfunções específicas da digestão que podem ter se desenvolvido ao longo de anos de respostas ao trauma. Assim como existem princípios para acessar com segurança traumas armazenados no corpo, o intestino precisa de uma abordagem igualmente cuidadosa.

Aprendemos que para curar o trauma é preciso criar segurança antes de processar experiências difíceis. O mesmo se aplica à cura intestinal. Não podemos forçar ou acelerar o processo – tentar protocolos digestivos agressivos antes de estabelecer um suporte básico muitas vezes piora o cenário. Em vez disso, devemos criar as condições para uma cura natural.

Já sabemos da importância do trabalho sequencial, que é igualmente relevante para o reparo intestinal. Assim como desenvolvemos nossa regulação antes de processar o trauma, precisamos restaurar a função

digestiva básica antes de tratar disfunções mais profundas. Cada tipo de disfunção digestiva afeta as demais, como uma rede complexa de padrões interconectados. Ao seguir a sequência correta, produzimos mudança sustentável em vez de alívio temporário.

Embora tenhamos uma sequência e um modelo para nos orientar, nossa jornada ao longo de cada etapa será individual e única, e algumas exigirão mais tempo do que outras. O reparo digestivo requer personalização: o que funciona para uma pessoa pode disparar sintomas em outra. A autossintonização, uma habilidade essencial para o reparo do apego, se torna inestimável aqui.

Reparo da digestão

Vamos partir de onde a digestão começa: na quebra dos alimentos. Se você já sentiu que a comida “fica parada” no estômago, ou se após comer se sente cansado em vez de energizado, isso é sinal de que sua capacidade digestiva está comprometida. Estados de estresse e apagão restringem as secreções digestivas, produzindo um efeito dominó. Dana ficou surpresa ao descobrir que seu refluxo, que ela vinha tratando com antiácidos havia anos, indicava, na verdade, pouca acidez estomacal, não excesso. “Eu achava que estava fazendo a coisa certa”, comentou ela, “mas piorava minha digestão cada vez que tomava um antiácido.” Sem a quantidade certa de ácido gástrico, as proteínas não são quebradas corretamente. Sem produção adequada de enzimas, os nutrientes não são absorvidos com eficiência. E, sem fluxo biliar suficiente, as gorduras permanecem não digeridas, levando àquela sensação tão familiar de que a comida está “pesando” no estômago.

O processo de reparo começa com o tratamento da acidez. Se tivermos ácido demais, sentiremos problemas entre as refeições, o que pode ser tratado com suco de babosa, por exemplo. Para Dana, introduzimos um suplemento de ácido clorídrico e vinagre de maçã antes das refeições para aumentar a acidez estomacal. Ela também incorporou bitters digestivos, que estimulam a liberação de enzimas digestivas por meio de receptores de sabor amargo na língua. Começou a tomar zinco para o refluxo e suplementação de vitamina B₁₂ por conta de uma deficiência causada pela baixa acidez estomacal.

Disbiose

Quando tratamos a disbiose, um desequilíbrio de bactérias intestinais que afeta muitos de nós, eliminar organismos problemáticos não é o primeiro passo. Para quem lida com infecções ocultas, como parasitoses ou supercrescimento bacteriano, a sequência de reparo se torna ainda mais importante. Essas infecções muitas vezes se desenvolvem por haver comprometimentos na digestão e na permeabilidade intestinal; portanto, trabalhar essas bases primeiro torna protocolos antimicrobianos mais eficazes e menos propensos a provocar reações desconfortáveis de eliminação. O foco deve ser criar um ambiente em que bactérias benéficas possam prosperar, o que começa com a digestão adequada dos alimentos pelo ácido gástrico e pelas enzimas digestivas. Para Dana, alimentos ricos em prebióticos foram então introduzidos gradualmente, garantindo pelo menos duas evacuações por dia. Depois disso, foi possível avançar para agentes específicos para eliminar a infecção fúngica.

Infecções ocultas e reparo

O processo de reparo de infecções ocultas exige uma abordagem metódica em três fases. A primeira fase se concentra na preparação, geralmente com duração de duas a quatro semanas. Nesse período, Dana se concentrou em fortalecer a capacidade digestiva, assegurando acidez estomacal e produção de enzimas adequadas, consolidando a eliminação regular e introduzindo suporte hepático suave. “Parecia contraintuitivo esperar”, admitiu ela, “mas entendi que pular direto para protocolos sem essa base costuma levar a reações intensas de eliminação e resultados apenas temporários.”

Pense nessa fase como se preparar para faxinar uma casa: você precisa garantir que o sistema de descarte (fígado e eliminação) esteja funcionando bem antes de levantar poeira e toxinas. Garantir a estabilidade de glicose no sangue também se torna crucial, pois oscilações glicêmicas podem estressar um sistema já deficiente. Dana percebeu que fazer refeições regulares com uma quantidade adequada de proteínas e gorduras saudáveis ajuda a manter essa estabilidade.

A segunda fase envolve a remoção de organismos indesejados e

normalmente dura de seis a oito semanas. É aqui que entram antimicrobianos vegetais direcionados ou medicações, mas a abordagem precisa ser cuidadosamente personalizada. Algumas pessoas precisam de protocolos mais intensos; outras se dão melhor com um processo mais suave e gradual. O segredo é adequar o protocolo à capacidade do seu corpo de lidar com reações de eliminação.

Durante essa fase, agentes ligantes se tornam cruciais; eles são como equipes de limpeza que ajudam a capturar e remover toxinas liberadas quando os organismos indesejados morrem. Dana descobriu que ingerir esses agentes ligantes entre as refeições e o tratamento antimicrobiano foi muito útil para lidar com sintomas de eliminação. “Eu aprendi a prestar atenção nos sinais do meu corpo”, comentou ela. “Quando os sintomas pioravam, eu sabia que precisava desacelerar ou aumentar o suporte com ligantes.”

A fase final de restauração, com duração de quatro a seis semanas, costuma ser negligenciada, mas é crucial para prevenir recidivas. É quando nos concentramos em reconstituir as bactérias benéficas, apoiar o reparo da mucosa protetora do intestino e corrigir deficiências de nutrientes que possam ter se desenvolvido. É como replantar e adubar um jardim depois de capinar: o objetivo é criar um ambiente em que organismos benéficos prosperem e os indesejados tenham dificuldade de se estabelecer. Estamos mudando o ambiente interno que abriu caminho para infecções e disbiose.

Disfunção na barreira intestinal

Esse processo de reparo exige o entendimento de como funciona a barreira intestinal. Cada célula do revestimento intestinal se conecta às células vizinhas por meio de proteínas sofisticadas chamadas junções oclusivas. Essas conexões determinam o que pode ir para a corrente sanguínea. Quando são comprometidas por estresse, trauma ou inflamação, as junções se afrouxam, permitindo a passagem de partículas que não deveriam passar. Isso cria reações imunes e inflamações que enviam sinais intensos de perigo para nossa neurocepção.

Reparar a barreira intestinal começa por remover o que está causando dano. Para Dana, isso significou identificar seus alimentos-gatilho

específicos, ao mesmo tempo que trabalhava os padrões emocionais que mantinham o sistema dela em modo de proteção. Ela começou a incorporar nutrientes específicos que auxiliam o reparo celular. A L-glutamina se tornou a base do seu protocolo, fornecendo a principal fonte de combustível de que as células intestinais precisavam para se reparar. O zinco carnosina ajudou a manter a integridade dessas junções oclusivas cruciais, ao passo que peptídeos de colágeno forneceram os alicerces para o reparo estrutural.

O acréscimo de raiz de alteia e caldo de ossos ajudou ainda mais, criando um revestimento protetor que favoreceu a cicatrização. Talvez o mais importante tenha sido Dana descobrir como a segurança emocional afetava a permeabilidade intestinal. Nos dias em que ela se sentia mais regulada, suas intolerâncias alimentares pareciam menos reativas, demonstrando a conexão íntima entre o estado do nosso sistema nervoso e a função da barreira intestinal.

Alteração na motilidade

A prisão de ventre de Dana refletia um padrão mais profundo de retenção, tanto emocional quanto física. Para tratar a motilidade foi preciso trabalhar com os ritmos naturais do corpo dela, em vez de forçar o movimento com intervenções agressivas. Esse processo começou com o estabelecimento de rotinas matinais que respeitavam o ciclo natural de mobilização do corpo. Movimentos leves ao acordar, beber água morna com limão e uma massagem abdominal suave ajudavam a sinalizar ao sistema que era seguro se mover.

Ela aprendeu a estimular a motilidade ao longo do dia com hidratação adequada entre as refeições e movimento regular, sem se exceder. A suplementação de magnésio se mostrou particularmente útil – não apenas pelo suporte suave ao movimento muscular, mas pelo efeito calmante no sistema nervoso. A rotina noturna também se tornou importante: Dana passou a evitar refeições substanciais tarde da noite e incluiu uma caminhada leve após o jantar para favorecer ritmos digestivos naturais.

Dana descobriu que trabalhar sua motilidade não se limitava a evitar a prisão de ventre: era preciso criar ritmo e regulação para todo o organismo. Conforme seus padrões de movimento digestivo se normalizavam, ela notou

mudanças paralelas na flexibilidade emocional e na capacidade de conexão. Ficou ainda mais nítido que o sistema digestivo tanto reflete quanto influencia nosso estado de regulação.

Ao oferecer suporte ao sistema digestivo com ferramentas fundamentais e específicas de reparo, ela alterou seu risco para muitas doenças. Ainda assim, precisava priorizar mais uma razão subjacente para o padrão persistente de trauma ligado à doença: o estresse oxidativo.

REPARO DO ESTRESSE OXIDATIVO

O estresse oxidativo é uma das formas mais poderosas de converter trauma em doença no corpo. O dano oxidativo ocorre quando nossas células são expostas a mais moléculas reativas do que conseguem neutralizar. Quando o corpo fica preso em um ciclo entre respostas de estresse e de apagão, ele cria um fluxo constante dessas moléculas nocivas que sobrecarrega nossas defesas antioxidantes naturais. Com o tempo, o dano celular se torna um fator determinante para inflamação, envelhecimento acelerado e desenvolvimento de doenças.

A conexão entre trauma e estresse oxidativo é imediata e duradoura. Cada vez que vivenciamos uma resposta ao trauma – seja forçando o corpo para além da exaustão, reprimindo emoções ou nos mantendo em estado de hipervigilância –, nossas células geram mais dessas moléculas nocivas. Sem a recuperação e o reparo adequados, o dano se acumula silenciosamente por anos ou décadas, até se manifestar como doença. Pesquisas mostram que esse é um dos mecanismos primários que ligam experiências adversas na infância ao risco aumentado de condições como câncer, doenças autoimunes e dor crônica mais tarde na vida.

Foi exatamente isso que Dana descobriu ao analisar mais a fundo seus padrões de saúde. A dor pélvica crônica, os problemas digestivos e o nódulo na mama não eram sintomas desconectados: eram manifestações de tecidos sofrendo por anos com dano oxidativo acumulado. “Eu achava que estava sendo forte por me forçar a seguir em frente”, disse ela, “mas eu estava danificando minhas células.” Cada vez que reprimia emoções para continuar funcional, e cada momento em que ignorava a exaustão, seu corpo acumulava dano celular. O nódulo foi o alerta, mas os sinais de estresse

oxidativo já estavam presentes muito antes, nos padrões de fadiga, inflamação e dor crônica.

A ciência do dano celular

Para entendermos o estresse oxidativo, precisamos ver o corpo como um sistema interconectado, em que o dano celular em uma área cria efeitos em cascata por todo o organismo. Esse estrago ocorre em vários níveis, de membranas celulares e proteínas às mitocôndrias e ao DNA. Quando o estresse oxidativo danifica o DNA, ele pode desencadear mudanças epigenéticas que alteram o funcionamento dos genes, potencialmente causando condições como TEPT, doenças autoimunes e câncer.

Três sistemas-chave formam um triângulo de interação com o estresse oxidativo: cérebro, sistema imunológico e trato digestivo. Quando a inflamação ativa as micróglia, células imunes do cérebro, ela gera mais estresse oxidativo, que, por sua vez, cria mais inflamação. Esse mesmo ciclo ocorre no intestino, onde uma barreira comprometida permite que toxinas bacterianas acionem um dano celular adicional. Enquanto isso, o sistema imunológico, quando preso em padrões de resposta ao trauma, pode gerar inflamações crônicas que produzem ainda mais estresse oxidativo.

Essa natureza sistêmica do dano oxidativo explica por que os efeitos do trauma surgem por todo o corpo. Não é apenas cansaço ou estresse; é o organismo inteiro se esforçando para funcionar sob uma carga crescente de dano. Sem mecanismos adequados de reparo celular, esse dano se acumula ao longo do tempo, especialmente quando estamos aprisionados em ciclos de estresse e apagão que impedem a limpeza e o reparo celular normais.

A jornada de Dana é um exemplo contundente dessas conexões. Na faculdade de medicina, ela havia aprendido sobre estresse oxidativo sobretudo em relação ao envelhecimento e à doença. Agora, descobria como as respostas de trauma retidas no seu corpo tinham criado uma combinação perfeita de dano celular. A névoa cerebral surgia quando as micróglia ficavam sobrecarregadas com estresse oxidativo. A dor pélvica crônica refletia uma ativação do sistema imunológico causada por dano celular. Até sua tendência bioquímica à submetilação significava que a produção natural de antioxidantes dela estava abaixo do ideal, tornando-a mais vulnerável ao

dano oxidativo.

“Eu tinha criado o ambiente ideal para a doença”, percebeu Dana. “Não apenas pelos meus comportamentos, mas pelo dano celular de estar presa no ciclo entre estresse e apagão. Sem que eu percebesse, tudo se acumulou.” Essa compreensão transformou a maneira como ela via sua jornada de saúde. Ao oferecer suporte ao corpo para limpar o estresse oxidativo com ferramentas de reparo, ela poderia não só prevenir doenças associadas ao trauma mas também aumentar a capacidade celular de processar o trauma que havia reprimido por tanto tempo.

Uma abordagem prática para o reparo

Os sinais estiveram ali o tempo todo, da mesma forma que podem estar para nós. Dana só não sabia como interpretá-los. Seus fios grisalhos precoces não eram apenas genética, mas evidência de dano oxidativo nos folículos. Suas quedas de energia à tarde, a exaustão pós-terapia e o esgotamento após viagens não eram só por que estava “ficando velha”; eram sinais de que as células precisavam de ajuda no equilíbrio oxidativo.

Dana começou com o básico – tentar eliminar rápido demais anos de estresse oxidativo acumulado poderia sobrecarregar seu sistema. Ela iniciou com vitamina C, selênio e NAC para favorecer a produção natural de antioxidantes do corpo.

Instalou um painel de terapia de luz vermelha no consultório, usando-o nos períodos de trabalho burocrático, para promover a saúde mitocondrial. As caminhadas matinais passaram a ser ao ar livre, pois a luz natural ajuda a equilibrar o estresse oxidativo. Passou também a comer mais frutas e vegetais de cores variadas, ricos em antioxidantes naturais. Priorizou o sono e organizou seu quarto para que ficasse completamente escuro e fresco.

Para sua surpresa, após uma semana ela já percebeu uma diferença na sua capacidade de realizar mais trabalho com o trauma. Começou devagar, mas Dana descobriu que não só tinha mais resiliência emocional, como também resiliência ao estresse: o corpo dela se adaptava mais rápido a novos fusos horários quando viajava.

Talvez o mais importante seja que Dana aprendeu a respeitar o próprio ritmo. Entender que todo estresse – emocional, físico ou ambiental –

contribui para a carga oxidativa ajudou-a a fazer escolhas conscientes sobre como gastar sua energia. Ela começou a programar tempo de recuperação após sessões de terapia e aprendeu a reconhecer sinais precoces de sobrecarga antes que evoluíssem para o apagão, prevenindo o acúmulo de estresse oxidativo que vinha trabalhando tanto para reduzir.

E o que acontece depois que os padrões mudam? A resposta está no próximo capítulo, sobre a expansão, que é a verdadeira essência da jornada de cura do trauma. Encontrar nossa zona de segurança e desenvolver a regulação é essencial, mas é na expansão que, a partir dessa base bem construída, podemos subir a níveis que jamais imaginamos alcançar.

RESUMO

Este capítulo explorou como oferecer suporte ao corpo no que diz respeito ao padrão de trauma ligado à doença. O que começou como mecanismos de sobrevivência (dissociação, imobilização e conservação de energia) pode se tornar padrões crônicos que aumentam nosso risco de adoecer por meio da disbiose, da inflamação intestinal e do estresse oxidativo.

Entender esses mecanismos nos traz esperança. Seja por meio do reparo digestivo que aumenta nossa capacidade de regulação, seja por meio do reparo oxidativo que favorece nossa resiliência inata, existem ferramentas específicas de reparo para ajudar o corpo a sair das estratégias de sobrevivência para as estratégias de cura. Essas estratégias de cura ajudam a reparar a conexão entre trauma e doença, a desenvolver a capacidade de regulação para mudar nosso estado preexistente e a estabelecer novas formas de resposta.

CAPÍTULO 18

Da cura para a vida plena: próximos passos

Eu não conseguia acreditar. Estava chorando com a vitória de um cavalo de corrida. Lembro-me da primeira vez que vi o filme *Seabiscuit – Alma de herói*. Senti que me identificava com aquele cavalo e que, se ele venceu contra todas as probabilidades, talvez eu também pudesse fazer isso.

O filme é baseado em uma história real. Seabiscuit não tinha o corpo de um campeão. Não era grande, elegante e perfeito; era pequeno, comia muito e dormia ainda mais. Quando era mais novo, colocaram-no para disputar com campeões, forçando-o a perder no intuito de dar mais confiança aos cavalos maiores. Quando o botavam para correr, ele fazia exatamente aquilo para o qual havia sido treinado: perdia. Tornara-se um cavalo amargo e irritadiço.

Os donos o compraram por causa da expressão nos seus olhos, uma força vital que ainda ardia dentro dele. Fiquei pasma porque, ao longo do filme, as lições pareciam mensagens pessoais para mim. Frases como: “Você não joga uma vida inteira fora só porque levou algumas pancadas”, “Ele está tão machucado que mal dá para saber como realmente é por dentro” e “Ele se esqueceu do que nasceu para fazer. Só precisa aprender a ser um cavalo de novo”.

Em determinado momento do filme, Seabiscuit recebe uma segunda chance de vencer, ou melhor, de aprender que podia vencer. Seu jóquei, cheio de raiva, amargura e tão machucado quanto ele na infância, foi o parceiro perfeito. Juntos, eles começaram a vencer corridas, até chegar ao ponto de enfrentar o cavalo mais rápido da Costa Leste e *ganhar*. Foi aí que eu chorei. Se Seabiscuit pôde abrir novamente o coração para a vida,

lembrar quem era e permitir que seu eu autêntico e poderoso brilhasse e vencesse, talvez eu também pudesse.

A história de Seabiscuit é um ótimo exemplo dos efeitos do trauma em nossa vida, das noções equivocadas que podemos ter e do que realmente é possível em uma jornada de cura. O ponto da virada para Seabiscuit aconteceu quando alguém demonstrou que se importava com ele. Ele não se sentia mais sozinho.

Não foi uma mudança imediata. Ele precisou de mais que tempo e cuidado para superar seu condicionamento inicial de desconfiança e insegurança. Foi necessário trabalho árduo, prática e treinamento, e não somente treinamento físico, embora esse fosse rigoroso. Ele também teria que aprender que não era um fracasso nem estava destinado a sempre perder.

A lição que o cavalo aprendeu serve para nós também. Podemos ir muito além do que imaginávamos quando recebemos o necessário para nos libertar do passado.

Existem possibilidades incríveis à nossa frente. Ainda assim, há muitos mitos e equívocos sobre o que é necessário para curar o passado, o que impede muitas pessoas de avançar. Mesmo com boas intenções, esses mal-entendidos nos deixam sem a sequência e as ferramentas que poderiam nos levar a viver plenamente em vez de apenas sobreviver. Assim como Seabiscuit, podemos ser condicionados para perder e cumprir exatamente esse propósito, até mesmo quando se trata da nossa jornada de cura.

Embora mesmo lendo este livro algumas pessoas possam permanecer estagnadas (vou explicar o porquê neste capítulo), quero juntar aqui todas as peças para que você tenha uma visão clara do caminho completo à sua frente. Um caminho que, como no caso de Seabiscuit, pode fazer você voltar à pista de corrida, lembrar quem é de verdade e permitir que seu eu autêntico, belo e poderoso brilhe.

A JORNADA DE CURA DO TRAUMA: MAIS DO QUE APENAS SE CURAR

Muita gente pode querer apenas recuperar o que foi perdido ou voltar a ser quem era antes de determinada experiência. No entanto, assim como na

história de Seabiscuit, a jornada de cura do trauma trata de descobrir quem podemos nos tornar quando não estamos mais presos ao passado. Embora o trauma inicialmente interrompa nosso estado natural de crescimento e conexão, a jornada de cura pode nos levar a uma vida mais plena do que jamais imaginamos ser possível.

Peter A. Levine capturou essa ideia em seu livro *Trauma Through a Child's Eyes* (O trauma pelos olhos de uma criança):

O paradoxo do trauma é que ele tem tanto o poder de destruir quanto de transformar e ressuscitar. Cheguei à conclusão de que os seres humanos nascem com uma capacidade inata de triunfar sobre o trauma. Acredito não apenas que o trauma é curável, mas que o processo de cura pode ser um catalisador para um despertar profundo: um portal que se abre para uma transformação emocional e espiritual genuína.

Embora estabelecer segurança e regulação sejam os primeiros passos cruciais, eles não são o destino final. O objetivo principal não é apenas obter uma cura, mas viver a vida em sua plenitude. É criar uma vida que queiramos viver e que nos faça acordar entusiasmados todos os dias. Nos meus papéis como mãe, médica e educadora, testemunhei essas mudanças e transformações profundas nas pessoas com quem trabalho e às quais ensino. É inspirador, como observar uma flor crescer e desabrochar, abrindo-se para a vida. Essa é a jornada que vai da retração criada pela sobrecarga até o retorno ao nosso estado natural de abertura, crescimento e expansão.

DA RETRAÇÃO À EXPANSÃO

Antes do trauma, nosso estado natural é o de crescimento e expansão. Ninguém precisa nos ensinar a crescer, engatinhar e depois andar. Nós naturalmente estabelecemos relacionamentos, perseguimos objetivos e encaramos os desafios da vida como oportunidades. Nossa biologia é de conexão, vitalidade e saúde.

Uma resposta ao trauma, que significa vivenciar impotência absoluta e entrar em apagão, interrompe esse movimento natural. Peter Levine faz a

seguinte descrição: “O trauma acontece quando uma experiência nos atinge como um raio inesperado. Ele nos sobrecarrega, deixando-nos alterados e desconectados.” Nossa vitalidade é substituída por mecanismos de sobrevivência. Em vez de crescer, nosso único propósito passa a ser sobreviver. A expansão natural dá lugar à retração.

Sem a conclusão do reparo, permanecemos nesse estado de retração. Em vez de nos conectarmos, nos recolhemos ou sabotamos a conexão. Em vez de assumir riscos saudáveis, evitamos qualquer risco. Onde antes víamos uma oportunidade, nosso sistema nervoso agora percebe uma ameaça. Até nossa biologia fica presa na retração, prejudicando nossa energia e nossa capacidade de levar a vida.

Muitos acreditam que o tempo, por si só, vai curar esses padrões; que, mais cedo ou mais tarde, “voltaremos ao normal” e recuperaremos nossa capacidade de nos conectar e crescer. Mas, como vimos no Capítulo 8, o tempo sem reparo aprofunda o dano. Cada vez que cruzamos nosso limite crítico da sobrecarga, reforçamos esses padrões de sobrevivência. O loop corpo-trauma fica ainda mais arraigado, e nossa biologia se torna mais desregulada e comprometida, criando seu próprio ciclo de retroalimentação.

Mas e se quisermos não apenas sobreviver, e sim viver plenamente e nos abrir outra vez para a vida, o crescimento e as possibilidades? Essa retração não precisa ser permanente. Embora não possamos apagar nossas experiências passadas nem o impacto delas sobre nossa biologia, podemos criar experiências que permitam ao nosso sistema retornar ao seu estado natural de expansão. É aqui que entra a esperança: assim como nossa biologia pode aprender padrões de sobrevivência, ela também pode aprender padrões de expansão. A mesma neuroplasticidade que codificou nossas respostas traumáticas pode ser utilizada para criar novas vias. O mesmo sistema nervoso que aprendeu a se retrair pode ser ensinado a se expandir. Os mesmos sistemas celulares que se adaptaram para se manter no modo de perigo podem receber suporte para expandir nossa vitalidade.

A segurança fornece estabilização. O suporte repara o dano. Na expansão, finalmente restauramos nosso movimento natural em direção ao crescimento, mas de uma forma ainda mais consciente, intencional e fortalecida do que antes. A expansão não se torna apenas o destino final, mas a própria jornada quando entendemos como navegar por essa última etapa.

Aqueles que escolhem a jornada de cura do trauma não esperam pelo futuro; eles criam as novas experiências de que precisam para se expandir rumo ao futuro que desejam, tornando-se autênticos, íntegros e saudáveis. Mas o que exatamente é a expansão? Como percorremos essa fase?

Entendendo a verdadeira expansão

Vamos voltar à analogia da expansão com o patinho saindo do ovo. A magia de uma vida emergente não está numa força externa que quebra a casca, mas no crescimento interno do patinho criando, de dentro para fora, a pressão certa. De maneira análoga, podemos emergir do trauma com vida, liberdade e autenticidade renovadas. Quando tentamos expandir nossa capacidade pela força, o crescimento que desejamos é esmagado pela sobrecarga. Quando seguimos a sequência essencial, usando nossa base de segurança e suporte para a expansão, uma nova vida emerge.

Em muitos aspectos, a verdadeira expansão é como subir uma escada em espiral. Embora cada degrau nos leve mais alto, a novos níveis, eles também nos levam mais fundo, a novas camadas. Podemos achar que conhecemos a dor, o medo e a sobrecarga que levamos conosco, mas cada degrau no processo de expansão nos conduz mais alto e mais fundo em camadas que talvez pensássemos já ter curado ou reparado. Teremos mais sucesso em subir essa escada em espiral se dermos cada passo com cuidado, garantindo que as bases estejam firmes. Assim não excedemos nossa capacidade à medida que a ampliamos e partimos de uma base de segurança e suporte para alcançarmos novos patamares. A cada degrau, adquirimos uma consciência mais profunda de nós mesmos, ampliando nossa capacidade e obtendo uma visão mais nítida do que será possível para nós no futuro.

À medida que subimos essa escada em espiral, ocorre uma mudança de perspectiva importante. No início, nosso foco ainda está naturalmente na cura, e estamos o tempo todo perguntando: “O que mais em mim precisa ser consertado?” Conforme nos expandimos, o foco passa a ser viver a vida, e começamos a perguntar: “Como posso me sentir mais vivo?” Ao identificarmos o que está nos impedindo de estar mais vivos do jeito como desejamos, desbloqueamos o próximo nível da escada em espiral à nossa frente.

A escada nos revela mais uma verdade sobre a expansão: ela não tem fim. Podemos ir tão longe e tão alto quanto quisermos. É uma jornada em que gatilhos não precisam mais ser inimigos, mas sim informações úteis sobre nós mesmos: coisas que podemos escolher reprogramar. Com o tempo, conseguimos entrar em áreas que antes eram desconfortáveis e proibidas para nós.

Laura pode ter começado a trabalhar a sequência essencial por causa de sua resposta de sobressalto exagerada, mas, quando chegou à expansão, ela parou de se perguntar “Como faço para não me assustar tanto?” e começou a se perguntar “Que nível de intimidade emocional eu quero ter com meu marido?”. Claire parou de se perguntar “Como eu acabo com essa fadiga?” e começou a se perguntar “Como posso servir a um propósito maior com tudo o que aprendi?”. Quando Sarah chegou à expansão, sua pergunta mudou de “O que faço com essa raiva toda?” para “Como posso ser minha melhor versão todos os dias?”.

Na etapa de expansão, buscamos mudanças sutis porém profundas ao longo do caminho, em vez de esperar mudanças grandes e imediatas. Podemos nos ver naturalmente chamando uma amiga para caminhar, em vez de recorrer à comida ou ao álcool. Podemos descobrir que conseguimos lidar com emoções desconfortáveis que antes nos levavam ao apagação. A biologia revela que estamos em expansão quando nos oferece um sono melhor, energia mais estável e pensamentos mais claros. Nossa relação com nós mesmos se transforma: nos mostramos curiosos em vez de críticos.

Pense na expansão como aprender a tocar um instrumento musical. No começo, parece exigir um esforço consciente enorme para fazer o básico, como aprender onde colocar os dedos e como ler as notas ao mesmo tempo. Com a prática, esses fundamentos se tornam automáticos, permitindo que exploremos peças mais complexas e, por fim, venhamos a compor nossa própria canção: a música da nossa alma.

RAZÕES PELAS QUAIS ALGUNS PODEM NÃO TER SUCESSO

Nem todos conseguirão avançar com sucesso pelos passos da jornada de cura ao aplicar o conhecimento e as ferramentas deste livro. Na maioria das

vezes, essa escolha não é consciente. Algumas pessoas podem ficar céticas e se recusar a experimentar práticas que parecem simples demais para serem úteis. Ou talvez desistam pela metade, sem dar uma chance de verdade ao processo. No entanto, na maioria das vezes o insucesso pode ser resultado de uma programação inconsciente.

Esses padrões de autolimitação aparecem nos nossos pensamentos. Eles podem vir na forma de observações como “Eu não consigo sentir meu corpo”, ou de afirmações resignadas como “Eu não tenho jeito mesmo”. Muitas vezes criamos explicações perfeitamente lógicas para justificar por que a mudança não é possível: “Isso é de família” ou “Eu já tentei de tudo”. Embora essas narrativas sobre por que a cura não é possível pareçam convincentes, elas costumam mascarar uma crença mais profunda: “Eu não mereço uma vida melhor.”

Essa programação inconsciente com frequência se manifesta como impotência aprendida. O renomado psicólogo Martin Seligman conduziu pesquisas na década de 1960 que mostraram como a exposição a eventos negativos incontrolláveis pode levar a uma sensação de impotência e a uma perda de autonomia diante de eventos negativos futuros. Para realizar o estudo, dois grupos de cães foram colocados em um compartimento que tinha dois lados separados por uma barreira baixa. Um grupo foi preso à parede pelas coleiras, e o outro ficou livre. Em seguida, os cães levavam um choque vindo do piso do compartimento. Todos se movimentaram para escapar do choque, é óbvio, mas aos que estavam presos só restou ver os companheiros pularem a barreira. Eles continuaram sendo expostos ao choque, impotentes. Essa condição se assemelha ao muro na resposta instintiva ao trauma, quando vivenciamos impotência e, em seguida, congelamento e apagão.

Mais tarde, os mesmos cães foram colocados no mesmo compartimento, com o mesmo sistema de choque e a mesma barreira. Só que, dessa vez, todos estavam livres. Os pesquisadores aplicaram o choque novamente. Os cães que haviam pulado a barreira antes saltaram rapidamente para o lado seguro. Os que haviam sido presos anteriormente não o fizeram. Mesmo vendo seus companheiros pularem (na prática mostrando-lhes como escapar), eles nem sequer tentaram. Deitaram-se na placa de choque, ganindo enquanto recebiam as descargas elétricas. A experiência havia programado a impotência aprendida nos cães que estiveram presos. Foi um

achado revolucionário.

Era o mesmo caso de Seabiscuit, treinado para perder até esquecer que podia vencer e parar de tentar. Será que temos a mesma programação inconsciente profunda de que não conseguimos fazer coisas difíceis e por isso nem tentamos? Pode ser que estejamos conduzindo a vida, o trabalho ou os relacionamentos com baixas expectativas, dispostos a nos contentar com migalhas. O padrão se torna tão enraizado que, mesmo quando oportunidades de mudança surgem, algo dentro de nós nos freia – mas não sabemos por quê, ou talvez nem percebamos.

Depois de vivenciarmos ocorrências suficientes de impotência em nossa própria vida, algumas partes de nós passam a acreditar que não somos capazes de realizações. O estado padrão do nosso cérebro presume que não somos capazes. Toda vez que nada do que fazemos muda o resultado, nosso cérebro reforça essa programação de impotência aprendida.

Quero contar o desfecho da história dos cães, pois ela nos dá muita esperança e, de novo, como o exemplo de Seabiscuit, mostra não apenas o que é possível, mas como fazer a reprogramação. Os cães presos, que haviam aprendido a ser impotentes, reaprenderam o estado de autonomia. Não pela força, por métodos de coerção ou graças a recompensas, embora os pesquisadores tenham tentado essas estratégias. A variável que reprogramou com sucesso a impotência aprendida foi receber orientação física de humanos sobre como pular de novo. Da mesma forma que Seabiscuit, que havia esquecido como ser um cavalo e correr livremente, os cães haviam esquecido como ser cães e saltar barreiras. Então, enquanto eram expostos repetidamente aos choques, os técnicos do laboratório seguraram as patas deles e as moveram por eles para fazê-los pular. Com o tempo, os cães aprenderam a escapar por conta própria. Vou repetir: os cães aprenderam que *podiam pular* para a segurança por conta própria.

Como essa reabilitação não era parte da descoberta da impotência aprendida, não recebeu tanta atenção quanto merece. Mas ela nos ajuda a ver os diferentes níveis em que uma resposta ao trauma nos afeta e o reparo necessário para recuperarmos o senso de autonomia na jornada de cura. Uma memória traumática fica armazenada na mente na forma de crenças sobre nós mesmos e, no corpo, como movimentos somáticos de autodefesa que foram bloqueados. Sabemos que a parte biológica também é afetada e precisa de reparo, mas isso não foi mensurado nesse estudo, e a reabilitação

aconteceu antes que mudanças biológicas tivessem tempo de evoluir para estados de doença.

O que torna essa programação particularmente desafiadora é que ela opera de modo inconsciente. Você pode saber racionalmente que a mudança é possível e, ainda assim, se ver incapaz de seguir as práticas básicas deste livro que tanto poderiam ajudar. Pode desejar ser mais saudável mas não fazer as avaliações, os exames e o reparo biológico que possibilitariam isso.

Entender essa programação não tem nada a ver com culpa. É uma questão de reconhecer que ela vai nos deter, como se nós também estivéssemos presos por uma coleira à parede do nosso passado. Mas nada nos impede de fazer as coisas mecanicamente no início, com cautela, mas com persistência, para desafiar algumas crenças profundas que carregamos sobre nossas capacidades, nossa autonomia e nosso merecimento. É isso que vai nos permitir voltar a superar as barreiras na nossa vida.

OS FUNDAMENTOS: POR ONDE COMEÇAR E QUAIS SÃO OS PRÓXIMOS PASSOS

A sequência essencial e o modelo da Biologia do Trauma podem parecer intimidadores quando vistos como um todo. Por onde começar? Quais ferramentas de reparo são necessárias e em que ordem?

Independentemente de onde você esteja na sua jornada, existem fundamentos que podemos aplicar agora mesmo para ajudar o corpo a sair da estagnação. Esses fundamentos formam a base da cura: sem eles, tudo o que tentarmos depois acabará desmoronando. Assim como não conseguimos compensar uma alimentação ruim ou a falta de sono, também não conseguimos contornar esses pilares básicos da recuperação apenas com terapia.

Vamos começar pelo que o corpo mais precisa: ritmo e rotina. Nosso sistema nervoso prospera na previsibilidade, e é por isso que estabelecer horários e rotinas diárias é simples e, ao mesmo tempo, extremamente poderoso. Um horário constante para dormir, comer e se exercitar cria a previsibilidade de que o corpo precisa para funcionar bem.

Criar uma rotina matinal com hidratação, movimento e luz solar natural ajuda a redefinir os ciclos naturais do organismo, permitindo que

hormônios como o cortisol e a melatonina trabalhem do modo ideal. Quando seguimos essa programação todos os dias, inclusive nos fins de semana, a qualidade do sono melhora. Um sono melhor significa que o sistema nervoso começa o dia mais regulado e com mais recursos. Estabelecer uma rotina noturna e evitar comer pelo menos três horas antes de dormir também oferece suporte essencial ao sistema nervoso.

As mudanças na alimentação são outro pilar fundamental. Existem princípios nutricionais básicos que aumentam nossa regulação interna e a sensação de segurança. Priorize alimentos integrais em vez de ultraprocessados, eliminando aditivos nocivos como xarope de milho rico em frutose, açúcares processados e gorduras inflamatórias que drenam nossa energia. A dieta específica que faz você se sentir mais estável emocionalmente e mais saudável costuma ser um bom guia. Seja ela carnívora, cetogênica, vegetariana ou vegana, a qualidade dos ingredientes e a regularidade nos horários das refeições serão grandes aliadas da sua jornada de cura.

Hidrate-se com água assim que acordar, antes de recorrer à cafeína, para não adicionar o estresse da desidratação ao organismo. Também pode ser útil evitar cafeína com o estômago vazio, pois ela estimula a liberação de mais adrenalina. Embora o pico de energia possa trazer foco e produtividade temporários, ele pode colocar o corpo em um estado de mobilização que não é sustentável quando há comprometimento mitocondrial e esgotamento energético, o que favorece a fadiga, o congelamento e o apagão mais tarde no dia.

Outra prática diária fundamental é equilibrar o nível de atividade com o nível de estresse, de modo a utilizar toda a adrenalina produzida. A quantidade de adrenalina liberada diariamente, seja pela cafeína, pelas notícias do dia ou por uma resposta intensa ao estresse, precisa ser compensada com movimento físico. A adrenalina acumulada acaba se transformando em mobilização excessiva, empurrando-nos além do limite crítico da sobrecarga. Muitas vezes, uma atividade regular e consistente é mais eficaz do que treinos intensos e esporádicos.

Ao longo do dia, reserve momentos para fazer pausas, tomar consciência do próprio corpo e praticar exercícios somáticos. Crie experiências de segurança e apoio. Observe quando alguma parte sua precisa de algo e tenta chamar sua atenção por meio de pensamentos, sensações corporais ou

emoções. Com essas pausas frequentes reconstruímos a conexão com nós mesmos e estabelecemos confiança e comunicação com o próprio corpo.

Complete quaisquer respostas de sobressalto e estresse que o corpo iniciar. No caso de um sobressalto, olhe ao redor para identificar o que assustou você, toque o objeto se for seguro e solte um suspiro, se isso ajudar o corpo a se regular novamente, sinalizando que você está em segurança e pode fazer a restauração. Completar uma resposta ao estresse exige pausa e tempo para que o corpo reúna todas as informações necessárias para saber, de fato, que o perigo passou. Às vezes, o corpo se move involuntariamente, por meio de tremores ou espasmos – quando permitimos que isso aconteça, a resposta pode ser concluída sem controle consciente.

Um exemplo clássico é quando escapamos por pouco de um acidente de carro. Muitas pessoas continuam dirigindo, o que impede o corpo de completar a resposta ao estresse, mantendo um nível elevado de tensão ao longo do dia. Em vez disso, se possível, estacione em lugar seguro, desligue o motor, solte as mãos do volante e tire os pés dos pedais, permitindo-se relaxar completamente. Enquanto olha ao redor para se reorientar, sentindo o próprio corpo e as partes do carro em busca de sinais de segurança, deixe o corpo ir se recompondo com um suspiro profundo. Depois que a resposta ao estresse for concluída, você poderá seguir viagem, sabendo que o corpo fez a restauração de volta à segurança de que precisava.

Também é essencial mudar a forma como você fala de si mesmo. Pare de se autodepreciar, mesmo em tom de brincadeira. Substitua frases como “Eu sou assim” ou “Só sei agir assim”, colocando-as no passado: “Eu era assim” ou “Eu costumava agir dessa forma”. Mesmo acrescentar um “até agora” deixa espaço para mudança. Quando surgirem pensamentos críticos, refira-se a partes suas, como “Há uma parte de mim que sente que não pode descansar até que tudo esteja perfeito”, em vez de se identificar completamente com essa crença.

Mais importante ainda, observe quando você começa a contar histórias dramáticas, sejam elas sobre o presente ou sobre o passado, e pare. Pratique permanecer no momento presente com você mesmo e com os outros. Pergunte a si mesmo: “Do que eu preciso agora para criar uma sensação interna de segurança e apoio?” Essa pergunta simples pode interromper padrões reativos antigos e criar experiências de regulação.

Dando suporte à sua biologia

Embora exames laboratoriais ajudem a orientar melhor o uso de suplementos, alguns fundamentos são seguros para a maioria das pessoas.

Comece pelo básico. Magnésio, especialmente na forma glicinato, oferece suporte natural ao sistema nervoso. Quando estamos presos entre os estados de estresse e apagação, o magnésio ajuda a reduzir a reatividade excessiva e estimula a produção de energia celular. Converse com um profissional da área da saúde sobre a melhor dosagem para você.

A vitamina C é outro antioxidante essencial, importante também para reações envolvidas na resposta ao estresse.

Para quem sofre de névoa mental ou ansiedade persistente, dois suportes adicionais podem ser úteis. A NAC (N-acetilcisteína) ajuda a reduzir a inflamação cerebral associada à percepção constante de perigo, e o magnésio L-treonato é mais conhecido por atuar diretamente nos neurônios.

Também é benéfico oferecer suporte ao eixo intestino-cérebro com zinco carnosina e L-glutamina, já que o sistema digestivo pode se tornar uma grande fonte de sinais de perigo quando comprometido pelo estresse crônico. No entanto, é importante introduzir suplementos aos poucos, fazendo intervalos de alguns dias e observando atentamente as respostas do corpo.

A jornada à frente

Ao concluir esta exploração de como o corpo vivencia, armazena e cura o trauma, lembre-se de que você não está só. Talvez tenha se reconhecido nas histórias de Elena, Claire, Sarah, Dana, Alex ou Laura. Essas pessoas também precisaram construir sua base de regulação, vencer programações inconscientes e criar experiências que lhes permitissem um futuro melhor.

Para avançar nessa jornada você não precisa forçar mudanças ou passar por cima das barreiras, mas sim criar experiências que mostrem ao sistema nervoso que outro caminho é possível. Não importa se quer se concentrar apenas nos fundamentos ou avançar para um reparo e uma expansão mais profundos: cada pequeno passo gera impulso para a mudança.

Seu corpo tentou proteger você durante todo esse tempo. Agora, você

tem o conhecimento e as ferramentas para trabalhar com ele, e não contra ele.

RESUMO

Compreender a expansão como a última etapa da sequência essencial é reconhecê-la como uma escada em espiral, na qual cada degrau nos leva mais alto e mais fundo. Passamos de “O que em mim precisa ser consertado?” para “Como posso me sentir mais vivo?”, e começamos a notar mudanças sutis, porém profundas, nas escolhas diárias, nas respostas emocionais e no bem-estar físico.

Neste capítulo, exploramos por que algumas pessoas não concluem com sucesso a jornada de cura, muitas vezes por programações inconscientes, como a impotência aprendida, e aprendemos a reconhecer esses padrões. Também apresentamos fundamentos práticos para iniciar ou avançar na cura: estabelecer ritmo e rotina, ajustar a alimentação, equilibrar atividade e estresse, praticar consciência corporal, completar respostas ao estresse, mudar a linguagem que usamos com nós mesmos e garantir suporte à biologia com nutrientes específicos.

Avançar na jornada não é uma questão de forçar mudanças, mas sim de criar experiências que mostrem ao sistema nervoso que existe um jeito melhor de viver. É possível. Você consegue.

EPÍLOGO

Como médica, tive uma experiência singular com o campo da recuperação do trauma: primeiro como uma cética vindo de fora, depois como uma mãe desesperada, uma paciente em um beco sem saída e, agora, como uma colaboradora comprometida por meio das minhas pesquisas e programas. Ao longo desse tempo, testemunhei a evolução desse campo; especialmente desde que minha jornada começou com a busca de respostas para Miguel, vi avanços promissores. Nunca tivemos tantos estudos nem tantas ferramentas clínicas. Algumas das maiores mudanças vieram de uma inclusão mais profunda do corpo no processo de recuperação, de modo que hoje há mais consciência tanto das intervenções no cérebro quanto no corpo. Até mesmo nossa compreensão da conexão entre trauma e doença se expandiu graças a todas as pesquisas subsequentes desde o estudo inicial sobre Experiências Adversas na Infância, o ACE, publicado em 1992. É um momento empolgante para se fazer parte dessa expansão de conhecimento.

Ainda assim, existe uma lacuna que desencorajou muita gente que havia gastado anos e rios de dinheiro com terapia e intervenções de saúde. Essa lacuna levou muitos a se contentarem com uma recuperação do trauma “boa o bastante”, mas longe do que poderiam ter alcançado. Eu mesma talvez tivesse feito isso, se não houvesse assumido, antes de tudo, um compromisso com Miguel. No início, os especialistas que procurei me disseram que as chances de Miguel ter uma vida boa eram mínimas. Ele dificilmente escaparia de uma ficha corrida na adolescência e, provavelmente, de um histórico de dependência química e relacionamentos rompidos. Apesar das probabilidades contra mim, continuei minha busca pelo que Miguel precisava até que, cinco anos depois de começarmos, a última peça finalmente se encaixou.

Ciente do que era possível fazer, cuidei da minha própria recuperação do trauma do mesmo modo quando tudo veio à tona em 2014. Foi desanimador receber respostas diferentes de profissionais da área da saúde diferentes; e, se eu não tivesse me visto tão acuada, nunca teria buscado formação em terapia do trauma como médica. Jamais tive a intenção de criar programas para isso, nem de treinar outros profissionais. Naquele momento, minha vontade era apenas montar meu próprio quebra-cabeça a partir de tantas peças espalhadas. Minha formação e minha curiosidade me ajudaram a encontrar a peça que faltava. Descobri que tinha quase todos os bloqueios biológicos que compartilhei neste livro. Não era de admirar que eu tivesse empacado. Não era um fracasso da terapia, era a minha própria biologia.

Essa descoberta me inspirou. Mesmo quando não tinha descoberto ainda todas as relações entre minha biologia e meus padrões traumáticos, comecei a compartilhar com outras pessoas o que vinha aprendendo. Pacientes que estavam vivenciando as mesmas mudanças que eu passaram a pedir ajuda especificamente com a biologia do trauma. Perguntei a colegas terapeutas se seus pacientes ficavam estagnados como eu. A resposta foi unânime: *sim*. Eles repetiam as mesmas histórias e os mesmos padrões, e os terapeutas não estavam fazendo nada diferente do que faziam com os outros. Eu me ofereci para conduzir avaliações biológicas e, à medida que identificávamos as razões subjacentes e aplicávamos ferramentas de reparo biológico, os pacientes voltavam a progredir na terapia. Esses mesmos profissionais começaram a querer saber como poderiam reconhecer e integrar esse componente biológico.

Foi então que decidi compartilhar essa peça que faltava com mais pessoas e mais profissionais. Escrevi este livro com o desejo de evitar que outros passassem pelo que eu passei. Embora a recuperação do trauma exija a integração de modalidades (e eu tenha traçado os diferentes componentes que devem ser integrados por meio da sequência essencial), escolhi me concentrar principalmente no pilar biológico. Não porque ele seja superior às demais abordagens, mas porque outras pessoas já haviam trazido as outras peças valiosas para o quebra-cabeça da cura.

O que começou como uma missão para ajudar indivíduos a destravar sua jornada de cura evoluiu para uma visão transformadora sobre como abordamos o trauma, seus efeitos e a recuperação. Este livro busca

revolucionar tanto a terapia quanto a medicina ao incorporar a biologia do trauma ao padrão de cuidado em saúde. Quando os terapeutas inserem essa peça que faltava, pacientes estagnados há anos conseguem finalmente avançar. Quando os profissionais da área da saúde entendem como o trauma armazenado promove doenças, eles podem tratar a verdadeira causa, em vez de apenas manejar os sintomas. Não basta mais estar bem-informado sobre o trauma nem mesmo conhecer as abordagens que integram mente e corpo. A era atual exige que os profissionais se informem sobre a biologia do trauma e conheçam as abordagens que unem mente, corpo e biologia.

A biologia do trauma vai muito além dos campos do trauma e da medicina em si. Nas salas de aula, ela ajuda os professores a entender por que algumas crianças não conseguem se concentrar ou se autorregular. Em ambientes corporativos, explica por que os programas de gerenciamento de estresse muitas vezes fracassam. Em centros de crise e zonas de guerra, ela fornece ferramentas práticas para trabalhar com respostas ativas ao trauma. Essa compreensão mais ampla vem atraindo profissionais de diversas áreas e lugares – de nutricionistas a assistentes sociais que trabalham com crianças e adolescentes, de terapeutas a médicos –, todos buscando aprender sobre o cuidado integral do indivíduo.

Haverá desafios para integrar essa ciência ao padrão de assistência à saúde, pois esse é sempre um processo muito lento. Então volto para onde a verdadeira mudança acontece: o nível individual. Ela começa com profissionais que desejam prover um cuidado verdadeiramente integrativo que aborde todos os níveis do impacto do trauma, reconhecendo que seus pacientes precisam de mais do que apenas serem ouvidos, mudar seus pensamentos ou movimentar o corpo. Eles devem estar dispostos a aprender como avaliar e abordar a biologia que mantém pessoas presas em padrões de trauma.

Vejo profissionais da área da saúde frustrados com pacientes estagnados; eles internalizam traumas que não são seus e questionam a própria eficácia. Porém, à medida que aprendem a integrar todas as peças e a guiar pela sequência essencial aqueles a quem estão auxiliando, além de verem resultados melhores, também se tornam mais felizes, energizados e confiantes em fornecer abordagens capazes de criar mudanças duradouras. Hoje existem profissionais da Biologia do Trauma em todo o mundo, e espero que você considere se juntar a esta comunidade integrando mente,

corpo e biologia na recuperação e na medicina do trauma.

A verdadeira magia, no entanto, acontece dentro de você, a pessoa que está lendo este livro. Quer esteja buscando sua própria cura, quer seja pai, mãe, profissional, educador ou profissional da área da saúde tentando melhorar vidas, você é o catalisador da mudança. Ela começa com você.

Sou profundamente grata a todos que me apoiaram na escrita deste livro e àqueles que me colocaram nesta jornada. Penso em Miguel, que me deu o privilégio de ser sua mãe adotiva por seis anos. Se não fosse meu compromisso com ele, talvez eu tivesse me contentado com o “bom o bastante” ao tentar entender a recuperação do trauma.

Penso em meus professores e mentores, cuja sabedoria eu integrei nesta abordagem holística.

Penso nos participantes dos meus cursos, que continuam a me inspirar com sua determinação e coragem, confiando em mim como orientadora. Ver suas transformações, desde abrir-se lentamente para o próprio corpo até abraçar a vida e criar experiências e conexões que jamais imaginaram serem possíveis, continua sendo profundamente significativo.

Para mim, o mais importante são os profissionais da área da saúde que se capacitam comigo, trazendo sua própria abordagem para essa ciência e transformando ainda mais vidas do que eu poderia transformar sozinha. Sou especialmente grata aos meus primeiros alunos, que tiveram paciência comigo enquanto eu aprendia a ensinar, liderar e orientar esse conhecimento e essas ferramentas de modo eficaz. Vocês todos moram no meu coração.

E sou grata a você, que me lê agora. Espero me conectar com você no site de recursos on-line deste livro, BiologyofTrauma.com/book [em inglês], onde encontrará outros recursos e uma forma de me enviar perguntas. Não deixe de compartilhar comigo como este livro ajudou você a aprender mais sobre si mesmo e inspirou ou mudou algo em você. Eu adoraria saber.

À sua melhor saúde e ao seu melhor eu,
Aimie

AGRADECIMENTOS

Este livro nasceu de uma jornada que eu jamais poderia ter percorrido sozinha, e quero deixar aqui o meu reconhecimento àqueles que fizeram parte desse processo.

A *biologia do trauma* representa não apenas a minha voz, mas a sabedoria coletiva de meus instrutores e mentores oficiais e não oficiais ao longo do caminho. Para citar apenas alguns: a Dra. Tian Dayton, cujos insights sobre filhos adultos de alcoólatras abriram meus olhos para uma nova definição de trauma no corpo; Robin Karr-Morse, cujo trabalho pioneiro sobre trauma precoce transformou meu entendimento do impacto de experiências da primeira infância no corpo; o Dr. Peter Levine, cuja terapia de Experiência Somática revolucionou minha maneira de trabalhar memórias armazenadas de impotência no corpo; o Dr. Bruce Lipton, cujas contribuições sobre biologia celular e epigenética ofereceram fundamentos científicos essenciais; o Dr. Dick Schwartz, cujo modelo de Sistemas Familiares Internos abriu caminho para o desenvolvimento de ferramentas práticas para lidar com partes fragmentadas do eu; o Dr. Stephen Porges, cuja teoria polivagal mudou para sempre a forma como compreendo o sistema nervoso autônomo e seus estados; e o Dr. Bessel van der Kolk, que popularizou a ideia de que “o corpo guarda as marcas” e cujo compromisso inabalável com a pesquisa sobre trauma abriu espaço para que abordagens como a minha existissem. A sabedoria coletiva de vocês atravessa estas páginas.

Um agradecimento especial e do fundo do meu coração ao Dr. Gabor Maté, cuja validação do meu trabalho e generosa contribuição com o prefácio deste livro significam mais do que sou capaz de expressar. Sua coragem ao conectar trauma e doença física ajudou a pavimentar o caminho para as conversas a que este livro espera dar continuidade.

Aos meus agentes literários, Mike e Adayla Michalowicz, cujo apoio a este projeto e orientação ao longo da jornada editorial foram inestimáveis. Este livro não existiria sem a equipe editorial da BenBella, liderada por Glenn Yeffeth, e sou especialmente grata à minha editora, Claire Schulz.

E aos incontáveis clientes, pacientes e leitores cujas histórias de sofrimento e resiliência foram meus maiores professores: este livro existe por causa de vocês e para vocês. Sua coragem para encarar e mudar a própria biologia do trauma continua a inspirar meu trabalho todos os dias.

Este livro representa a sabedoria coletiva de uma comunidade em crescimento, dedicada a compreender a marca física do trauma e a mapear caminhos rumo a uma cura genuína. A essa comunidade, sou eternamente grata.

SOBRE A AUTORA



Aimie Apigian formou-se em medicina preventiva e medicina da adição antes de se dedicar às pesquisas sobre trauma em nível celular. Sua

inspiração inicial para se especializar em terapias do trauma veio de seu filho, Miguel, adotado por ela quando cursava a faculdade. Em todo o mundo, mais de 300 mil pessoas já participaram dos programas educativos criados pela Dra. Aimie para divulgar a ciência da biologia do trauma.

BIBLIOGRAFIA

CAPÍTULO 1

- GORKA, Stephanie M.; LIEBERMAN, Lynne; SHANKMAN, Stewart A.; PHAN, K. Luan. “Startle Potentiation to Uncertain Threat as a Psychophysiological Indicator of Fear-Based Psychopathology: An Examination Across Multiple Internalizing Disorders”. *Journal of Abnormal Psychology*, [S.l.], v. 126, n. 1, p. 8–18, 2017. DOI: [10.1037/abn0000233](https://doi.org/10.1037/abn0000233).
- LEVINE, Peter A. *O despertar do tigre: Curando o trauma*. São Paulo: Summus, 2022.
- PORGES, Stephen W. *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2011.
- TINNIN, Louis; GANTT, Linda. *The Instinctual Trauma Response and Dual-Brain Dynamics: A Guide for Trauma Therapy*. [S.l.]: Intensive Trauma Therapy, Inc., 2013.
- VAN DER KOLK, Bessel. *O corpo guarda as marcas: Cérebro, mente e corpo na cura do trauma*. Rio de Janeiro: Sextante, 2020.

CAPÍTULO 2

- Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Administração para Crianças e Famílias. Bureau da Criança. *Child Maltreatment 2022*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 2024.
- SAPOLSKY, Robert M. *Por que as zebras não têm úlceras?*. São Paulo: Francis, 2007.
- STULBERG, Brad; MAGNESS, Steve. *Auge do desempenho: Melhore sua técnica, evite o burnout e cresça com a nova ciência do sucesso*. [S.l.]: Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

CAPÍTULO 3

- DANZIGER, Shai; LEVAV, Jonathan; AVNAIM-PESSO, Liora. “Extraneous Factors in Judicial Decisions”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, [S.l.], v. 108, n. 17, p. 6.889–6.892, 2011. DOI: [10.1073/pnas.1018033108](https://doi.org/10.1073/pnas.1018033108).
- PORGES, Stephen W. “Neuroception: A Subconscious System for Detecting Threats and Safety”. *Zero to Three: Bulletin of the National Center for Clinical Infant Programs*, [S.l.],

v. 24, n. 5, p. 19–24, 2004.

PORGES, Stephen W. *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2011.

CAPÍTULO 4

ALBERTS, Bruce; JOHNSON, Alexander; LEWIS, Julian; RAFF, Martin; ROBERTS, Keith; WALTER, Peter. *Molecular Biology of the Cell*. 5. ed. Nova York: Garland Science, 2008.

CANNON, Walter B. *The Wisdom of the Body*. Nova York: W. W. Norton & Company, 1932.

DUMIC, Jerka; DABELIC, Sanja; FLÖGEL, Mirna. “Galectin-3: An Open-Ended Story”. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – General Subjects*, [S.l.], v. 1.760, n. 4, p. 616–635, 2006. DOI: [10.1016/j.bbagen.2005.12.020](https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2005.12.020).

FRANTZ, Christian; STEWART, Kathleen M.; WEAVER, Valerie M. “The Extracellular Matrix at a Glance”. *Journal of Cell Science*, [S.l.], v. 123, n. 24, p. 4.195–4.200, 2010. DOI: [10.1242/jcs.023820](https://doi.org/10.1242/jcs.023820).

GARCÍA-REVILLA, Juan; BOZA-SERRANO, Antonio; ESPINOSA-OLIVA, Ana M.; SOTO, Manuel Sarmiento; DEIERBORG, Tomas; RUIZ, Rocío; et al. “Galectin-3, a Rising Star in Modulating Microglia Activation Under Conditions of Neurodegeneration”. *Cell Death & Disease*, [S.l.], v. 13, art. 628, 2022. DOI: [10.1038/s41419-022-05058-3](https://doi.org/10.1038/s41419-022-05058-3).

GOLDSTEIN, David S. *The Autonomic Nervous System in Health and Disease*. Boca Raton: CRC Press, 2019.

HALL, John E. (org.). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*. 13. ed. [S.l.]: Elsevier, 2016.

LIPTON, Bruce H. *A biologia da crença*. São Paulo: Butterfly, 2007.

LIU, Lei; LI, Yanjun; CHEN, Guo; CHEN, Quan. “Crosstalk Between Mitochondrial Biogenesis and Mitophagy to Maintain Mitochondrial Homeostasis”. *Journal of Biomedical Science*, [S.l.], v. 30, n. 1, art. 86, 2023. DOI: [10.1186/s12929-023-00975-7](https://doi.org/10.1186/s12929-023-00975-7).

LODISH, Harvey; BERK, Arnold; KAISER, Chris A.; KRIEGER, Monty; BRETSCHER, Anthony; PLOEGH, Hidde L.; et al. *Molecular Cell Biology*. 8. ed. Nova York: W. H. Freeman, 2016.

NAVIAUX, Robert K. “Metabolic Features of the Cell Danger Response”. *Mitochondrion*, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 7–17, 2014. DOI: [10.1016/j.mito.2013.08.006](https://doi.org/10.1016/j.mito.2013.08.006).

NICHOLLS, David G.; FERGUSON, Stuart J. *Bioenergetics* 4. [S.l.]: Academic Press, 2013.

CAPÍTULO 5

BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. *Neuroscience: Exploring the Brain*. 4. ed. [S.l.]: Wolters Kluwer, 2020.

- CHROUSOS, George P. “Stress and Disorders of the Stress System”. *Nature Reviews Endocrinology*, [S.l.], v. 5, n. 7, p. 374–381, 2009. DOI: [10.1038/nrendo.2009.106](https://doi.org/10.1038/nrendo.2009.106).
- DANA, Deb. *The Polyvagal Theory in Therapy: Engaging the Rhythm of Regulation*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2018.
- FASANO, Alessio. “Leaky Gut and Autoimmune Diseases”. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*, [S.l.], v. 42, n. 1, p. 71–78, 2012. DOI: [10.1007/s12016-011-8291-x](https://doi.org/10.1007/s12016-011-8291-x).
- KONTUREK, Peter C.; BRZOZOWSKI, T.; KONTUREK, S. J. “Stress and the Gut: Pathophysiology, Clinical Consequences, Diagnostic Approach and Treatment Options”. *Journal of Physiology and Pharmacology*, [S.l.], v. 62, n. 6, p. 591–599, 2011.
- LEVINE, Peter A. *O despertar do tigre: Curando o trauma*. São Paulo: Summus, 2022.
- MAYER, Emeran. *The Mind-Gut Connection: How the Hidden Conversation Within Our Bodies Impacts Our Mood, Our Choices, and Our Overall Health*. Nova York: Harper Wave, 2016.
- McEWEN, Bruce S. “Central Effects of Stress Hormones in Health and Disease: Understanding the Protective and Damaging Effects of Stress and Stress Mediators”. *European Journal of Pharmacology*, [S.l.], v. 583, n. 2–3, p. 174–185, 2007. DOI: [10.1016/j.ejphar.2007.11.071](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2007.11.071).
- MCGONIGAL, Kelly. *The Upside of Stress: Why Stress Is Good for You, and How to Get Good at It*. Nova York: Avery, 2015.
- MILLER, Andrew H.; MALETIC, Vladimir; RAISON, Charles L. “Inflammation and Its Discontents: The Role of Cytokines in the Pathophysiology of Major Depression”. *Biological Psychiatry*, [S.l.], v. 65, n. 9, p. 732–741, 2009. DOI: [10.1016/j.biopsych.2008.11.029](https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.11.029).
- PERLMUTTER, Austin. “How Inflammation Can Threaten Your Mental Health”. *Psychology Today*, [S.l.], 6 dez. 2024. Disponível em: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-modern-brain/202412/how-inflammation-affects-your-mental-health>. Acesso em: 13 dez. 2025.
- PORGES, Stephen W. *The Polyvagal Theory*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2011.
- SAPOLSKY, Robert M. *Por que as zebras não têm úlceras?*. São Paulo: Francis, 2007.
- SILVERTHORN, Dee. *Fisiologia humana: Uma abordagem integrada*. Porto Alegre: Artmed, 2017.

CAPÍTULO 6

- FISHER, Janina. *Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Overcoming Internal Self-Alienation*. [S.l.]: Routledge, 2017.
- GEISER, Fritz; BRIGHAM, R. Mark. “The Other Functions of Torpor”. In: RUF, Thomas; BIEBER, Claudia; ARNOLD, Walter; MILLESI, Eva (org.). *Living in a Seasonal World*. [S.l.]: Springer, 2012.
- VAN DER KOLK, Bessel A.; FISLER, Rita. “Dissociation and the Fragmentary Nature of

Traumatic Memories: Overview and Exploratory Study”. *Journal of Traumatic Stress*, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 505–525, 1995. [DOI: 10.1002/jts.2490080402](https://doi.org/10.1002/jts.2490080402).

CAPÍTULO 7

KORN, Leslie E. *Rhythms of Recovery: Trauma, Nature, and the Body*. [S.l.]: Routledge, 2012.

LEVINE, Peter A. *Uma voz sem palavras: Como o corpo libera o trauma e restaura o bem-estar*. São Paulo: Summus, 2012.

NAVIAUX, Robert K. “Metabolic Features of the Cell Danger Response”. *Mitochondrion*, [S.l.], v. 16, p. 7–17, 2014. [DOI: 10.1016/j.mito.2013.08.006](https://doi.org/10.1016/j.mito.2013.08.006).

OGDEN, Pat; MINTON, Kekuni; PAIN, Clare. *Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2006.

SCHWARTZ, Richard C. *Internal Family Systems Therapy*. Nova York: Guilford Press, 1995.

CAPÍTULO 8

BIANCO, Antonio C.; KIM, Brian W. “Deiodinases: Implications of the Local Control of Thyroid Hormone Action”. *Journal of Clinical Investigation*, [S.l.], v. 116, n. 10, p. 2.571–2.579, 2006. [DOI: 10.1172/JCI29812](https://doi.org/10.1172/JCI29812).

CRYAN, John F.; DINAN, Timothy G. “Mind-Altering Microorganisms: The Impact of the Gut Microbiota on Brain and Behaviour”. *Nature Reviews Neuroscience*, [S.l.], v. 13, n. 10, p. 701–712, 2012. [DOI: 10.1038/nrn3346](https://doi.org/10.1038/nrn3346).

DOIDGE, Norman. *O cérebro que se transforma: Como a neurociência pode curar as pessoas*. Rio de Janeiro: Record, 2011.

DONATH, Marc Y.; SHOELSON, Steven E. “Type 2 Diabetes as an Inflammatory Disease”. *Nature Reviews Immunology*, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 98–107, 2011. [DOI: 10.1038/nri2925](https://doi.org/10.1038/nri2925).

ESPLUGUES, J. V.; BARRACHINA, M. D.; BELTRÁN, B.; CALATAYUD, S.; WHITTLE, B. J.; MONCADA, S. “Inhibition of Gastric Acid Secretion by Stress: A Protective Reflex Mediated by Cerebral Nitric Oxide”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, [S.l.], v. 93, n. 25, p. 14.839–14.844, 1996. [DOI: 10.1073/pnas.93.25.14839](https://doi.org/10.1073/pnas.93.25.14839).

FASANO, Alessio. “Leaky Gut and Autoimmune Diseases”. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*, [S.l.], v. 42, n. 1, p. 71–78, 2012. [DOI: 10.1007/s12016-011-8291-x](https://doi.org/10.1007/s12016-011-8291-x).

HAAS, Helmut L.; SERGEEVA, Olga A.; SELBACH, Oliver. “Histamine in the Nervous System”. *Physiological Reviews*, [S.l.], v. 88, n. 3, p. 1.183–1.241, 2008. [DOI: 10.1152/physrev.00043.2007](https://doi.org/10.1152/physrev.00043.2007).

HOFMANN, Alan F. “Bile Acids: The Good, the Bad, and the Ugly”. *News in Physiological Sciences*, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 24–29, 1999. [DOI: 10.1152/physiologyonline.1999.14.1.24](https://doi.org/10.1152/physiologyonline.1999.14.1.24).

HOTAMISLIGIL, Gökhan S. “Inflammation, Metaflammation, and Immunometabolic Disorders”. *Nature*, [S.l.], v. 542, n. 7640, p. 177–185, 2017. [DOI: 10.1038/nature21363](https://doi.org/10.1038/nature21363).

- KARUNYAM, Bheena Vyshali; ABDUL KARIM, Abdul Kadir; MOHAMED, Isa Naina; UGUSMAN, Azizah; MOHAMED, Wael M. Y.; FAISAL, Ahmad Mohd; et al. "Infertility and Cortisol: A Systematic Review". *Frontiers in Endocrinology*, [S.l.], v. 14, art. 1147306, 2023. DOI: [10.3389/fendo.2023.1147306](https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1147306).
- KETTENMANN, Helmut; RANSOM, Bruce R. (ed.). *Neuroglia*. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- McEWEN, Bruce S. "Central Effects of Stress Hormones in Health and Disease: Understanding the Protective and Damaging Effects of Stress and Stress Mediators". *European Journal of Pharmacology*, [S.l.], v. 583, n. 2–3, p. 174–185, 2008. DOI: [10.1016/j.ejphar.2007.11.071](https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2007.11.071).
- MURPHY, Michael P. "How Mitochondria Produce Reactive Oxygen Species". *Biochemical Journal*, [S.l.], v. 417, n. 1, p. 1–13, 2009. DOI: [10.1042/BJ20081386](https://doi.org/10.1042/BJ20081386).
- PERRY, V. Hugh; HOLMES, Clive. "Microglial Priming in Neurodegenerative Disease". *Nature Reviews Neurology*, [S.l.], v. 10, n. 4, p. 217–224, 2014. DOI: [10.1038/nrneurol.2014.38](https://doi.org/10.1038/nrneurol.2014.38).
- PORGES, Stephen W. *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2011.
- ROSE, Noel R.; MACKAY, Ian R. *The Autoimmune Diseases*. 5. ed. [S.l.]: Academic Press, 2014.
- THEOHARIDES, Theoharis C.; KALOGEROMITROS, Dimitrios. "The Critical Role of Mast Cells in Allergy and Inflammation". *Annals of the New York Academy of Sciences*, [S.l.], v. 1.088, n. 1, p. 78–99, 2006. DOI: [10.1196/annals.1366.025](https://doi.org/10.1196/annals.1366.025).
- WALLACE, Douglas C. "A Mitochondrial Bioenergetic Etiology of Disease". *Journal of Clinical Investigation*, [S.l.], v. 123, n. 4, p. 1.405–1.412, 2013. DOI: [10.1172/JCI61398](https://doi.org/10.1172/JCI61398).

CAPÍTULO 9

- LEVINE, Peter A. *Uma voz sem palavras: Como o corpo libera o trauma e restaura o bem-estar*. São Paulo: Summus, 2012.
- MATÉ, Gabor. *When the Body Says No: Exploring the Stress-Disease Connection*. [S.l.]: Wiley, 2003.
- McEWEN, Bruce S.; LASLEY, Elizabeth Norton. *O fim do estresse como o conhecemos*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.
- SCAER, Robert. *The Trauma Spectrum: Hidden Wounds and Human Resiliency*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2005.
- SIEGEL, Daniel J. *A mente em desenvolvimento: Como os relacionamentos e o cérebro interagem para moldar quem somos*. São Paulo: nVersos, 2024.
- VAN DER KOLK, Bessel. *O corpo guarda as marcas: Cérebro, mente e corpo na cura do trauma*. Rio de Janeiro: Sextante, 2020.

YARIBEYGI, Habib; PANAHI, Yunes; SAHRAEI, Hedayat; JOHNSTON, Thomas P.; SAHEBKAR, Amirhossein. "The Impact of Stress on Body Function: A Review". *EXCLI Journal*, [S.l.], v. 16, p. 1.057–1.072, 2017. [DOI: 10.17179/excli2017-480](https://doi.org/10.17179/excli2017-480).

CAPÍTULO 10

ANDA, Robert F.; CROFT, Janet B.; FELITTI, Vincent J.; NORDENBERG, Dale; GILES, Wayne H.; WILLIAMSON, David F.; GIOVINO, Gary A. "Adverse Childhood Experiences and Smoking During Adolescence and Adulthood". *JAMA*, [S.l.], v. 282, n. 17, p. 1.652–1.658, 1999. [DOI: 10.1001/jama.282.17.1652](https://doi.org/10.1001/jama.282.17.1652).

BRADFORD, Kara; SHIH, Wendy; VIDELOCK, Elizabeth J.; PRESSON, Angela P.; NALIBOFF, Bruce D.; MAYER, Emeran A.; CHANG, Lin. "Association Between Early Adverse Life Events and Irritable Bowel Syndrome". *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, [S.l.], v. 10, n. 4, p. 385–390.e1–3, 2012. [DOI: 10.1016/j.cgh.2011.12.018](https://doi.org/10.1016/j.cgh.2011.12.018).

BUGIANESI, Elisabetta; McCULLOUGH, Arthur J.; MARCHESINI, Giulio. "Insulin Resistance: A Metabolic Pathway to Chronic Liver Disease". *Hepatology*, [S.l.], v. 42, n. 5, p. 987–1.000, 2005. [DOI: 10.1002/hep.20920](https://doi.org/10.1002/hep.20920).

DAHLHAMER, James; LUCAS, Jacqueline; ZELAYA, Carla; NAHIN, Richard; MACKEY, Sean; DEBAR, Lynn; et al. "Prevalence of Chronic Pain and High-Impact Chronic Pain Among Adults – United States, 2016". *Morbidity and Mortality Weekly Report*, [S.l.], v. 67, n. 36, p. 1.001–1.006, 2018. [DOI: 10.15585/mmwr.mm6736a2](https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6736a2).

DE LUCA, Carl; OLEFSKY, Jerald M. "Inflammation and Insulin Resistance". *FEBS Letters*, [S.l.], v. 582, n. 1, p. 97–105, 2008. [DOI: 10.1016/j.febslet.2007.11.057](https://doi.org/10.1016/j.febslet.2007.11.057).

FELITTI, Vincent J.; ANDA, Robert F.; NORDENBERG, Dale; WILLIAMSON, David F.; SPITZ, Alison M.; EDWARDS, Valerie; et al. "Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study". *American Journal of Preventive Medicine*, [S.l.], v. 14, n. 4, p. 245–258, 1998. [DOI: 10.1016/S0749-3797\(98\)00017-8](https://doi.org/10.1016/S0749-3797(98)00017-8).

HAYTER, Scott M.; COOK, Matthew C. "Updated Assessment of the Prevalence, Spectrum and Case Definition of Autoimmune Disease". *Autoimmunity Reviews*, [S.l.], v. 11, n. 10, p. 754–765, 2012. [DOI: 10.1016/j.autrev.2012.02.001](https://doi.org/10.1016/j.autrev.2012.02.001).

HUGHES, Karen; BELLIS, Mark A.; HARDCASTLE, Katherine A.; SETHI, Dinesh; BUTCHART, Alexander; MIKTON, Christopher; et al. "The Effect of Multiple Adverse Childhood Experiences on Health: A Systematic Review and Meta-analysis". *The Lancet Public Health*, [S.l.], v. 2, n. 8, p. e356–e366, 2017. [DOI: 10.1016/S2468-2667\(17\)30118-4](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30118-4).

INSTITUTO DE MEDICINA DOS ESTADOS UNIDOS. *Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness*. Washington, D.C.: The National Academies Press, 2015. [DOI: 10.17226/19012](https://doi.org/10.17226/19012).

JI, Ru-Rong; NACKLEY, Andrea; HUH, Yul; TERRANDO, Niccolò; MAIXNER, William. "Neuroinflammation and Central Sensitization in Chronic and Widespread Pain".

- Anesthesiology*, [S.l.], v. 129, n. 2, p. 343–366, 2018. DOI: [10.1097/ALN.0000000000002130](https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002130).
- LANTOS, Paul M.; RUMBAUGH, Jeffrey; BOCKENSTEDT, Linda K.; FALCK-YTTER, Yngve T.; AGUERO-ROSENFELD, Maria E.; AUWERTER, Paul G.; et al. “Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), and American College of Rheumatology (ACR): 2020 Guidelines for the Prevention, Diagnosis and Treatment of Lyme Disease”. *Clinical Infectious Diseases*, [S.l.], v. 72, n. 1, p. e1–e48, 2021. DOI: [10.1093/cid/ciaa1215](https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1215).
- MATÉ, Gabor. *O mito do normal: Trauma, saúde e cura em um mundo doente*. Rio de Janeiro: Sextante, 2023.
- MAYER, Emeran A.; TILLISCH, Kirsten. “The Brain-Gut Axis in Abdominal Pain Syndromes”. *Annual Review of Medicine*, [S.l.], v. 62, p. 381–396, 2011. DOI: [10.1146/annurev--med-012309-103958](https://doi.org/10.1146/annurev--med-012309-103958).
- RINELLA, Mary E. “Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review”. *JAMA*, [S.l.], v. 313, n. 22, p. 2.263–2.273, 2015. DOI: [10.1001/jama.2015.5370](https://doi.org/10.1001/jama.2015.5370).
- ROSE, Noel R. “Prediction and Prevention of Autoimmune Disease in the 21st Century: A Review and Preview”. *American Journal of Epidemiology*, [S.l.], v. 183, n. 5, p. 403–406, 2016. DOI: [10.1093/aje/kwv292](https://doi.org/10.1093/aje/kwv292).
- SANDERSON, Maureen; MOUTON, Charles P.; COOK, Makeila; LIU, Janguo; BLOT, William J.; HARGREAVES, Margaret K. “Adverse Childhood Experiences and Chronic Disease Risk in the Southern Community Cohort Study”. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, [S.l.], v. 32, n. 3, p. 1.384–1.402, 2021. DOI: [10.1353/hpu.2021.0139](https://doi.org/10.1353/hpu.2021.0139).
- SHOEMAKER, R. C.; HUDNELL, H. K. “Possible Estuary-Associated Syndrome: Symptoms, Vision, and Treatment”. *Environmental Health Perspectives*, [S.l.], v. 109, n. 5, p. 539–545, 2001. DOI: [10.1289/ehp.01109539](https://doi.org/10.1289/ehp.01109539).
- SUDRE, Carole H.; MURRAY, Benjamin; VARSAVSKY, Thomas; GRAHAM, Mark S.; PENFOLD, Rose S.; BOWYER, Ruth C.; et al. “Attributes and Predictors of Long COVID”. *Nature Medicine*, [S.l.], v. 27, n. 4, p. 626–631, 2021. DOI: [10.1038/s41591-021-01292-y](https://doi.org/10.1038/s41591-021-01292-y).
- SWARUP, Supreya; AHMED, Intisar; GRIGOROVA, Yulia; ZELTSER, Roman. “Metabolic Syndrome”. *StatPearls*, [S.l.], 7 mar. 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459248>.
- VALKO, Marian; LEIBFRITZ, Dieter; MONCOL, Jan; CRONIN, Mark T. D.; MAZUR, Milan; TELSER, Joshua. “Free Radicals and Antioxidants in Normal Physiological Functions and Human Disease”. *International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, [S.l.], v. 39, n. 1, p. 44–84, 2007. DOI: [10.1016/j.biocel.2006.07.001](https://doi.org/10.1016/j.biocel.2006.07.001).
- WALLACE, Douglas C.; CHALKIA, Dimitra. “Mitochondrial DNA Genetics and the Heteroplasmy Conundrum in Evolution and Disease”. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, [S.l.], v. 5, n. 11, art. a021220, 2013. DOI: [10.1101/cshperspect.a021220](https://doi.org/10.1101/cshperspect.a021220).
- YOUNOSSI, Zobair M.; KOENIG, Aaron B.; ABDELATIF, Dinan; FAZEL, Yousef; HENRY, Linda; WYMER, Mark. “Global Epidemiology of Nonalcoholic Fatty Liver Disease –

Meta-analytic Assessment of Prevalence, Incidence, and Outcomes”. *Hepatology*, [S.l.], v. 64, n. 1, p. 73–84, 2016. [DOI: 10.1002/hep.28431](https://doi.org/10.1002/hep.28431).

CAPÍTULO 11

FIELD, Tiffany. “Postpartum Depression Effects on Early Interactions, Parenting, and Safety Practices: A Review”. *Infant Behavior and Development*, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 1–6, 2010. [DOI: 10.1016/j.infbeh.2009.10.005](https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2009.10.005).

GODDARD BLYTHE, Sally. *Attention, Balance and Coordination: The A.B.C. of Learning Success*. 2. ed. [S.l.]: Wiley-Blackwell, 2015.

GODDARD BLYTHE, Sally. *The Well Balanced Child: Movement and Early Learning*. [S.l.]: Hawthorn Press, 2015.

HELLER, Laurence; LAPIERRE, Aline. *Healing Developmental Trauma: How Early Trauma Affects Self-Regulation, Self-Image, and the Capacity for Relationship*. Berkeley: North Atlantic Books, 2012.

LEVINE, Peter A.; KLINE, Maggie. *Trauma Through a Child’s Eyes: Awakening the Ordinary Miracle of Healing*. Berkeley: North Atlantic Books, 2007.

PERRY, Bruce D.; SZALAVITZ, Maia. *Born for Love: Why Empathy is Essential—and Endangered*. Nova York: HarperCollins, 2010.

PORGES, Stephen W. *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation*. Nova York: W. W. Norton & Company, 2011.

SIEGEL, Daniel J.; HARTZELL, Mary. *Parentalidade consciente: Como o autoconhecimento nos ajuda a criar nossos filhos*. São Paulo: nVersos, 2020.

TRONICK, Edward Z.; ALS, Heidelise; ADAMSON, Lauren; WISE, Susan; BRAZELTON, T. Berry. “The Infant’s Response to Entrapment Between Contradictory Messages in Face-to-Face Interaction”. *Journal of the American Academy of Child Psychiatry*, [S.l.], v. 17, n. 1, p. 1–13, 1978. [DOI: 10.1016/S0002-7138\(09\)62273-1](https://doi.org/10.1016/S0002-7138(09)62273-1).

WALSH, William J. *O poder dos nutrientes: Como a bioquímica natural está substituindo os remédios psiquiátricos no tratamento de distúrbios mentais*. Rio de Janeiro: Versal, 2018.

CAPÍTULO 12

CORRIGAN, Frank; FISHER, J.; NUTT, David. “Autonomic Dysregulation and the Window of Tolerance Model of the Effects of Complex Emotional Trauma”. *Journal of Psychopharmacology*, [S.l.], v. 25, p. 17–25, 2011. [DOI: 10.1177/0269881109354930](https://doi.org/10.1177/0269881109354930).

DAYTON, Tian. *Trauma and Addiction: Ending the Cycle of Pain Through Emotional Literacy*. [S.l.]: Health Communications, 2000.

DOIDGE, Norman. *O cérebro que se transforma: Como a neurociência pode curar as pessoas*. Rio de Janeiro: Record, 2011.

- HEBB, Donald O. *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory*. [S.l.]: Wiley, 1949.
- HERMAN, Judith Lewis. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence—from Domestic Abuse to Political Terror*. Nova York: Basic Books, 1997.
- LEVINE, Peter A. *Uma voz sem palavras: Como o corpo libera o trauma e restaura o bem-estar*. São Paulo: Summus, 2012.
- LEVINE, Peter A. *O despertar do tigre: Curando o trauma*. São Paulo: Summus, 2022.
- PORGES, Stephen W. “Neuroception: A Subconscious System for Detecting Threats and Safety”. *Zero to Three: Bulletin of the National Center for Clinical Infant Programs*, [S.l.], v. 24, n. 5, p. 19–24, 2004.

CAPÍTULO 14

- AMES, Bruce N. “A Role for Supplements in Optimizing Health: The Metabolic Tune-up”. *Archives of Biochemistry and Biophysics*, [S.l.], v. 423, n. 1, p. 227–234, 2004. DOI: [10.1016/j.abb.2003.11.002](https://doi.org/10.1016/j.abb.2003.11.002).
- BIRDSALL, T. C. “5-Hydroxytryptophan: A Clinically-Effective Serotonin Precursor”. *Alternative Medicine Review*, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 271–280, 1998.
- CHROUSOS, George P. “Stress and Disorders of the Stress System”. *Nature Reviews Endocrinology*, [S.l.], v. 5, n. 7, p. 374–381, 2009. DOI: [10.1038/nrendo.2009.106](https://doi.org/10.1038/nrendo.2009.106).
- HALL, John E. (org.). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology*. 13. ed. [S.l.]: Elsevier, 2016.
- HAMBLIN, Michael R. “Mechanisms and Applications of the Anti-inflammatory Effects of Photobiomodulation”. *AIMS Biophysics*, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 337–361, 2017. DOI: [10.3934/biophy.2017.3.337](https://doi.org/10.3934/biophy.2017.3.337).
- JOSEPH, James A.; SHUKITT-HALE, Barbara; CASADESUS, Gemma. “Reversing the Deleterious Effects of Aging on Neuronal Communication and Behavior: Beneficial Properties of Fruit Polyphenolic Compounds”. *American Journal of Clinical Nutrition*, [S.l.], v. 81, n. 1, p. 313S–316S, 2005. DOI: [10.1093/ajcn/81.1.313S](https://doi.org/10.1093/ajcn/81.1.313S).
- KHARRAZIAN, Datis. *Why Isn't My Brain Working? A Revolutionary Understanding of Brain Decline and Effective Strategies to Recover Your Brain's Health*. [S.l.]: Morgan James Publishing, 2013.
- MARTINS, W. A.; PURDY, G. M. “Oculocardiac Reflex”. *StatPearls*, [S.l.], 7 maio 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499832>.
- MILLER, Andrew H.; RAISON, Charles L. “The Role of Inflammation in Depression: From Evolutionary Imperative to Modern Treatment Target”. *Nature Reviews Immunology*, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 22–34, 2016. DOI: [10.1038/nri.2015.5](https://doi.org/10.1038/nri.2015.5).
- STRANDWITZ, Philip. “Neurotransmitter Modulation by the Gut Microbiota”. *Brain Research*, [S.l.], v. 1693, p. 128–133, 2018. DOI: [10.1016/j.brainres.2018.03.015](https://doi.org/10.1016/j.brainres.2018.03.015).
- WALLACE, Douglas C. “A Mitochondrial Paradigm of Metabolic and Degenerative

Diseases, Aging, and Cancer: A Dawn for Evolutionary Medicine”. *Annual Review of Genetics*, [S.l.], v. 39, p. 359–407, 2005. [DOI: 10.1146/annurev.genet.39.110304.095751](https://doi.org/10.1146/annurev.genet.39.110304.095751).

CAPÍTULO 15

- ALAM, Reza; ABDOLMALEKY, Hamid M.; ZHOU, Jin-Rong. “Microbiome, Inflammation, Epigenetic Alterations, and Mental Diseases”. *American Journal of Medical Genetics*, Part B: Neuropsychiatric Genetics, [S.l.], v. 174, n. 6, p. 651–660, 2017. [DOI: 10.1002/ajmg.b.32567](https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32567).
- CREWS, Fulton T.; NIXON, Kim. “Mechanisms of Neurodegeneration and Regeneration in Alcoholism”. *Alcohol and Alcoholism*, [S.l.], v. 44, n. 2, p. 115–127, 2009. [DOI: 10.1093/alcalc/agn079](https://doi.org/10.1093/alcalc/agn079).
- FARINA, Marcelo; ROCHA, João B. T.; ASCHNER, Michael. “Mechanisms of Methylmercury-induced Neurotoxicity: Evidence from Experimental Studies”. *Life Sciences*, [S.l.], v. 89, n. 15–16, p. 555–563, 2011. [DOI: 10.1016/j.lfs.2011.05.019](https://doi.org/10.1016/j.lfs.2011.05.019).
- GRANDJEAN, Philippe; LANDRIGAN, Philip J. “Neurobehavioural Effects of Developmental Toxicity”. *Lancet Neurology*, [S.l.], v. 13, n. 3, p. 330–338, 2014. [DOI: 10.1016/S1474-4422\(13\)70278-3](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70278-3).
- HOPE, Janette. “A Review of the Mechanism of Injury and Treatment Approaches for Illness Resulting from Exposure to Water-damaged Buildings, Mold, and Mycotoxins”. *Scientific World Journal*, [S.l.], v. 2013, art. 767482, 2013. [DOI: 10.1155/2013/767482](https://doi.org/10.1155/2013/767482).
- JANDACEK, Ronald J.; TSO, Patrick. “Factors Affecting the Storage and Excretion of Toxic Lipophilic Xenobiotics”. *Lipids*, [S.l.], v. 36, n. 12, p. 1.289–1.305, 2001. [DOI: 10.1007/s11745-001-0844-z](https://doi.org/10.1007/s11745-001-0844-z).
- LISKA, DeAnn J.; LYON, Michael; JONES, David S. “Detoxification and Biotransformational Imbalances”. *Explore*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 122–140, 2006. [DOI: 10.1016/j.explore.2005.12.009](https://doi.org/10.1016/j.explore.2005.12.009).
- MANDAL, Badal Kumar; SUZUKI, Kazuo T. “Arsenic Round the World: A Review”. *Talanta*, [S.l.], v. 58, n. 1, p. 201–235, 2002. [DOI: 10.1016/S0039-9140\(02\)00268-0](https://doi.org/10.1016/S0039-9140(02)00268-0).
- NOBLE, Emily E.; KANOSKI, Scott E. “Early Life Exposure to Obesogenic Diets and Learning and Memory Dysfunction”. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, [S.l.], v. 9, p. 7–14, 2016. [DOI: 10.1016/j.cobeha.2015.11.014](https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2015.11.014).
- ROOK, Graham A. “Regulation of the Immune System by Biodiversity from the Natural Environment: An Ecosystem Service Essential to Health”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, [S.l.], v. 110, n. 46, p. 18.360–18.367, 2013. [DOI: 10.1073/pnas.1313731110](https://doi.org/10.1073/pnas.1313731110).
- WALSH, William J. *O poder dos nutrientes: Como a bioquímica natural está substituindo os remédios psiquiátricos no tratamento de distúrbios mentais*. Rio de Janeiro: Versal, 2018.

CAPÍTULO 16

- ALAM, Reza; ABDOLMALEKY, Hamid M.; ZHOU, Jin-Rong. “Microbiome, Inflammation, Epigenetic Alterations, and Mental Diseases”. *American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics*, [S.l.], v. 174, n. 6, p. 651–660, 2017. DOI: [10.1002/ajmg.b.32567](https://doi.org/10.1002/ajmg.b.32567).
- ANILKUMAR, Sudha; WRIGHT-JIN, Elizabeth. “NF-κB as an Inducible Regulator of Inflammation in the Central Nervous System”. *Cells*, [S.l.], v. 13, n. 6, art. 485, 2024. DOI: [10.3390/cells13060485](https://doi.org/10.3390/cells13060485).
- HIGGINS, A. J.; LEES, P. “The Acute Inflammatory Process, Arachidonic Acid Metabolism and the Mode of Action of Anti-inflammatory Drugs”. *Equine Veterinary Journal*, [S.l.], v. 16, n. 3, p. 163–175, 1984. DOI: [10.1111/j.2042-3306.1984.tb01893.x](https://doi.org/10.1111/j.2042-3306.1984.tb01893.x).
- LESCHAK, Carriane J.; EISENBERGER, Naomi I. “Two Distinct Immune Pathways Linking Social Relationships With Health: Inflammatory and Antiviral Processes”. *Psychosomatic Medicine*, [S.l.], v. 81, n. 8, p. 711–719, 2019. DOI: [10.1097/PSY.0000000000000685](https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000685).
- LIPTON, Bruce H. *A biologia da crença*. São Paulo: Butterfly, 2007.
- MASGUTOVA, S. K.; AKHMATOVA, N. K.; SADOWSKA, L.; SHACKLEFORD, P.; AKHMATOV, E. A. “Neurosensorimotor Reflex Integration for Autism: a New Therapy Modality Paradigm”. *Journal of Pediatric Neurological Disorders*, [S.l.], v. 2, p. 107, 2016. DOI: [10.4172/2572-5203.1000107](https://doi.org/10.4172/2572-5203.1000107).
- MATÉ, Gabor. *O mito do normal: Trauma, saúde e cura em um mundo doente*. Rio de Janeiro: Sextante, 2023.
- MATÉ, Gabor. *When the Body Says No: Exploring the Stress-Disease Connection*. [S.l.]: Wiley, 2003.
- MEHDI, Syan Faizad; PUSAPATI, Suma; KHENHRANI, Raja Ram; FAROOQI, Muhammad Saad; SARWAR, Sobia; ALNASARAT, Ahmad; et al. “Oxytocin and Related Peptide Hormones: Candidate Anti-inflammatory Therapy in Early Stages of Sepsis”. *Frontiers in Immunology*, [S.l.], v. 13, art. 864007, 2022. DOI: [10.3389/fimmu.2022.864007](https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.864007).
- RHIE, Sung Ja; JUNG, Eun-Yee; SHIM, Insop. “The Role of Neuroinflammation on Pathogenesis of Affective Disorders”. *Journal of Exercise Rehabilitation*, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 2–9, 2020. DOI: [10.12965/jer.2040016.008](https://doi.org/10.12965/jer.2040016.008).
- RUDRAPAL, Mithun; KHAIRNAR, Shubham J.; KHAN, Johra; BIN DUKHYIL, Abdulaziz; ANSARI, Mohammad Azam; ALOMARY, Mohammad N.; et al. “Dietary Polyphenols and Their Role in Oxidative Stress-Induced Human Diseases: Insights into Protective Effects, Antioxidant Potentials, and Mechanism(s) of Action”. *Frontiers in Pharmacology*, [S.l.], v. 13, art. 806470, 2022. DOI: [10.3389/fphar.2022.806470](https://doi.org/10.3389/fphar.2022.806470).
- SAHA, Sarmistha; BUTTARI, Brigitta; PANIERI, Emiliano; PROFUMO, Elisabetta; SASO, Luciano. “An Overview of Nrf2 Signaling Pathway and Its Role in Inflammation”. *Molecules*, [S.l.], v. 25, n. 22, art. 5474, 2020. DOI: [10.3390/molecules25225474](https://doi.org/10.3390/molecules25225474).
- VASCONCELOS, Andrea Rodrigues; DOS SANTOS, Nilton Baretto; SCAVONE,

Cristoforo; MUNHOZ, Carolina Demarchi. “Nrf2/ARE Pathway Modulation by Dietary Energy Regulation in Neurological Disorders”. *Frontiers in Pharmacology*, [S.l.], v. 10, art. 33, 2019. DOI: [10.3389/fphar.2019.00033](https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00033).

CAPÍTULO 17

CLEVELAND CLINIC. “Glutamine”. [S.l.], 6 dez. 2022. Disponível em: <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/glutamine>.

COLLINS, A. R.; HORVÁTHOVÁ, E. “Oxidative DNA Damage, Antioxidants and DNA Repair: Applications of the Comet Assay”. *Biochemical Society Transactions*, [S.l.], v. 29, pt. 2, p. 337–341, 2001. DOI: [10.1042/0300-5127:0290337](https://doi.org/10.1042/0300-5127:0290337).

CZERWONY, K. A. “Do Digestive Bitters Work?”. *Cleveland Clinic Health Essentials*, [S.l.], 27 jan. 2020. Disponível em: <https://health.clevelandclinic.org/digestive-bitters>.

GERSHON, Michael D. *O segundo cérebro: Entenda o funcionamento do aparelho digestivo e sua relação com o cérebro, uma visão revolucionária das doenças nervosas do estômago e do intestino*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

GUO, Shuhong; NIGHOT, Meghali; AL-SADI, Rana; ALHMOUD, Tarik; NIGHOT, Prashant; MA, Thomas Y. “Lipopolysaccharide Regulation of Intestinal Tight Junction Permeability Is Mediated by TLR4 Signal Transduction Pathway Activation of FAK and MyD88”. *Journal of Immunology*, [S.l.], v. 195, n. 10, p. 4.999–5.010, 2015. DOI: [10.4049/jimmunol.1402598](https://doi.org/10.4049/jimmunol.1402598).

ZAWIA, Nasser H.; LAHIRI, Debomoy K.; CARDOZO-PELAEZ, Fernando. “Epigenetics, Oxidative Stress, and Alzheimer Disease”. *Free Radical Biology and Medicine*, [S.l.], v. 46, n. 9, p. 1.241–1.249, 2009. DOI: [10.1016/j.freeradbiomed.2009.02.006](https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2009.02.006).

ZHENG, Xiaoqing; SAWALHA, Amr H. “The Role of Oxidative Stress in Epigenetic Changes Underlying Autoimmunity”. *Antioxidants & Redox Signaling*, [S.l.], v. 36, n. 7–9, p. 423–440, 2022. DOI: [10.1089/ars.2021.0066](https://doi.org/10.1089/ars.2021.0066).

CAPÍTULO 18

LEVINE, Peter A. *Healing Trauma: A Pioneering Program for Restoring the Wisdom of Your Body*. [S.l.]: Sounds True, 1999.

MAIER, Steven F.; SELIGMAN, Martin P. “Learned Helplessness: Theory and Evidence”. *Journal of Experimental Psychology: General*, [S.l.], v. 105, n. 1, p. 3–46, 1976. DOI: [10.1037/0096-3445.105.1.3](https://doi.org/10.1037/0096-3445.105.1.3).

DESTAQUES DE NOSSO CATÁLOGO

- Ana Claudia Quintana Arantes: A morte é um dia que vale a pena viver (650 mil livros vendidos) e Pra vida toda valer a pena viver
- Haemin Sunim: As coisas que você só vê quando desacelera (700 mil livros vendidos) e Amor pelas coisas imperfeitas
- Dale Carnegie: Como fazer amigos e influenciar pessoas (16 milhões de livros vendidos) e Como evitar preocupações e começar a viver
- Brené Brown: A coragem de ser imperfeito – Como aceitar a própria vulnerabilidade e vencer a vergonha (900 mil livros vendidos)
- T. Harv Eker: Os segredos da mente milionária (3 milhões de livros vendidos)
- Greg McKeown: Essencialismo – A disciplinada busca por menos (700 mil livros vendidos) e Sem esforço – Torne mais fácil o que é mais importante
- Ichiro Kishimi e Fumitake Koga: A coragem de não agradar – Como se libertar da opinião dos outros (350 mil livros vendidos)
- Simon Sinek: Comece pelo porquê (350 mil livros vendidos) e O jogo infinito
- Robert B. Cialdini: As armas da persuasão (500 mil livros vendidos)
- Eckhart Tolle: O poder do agora (1,2 milhão de livros vendidos)



Este e outros títulos do nosso catálogo estão disponíveis em audiolivro.

Para saber mais sobre os títulos e autores da Editora Sextante, visite o nosso site e siga as nossas redes sociais. Além de informações sobre os próximos lançamentos, você terá acesso a conteúdos exclusivos e poderá participar de promoções e sorteios.

sextante.com.br

